

神志病

SHENZHIBING

MINGYI MIYAN JUEJI

名医秘验绝技

总主编 梁亚奇

主编 苏维霞

名医秘技丛书



人民军医出版社

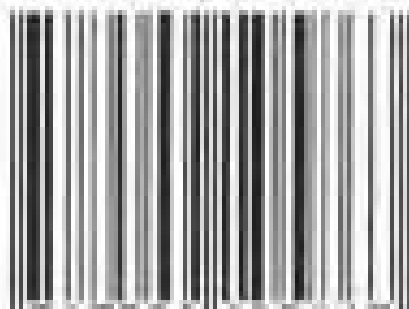
PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

更多书籍尽在**bbs.snow-zone.cn**

名医秘技丛书

小儿病 名医秘验绝技
男性病 名医秘验绝技
脑卒中 名医秘验绝技
胃肠病 名医秘验绝技
腰腿痛 名医秘验绝技
神志病 名医秘验绝技
乳腺病 名医秘验绝技
前列腺病 名医秘验绝技
高脂血症 名医秘验绝技
跌打损伤 名医秘验绝技

ISBN 7-5091-0586-2



9 787509 105863 >

◎策划编辑 战博

◎封面设计 东方秀谷

ISBN 7-5091-0586-2

定价：20.00元

名医秘技丛书

神志病

名医秘验绝技

SHENZHIBING MINGYI MIYAN JUEJI

总主编 梁亚奇

主 编 苏维霞

编 委 马红治 田 雨 苏维霞

李小晨 邱新红 陈 平

秦玮林 梁亚奇



人民军医出版社

Peoples Military Medical Press

北 京

图书在版编目(CIP)数据

神志病名医秘验绝技/苏维霞主编. —北京:人民军医出版社, 2006. 11

(名医秘技丛书)

ISBN 7-5091-0586-2

I. 神... II. 苏... III. 心病(中医)-中西医结合-诊疗 IV. R256.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 109728 号

策划编辑:成 博 文字编辑:荣 堃 责任审读:李 晨
出 版 人:齐学进

出版发行:人民军医出版社 经销:新华书店

通信地址:北京市 100036 信箱 188 分箱 邮编:100036

电话:(010)66882586(发行部)、51927290(总编室)

传真:(010)68222916(发行部)、66882583(办公室)

网址:www.pmtmp.com.cn

印刷:北京天宇星印刷厂 装订:京兰装订有限公司

开本:787mm×1092mm 1/32

印张:8.375 字数:176 千字

版、印次:2006 年 11 月第 1 版第 1 次印刷

印数:0001~4500

定价:20.00 元

版权所有 侵权必究

购买本社图书,凡有缺、倒、脱页者,本社负责调换

电话:(010)66882585、51927252



内容提要

本书系“名医秘技丛书”之一。全书共分6章,以神志病的西医诊疗和中医辨证施治为引导,详细介绍了作者收集、整理的各名家治疗躁狂抑郁、癔症、癫痫、老年痴呆的名医秘验绝技、专家经验良方、常用中成药及食疗妙方。全书内容丰富,实用性强,所选秘验绝技疗效确切,适合中医、中西医结合专科医师及广大相关疾病患者阅读参考。

前言

广大的中医工作者在长期的临床实践中,对各种疑难杂症做了大量的临床研究,总结了许多简洁、有效的治疗药方,散载于国内各中医药期刊中。为了使这些宝贵的经验秘方得以流传得更广,效用于临床,我们特精心编写“名医秘技丛书”,以奉献给临床一线的同仁和受疾病折磨的患者朋友。

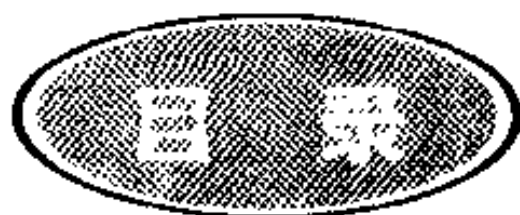
本套丛书编写体例沿用于前,尽量保持一致。编写体例以疾病为纲,以名医专家经验为目,收集杏林诸家经验于一处,配合多种治疗方法,方便临床医师阅读、查找资料,实践于临床。本套丛书在疾病的选择上作了些调整,选择标准为常见病、难治病,尽量把一种疾病的治疗方法整理全面。

中医治病重点在于辨证。各位中医爱好者在引用本书所载的方药时,请一定要在专业医师的指导下使用,以防发生意外。

本书在写作时,得到徐强、王劲中、程文瑾、丁志勋、王文华的支持和帮助,在此向他们致以谢意!并向验方的原作者致以崇高的敬意!

中医中药正在受到世界各国的青睐,中医研究进展很快,文献资料浩如烟海,我们虽然尽了努力,但限于个人经验和水平,书中存在的某些不足或错漏之处,望各位同仁予以批评指正。

编 者



第一章 西医诊疗	1
第一节 躁狂抑郁性精神病.....	1
第二节 癔症.....	4
第三节 癫痫.....	7
第四节 老年痴呆	11
第二章 中医辨证施治	13
第一节 郁病	13
第二节 癲狂病	15
第三节 痫证	18
第三章 名医秘验绝技	21
第一节 癫痫	21
黄明志临床经验	21
关幼波临床经验	22
董廷瑶临床经验	24
金舒白临床经验	26
李鲤临床经验	28
杨杏林临床经验	30
陈鲁临床经验	33
汪受传临床经验 1	35
汪受传临床经验 2	36
吴承玉临床经验	37



王伯岳临床经验	39
谢海洲临床经验	43
杨甲三临床经验	47
张奇文临床经验	48
张鹰临床经验	50
赵建军临床经验	51
王晶辉临床经验	53
朱良春临床经验	60
黄培新临床经验	65
钱荣江临床经验	67
龚文德临床经验	69
杨杏林临床经验	71
周仲瑛临床经验	73
熊杰临床经验	74
张介安临床经验	75
杨康德临床经验	77
第二节 精神异常	79
常蔚临床经验	79
丁德正临床经验	80
邹锦山临床经验	83
郝万山临床经验	85
胡珍香临床经验	86
陈家建临床经验	88
包祖晓临床经验	90
李树年临床经验	91
梁静玉临床经验	93
孙忠人临床经验	95



李书林临床经验	96
汪履秋临床经验	97
张铁英临床经验	98
张志浩临床经验	100
谢衡辉临床经验	101
胡海燕临床经验	103
周正保临床经验	105
程士德临床经验	107
第三节 老年痴呆	109
李鲤临床经验	109
李玉梅临床经验	111
吕继端临床经验	113
孙明韵临床经验	114
袁德培临床经验	116
夏翔临床经验	118
郑绍周临床经验	120
朱良春临床经验	121
张琪临床经验	123
颜乾麟临床经验	124
第四章 专家经验良方	127
第一节 癫痫	127
一、内服方	127
方1 自拟止痫汤(王红石)	127
方2 自拟抗痫汤(金淑梅、王有胜)	128
方3 自拟宁神镇癫汤(黄金铭)	128
方4 自拟镇痫止眩汤(贺新玉)	129
方5 自拟抗痫灵(崔红海)	130



方 6	自拟止痫丸(雍履平)	130
方 7	自拟活血止癫汤(付万仓)	131
方 8	追风定痫丸(张晓红、相彩枝)	132
方 9	自拟五虫散加味(琚坚)	132
方 10	定痫丸(黄勇坚、李园园)	133
方 11	愈痫散(李素香、吴振刚、冯黎)	133
方 12	血府逐瘀汤(陈发青)	134
方 13	抑痫散(张学斌、滕利萍)	135
方 14	自拟方(单人骧)	136
方 15	熄风涤痰汤(方婷娜、方思远)	137
方 16	熄风化痰汤(陈四清)	137
方 17	通络熄风汤(徐荣谦)	138
方 18	桃红四物汤加味(陈园桃)	139
方 19	天麻钩藤煎(吴东泽)	140
方 20	疏肝理脾汤(肖旭腾、钟建岳)	141
方 21	三虫抗痫汤(张宽智、张宗芹)	142
方 22	宁痫散(杨宗正)	143
方 23	宁痫汤(张丽萍)	143
方 24	祛癫汤(李新纯、李庆、唐武)	144
方 25	平肝熄风汤(常冬梅、杨絮、甄薇)	145
方 26	痫痛宁(王喜聪)	146
方 27	克痫灵(李志彬)	147
方 28	抗痫散(逯建存、王忠良、汤明双)	148
方 29	抗痫方(时滢、苏莉、李青)	149
方 30	健脑豁痰汤(熊杰、马融、张果忠)	149
方 31	加味通窍活血汤(刘炳志、于仙福)	150
方 32	建中汤加生铁落饮(周丽华、刘传珍)	151



方 33	加减桃仁承气汤(王伟、粟明兰)	152
方 34	加减癫狂梦醒汤(叶德梁)	152
方 35	葛根僵蚕汤(陈忠伟)	153
方 36	抗痫面饼(庄振裕)	154
方 37	风引汤(王冉、陈霞)	155
方 38	定痫证散(陈丕烈)	156
方 39	定痫复健丸(相修平、孙世山)	157
方 40	癫痫消散(付江)	158
方 41	涤痰活血汤(叶莲、吕向阳)	158
方 42	柴胡加龙骨牡蛎汤(闫炳远)	159
二、综合疗法		160
方 1	埋线治疗癫痫 1(陶俊艳、刘玉伟)	160
方 2	针刺治疗运动性癫痫(任永霞)	161
方 3	脏腑点穴治疗小儿癫痫(赵鉴秋)	162
方 4	穴位埋植法治疗癫痫(李东海)	163
方 5	羊肠线穴位埋藏治疗癫痫 2(张俊卿)	164
方 6	穴位埋藏中药浸泡羊肠线治疗癫痫 3(鞠录升、 李秀梅)	165
方 7	穴位埋线法治疗癫痫 4(冷钰玲、潘清蓉等) ...	165
方 8	穴位埋线治疗癫痫 5(杨晓华)	167
方 9	头皮针治疗癫痫(李效芳、马志刚)	167
方 10	针挑治疗癫痫(戴海玉、卫海英、沈丽娟)	168
方 11	挑刺加埋线治疗癫痫(欧广升)	169
方 12	深刺鸠尾穴治疗癫痫(王天才、任建梅等) ...	170
方 13	背三针治疗癫痫(王进才)	171
第二节 瘰疬		172
一、内服方		172



方 1	通天打地汤(王之良)	172
方 2	自拟鲮鱼理咽汤(祁付有)	173
方 3	自拟苇茎厚朴汤(周文荣)	173
方 4	自拟开胸降逆汤(郭杰、郭山鹰)	174
方 5	自拟化核丸(贾云)	175
方 6	益母草合剂加味(陶荣芬)	176
方 7	旋覆代赭汤加味 1(吴成光)	177
方 8	旋降汤(张锐、孙中兰)	177
方 9	四七汤加味(来志华、侯建钢、范广岩)	178
方 10	逍遥散加减 1(张香芝)	179
方 11	逍遥散加味 2(戴春禧)	179
方 12	顺气导痰汤加减(徐新荣)	180
方 13	启膈散(李静)	181
方 14	三梗汤(曹建英、姜文英)	181
方 15	利咽疏郁汤(高建民)	182
方 16	六君子汤加味(方志扬)	183
方 17	加味逍遥散合二子二石汤(何忠俊)	184
方 18	加味逍遥散(戴春禧)	185
方 19	加味柴胡疏肝散(师会)	185
方 20	加味四七汤(王学民、张乐明)	186
方 21	和胃涤痰汤(徐海虹、童林根)	187
方 22	痰麦饮合苦酒汤(朱安龙)	188
方 23	加减麦门冬汤(周仕亮)	189
方 24	甘麦大枣汤(全世建)	190
方 25	防己地黄汤(张国亭、杨晓)	190
方 26	半夏厚朴汤加减 1(李明)	191
方 27	半夏厚朴汤加味 2(张文才)	192



方 28	半夏厚朴汤 1(黄韶芳).....	193
方 29	半夏厚朴汤 2(刘红、王泽山)	194
方 30	百合地黄汤加味(胡辰生、景秋芝)	195
二、综合疗法		195
方 1	针挑治疗梅核气(李红新、孙清军)	195
方 2	针药并用治疗梅核气(张继红、赵藏朵) ...	196
方 3	针药并用治疗癔症(刘芳琴)	197
方 4	针刺治疗癔症 1(白晓英、周志杰、谢治椽)	198
方 5	针电结合治疗癔症性构语障碍(王奎、 张化利)	200
方 6	针灸治疗梅核气(寿黎生)	201
方 7	针刺治疗癔症性躯体障碍(刘茜、孙玲) ...	202
方 8	针刺治疗癔症性失音 1(沈小雷)	203
方 9	针刺治疗癔症性失语 2(付万仓)	203
方 10	针刺治疗癔症性失语 3(朱俊珂)	205
方 11	针刺治疗癔症 2(张玥)	206
方 12	针刺治疗癔症性失明症(张晓玲、郑健男) ...	206
方 13	针刺治疗癔症性失语 4(何继勇、何小翠)	207
方 14	针刺治疗癔症性失语 5(王家田、王家琪)	208
方 15	针刺治疗癔症性失音 6(李丽英)	209
方 16	针刺治疗癔症性黑矇症(孙彦奇、徐珂民) ...	210
方 17	针刺配合电兴奋治疗癔症性失音(费立凤) ...	210
方 18	针刺配合甘麦大枣汤治疗癔症失语(许克洋、 高先德)	211
方 19	针刺人中治疗癔症性晕厥(李乐敬、 朱守莲)	212
方 20	针刺少商、隐白治疗癔症瘫(王长海)	213



方 21	针刺内关和天突穴治疗梅核气(白侠) …	214
方 22	针刺内关治疗癔瘫(周晓燕、闫凤祥、 李耀辉) ……………	215
方 23	针刺并语言暗示治疗癔症性失音(李桂松、 袁明华、许玲) ……………	215
方 24	睛明为主穴针刺治疗癔症(霍明霞) ……	216
方 25	耳针与体针配合治疗梅核气(纪金国、 刘希云) ……………	217
方 26	耳压疗法治疗癔症(韩海生) ……………	218
方 27	电针治疗癔症 1(王社平、谢瑞山、牛文) ……	219
方 28	电针治疗癔症 2(章慧英、王云彩) ……	219
方 29	催眠针法治疗癔症(刘安丰、薛迪中等) ……	220
方 30	采用远道刺法治疗梅核气(赵明智、 陈兴文) ……………	221
第三节	老年痴呆症……………	222
方 1	补肾开窍汤(彭萌等) ……………	222
方 2	补髓益智汤(朱玲、孙丽君) ……………	222
方 3	呆聪汤(阎乐法、刘百波等) ……………	223
方 4	二仙四物汤(李社瑄) ……………	224
方 5	地黄饮子加减(华刚) ……………	225
方 6	还神转呆汤(党安琪) ……………	225
方 7	益肾化痰汤(郝美华) ……………	226
第五章	中成药……………	228
方 1	牛黄宁宫片 ……………	228
方 2	医痫丸 ……………	228
方 3	天麻钩藤颗粒 ……………	228
方 4	全天麻胶囊 ……………	229



方 5	越鞠丸	229
方 6	二十五味珊瑚丸	229
方 7	如意珍宝丸	229
方 8	安宫牛黄丸(胶囊)	230
方 9	安脑丸	230
方 10	局方至宝丸	231
方 11	礞石滚痰丸	231
方 12	苏合香丸	231
方 13	十香返生丸	232
方 14	安神补心丸(胶囊)	232
方 15	朱砂安神丸	232
方 16	十香定痛丸	233
方 17	逍遥丸(颗粒)	233
方 18	平肝舒络丸	233
第六章	食疗妙方	235
第一节	茶饮	235
方 1	郁菖茶	235
方 2	商陆汁	235
方 3	菊楂决明饮	235
方 4	五宝茶汤	236
方 5	核桃仁山楂茶	236
方 6	冬虫夏草茶	236
方 7	灵芝茶	237
方 8	二子延年茶	237
方 9	何首乌杜仲茶	237
方 10	五子健脑茶	238
方 11	西洋参茶	238



方 12	人参茶	239
方 13	黄精茯苓茶	239
方 14	龙眼红枣茶	239
方 15	十仙茶	240
方 16	牛乳红茶	240
方 17	石菖蒲醒脑茶	240
方 18	苍术川芎三宝茶	241
方 19	山楂荷叶茶	241
方 20	五宝普洱茶	241
方 21	丹参茶	242
方 22	川芎茶	242
方 23	鸡血藤茶	242
方 24	三花活血茶	243
方 25	柴龙牡蛎汤	243
方 26	清心泻狂汤	243
方 27	补气养心振神汤	244
方 28	酸枣仁汤	244
方 29	解郁汤	244
第二节	粥汤	245
方 1	龙眼莲子粥	245
方 2	十全大补汤	245
方 3	豆麦汤	246
方 4	益精养神灵芝汤	246
方 5	补肾健脑乌龟汤	246
方 6	益寿鸽蛋汤	247
方 7	酸枣仁粥	247
方 8	小米龙眼粥	247



方 9	洗心汤	247
方 10	小麦粥	248
方 11	山茱萸生地黄春鸡汤	248
方 12	牡丹干贝蒺藜汤	248
方 13	豆浆莴笋汤	249

第一章 西医诊疗

第一节 躁狂抑郁性精神病

躁狂抑郁性精神病,简称躁郁症。是一组以情感过度高涨或低落为基本特征的精神病。这种精神病是发作性的,有时为躁狂状态,有时为抑郁状态。有时由一种状态转为另一种状态,也有时在整个患病期间只重复地出现抑郁状态或躁狂状态。在2次发作之间的静息期,患者的精神活动完全正常。虽然可多次发病,但精神活动并不出现衰退。这种病常常是青年时期开始的,一般预后较好。

一、病 因

巴甫洛夫在关于躁狂抑郁性精神病病因的论述中强调指出外界影响的意义,并认为精神病的病理生理基础就是抑制与兴奋过程之间的正常关系的破坏。在躁狂期,兴奋过程对抑制过程占优势;而在抑郁期,则抑制过程对兴奋过程占优势。

近年来,在遗传和生化方面取得了有意义的探索。

(一)遗传因素

国内外有关本病家族史、孪生子等研究资料,提示本病的发生与遗传有关。家族遗传倾向较为明显。



(二)生化代谢异常

近年来,集中于对脑内神经递质的研究。其假设来源于精神药理学研究资料:①耗竭脑内 5-HT(5-羟色胺)和 NE(去甲肾上腺素)的药物,如利舍平、四苯嗪等可导致抑郁;②使脑内受体部位上述生物胺活性增高的药物,如三环类抗抑郁药、单胺氧化酶抑制药具有抗抑郁作用。

临床研究发现:某些抑郁症患者尿内 NE 的代谢产物 MHPG 排出较对照组明显要低,说明患者中枢 NE 活性低下;而躁狂期则相对增高,说明躁狂和抑郁与脑内 NE 的活性高、低有关。另有资料指出,抑郁症患者尸检发现脑内 5-HT 以及其代谢产物 5-HIAA 的含量较正常人均低。临床研究发现不论躁狂或抑郁期,患者脑脊液、尿内 5-HT 的代谢产物 5-HIAA 均较对照组显著要低。提示脑内 5-HT 更新率低可能与躁狂和抑郁二者均有关。根据这些资料,出现了多种胺代谢障碍的病因新假说:5-羟色胺(5-HT)缺乏是其共同生化基础;而 NE 系统活动过度出现躁狂,活动不足则出现抑郁。

(三)神经内分泌功能失调

抑郁症患者有神经内分泌失调,反映下丘脑-垂体-肾上腺系统功能异常。抑郁症患者血浆皮质激素和 17 羟皮质类固醇的含量增高,服地塞米松后,未见应有的抑制现象。此外,有其他神经内分泌功能异常。如促甲状腺素对于促甲状腺释放因子的反应迟缓或消失。推测这些神经内分泌变化,可能与间脑、下丘脑生物胺功能障碍有关。间脑、特别是下丘脑功能障碍,可能与躁郁症发生有关。躁郁症患者病理解剖未发现任何脑器质性形态学改变。

(四)精神因素和躯体因素

躁狂症和抑郁症在首次发病前约半数以上有精神因素。



少数患者在躯体因素影响下(产后、传染病等)诱发起病。

二、临床表现

(一)躁狂症

典型症状有 3 个:情绪高涨,思维活动兴奋,运动兴奋,称躁狂三联症。患者在躁狂期情绪非常高涨、欣快,并有思想快动症。由于思想快动,患者不停息地嚷叫,放声歌唱,写诗作文章。患者非常好动,精力旺盛,片刻不宁,终日无事忙乱,令人厌烦;任何一件事他都干涉,而且他的观察力也增强,一切小毛病他都能发现出来。这种兴奋状态可能日夜持续。患者一昼夜仅睡 2~4 小时,有时终日不睡。患者时刻运动,但患者的体重减轻得很少。患者对自己常常不能正确估计,认为自己非常能干无所不能。

躯体方面,患者常面色红润、目光炯炯有神,因为说话过多而致舌干唇燥。因持久兴奋不顾饮食,不顾睡眠,并有血压升高、脉搏加快、瞳孔扩大、便秘等交感神经活动亢进的症状。

(二)抑郁症

在抑郁状态时可见到精神病理变化:情绪低落,思维活动抑制,运动抑制,称抑郁三联症。在抑郁期患者的状态和躁狂期完全相反:情绪低落,患者感到极大苦闷,任何方法也解脱不了痛苦的忧郁,坚持企图自杀(自杀妄想)。到夜里也不安静,患者不能入睡。由于思维迟慢,回答问题拖延、简单。患者终日抑郁不安地坐着,愁眉苦脸,垂头丧气,或者整天躺着。动作受极大的抑制:患者不能起床、穿衣、洗脸和自己吃饭。情绪低落是由于患者认为自己有罪而产生的(自责妄想)。所以,他认为别人用不着关心他,拒绝饮食。在抑郁期躯体方面



有很大的变化:食欲不振、胃肠收缩功能减弱,因此,常发生顽固性便秘,体重减轻。

此外,还有一种不典型的抑郁症,主要表现为周期性的各种躯体不适,如头痛、头晕、胸闷、气短、恶心、呕吐、无力等,而抑郁情绪相对不明显。躯体检查无阳性所见。对症治疗效果不佳,抗抑郁药物治疗往往收到意外效果。这类患者长期在内科就诊,有隐匿性抑郁之称。

自杀企图和行为是抑郁症患者最危险的症状。可以出现在症状严重期,但也可出现在早期或好转时。患者往往事先有周密计划,行动隐蔽,以逃避医护人员的注意。应提高警惕。

三、治疗常规

(一)药物治疗

躁狂发作者常用氯丙嗪、碳酸锂等,抑郁状态常用多塞平、阿米替林等治疗。锂盐除用于本症治疗外,对预防复发有良好效果。适用于慢性、反复发作的病例。据报道,锂盐对躁狂及抑郁状态都有预防复发作用。

(二)电抽搐疗法

对严重、急性躁狂,在严格掌握适应证的情况下,可合并使用电抽搐疗法。

第二节 癔症

癔症俗称歇斯底里,系由于明显的心理因素,如生活事件、内心冲突或者强烈的情绪体验、暗示或者自我暗示等作用于易感个体引起的一组疾病。本病女性多见。



一、临床表现

本病起病于青春期,发病率较高,症状复杂多样,可以出现类似任何疾病症状的表现,总的可分为分离性障碍和转换性障碍两大类,二种症状可分别出现,也可同时出现。

1. 癔症性躯体障碍即转换性障碍,是指被压抑的反应转换为某种躯体障碍。癔症性痉挛发作最常见,患者突然跌倒,手足乱动,伴过度换气或屏气,四肢痉挛甚至角弓反张,呼之不应,问之不答;癔症性瘫痪可为单瘫、截瘫、偏瘫等;其他还有失音、失明、耳聋、步态障碍、震颤等。但通过体格检查及实验室检查,却不符合躯体疾病的一般规律,以及生理、解剖、病理学规律。

2. 癔症性精神障碍即分离性障碍,是指过去的经历与现实环境、自我身份的完全或部分不相符合。最常见的为情感暴发,患者在精神刺激后急起又哭又笑、大吵大闹,以夸张表演的姿态,诉说其委屈和不快,带有情感发泄的特征。有些精神运动性兴奋颇为剧烈,如扯头发、撕衣服、捶胸顿足、打滚,可持续数小时之久,发作时可有意识范围的狭窄。①癔症性遗忘:患者突然遗忘某阶段与某事有联系的经历;②癔症性漫游:受刺激后外出无目的地游逛,数小时或数天后突然清醒,不知自己怎么来到了异地;③癔症性昏睡:突然昏倒,呼之不应、推之不动,但可见眼睑眨动;④癔症性假性痴呆:突然出现痴呆样症状,记忆丧失,回答错误,对简单的问题给予近似的回答,而对复杂的事物却能够应付;⑤双重人格:是身份的突然改变,同一患者有2种身份,表现不同的口气、行为和态度。



二、诊断和鉴别诊断

对癔症的诊断应十分慎重。诊断要点如下：①有心理、社会因素作为诱因；②大多具有癔症性性格特征；③临床表现复杂多变，但无解剖和病理基础；④本人对症状不太重视，发作时有防御反射；⑤暗示及自我暗示与症状的发生、加重、消失有关；⑥体检及实验室检查均为阴性。

本病须与癫痫和心因性精神障碍相鉴别，特别是癔症性痉挛发作应与癫痫大发作相鉴别。

三、治疗常规

1. 心理治疗癔症的病情是功能性的，因此，心理治疗占有重要的地位。

(1)心理疗法：目的在于引导患者正确对待致病的精神因素，认识疾病的性质，帮助患者分析个性缺陷和改变的途径、方法。

(2)暗示疗法：是治疗癔症的经典方法。可用言语暗示治疗失听、失明、失语和瘫痪等症状。用简短明确的言语说明检查结果，告诉患者这是一种短暂的精神功能障碍，在治疗的帮助下，即可完全恢复正常。用药物如葡萄糖酸钙静脉注射或用感应电刺激患病部位，同时配合按摩或被动运动，并用语言鼓励患者运用其功能，可获得较好的效果。也可使用药物催眠暗示治疗。

2. 药物治疗癔症性状态、精神病状态或痉挛发作时可用氯丙嗪或地西洋使患者入睡，有些患者醒后症状可消失。

3. 物理治疗用针刺或电兴奋治疗癔症性瘫痪、耳聋、失明、失音或肢体抽动等功能障碍，可获得良好的效果。但须配合语



言暗示。也可用较强的针刺或电刺激治疗癔症性木僵状态。

一般预后良好。多数初发者可迅速恢复。少数患者反复发作,病程超过1年,甚至多年。社会功能可明显受损。

第三节 癲 癇

癲癇是一组临床综合征,其特征为反复发作的大脑神经元异常放电,导致暂时性大脑功能失调。临床表现为运动、感觉、意识、行为和自主神经等障碍。癲癇具有发作性、异常放电、脑部疾病3个特点。癲癇的年发病率为50/10万~70/10万,其年患病率为5‰。

一、病 因

癲癇不是一个独立的疾病,而是一组疾病或者综合征,其病因非常复杂。按病因癲癇分为原发性癲癇和继发性癲癇两大类,前者患者脑部无可以解释症状的结构异常或代谢异常,而和遗传因素有较密切的关系。后者是由于多种脑部病损和代谢障碍所致,常见于先天性疾病、脑外伤、颅内感染、中毒性脑病、颅内肿瘤、脑血管病、营养代谢疾病、脑变性病等。此外癲癇发作常与年龄、内分泌改变、睡眠不足、劳累、声乐刺激等有关。发病机制多认为当某种因素使得某群神经元的形态、结构发生改变或内外生化环境发生巨大变化时,就有可能破坏神经细胞间的相互反馈调节关系,而产生异常放电。

二、临 床 表 现

(一)临床表现

癲癇发作的表现非常复杂,根据1981年国际抗癲癇联盟



分类及我国(1985)第一届全国癫痫学术会议草案,对癫痫分类如下。

1. 部分发作

(1)单纯部分发作:不伴意识障碍。部分运动发作表现为口角、手指或足趾的阵挛抽搐,按大脑皮质运动区的分布顺序缓慢地扩展到整个肢体或同侧偏身的抽搐称杰克逊(Jackson)癫痫。其他的部分感觉、部分自主神经发作较少见。

(2)复杂部分发作:以发作性的精神症状或特殊感觉症状,随后出现意识障碍、自动症和遗忘症为特征,又称精神运动性发作,病变多在颞叶,故又称颞叶癫痫。患者往往先瞪目不动,然后做一些搓手、解扣、甚至游走等无意识动作,即自动症。

(3)部分发作继发为全面性强直阵挛发作。

2. 全身性发作

(1)失神发作:通常称为小发作,表现短暂的意识障碍,患者静止、瞪目、呼之不应,持续为3~15s,事后无记忆,此为典型失神发作。如意识障碍较轻,发作甚短,<5s即为非典型失神发作。典型者脑电图可见3次/s棘-慢综合征。

(2)强直阵挛发作:又称大发作,以意识丧失和全身抽搐为特征。发作分3期:①强直期,所有骨骼肌呈持续性收缩,肢体强直为10~20s;②阵挛期,全身肌肉间歇性痉挛,持续为30~60s后抽搐突然停止,上2期均表现呼吸停止,瞳孔扩大,对光反应消失,大小便失禁;③惊厥后期,呼吸首先恢复,意识逐渐转清,历时为5~10min,事后无记忆。一次癫痫发作持续30min以上或者大发作在短期内频繁发生,以致发作间歇期意识持续昏迷者,称癫痫持续状态。常伴高热、脱水、酸中毒等。



(3)其他类型:肌阵挛发作表现突然、短暂、快速的肌收缩。脑电图示多棘-慢波、棘-慢或尖-慢波。其他如强直性发作、阵挛性发作、无张力性发作较少见。

3. 未分类的发作以及癫痫综合征

(1)婴儿痉挛症:亦称 West 综合征,常在 4~7 个月发病,男孩多见,表现为突然的屈颈、弯腰。每次数秒钟,常连续发作数次,以睡前、醒后多见。一般于 2~5 岁症状自行消失,但也可转化为其他类型发作。

(2)良性中央回癫痫:常在 3~13 岁发病,有明显遗传倾向,男性多见,表现为口、咽部和一侧面部阵挛,意识清晰,常夜间发作,发作较稀疏。脑电图示对侧中央区高电位。大多 16 岁后可自愈。

(二)诊断与鉴别诊断

癫痫的诊断主要依据发作史及其表现,脑电图检查 30%~50% 的患者可发现异常。动态脑电图和录像脑电图监测可明显提高脑电图诊断阳性率。诊断首先要确定是否为癫痫,因为癫痫易与晕厥、癔症、短暂性脑缺血发作、偏头痛等相混淆。癫痫的特征是反复的癫痫性发作,有意识丧失的佐证,如尿失禁、跌伤等。其次要区分是原发性或继发性癫痫。原发性癫痫常 20 岁以前发病,有家族史,发作多无先兆,发作时间短,无阳性体征,癫痫性放电常对称同步。第三是查明继发性癫痫的病因,须做生化检查以排除代谢性疾病。对于头部疾病,可从病史及发病年龄中查找病因,配合 CT、MRI、SPECT、PET 和脑磁图等检查。

癫痫鉴别诊断包括:

1. 癔症须与强直-阵挛发作鉴别,癔症发作皆在有人在场及情感刺激后。发作时间长,抽搐无规律,瞳孔、角膜反射



无改变,无尿失禁,无舌咬伤等。

2. 晕厥须与失神发作相鉴别,晕厥多有情感刺激或疼痛刺激史,多在脱水、持久站立、排尿、咳嗽时发生。发作时脸色苍白、出冷汗等。

三、治疗常规

1. 药物治疗的原则

(1)根据癫痫发作的类型选择药物:原发性强直-阵挛发作选用苯妥英钠、苯巴比妥或丙戊酸钠;继发性强直-阵挛发作、局限性发作,选用卡马西平、苯妥英钠、苯巴比妥;失神发作,选用丙戊酸钠、乙琥胺、氯硝西泮(氯硝安定);复杂症状部分性发作选用卡马西平、苯妥英钠、扑米酮(扑痫酮)。

(2)剂量与合并用药:药物剂量原则上从小剂量开始,逐渐增至治疗剂量,如有条件可通过药物血浓度的监测来控制药物剂量。当一种药物效果不满意,或为拮抗第一种药物不良反应时,可合并使用第二种药物。理想的剂量既能控制癫痫发作又不产生严重的毒性反应。在撤换和增加药物时必须在3~5d内递减要撤换的药物,同时递增新用第二种药物,突然停药可诱发癫痫持续状态。

(3)用药方法:常每日分数次服,宜在饭后,对于发作多在夜晚和清晨的患者,用药可集中于下午和睡前。持续、规则服用。

(4)治疗的终止:应遵循缓慢和逐渐减量的原则,大发作和单纯部分发作在完全控制2~5年后,失神发作在完全控制6个月后,可缓慢减量至停用,其减量时间不少于6个月至1年,若有复发,则重新给药。

(5)严密观察不良反应并及时处理:常见不良反应为皮



疹、胃肠症状、牙龈增生、毛发增生；亦可有粒细胞缺乏、肝功能损害以及震颤、共济失调等。因此，在用药期间必须定期复查血象或生化检查。

2. 发作时的防护 发作时要防止跌伤、骨折、舌咬伤等，要保持呼吸道通畅。

3. 癫痫持续状态的治疗迅速控制抽搐 首选地西泮(安定)10~20mg，静脉注射，每分钟不超过2mg，半小时可重复1次，抽搐停止后，可用苯巴比妥钠0.1~0.2g肌注，8~12小时1次维持。清醒后口服抗癫痫药。同时注意保持呼吸道通畅、维持酸碱平衡及控制脑水肿等。

第四节 老年痴呆

老年性痴呆是一组起病于老年期的原因不明的慢性进行性精神衰退性疾病。可分为原发性痴呆症和血管性痴呆症，前者又称阿尔茨海默病(AD)，是一种与年龄高度相关的、以进行性认知障碍和记忆力损害为主的中枢神经系统退行性疾病。表现为记忆力、判断力、抽象思维等一般智力的丧失，但视力、运动能力等则不受影响。

老年性痴呆大多数患者起病隐匿，性格改变是最早出现的症状，患者变得特自私、固执、生活懒散，或足不出户，或放荡不羁、暴躁易怒。后期，涉及伦理道德标准的人格也受影响，无羞耻感、责任感，敷衍塞责，冷酷无情，不计后果。智能活动中近事记忆最先受累。记不住人名、地名，经常丢失日常用品，遗忘已允诺的事情。以后可有理解判断、计算等智能活动全面下降，情绪反应幼稚，行为荒诞。后期，日常生活不能自理，大小便均失禁，进食不知饥饱，出门不知归途，发音不



清,词不达意。末期,整日卧床,喃喃自语,精神功能几乎丧失殆尽。在疾病早期,可能因心理代偿反应而出现妄想观念,随着痴呆的日益加重,妄想症状亦逐渐消退。

尽管有关老年性痴呆的研究进展很快,但迄今尚无十分有效的治疗方法。现有的药物治疗基于以下理由:老年性痴呆主要表现为认知和记忆障碍,而认知和记忆障碍的主要解剖基础为海马组织结构的萎缩,功能基础主要为胆碱能神经兴奋传递障碍和中枢神经系统内乙酰胆碱受体变性、神经元数目减少等。目前,采用的比较有特异性的治疗策略是增加中枢胆碱能神经功能,其中胆碱酯酶抑制药效果相对肯定,M受体激动药正在临床试验中。

第二章 中医辨证施治

第一节 郁 病

郁病是由于情志不舒,气机郁滞,脏腑功能失调所引起的一类病证。临床表现主要为心情抑郁,情绪不宁,胁肋胀痛,或易怒善哭,以及咽中如有异物梗阻、失眠等各种复杂症状。现代医学的神经衰弱、癔症、更年期综合征等病证凡表现郁病症状者可参考本篇辨证论治。

【病因病机】

郁病皆由情志所伤,肝气郁结,渐引起五脏气机不和,主要涉及肝、脾、心 3 脏以及气血失调。

1. 郁怒不畅

肝失条达,气失疏泄,致肝气郁结。气滞可致血瘀不行;气郁亦可化火,上扰心神;肝气犯脾,脾失健运,食滞中阻,痰湿中生,从而产生血、热、食、湿、痰郁。

2. 情志不遂

肝郁抑脾,脾虚化源不足,气血乏源,心脾两虚,心气耗伤,营血渐耗,心失所养,心神不安。郁病初病气滞而夹热、夹湿、夹食、夹痰者多属实,久则由气及血,由实转虚。

【诊断要点】



①以忧郁不畅,胸胁胀满疼痛,或易怒易哭,或咽中有异物梗阻为主症,多发生于中青年女性;②病史:患者大多数有忧愁、焦虑、悲哀、恐惧、愤懑等情志内伤的病史,并且郁病病情的反复常与情志因素密切相关;③除外器质性病变,各系统检查和实验诊断正常。

【辨证论治】

1. 实证

(1)肝气郁结

主症:精神抑郁,情绪不宁,善太息,不思饮食,胸胁胀痛,痛无定处,噎气,腹胀,大便失常,女子月经不调。舌苔薄腻,脉弦。

治法:疏肝理气。

方药:柴胡疏肝散。柴胡、芍药、枳实、香附、甘草、川芎。胁肋疼痛,加郁金、青皮以助疏肝解郁之功;噎气频作,加旋覆花、赭石以和胃降逆。

(2)气郁化火

主症:性情急躁易怒,头痛,目赤,耳鸣,口苦而干,胸胁胀满,嘈杂吞酸,大便秘结。舌红,苔黄,脉弦数。

治法:清肝泻火。

方药:丹栀逍遥散合左金丸。牡丹皮、栀子、柴胡、白术、白芍、当归、茯苓、炙甘草、薄荷、煨姜、黄连、吴茱萸。若口苦、苔黄、便秘者,可加大黄、龙胆草以泻火通便。

(3)痰气郁结

主症:精神抑郁,咽中如有梗阻,咳之不出,咽之不下,但不碍饮食,伴见胸中窒闷,或兼胁痛。苔白腻,脉弦滑。

治法:化痰利气解郁。

方药:半夏厚朴汤。半夏、厚朴、紫苏、茯苓、生姜。酌加制香附、枳壳、佛手、旋覆花、赭石等以增强理气开郁、化痰降



逆之效。

2. 虚证

(1) 忧郁伤神

主症：精神恍惚，心神不宁，悲忧善哭，时时欠伸。舌质淡，苔薄白，脉弦细。

治法：养心安神。

方药：甘麦大枣汤。淮小麦、炙甘草。可加栀子、酸枣仁、茯神、合欢花等以加强药力。

(2) 心脾两虚

主症：多思善虑，胆怯心悸，失眠健忘，头晕神疲，面色不华，食欲不振。舌质淡，脉细弱。

治法：健脾养心，益气补血。

方药：归脾汤。人参、白术、黄芪、酸枣仁、茯神、远志、龙眼肉、甘草、当归、木香。可酌加郁金、合欢花之类以开郁安神。

(3) 阴虚火旺

主症：眩晕，心悸，失眠，心烦易怒，或遗精腰酸，妇女则月经不调。舌红，脉弦细而数。

治法：滋阴清热，镇心安神。

方药：滋水清肝饮。生地黄、山茱萸、茯苓、当归身、山药、牡丹皮、泽泻、白芍、柴胡、栀子、酸枣仁。可加入珍珠母、磁石、生铁落等重镇安神；月经不调者，加香附、益母草以理气开郁调经；腰酸，遗精，乏力者，加龟甲、知母、杜仲、牡蛎等以益肾固精。

第二节 癲狂病

癲狂病是指痰蒙心窍所导致的精神错乱、神志失常的疾



病。癫病以沉默痴呆、语无伦次、静而多喜为特征；狂病以喧扰不宁、躁妄打骂、动而多怒为特征。现代医学的精神分裂症、躁狂症、抑郁性精神病，以及部分神经官能症等，均可参照本篇辨证论治。

【病因病机】

1. 情志所伤

凡外来强烈、持久的刺激，超过其耐受限度，如思虑过度、情怀愤郁、意欲不遂等，可导致肝郁气滞，心脾气结，聚津成痰，蒙蔽神机；或惊恐恼怒，肝胆气逆，心火亢盛，煎熬津液成痰，痰火上扰心神，则成为癫证或狂证。

2. 禀赋不足

禀赋不足，耐受性差，遇有情志内伤，则易由于阴阳失调而发病。癫狂的病理因素主要是气、痰、火，而以气郁为主，继而化火生痰，三者互有联系。此外，癫狂日久不愈，痰浊留恋，气病及血，气滞血瘀，凝滞脑气。其病变主要在心、肝、脾 3 脏。在发病上，痰气郁结、神志被蒙为癫；痰火上扰、心神不安为狂，二者可互相转化。如癫证痰气郁而化火，可转化为狂证；狂证日久，郁火宣泄而痰气留结，又往往转为癫证。

【诊断要点】

癫证以沉默痴呆、语无伦次、静而多喜为特征；狂证以喧扰不宁、躁妄打骂、动而多怒为特征。

【鉴别诊断】

癫、狂、痫的鉴别：癫与狂同属精神失常之病证，但癫证以静属阴多喜，狂证以动属阳多怒。痫证平素如常人，发时眩仆倒地，昏不知人，四肢抽搐，口吐涎沫，啼叫有声。

【辨证论治】



1. 癫病

(1) 痰气郁结

主症：癫病初起，精神抑郁，神情淡漠，沉默痴呆，语无伦次或喃喃独语，或悲或泣，妄见妄闻，多疑妄想，不知秽洁，不思饮食。舌苔薄白腻，脉弦细或弦滑。

治法：理气解郁，化痰开窍。

方药：顺气导痰汤加味。半夏、茯苓、陈皮、胆南星、香附、木香、石菖蒲、郁金。痰浊壅盛，胸膈满闷，口多痰涎，形体壮实者，可暂用探吐法。痰郁化热，烦躁不寐，舌苔黄腻，脉滑数，酌加黄连、天竺黄。

(2) 心脾两虚

主症：癫证日久，神思恍惚，心悸易惊，善悲易哭，少寐多梦，四肢困乏，饮食减少，面色少华。舌淡，脉细无力。

治法：健脾养心，益气安神。

方药：养心汤加味。人参、黄芪、甘草、当归、川芎、茯苓、远志、柏子仁、酸枣仁、五味子、丹参、石菖蒲。心气耗伤，营血亏虚，喜悲伤欲哭者，加炙甘草、淮小麦、大枣。

2. 狂病

(1) 痰火上扰

主症：病起急骤，先有性情急躁，头痛失眠，面红目赤，突然狂乱无知，逾垣上屋，哭骂叫号，不避亲疏，或毁物伤人，气力逾常，不食不眠。舌质红绛，苔黄腻，脉弦大滑数。

治法：涤痰清心，泻肝清火。

方药：生铁落饮加味。生铁落、胆南星、贝母、橘红、石菖蒲、远志、茯神、朱砂、天冬、麦冬、玄参、连翘。如阳明热盛，大便秘结，舌苔黄糙，脉实大者，加大黄、玄明粉或芫花。

(2) 火盛伤阴



主症：狂病日久其势渐减，形疲神倦，多言善惊，时而烦躁，形瘦面红，少寐，食少。舌红少苔，脉细数。

治法：滋阴降火，安神定志。

方药：二阴煎加减。生地黄、玄参、麦冬、黄连、木通、淡竹叶、灯心草、生甘草、酸枣仁、茯神、五味子。舌苔黄腻，痰火未平者，加胆南星、竹茹、天竺黄。

第三节 痫 证

痫病(痫证)是由于痰聚气逆、风痰闭阻所导致的一种发作性神志异常的疾病。其特征为发作性精神恍惚，甚则突然仆倒，昏不知人，口吐涎沫，两目上视，四肢抽搐，或口中如作猪羊叫声，移时苏醒，醒后如常人。现代医学中的癫痫大发作，可参照本篇辨证论治。至于癫痫小发作虽表现类型不一，其辨证论治亦需参考本篇内容。

【病因病机】

1. 七情失调，惊恐郁怒，致脏腑气机逆乱，心肝气郁，津聚成痰。一遇诱因，痰随气逆，导致痫证发作。

2. 过食肥甘厚味，脾失健运，水谷精微凝聚成痰，蕴伏于内。一遇劳累过度，或生活起居失于调摄，遂致气机逆乱，触动积痰，而发为痫证。

3. 病后继发某些温病，脑寄生虫病、颅内病变等，脏腑受损，积痰内伏，亦可导致神机失用，发为癫痫。

4. 先天因素指母亲妊娠期间，母体多病，或过服药物，损及胎儿，或突受惊恐，气机逆乱，恐则伤肾，精伤肾亏，以致影响胎儿发育，出生后遂易发生痫证。

【诊断要点】



①发作性精神恍惚,甚则突然仆倒,昏不知人,口吐涎沫,两目上视,四肢抽搐,或口中如作猪羊叫声,移时苏醒,醒后如常人;②可因精神紧张、惊恐、劳累、饮食不节而发作;③辅助检查:脑电图、颅脑CT检查等有助于明确诊断。

【鉴别诊断】

1. 中风:中风仆地口中无声,昏迷持续时间长,醒后常有半身不遂等后遗症。痫证昏仆后口吐涎沫,且有叫吼声,可自行苏醒,有反复发作史。

2. 厥证:气厥实证多因情志郁怒而卒然厥仆,可见口噤握拳,胸闷气塞,而意识可不全丧失,无口吐涎沫、抽搐等痫证发作时的症状特点。

3. 痉证:痉证抽搐多呈持续频作,甚至项强,角弓反张,大都伴有发热。痫证抽搐见于发作时,发后即止。

【辨证论治】

1. 风痰闭阻

主症:发作前常有眩晕、胸闷、乏力等症,亦有无明显先兆者。发则突然昏仆,神志不清,抽搐,口吐涎沫,或口有叫声。舌苔白腻,脉多弦滑。

治法:涤痰熄风,开窍定痫。

方药:定痫丸加减。竹沥、石菖蒲、胆南星、半夏、天麻、全蝎、白僵蚕、琥珀、朱砂、茯神、远志。

2. 痰火内盛

主症:发作时昏仆抽搐吐涎,或有叫吼,平日情绪急躁,心烦失眠,咳痰不爽,口苦而干,便秘。舌红苔黄腻,脉弦滑数。

治法:清肝泻火,化痰开窍。

方药:龙胆泻肝汤合涤痰汤加减。龙胆草、木通、生地黄、半夏、胆南星、枳实、石菖蒲、石决明、钩藤、竹沥、地龙。



3. 心肾阴虚

主症：癫痫发作日久，精神萎靡，头目昏花，面色不华，心悸健忘，腰膝酸软，甚或智力减退，言语欠清。舌质淡，脉细或细滑。

治法：补益心肾，健脾化痰。

方药：大补元煎合六君子汤加减。熟地黄、山药、山茱萸、枸杞子、当归、杜仲、人参、甘草、石菖蒲、远志、木香、砂仁、茯苓、白术、陈皮、半夏。

第三章 名医秘验绝技

第一节 癲 痢

黄明志临床经验

[《河南中医药学刊》]

1. 病因多端,重肝脾及瘀血 小儿“脾常不足”有两种情况:一是相对不足。因小儿在生长发育过程中,营养物质需求量大,而脾胃运化功能尚未健旺,一是小儿由于乳食不知自节,寒暖不能自调,令脾胃运化功能失常,中焦积滞,酿生湿热,聚而为痰。肝常有余易动风,脾常不足易生痰,痰郁日久易生火,风、痰、火三者相搏,舍于心窍,走窜闭阻于经络,癲痢由是而作矣。同时,通过长期临床观察,瘀血也是癲痢发作的一个重要病因。小儿由于出生时窒息或产伤,令颅脑缺氧或形成血肿,头为诸阳之会,因瘀血内阻,血行不畅,则清窍失养,神明逆乱,而发癲痢。

2. 临证制宜,创治痢方药 用验方“痢愈散”治疗肝火偏盛、痰热上扰清窍之痢证,多获良效。后因该方中白马蹄药源缺乏,又自拟“龙虎镇惊散”用于临床,也取得了令人满意的效果。结合外治法,创制了“熄风痢宁药膏”,患者双手涂药或涂



敷双足涌泉穴,使药膏从表皮渗入手厥阴心包和足少阴肾经之穴位,通过经络达于心、脑,收到良好的功效。现将药物组成简介如下:龙虎镇惊散:生龙齿、琥珀、朱砂、白僵蚕、蝉蜕、全蝎、蜈蚣、石菖蒲、天麻、钩藤等。熄风痫宁药膏:安息香、白胡椒、琥珀、苏合香、朱砂、冰片、公丁香、麝香等。

3. 针药并用,重视间歇期治疗 在癫痫发作期,多取风池以疏风醒脑开窍,神门以安神镇惊,丰隆重以祛湿化痰,百会以平肝熄风醒脑,内庭以泄热宁神;在癫痫间歇期,常取鸠尾以和中降逆、清心化痰,膻中以宽胸理气、宁心安神,会阴以清肝热,腰奇为治痫之奇穴,能缓解癫痫的发作。通过长期临床实践,指出治疗癫痫重点在于间歇期治疗。因在间歇期,患儿“肝风未动,脏气尚平,气血畅行”,此时疗痫,药物易于发挥作用,同时使用针灸通经络,调气机,更可起到较好的治疗效果。

治验:罗某,女,6岁。患儿于2岁曾患高热惊厥1次,约半年后出现癫痫大发作,曾在外院诊治,服苯妥英钠无明显疗效。半月前看电视时突然再度发作,四肢抽搐,意识丧失,牙关紧闭,口吐白沫,经掐入中、合谷穴后,约10分钟缓解。急查脑电图可见一棘波及尖波。查舌红、苔黄,脉弦滑。诊为肝风内动、痰火上扰之痫证。治以平肝熄风、清热涤痰理气,投龙虎镇惊散6g,每日3次,配合熄风痫宁药膏外用。2周后未再发作,继服2个月。随访未复发。

关幼波临床经验

[《河北中医》]

治验1:贺某,男,7岁。患者突然仆倒,意识不清,四肢抽搐,以后反复发作,每月发作4~5次,每次持续几十秒钟,发



作时面色苍白,神智不清,四肢抽搐,口角流涎。专科医院诊断为癫痫,服用苯妥英钠、丙戊酸钠等药,未能控制病情,前往关老处就诊。平素精神、睡眠差,乏力,烦躁,易头痛,记忆力减退,纳差,二便调,舌淡红,苔薄白,脉弦细。辨证为肝肾阴虚,风痰阻络。治则:养血柔肝,化痰熄风。方药:当归 10g,白芍 15g,生地黄 15g,何首乌 10g,天竺黄 10g,胆南星 10g,杏仁 10g,橘红 10g,旋覆花 10g,生赭石 10g,夜交藤 30g,钩藤 10g,香附 10g,黄芩 10g,丹参 15g,川芎 10g,全蝎 5g。水煎服,每日 1 剂。上方加减治疗 3 个月,癫痫发作次数明显减少,睡眠改善,精神好转,纳食增加。调理 6 个月,已能上学,正常生活。随访 1 年未复发。

治验 2:晁某,男,16 岁。小时头部外伤史,自幼胆小易受惊吓,性格孤僻,2 年前因惊吓后出现四肢抽动,摇头,眨眼,发作时意识欠清,每次持续几分钟,每日发作 10 多次,平素精神、睡眠差,多梦,烦躁,恐慌感,纳差,大便溏,舌红,苔薄白,脉弦细弱。专科医院做脑电图检查显示异常。诊为癫痫。服用苯巴比妥、地西洋、苯海索等药,发作次数无减少,已休学。辨证为阴血不足,肝风内动。治则:养血安神,平肝熄风。方药:生地黄 15g,白芍 15g,当归 10g,夜交藤 30g,旋覆花 10g,生赭石 10g,佩兰 10g,枸杞子 15g,川芎 10g,香附 10g,木瓜 10g,牛膝 10g,远志 10g,百合 10g,藕节 10g,白豆蔻 6g。水煎服,每日 1 剂。二诊:抽动次数每日减至 8~9 次,程度减轻,睡眠改善,烦躁减轻,仍有乏力,精神不集中,多梦,纳差,舌红,苔白,脉弦细弱。上方加石斛 15g,全蝎 5g,继服。三诊、四诊:抽动次数减少至每日 6~7 次,发作时意识较前清醒,日多在劳累时发作,纳食增加,大便成形,仍有多梦,恐惧,腰酸乏力。上方减白豆蔻,加酸枣仁 10g,石菖蒲 10g,珍珠母



30g,白僵蚕 10g。服药 6 个月后,病情基本稳定,劳累后偶尔有发作,已可上学。

按:癫痫是神经系统的常见病、多发病,反复发作,缠绵难愈。中医药治疗癫痫历史悠久,历代医家多从风、火、痰入手。关老对癫痫的治疗有独特之处,认为其病因病机多为阴血不足,肝风内动,痰湿阻络,蒙闭清窍。治疗上强调滋阴养血,平肝熄风,化痰通络。癫痫有因先天禀赋不足,肝肾亏虚,或体质虽强,但因反复发作,久病致虚。因此,关老强调癫痫的治疗以滋阴养血、调脾柔肝治其本,化痰熄风通络治其标。方以生地黄、当归、白芍养血柔肝;旋覆花、赭石、橘红、杏仁平肝降气化痰;珍珠母、石决明、钩藤镇肝熄风;全蝎、川芎、木瓜活血通络。气阴两虚加何首乌、枸杞子以益气养阴;有外伤史加藕节、香附、丹参行气活血;痰涎壅盛加半夏、瓜蒌;病程日久,肝肾阴虚加石斛、麦冬养阴清热。体现了扶正祛邪、标本同治的指导思想,临床取得较好疗效。

董廷瑶临床经验

[《上海中医药》]

治验 1: 张某, 女性, 3 岁。初诊: 幼儿形体较胖, 自去年 11 月起, 渐发惊搐。每月发作, 轻则神志恍惚, 双目直视, 表情呆滞; 重则昏不知人, 四肢抽搐。脑电图提示有异常癫痫波, 诊断为特发性癫痫。临诊: 面黄少华, 喉中痰鸣, 咳嗽吐涎, 食欲不振, 舌苔白腻, 脉弦滑。辨证属脾虚生痰, 痰浊阻络, 蒙蔽心窍。治拟涤痰逐涎, 宣窍熄风。处方: 钩藤 6g, 石菖蒲 3g, 天竺黄 6g, 陈胆南星 45g, 竹节白附子 45g, 陈皮 3g, 龙齿(先煎) 12g, 川贝母 3g, 白僵蚕 6g, 竹沥半夏 9g。5 剂。二诊: 药后痫停, 痰鸣减少, 少咳夜烦, 胃纳欠馨, 舌苔渐化。



前法奏效,续以原法。上方去川贝母、白僵蚕加远志 6g。7 剂。三诊:痫病未发,痰声尚有,胃纳有增,夜寐安定,小便短数,舌苔薄净。痫发虽停,痰浊未净,兹拟调扶。处方:太子参 9g,远志 6g,朱砂拌茯苓 9g,天竺黄 6g,川贝母 3g,陈胆南星 24g,竹节白附子 45g,陈皮 3g,竹沥半夏 9g,龙齿(先煎)15g。7 剂。四诊:痰声渐少,痫证未发,纳和舌净。改用扶元健脾、养心安神之剂而收全功。随访证情日见好转。复查脑电图正常。痫疾从此未复发。

按:董老强调医者治病,首要明理识病,辨证求因,方能推理论病,推理论治。是例据其临床表现形体丰腴,喉中痰鸣,咳嗽吐涎,舌苔白腻,辨为痰湿之体,其因为痰。《幼科释速》谓:“然诸痫证,莫不有痰。”故初诊从涤痰逐涎、宣窍熄风论治,首选涤痰汤攻逐痰涎。药后痰浊下泄,痫证即停,可谓药证合拍,再守原法而巩固。《明医指掌·痰证》谓“痰生于脾胃,宜实脾燥湿,使脾胃调和,饮食运化而痰自不生,此治其本也”。后遂用扶脾培本之剂,以杜痰之源,俾痰浊涤除,痫不复作矣。

治验 2:陈某,女性,13 岁。初诊,患儿 3 岁时曾患“早期流行性乙型脑炎”。上个月起因用脑过度,突发抽搐。发作时神识不清,肌肉搐动,两目凝视。每日发作 3~4 次,近来发作次数达 5~6 次。脑电图提示诊为癫痫。平时表情淡漠,心烦心悸,形体消瘦,夜寐不安,舌红苔少,两脉细数。此乃思虑伤脾,蕴湿生痰,营阴暗耗,神不守舍所致。急需清心安神,滋阴熄风。处方:小生地黄 15g,麦冬 9g,远志 6g,琥珀 24g,朱砂拌茯苓 9g,龙齿(先煎)15g,玄参 9g,石菖蒲 45g,炙甘草 3g,磁石(先煎)24g。7 剂。二诊:形神转活,癫痫未发,神志安宁,纳谷亦和。前方尚合,已见效机,再以原法,守方续服 14



剂。三诊：形神正常，病情稳定，夜睡渐安，心烦减少，月经初潮 3 天。调扶尚合，再以养血安神、调补气血为主。处方：生地黄、熟地黄各 15g，当归 6g，太子参 6g，炙甘草 3g，龙齿（先煎）24g，白芍 9g，远志 6g，朱砂拌茯苓 9g，琥珀 24g。10 剂。四诊：气血已和，形神正常。续以原法出入。原方去琥珀。10 剂。五诊：气血已复，形体渐丰，痼病未发，病情稳定。再以守方出入，连服 10 余剂后痊愈。随访半年，患儿形神正常，未再复发。

按：董老常告诫曰：治病既要知其常，又要知其变。即所谓“因病知变，因变知治”。该患儿 3 岁时曾患过早期流行性乙型脑炎，说明禀质素薄，元神受损。本次抽搐起于思虑过度，故之治疗尚须知变。首投以清心安神、滋阴熄风，选用增液汤为主方，辅以宁心安神与之。药后营阴得复，心神安宁，形神转活，痼证未发。继之，经水来潮，改用八珍汤化裁，佐以养神通志之品，以调补气血，充养精气而告愈。

金舒白临床经验

〔《云南中医中药杂志》〕

癫痫主要与痰气郁结、心脾两虚等有关。金老针灸治疗本病多宗明代高武“善用针者，从阳到阴，从阴到阳”之说，以调整阴阳为施治大法，按不同类型的患者及其临床表现，辨证分型，定经配穴，随症出入。在督脉上选取主要穴从阳引阴，并根据患者情志变化，辅以心包经内关或间使穴，或再在其他有关经络的“五输”、“原”、“络”穴中各取一二配穴，以协调阴阳，补虚泻实。由于癫痫属阴、多虚，主于痰和气，故其治则宜以理气化痰、宁心安神为主，现分型介绍如下。

1. 痰气郁结 主症：精神抑郁，沉默少语，或喃喃自语，



行为被动,生活懒散,对答迟缓,不知秽洁,少思饮食,苔多白腻,脉象弦滑。取穴:神聪(轻刺)、风府、内关、丰隆,痴呆加通里。刺法:神聪穴在百会穴前后左右各1寸,齐向百会穴透刺,少留针;风府穴直刺0.7~1.0寸,徐进疾出;内关穴多捻转。

本症由于心脾痰气郁结所致,故取癫痫之效穴神聪穴以醒脑开窍,扬清黜浊;“阳脉之海”督脉之风府从阳脉引泄阴邪,以调气通阳,宁神疏经;心包之内关穴以宁心宽胸,理气化痰;胃经之络丰隆穴和胃化痰,运脾利湿。痴呆加通里穴以定志安神解郁。

2. 心脾两虚 主症:神志恍惚,妄见妄闻,悲伤欲哭,心悸易惊,少语懒动,不思饮食,舌淡苔薄,脉象细弱。治则:健脾养心,益气安神,针刺手法以捻转补法为主。取穴:风府、印堂透心区(轻刺)、内关、三阴交,幻视加睛明,幻听加听宫,幻嗅加迎香。刺法:印堂穴向下透心区,宜轻宜浅。本症由于心脾气血两虚所致,故取督脉之风府穴以通阳利气,镇惊宁神;癫痫效穴印堂穴透心区以调气醒神脑,宁心安神;心包之内关穴以养心和胃,理气疏郁;足三阴之会三阴交穴以健脾疏肝,益气理血。幻视加睛明穴以定睛宁神;幻听加听宫穴以聪耳通窍安神;幻嗅加迎香穴以通鼻利窍散风。

3. 阴虚火旺 主症:忧郁焦虑,烦躁不宁,多疑易惊,行为紊乱,夜寐不安,大便干结,舌红苔黄,脉象滑数。治则:滋阴解郁,化痰安神。针刺手法以捻转补法为主。取穴:印堂透心区、间使、三阴交,不寐加神门,体虚取内关(或间使穴和内关穴交替应用)。本症由于心肝阴虚炼痰所致,故取癫痫效穴印堂穴透心区以安神醒脑,宁心解郁;心包之经间使穴以清心除烦,祛痰镇惊;足三阴之会三阴交穴以健脾疏肝,滋阴宁神;



不寐加神门穴以养心安神益阴；体虚取内关穴以养心和胃益气。

李鲤临床经验

[《河南中医》]

1. 痰伏、气逆、风动为基本病机 李老认为，癫痫源于痰、火、积、瘀、虫、惊，而尤以痰邪作祟最为重要。五志过极化火，炼液成痰；或饮食不节，损伤脾胃，失于健运，聚湿生痰。积痰内伏，或随气逆，或随火炎，或随风动，迷塞心窍，扰乱神明而致痫证。正如《医学纲目·癫痫》说：“癫痫者，痰邪逆上也。”故有“无痰不作痫”之说。痰浊聚散无常，故致痫发无定时。又认为人体内诸气运行有其正常规律，卒受惊恐，气机逆乱，致逆气上巅犯脑，迷闭脑窍，引动肝风，故出现卒暴昏仆、四肢抽搐症状，而发癫痫。如清·陈梦雷《古今图书集成医部全录·小儿惊痫门》所说：“癫痫者，逆气之所生也，故因气上逆而发癫痫。”此外，情志所伤，或操劳过度，耗伤肝肾之阴，水不涵木，阴虚阳亢，阳化风动；或五志过极化火，火热炽盛，燔灼肝经，阳热亢盛则化而为风，痫证始作。

2. 下气消痰，熄风清热为重要治则 痫证之作，因痰伏、气逆、风动所致，故痰消、气顺、风熄则发作自止。治疗本病的关键当以下气消痰、熄风清热为要。主张癫痫发作时先行针刺申柱、长强，若频繁发作则于醒后急予汤药调治，着重治标，处于发作间期可配制丸药常服，以防痫症再发。若症见昏仆，不醒人事，四肢抽搐，息粗痰鸣，口吐涎沫，胸闷，心烦不宁，口苦咽干，便秘溲黄，舌红，苔黄腻，脉滑数者，属痰火上扰，蒙蔽心神，予自拟“痫饼”。药物：煅青礞石 40g，海浮石 24g，生熟牵牛子各 40g，焦建曲 120g，半夏 20g，胆南星 20g，全蝎 40g，



蜈蚣 20 条,郁金 60g,烘干后研末加白面 1 000g,烙成 21 张薄饼,每晨食 1 个。也可研末后装胶囊,每服 12 粒,每日 3 次。若发作频繁者,上方减量后投煎剂。本方煅青礞石下气消痰、平肝镇惊为君;海浮石与青礞石相须为用,可增清肺化痰之力;半夏、胆南星燥湿化痰、清热熄风共为臣药;蜈蚣熄风止痉,郁金“凉心热,散肝郁”,行气活血共为佐药。生熟牵牛子导泻下行,荡涤痰浊使从肠腑下泻,以宣通清窍;神曲入脾胃经,善消食和胃而化痰浊,重用之既可疏解生痰之源,又兼顾护胃气之意为佐。诸药相合,共奏豁痰下气、熄风镇痉之功。

若症见牙关紧闭,二目上视,四肢抽搐有力,面赤身热,眩晕,或头痛而胀,大便秘结,舌质红绛,脉弦滑者;属风火亢盛,上犯脑窍,治以重镇潜阳,清热泻火,佐以涤痰定痫之法。方以《金匱要略》中“风引汤”加减。药用:牡蛎 18g,龙骨 18g,赤石脂 18g,白石脂 12g,紫石英 20g,石膏 18g,寒水石 12g,滑石 12g,大黄 10g,干姜 9g,桂枝 9g,胆南星 10g,地龙 20g,全蝎 12g,郁金 10g,甘草 6g。方中牡蛎、龙骨、赤石脂、白石脂、紫石英重镇以潜肝阳之亢;石膏、寒水石、滑石咸寒以泻火;妙在大黄苦寒泻下,使热盛风动得以平熄;反佐干姜、桂枝之温以制赭石之咸寒,胆南星、地龙、全蝎清化热痰,熄风止痉,甘草调和诸药。

治验 1:张某,男,15 岁。患癫痫病已 6 年,发无定时,数天至半月发作 1 次,甚则昼夜发病 1~2 次。发病时突然昏仆,口中如羊叫声,抽搐吐沫,息粗痰鸣,目睛上视,牙关紧闭,每次发作为 2~3 分钟,渐醒如常人,仅感倦怠乏力。平素口苦咽干,便秘溲黄,靠西药维持,但仍时有发作。脉滑数,舌质红,苔黄腻。证属痰火上扰,蒙蔽心神。治法:豁痰下气,熄风镇痉。方药:煅青礞石 24g,海浮石 20g,生熟牵牛子各 10g,



焦建曲 12g,半夏 12g,胆南星 10g,全蝎 12g,蜈蚣 2 条,郁金 12g。水煎服,每日 1 剂。进药 12 剂,仅发病 1 次,症状轻微,停汤剂续服“痫饼”3 个月,服药后 3 个月仅发病 1 次,同时逐渐减量停服苯妥英钠。后又服验方“痫饼”约半年未发病,停药观察。随访 2 年一切正常。

治验 2:贾某,男,64 岁。因患脑梗死后而癫痫发作。数日一发,发作时左侧肢体抽搐,持续数分钟至半小时,面赤身热,眩晕,大便秘结。舌质暗红,苔黄,脉象弦滑。辨证:风火相煽,瘀阻脉络。治法:平肝潜阳,清热熄风,佐以活血通络。方药:风引汤化裁:生石膏 24g,寒水石 20g,紫石英 20g,赤石脂 18g,滑石粉 15g,桂枝 6g,大黄 10g,干姜 6g,生龙骨 24g,生牡蛎 24g,丹参 20g,天麻 12g,全蝎 15g,地龙 20g。水煎服,每日 1 剂。进药 15 剂未发病。停汤剂,将上方按比例研末装胶囊,每次 6 粒,每日 3 次,续服 3 个月,服药期间仅发作 1 次,程度轻微,后随访 1 年未见异常。

杨杏林临床经验

[《中医文献杂志》]

辛热开破法属于祛痰法的范畴,是根据古方五生丸的临床应用而总结提出的一种治疗癫痫的方法。本法应用辛味性温、通经走窜的药物,通闭开窍,消涤顽痰,达到治疗癫痫的目的。

1. 祛痰法治疗癫痫的源流 痰为津气所聚,凝着既久,裹结日深,即成胶固难拔之势。癫痫患者久发难愈,缠绵不止的病理基础,正是此胶固于心胸脑络之间的“顽痰”所致。诚如喻嘉言所言:“浊痰溢于上窍,久久不散,结为窠囊……生长则易,剥落则难”(《医门法律·痰饮论》)。由于癫痫因痰邪而



起,故治病必先治痰。祛痰法是治疗癫痫始终一贯的法则,治疗时多以涤痰、行痰、豁痰为大法。然而,痰邪为病往往在病机和证候上较为复杂,多数情况下,痰邪与风、火、气、瘀、虚等相互搏结为病,故用祛痰法治疗癫痫常与疏风、清热、泻火、化痰、理气、健脾等治法配合应用。

2. 辛热开破法的临床应用 痰为阴邪,性质黏腻而胶着,本不易消除。对于深遏潜伏、黏腻胶着的痫痰,在治疗时若仅用一般的化痰之品,则较难动其毫末而取得满意疗效。《内经》说:“甚者折之,结者散之,留者攻之”,痫痰既胶腻痼着,就需用破涤力劲、开导推动之药物,以驱实邪之积聚,辛热开破法即为此目的而设。所谓“辛热开破”就是选用味辛性温的药物,如乌头、半夏、天南星、附子、白附子、石菖蒲、干姜等,以振奋阳气,推动气化,起到开气机之壅闭、捣沉痼之胶结、破痰邪之积聚、促顽痰之消散的作用。这种治法在汉代就有所见,《中藏经》中治风痫,用天南星为末,姜汁糊丸,以人参石菖蒲汤送服。宋元之后此法则日益倡行,如《圣济总录·卷十五》载有五生丸,用于姜、乌头、附子、半夏、大豆等治疗痫疾。《杨氏家藏方》用天南星、半夏、附子、白附子、天麻、白矾、朱砂等,治疗头目眩晕、风痰、头眩臂痛等症。《和剂局方》中有三生饮,由生天南星、生附子、木香、生川乌等组成,治疗痰厥气逆,以及中风口眼喎斜等症。《证治准绳·类方》用川乌、附子、天南星、半夏、干姜、生姜等治疗风痫有痰者。现代应用如《实用中医内科学》治疗阴痫,法以温阳除痰、顺气定痫,用五生丸以二陈汤送服。

在临床应用时常配伍蜈蚣、白僵蚕、全蝎等虫类药,熄风平肝,搜剔经络之风邪。丹参、川芎等血分药化瘀通经,疏通脑络;枳壳、柴胡、八月札等行气消痰;白芍、当归等养血柔筋。



若有郁火者,加用黄芩、栀子;抽搐频作,肝风明显者,加生龙骨、生牡蛎、羚羊角粉;症见脾气虚弱者,加党参、茯苓;有肾气不足者,加桑寄生、杜仲。临床中可根据患者的发作情况,使用汤剂或丸剂。大抵发作期给予汤剂煎服;休止期可制成丸剂服用。

此法既善开破散结,又能祛风止痉,标本兼顾,休作两宜,从而促使顽痰消散,癫痫停止发作,故能作为主要治法,用于各类癫痫发作和癫痫的各个阶段,贯穿治疗的始终。但在临床实际中还须根据癫痫患者的具体病机证候和不同病理属性,辨证运用,才能取得好的临床疗效。

治验 1:夏某,男。患癫痫 6 年余,无家族史,11 岁始发癫痫,长期服苯妥英钠、苯巴比妥、卡马西平等药,尚能控制。近来发作渐频繁,每月 2~3 次,发则昏仆,肢体抽搐,牙关紧闭,双目斜视,口有涎沫,持续约数分钟。苏醒后感头痛头沉、胸闷肢软,已影响学习。大便 2 日一行,解而不爽。脑电图检查显示:痫性放电,诊见舌质淡红,舌苔白色微腻,脉来细数带滑。证属风痰阻络,蒙蔽清窍,治以辛热破痰,通络止痫。处方:桂枝 10g,姜半夏 10g,天南星 12g,白僵蚕 10g,白芍 12g,石菖蒲 12g,丹参 15g,生龙骨、生牡蛎(先煎)各 30g,制川乌 6g(先下),枳壳 10g,蜈蚣 1 条,黄芩 10g,钩藤 15g。水煎服,每日 1 剂。原服西药继续服用,并嘱注意休息,避免感冒。连服 3 个月,发作次数明显减少,发作时间和症状亦明显减轻。加减治疗 2 年余,癫痫发作基本控制,改予:制川乌、制半夏、天南星、白附子、白芍、蜈蚣、丹参、黑大豆、生姜,按照一定比例制成水丸,每日 2 次,每次 5g。再连续服用 2 年,癫痫已不再发作,脑电图检查已转为大致正常,原用西药已停药。按:本例为原发性癫痫大发作,已有 6 年病程,来诊时处于发作



期。中医诊断属痰邪壅阻,挟风上扰,因其病久,痰邪必成巢窠,瘀阻脑络,故以辛热开破,攻逐结聚之痰,开通瘀塞,取得疗效。发作休止期,给予丸药维持。

治验 2:祝某,女,12岁。患者自9岁起经常发作腹部疼痛,时间10余分钟到1~2小时不等。开始以为是胃病或虫痛,但服药无效。某西医院专家门诊考虑为腹型癫痫,经脑电图检查而确诊。因患者家长不愿服用西药,前来就诊。刻下腹痛约2~3周发作1次,痛在上中腹部,痛发时拒按,有气上冲之感,伴有恶心,不欲饮食。大便2~3日一行。近来情绪不宁,学习成绩有所退步。诊见舌质淡红,舌苔薄白,脉稍弦滑。辨证为痰气阻闭,肠胃气逆,心脾不和。治以开破消痰,利气降逆,宁心健脾,佐以通络。给予制川乌、白附子、天南星、半夏、白芍、蜈蚣、丹参、黑大豆、生姜等药制成片剂(癫痫二号片),每服5片,每日2次。同时服煎剂:党参12g,石菖蒲30g,郁金9g,枳实12g,槟榔9g,生龙骨、生牡蛎(先煎)各30g,木香6g,延胡索9g,五灵脂9g,白芍24g,八月札10g,朱茯苓9g,炙甘草6g,乌药9g,半夏9g。水煎,每日1剂。以上治疗2个月后,腹痛发作已明显减少。续经加减服药1年余,腹痛未再发作,复查脑电图转为正常。停服水煎中药,以癫痫二号片继续维持治疗。按:本例为腹型癫痫,是癫痫发作中的特殊类型。根据辨证与辨病相结合的原则,以辛热开破治疗癫痫,以理气通降治疗腹部疼痛,标本相兼,相得益彰。

陈鲁临床经验

[《陕西中医》]

1. 小儿癫痫病机多责之于脾 由于小儿生理上有“脾常不足”的特点,加之饮食尚不知自节,嗜食甘甜厚味、煎烤、油



腻之品,极易损伤脾胃,脾受克伐,功能失调,运化失常,水液失于输布,则聚湿蕴痰,酿成癫痫发病的内因。若再遇惊恐、食滞、风邪、外伤等外因作用,易于内外合邪,引起阴阳失衡,气机失调,血行逆乱,以致阳升风动,痰闭经络,上扰清阳,闭塞清窍,精明之府失于神主,阴阳一时不得顺接而致昏仆、抽搐。所以说小儿癫痫主要病机为顽痰内伏。痰是造成痫证的中心环节,而脾虚不能运化其津液,又是痰产生的主要根源,痫由痰致,痰自脾生,脾虚痰伏,乃是小儿癫痫的主要病理基础。正因痰浊聚散、阻塞经络清窍无常,故而癫痫症状时作时止,病势时轻时重。无论表现为何种类型,均具有“昏晕一时,即醒如常”的特征,此特征是除痰邪以外的任何病邪所不具备的。正如《医学纲目》中载:“痫者,痰邪上逆也……痰邪上逆,则头中气乱,头中气乱,则脉道闭塞,孔窍不通”。

2. 临证治疗重在健脾化痰 小儿癫痫的发生由于顽痰内伏,而痰之所生多由脾虚之故。发作期痰扰风动,心神失主,休止期痰浊内伏,不能自消。基于以上原因,临证中应治病求本,从脾论治,辨别标本虚实,初期发作多以标实为主,风盛痰壅,闭阻心窍,阻塞经络为主要病机,治以豁痰开窍、熄风镇惊为主。久病反复发作,必伤正气,气血耗伤,治宜健脾化痰、养心益肾为主,佐祛风定癫之品,以达标本兼顾、控制发作的目的。在休止期,亦应积极治疗,健脾化痰,补益心肾,调补气血。总之,健脾化痰法应贯穿治疗始终。方药常先二陈汤化痰应用,再配伍柔肝达木之白芍、钩藤、木香等药,使脾土得以肝木的疏泄而促运化,并据风、惊、食、瘀血的偏盛加减治疗。风盛痰壅常加用郁金、天竺黄、竹沥;痰火壅盛可加用黄芩、青礞石等药。同时治疗又要注意健脾燥湿,以治痰源,如用党参、白术、茯苓、薏苡仁等药。实象重者,健脾涤痰、宁心



安神、镇惊熄风三组药物同用，脉象虚、肝肾亏损者，常用补肾地黄丸合化痰开窍之石菖蒲、远志、益智仁等药。在整个治疗过程中应考虑到小儿癫痫乃为“本虚标实，痰气上逆”这一特点，应在治标之时不忘治本，健脾扶正以生痰之源。

汪受传临床经验 1

〔《贵阳中医学院学报》〕

1. 发作期豁痰定痫急救治标 一般认为，癫痫的发病与风、惊、痰有密切的关系。汪受传教授认为痰是导致癫痫最根本的因素，是其病机的关键所在。在本病的发作期应急投豁痰之剂定痫以救其急，此乃治标之法。由于患儿禀赋各异，诱因不同，病机演变也各有差异，故在临床实践中根据患儿的不同临床表现，在豁痰定痫的基础上，或配以平肝熄风、镇惊定心之品，或配以降火泄热、导滞通腑、通气降逆之剂，往往可使病情得以有效控制。常用药物有全蝎、蜈蚣、白僵蚕、地龙、蝉蜕、羚羊角、牡蛎等动物类药物以及灵磁石、赭石、青礞石、朱砂、琥珀、石决明、龙骨等矿物类药物。汪受传教授认为，动物类药物一般偏重于止痉熄风，矿物类药物大多偏重于安神涤痰，二者联合使用，再配以草木化痰之品，可共收豁痰定痫之功，能救急治标而使癫痫发作迅速得以控制进入休止期。

2. 休止期化痰断痫缓图治本 在癫痫发作的休止期，痰浊内伏，不能自消，因而成为本病反复发作的宿因。有鉴于此，汪教授认为，脾虚是导致癫痫反复发作、缠绵难愈的病机枢纽。因而在休止期治疗时，主要以健脾化痰立法，以使脾运康健，新痰难生而宿痰得化，终致痫断不复；同时还常根据患儿具体情况，与补血养心、滋养肝肾、平肝降火等法联用，以求纠正已虚之偏，致收全功。由于小儿癫痫病程迁延，缠绵难



愈,极易反复,因而患儿一般需要较长时间服药,其组方选药必须以平和为要,寒温不可过于偏执。基于以上观点,他在癫痫休止期的治疗中一般以植物药为主组方,如石菖蒲、郁金、钩藤、天麻、天竺黄、浙贝母、胆南星、陈皮、半夏、云茯苓等,认为这类药物一般都有较强的化痰之力,而且大部兼有健脾、平肝、安神之功,同时又没有虫类及金石药物克伐伤正之虞,可以在休止期长期服用,以求化痰断痫,缓图治本。

3. 多剂型灵活运用长期服药 虽然癫痫一病病因多端,病机演变复杂,临床往往有许多不同的表现,实际上发作期和休止期也只能大体而论,临床很难截然分割,主张“治疗癫痫应以化痰法贯穿始终”,“方药、药量及服法相对稳定,多种剂型相互配合,规律服药,坚持长期治疗”的用药原则。临证在癫痫频繁发作期间,一般选散剂与汤剂并进,取汤剂迅速起效、散剂药专力猛,以期豁痰定痫而达到迅速控制发作的目的;当病情逐渐控制后,多单用汤剂内服,选其配伍灵活,豁痰化痰并进以求巩固疗效;病至休止期则改用浓缩糖浆剂长期使用,择其服用方便,扶正补虚、化痰断痫,守方缓图,求得彻底根治。

汪受传临床经验 2

[《中国农村医学》]

癫痫为儿科顽症之一,在临床用动物药治疗,收到了良好的效果,介绍如下。

1. 辨证用药机制 针对癫痫的病理特点,发作期当以豁痰熄风为主,缓解期当以化痰定风为主,兼以潜阳、镇惊,作为本病的治疗原则。

癫痫用药范围较广,常用药如:植物药石菖蒲、远志、竹



沥、半夏、陈皮、天南星、枳实、伏苓等，多属化痰之品；矿物药朱砂、磁石、赭石、青礞石、琥珀等，多具安神之功；动物药多灵动性猛，能平熄肝风、搜剔邪风，驱风定痫之功力比草木金石之类更胜一筹。动物药中有取虫体而用者，如全蝎、蜈蚣熄风止痉性烈，并能解毒；白僵蚕、地龙祛风解痉、兼化痰热；乌梢蛇、白花蛇搜风通经舒络、可逐顽风。有取动物尖角，如羚羊角、山羊角功擅平肝熄风；动物胆汁，如熊胆、猪胆能清热止痉；动物皮壳，如蝉蜕、蛇蜕长于祛风定惊；动物结石，如牛黄、马宝能豁痰熄风；动物化石，如龙骨、龙齿功专潜阳镇惊；动物贝壳，如牡蛎、石决明、珍珠母、紫贝齿性能凉肝镇肝等，皆可供辨证选用。

2. 药以配伍功效 动物药治疗小儿痫证历史悠久，且常与植物药、矿物药联用。临床应用时，发作期痰涎壅盛配伍胆南星、枳实、鲜竹沥、青礞石、玄明粉等涤痰降气；肝火上亢配伍龙胆草、黄芩、赭石等清泄肝火；抽掣频作配伍钩藤、天麻、防风等熄风止痉；心神不明配伍朱砂（以之拌钩藤、茯神、连翘、灯心草，或以少量入散剂）、琥珀、磁石等镇心安神；瘀阻脑络配伍丹参、三七、琥珀等化瘀通络。动物药中部分为温燥之品，应用时又常配用白芍、当归、生地黄、甘草等养阴柔肝。

吴承玉临床经验

[《南京中医药大学学报》]

1. 明辨病位，详审病性 癫痫之形成，大多由于七情失调，先天因素，脑部外伤，饮食不节，劳累过度，或患它病之后，造成脏腑失调，痰浊阻滞，气机逆乱，风阳内动所致。因此，癫痫病位主要有心、肝、脾、肾、脑；病性主要有风、火、痰、虚、瘀。



癫痫无论是因实致病或因虚而致病,病程迁延者多为虚实夹杂。吴师指出:癫痫病情复杂,变化多端,证型各异,临证之际,切不可受某些证型的拘束,更不可以病套证;可根据痫位与病性组合的原则,灵活确定各证型。在辨清病位病性要素的基础之上,选用豁痰开窍、熄风止痉、清热泻火、镇惊定痫、活血化瘀、益气健脾、补益肝肾、养心安神等,或侧重一法,或多法并用,综合治理,方能获效。

2. 精选药物,注重配伍 用药如用兵,临证务必明晰药物的升降沉浮和性味归经之理。吴师根据病情需要,精选药物,注重药物之间的区别。“心主神明”,癫痫辨证处方,常加用安神之品,如酸枣仁、远志、合欢皮、龙骨等。认为四者虽皆能安神定志,然机制各异,酸枣仁养血安神;远志豁痰安神;合欢皮解郁安神;龙骨镇静安神。由于癫痫的病位涉及脑,故常选用一些能透过大脑屏障的药物,如天麻、川芎、地龙等。补气药常选黄芪、黄精、白术等,补而不膩。吴师选用药物扬其长避其短,注重药物之间配伍。癫痫发作,以熄风为要务,虫类药多灵动性猛,能平熄肝风、搜剔邪风,驱风定痫之功力比草木、金石之类更胜一筹。然而虫类药中多有小毒,应用时应严格控制使用时间和剂量;认为小儿脏腑娇嫩,形体未充,尤当慎用。且常配用白芍、当归、地黄、天冬、麦冬等养阴柔肝之品。对久病体弱者,使用活血化瘀及理气药的同时,常配以养血益气之品。

3. 顾护脾胃,扶助正气 吴师认为,癫痫的病机从根本上说,属本虚标实,因虚而生痰、生瘀、生风,故用补虚法治疗本病属治本之图。脾胃位居中州,通上联下,是升降的枢纽。脾主升清,胃主降浊,升降失常,则清浊不分,运化失职,痰浊内生,痰蒙清窍,是为痰痫。病生脾胃,或中气不足,或阴火上



冲,则脑神失充,阴火蒙蔽清窍,元神运转失机,亦可发为痫证。此“阴火”之成,由于中气不足,清气下陷,水谷不化,变生湿浊,流于肾间,以致下焦之气不化,郁而生热;而下焦阴火上冲,中焦脾胃亦首当其冲,且脾胃与肾,后天之精与先天之精互根互用。元气不足,精气亏虚,髓海不足,脑神失荣,癫痫则更易生矣,故健脾化湿为治疗癫痫重要的原则之一。此外,癫痫病的治疗时间往往较长,方中加用顾护脾胃之品往往可防止因长期服药可能引起的胃脘不适;方中顾护脾胃之品还能促进其他药物的吸收,以提高疗效。

4. 活用经方,师古不泥 《伤寒杂病论》方药,既是治疗伤寒热病及疑难杂症的妙方,也是治疗癫痫的良药。《伤寒论》113方中,临床加减常用于癫痫治疗的汤方有17首之多,且有很好的疗效。吴师认为,经方的选用,务必切中病机。痰浊蒙蔽心窍,窜走经络所致者,选用柴胡加龙骨牡蛎汤;瘀血所致者,选用桃核承气汤。寒邪上犯厥阴巅顶所致者,选用吴茱萸汤;气机紊乱上逆,血热妄行,肝风内动所致者,选用柴胡桂枝汤、桂枝龙骨牡蛎汤、甘麦大枣汤三方合用,以养阴平肝,熄风定痫;发作时有胸腹部挛急,两胁苦满,涌吐涎沫者,选用柴胡桂枝汤。吴师还指出,临证之际,病情复杂,常常需要对经方加减,包括药味、剂量的增减。

王伯岳临床经验

[《甘肃中医学院学报》]

小儿癫痫的发病原因很多,除先天因素外,与难产、跌仆损伤、急慢惊风史,以及暴受惊吓、乳食内伤等因素都有密切关系。先师王伯岳在长期临床实践中,总结出一套治疗小儿癫痫的方法,介绍如下。



1. 小儿癫痫多发、惊痫癫狂须辨清 小儿癫痫属于中医儿科惊痫类,惊和痫是有区别的。惊是惊风,一般分为急惊风、慢惊风和慢脾风。急惊风发病急暴,多系外感热病所致,故抽搐常伴有发热,或其他外感热病证候,多无反复发作史;慢惊风及慢脾风则多为缓慢发病,不伴发热,而有明显虚实或其他慢性病证。痫是癫痫,严格讲,中医所说的癫和痫也有区别。癫,常与“狂”相并称。《内经》曰:“重阴者癫,重阳者狂。”《临证指南医案》更明确地将癫、狂、痫三者予以辨别,谓:“言乎现症,狂则少卧不饥,妄言妄笑,甚则上屋逾垣,其候多躁而常醒;癫则或歌或哭,如醉如痴,甚至不知秽洁,其候多静而常昏;痫则发作无时,卒然昏仆,筋脉瘛瘲,口中作声,后人因其声似,分马痫、牛痫、猪痫、羊痫、鸡痫五名,其候经时而必止。”这一鉴别诊断可以说是非常符合临床实际的。

由此可见,癫痫与惊风,从其病因病机、临床表现到治疗方法都是有所区别的。王老结合临床,将二者的区别归纳为以下八个方面:①癫痫发病突然,惊风发病暴急。②癫痫间歇发作,惊风持续发作。③癫痫不伴发热,惊风伴有发热或高热。④癫痫昏迷时间短暂,醒后即正常;惊风昏迷时间亦短,但醒后多烦躁不安。⑤癫痫抽搐较轻较缓,惊风抽搐较重较急。⑥癫痫发作,喉间多作异声;惊风发作,喉间仅作痰鸣。⑦癫痫发病时多口吐泡沫,惊风发病时只是喉间痰壅。⑧癫痫发病时面青气不促,惊风发病时面赤气粗。

综上所述,根据癫痫和惊风在发病特点和证候表现上的不同,临证时并不难作出鉴别。但是,由于小儿癫痫发病多较突然,且具有昏迷、抽搐、痰壅等表现,往往容易当或惊风治疗;又由于其醒后即恢复如常人,因此家长多不经意,直至反复发作,乃至病势加剧,则治之难矣。所以,先师一再强调,即



使对于一般小发作的癫痫患儿,也必须进行详细的检查和诊断,并给予及时合理的治疗,否则,将会贻误病机。

2. 癫痫之生不离风火痰食、疗痫之法应调心肝脾肾 所谓惊痫、风痫、食痫,是以病因而论,也即是由于惊恐、风邪、过食可引起癫痫。所谓阴痫、阳痫,是以病情的轻重久暂而论,如一般只是间歇地发作,属于阳痫,如经久不愈,反复发作,加之四肢逆冷,形体瘦弱,则属于阴痫。关于小儿癫痫的治法,先师指出,鲁伯嗣以五脏分别命名,《医宗金鉴·幼科心法》除惊、风、食、阴阳而外,又另列一瘦痫,但实际上都是以各脏的偏胜及其证候的表现而言,在临床上,仍然应按照“阴阳二证,别而治之”的原则进行治疗。

先师根据其临床经验,认为在治疗上应着重制止昏仆和抽搐。昏仆和抽搐产生的主要原因是由于肝热心火,炼液成痰,火升痰壅,气血不顺。痰阻清窍,神识不清,则出现昏仆;肝失条达,肝风内动,则出现抽搐。所以其治疗应以清肝定搐、清心开窍为主。清肝,在于清肝经之热,而达到熄风定搐的目的,故清肝必须降火,佐以养血,以使血和而风灭。清心,在于泻心经之火,而达到安神开窍的目的,故清心必须豁痰,佐以顺气,以使气顺而神安。对于癫痫经常发作,历久不愈,或脾胃素虚,先天不足者,虽应考虑补虚,但在发搐时,仍应本“急则治标,缓则治本”的原则,先治搐,待病势缓解后,再行温补脾胃或滋养肝肾,以固本培元。

3. 临证习用千金龙胆汤、温胆汤

(1)治疗小儿癫痫,先师习用千金龙胆汤加减治疗小发作,无其他兼证,而症见突然昏倒,面色红紫,手足抽搐,口吐涎沫,须臾即醒,一如常人,平时眠食正常,二便无异,脉象平和者。《千金方》龙胆汤原方为龙胆草、钩藤、柴胡、黄芩、桔



梗、赤芍、茯苓、甘草、蛭螂、大黄。“治婴儿出腹，血脉盛实，寒热温壮，四肢惊掣，发热大吐者，……并诸惊痫，方悉主之。”其中龙胆草、钩藤、柴胡、黄芩、赤芍可清泻肝热，茯苓、桔梗渗湿祛痰，大黄、蛭螂祛瘀通下。本方虽能清肝祛痰，但其平肝定搐、豁痰开窍之力终嫌不足，故先师每于临床随症加减，以原方去大黄、蛭螂，加天麻、地龙，以增强平肝定搐之力，加胆南星、远志，以助祛痰开窍之功，组成治病基本方：龙胆草 9g，钩藤 6g，天麻 6g，柴胡 6g，黄芩 6g，赤芍 6g，胆南星 6g，远志 6g，地龙 6g，桔梗 6g，甘草 3g。随症加减：痰多、便干，加青礞石 9g，熟大黄 6g；痰多，头痛，加天竺黄 6g，野菊花 9g；纳差、腹胀，加炒神曲 9g，枳实 6g；热重、烦躁，加连翘 9g，栀子 9g。

(2)若癫痫小发作，而发作又比较频繁，症见突然昏倒，面色或青或白，手足抽搐，口吐涎沫，须臾即醒，醒后头昏，痰多，饮食时好时坏，睡眠不安，脉象弦数，舌苔白滑者，先师则习用千金温胆汤加味治之。《千金方》温胆汤，即二陈汤加枳实、竹茹。该方的适应范围比较广泛，它主治心胆虚怯，气郁生痰，或短气乏力，自汗，或热呕吐苦，痰气上逆，虚烦惊悸不眠等症。二陈汤本为治一切痰证之主方，加竹茹清化热痰，枳实降逆下气，则温胆汤行气豁痰的作用更强。因为清肝定搐、豁痰开窍是治疗小儿癫痫之常法，所以，先师临证习用本方为主。但是，这个方子在定搐熄风方面的力量不足，故而先师每与《证治准绳》“钩藤饮”合方化裁。

钩藤饮原方由钩藤、防风、人参、蝉蜕、麻黄、白僵蚕、天麻、蝎尾、川芎、甘草、麝香组成，主治小儿脾胃气虚，吐利虚风，卒然惊悸等证，其作用在于熄风止惊，但与泻肝清胆的方药配合，用于治疗小儿癫痫，甚为合拍。二方化裁后基本方如下：半夏 6g，陈皮 6g，茯苓 9g，枳实 6g，竹茹 9g，酸枣仁



9g,钩藤 6g,天麻 6g,地龙 6g,桑枝 9g,石菖蒲 6g,甘草 3g。随症加减:抽搐较甚,加白僵蚕 9g,可去竹茹、枳实;若汗多,气短,加太子参 9g,生龙骨 9g,生牡蛎 9g,去枳实;大便干燥,加瓜蒌 9g。以上两方为治疗小儿癫痫通用方,通过实践较为有效。

(3)对于癫痫日久不愈,经常发作,发作时四肢逆冷,发作后四肢无力,面黄肌瘦,懒进饮食,睡眠不安,证属素体脾胃虚弱,肝气偏旺者,先师每用钩藤饮加减,以益气补脾,养血柔肝。药如:太子参 9g,钩藤 6g,天麻 6g,茯苓 9g,石菖蒲 6g,远志 6g,生白芍 9g,生牡蛎 9g,生麦芽 9g,炙甘草 3g。随症加减:若四肢逆冷较甚、自汗者,加制附子 6g,桂枝 6g;烦躁、睡眠不安较明显者,加莲子肉 9g,夜交藤 9g;大便稀溏者,加陈皮 6g,干姜 6g;手足掣动、酸软无力者,加牛膝 9g,桑寄生 9g。待癫痫缓解后,病情稳定,不再经常发作,治疗则着重补益气血,增强体质,以期巩固疗效,促使完全恢复。针对这一阶段病情,先师习用养营汤加减:党参 9g,白术 9g,茯苓 9g,当归 6g,白芍 9g,半夏 6g,橘红 6g,天麻 6g,桑寄生 9g,炙甘草 9g。

谢海洲临床经验

〔《中医药通报》〕

谢老认为“癫痫一证,治疗颇为棘手,每治必中其的者,可谓少矣。”因此临证强调探明病机,精究方药,方可避免癫痫再发,是为关要。故根据病证的表现形式采用合理的治疗是本病的关键所在,如在发作期,应以祛邪为主,针对风、火、痰、热、瘀之不同而分别用药,间歇期则应以扶正为主,调理人之气血阴阳。



1. 发作期

(1)肝风痰浊有热：痫丸。方用竹沥、胆南星清热祛痰；半夏、陈皮、贝母、茯苓、麦冬降逆祛痰，兼防伤阴；丹参、石菖蒲开瘀利窍；全蝎、白僵蚕、天麻熄风止痉；朱砂、琥珀、远志、茯神、灯心草镇惊宁神；甘草调和诸药。若久病频发正气不足者，加人参以补元气；大便秘结者，加大黄以泻热通便，或用礞石滚痰丸。

(2)痰火内盛：龙胆泻肝汤合涤痰汤加减。方用龙胆草、栀子、黄芩、木通、生地黄等泻肝清热；半夏、橘红、胆南星、石菖蒲化痰开窍。可适量加入石决明、钩藤、竹沥、地龙等以平肝潜阳。

(3)寒痰壅盛：五生丸合二陈汤加减。方用胆南星、半夏、白附子辛温豁痰；川乌辛温散寒；黑豆补肾利湿；二陈汤健脾祛痰，共奏温阳除痰、理气定痫之功。

(4)瘀血阻脑：通窍活血汤合涤痰汤加减。方以通窍活血汤活血祛瘀；涤痰汤祛痰开窍。头痛加细辛；瘀血甚加水蛭、三七；气虚加党参、黄芪；血虚加丹参、紫河车。本型病程较长，常伴有正气不足之证，故除汤剂外，还可配制为散剂、丸剂以便于长期服用。

(5)阴阳不交：桂枝汤加味。方用桂枝、白芍调和阴阳；生姜、甘草、大枣益气补中。加地龙、石菖蒲、胆南星、天竺黄祛痰开窍；远志、茯苓宁神定志；痰多加竹沥水冲服。本法亦可用于过用涤痰剂而致气血亏虚、痫证频发者。

(6)经血不调：桃红四物汤加味。方用桃仁、红花、川芎活血调经；熟地黄、白芍、当归益气扶正；加地龙、石菖蒲开窍祛痰；郁金、香附理气行滞；龙骨、牡蛎潜阳平肝。若月经不调，少腹冷痛加干姜、肉桂；气短乏力加人参、黄芪。此型治疗要



抓好时机服药，一般多在痛证发作前数日服药；如经期发作痛证，则于经前 5 日服 3~5 剂，经后服数剂四物汤以调养，连续治疗数次方可有效。

2. 休止期

(1)脾虚痰盛：四君子汤加味。方用人参、白术、茯苓、甘草健脾益气；陈皮、半夏化痰降逆。若痰多便秘加瓜蒌、胆南星；便溏加山药、白扁豆、苍术；呕逆加生姜、旋覆花；痰多色黄，苔黄腻则改用温胆汤。

(2)肝郁化火：丹栀逍遥散。方用牡丹皮、栀子清肝泻火；柴胡疏肝理气；白芍柔肝理血；当归养血活血；白术、茯苓、甘草健脾益气。若肝火偏盛则加龙胆草、黄芩；大便秘结加大黄；痰多加胆南星、石菖蒲；头晕加石决明、天麻、怀牛膝。

(3)肝肾阴虚：一贯煎合六味地黄丸加减。方用熟地黄、枸杞子、山茱萸、生地黄、当归、麦冬、沙参补肝肾之阴，养阴降火；川楝子舒肝理气；牡丹皮、泽泻清肝肾虚火；山药、茯苓益气健脾助生化之源。肾阴亏甚者加鹿角胶、龟甲胶、阿胶以填髓益阴；肝阴不足，肝阳上亢者加石决明、龙骨、牡蛎；便秘加肉苁蓉、火麻仁以润肠通便。

(4)心脾两虚：归脾汤加减。方用人参、黄芪、白术、甘草、生姜、大枣甘温补脾益气；当归、龙眼肉、茯神、酸枣仁补血养肝；远志宁心定志；木香醒脾理气，共奏补益气血之功。

3. 吐法 此外，对于因风痰壅盛或肝火痰热所致痛证而身强体壮者，根据“因其高而越之”之法，因势利导将痰涎从口中呕出。方药可用三圣散，药用防风、瓜蒂各 6g，藜芦 3g，共为粗末，用温开水 250ml 冲服，先服半量，停片刻，待有恶心感后，用筷子或手指探吐，吐出食物及痰涎后，再服剩下的半量，令再吐之，以吐出大量的痰涎为好。吐后休息片刻，饮稀



米粥,以护胃气。此法不可过用,当痰涎吐出后仍有痰者,服二陈汤以健脾化痰。

4. 配伍精当、善用药对 谢老组方用药十分重视中药的配伍,常利用两味药的相互依赖、相互制约、相互作用以增强疗效,并在长期的临床实践中形成了一些固定的药物配伍模式。其常用于治疗癫痫的药对约有 10 对,如琥珀配朱砂、牛黄配羚羊角、玳瑁配珍珠、石菖蒲配郁金、郁金配白矾、熊胆配狗宝、白僵蚕配蝉蜕、白僵蚕配地龙、白僵蚕配全蝎、全蝎配蜈蚣。谢老认为琥珀与朱砂均有镇惊安神的作用,琥珀兼能祛心痰,朱砂兼能降心火,二药相配镇惊安神的作用更强,多用于心火较旺的癫痫患者;石菖蒲配郁金:石菖蒲辛温,开窍豁痰,醒神健脑,郁金苦寒,行气祛痰,清心解郁,石菖蒲以祛痰开窍为主,郁金以行气祛痰为要,二药伍用,一气一血,一温一寒,相互促进,豁痰行气,宣痹止痛,相得益彰,常用于风、火、痰、瘀共存的癫痫;郁金配白矾:郁金既入气分,又走血分,以行气解郁、凉血散瘀为要,白矾祛痰燥湿,能逐热痰下泄上涌,郁金以开郁为主,白矾以化痰为要,二药伍用,抗癫痫功效益彰;白僵蚕配地龙:二药均有清热熄风、通络止痉的作用,白僵蚕偏于祛风化痰,药性升多降少,地龙平肝定惊,药性以降为主,两药一升一降协和,止痉效用明显加强;全蝎配蜈蚣:二者均入肝经,为熄风止痉圣品,相须为用,其力更彰,且对脑动脉硬化、脑供血不足、脑软化引起的大脑功能障碍所表现出的智力减退、言语不清、反应迟钝等症有促进恢复作用。

5. 斟酌服法、调摄生活 谢老认为癫痫服药时间和方法可直接影响疗效。寻常中药服用是上午、下午各 1 次,但是癫痫患者相当部分发作时间有一定的规律,常以晚间初睡时或凌晨将醒时发者居多,故对其服药时间应做特殊安排,如可安



排在傍晚及寝前各服 1 次。谢老还认为中西药在人体发挥的作用不完全相同,西药大多根据发病机制用药,而中药主要在于激发、提高自身免疫力,调整气血,平衡阴阳。长期服西药的癫痫患者对药物有所适应和依赖,若改服中药,不可骤然停用西药,由于初用中药时,机体对中药尚未完全适应,此时骤然停用西药,反而易使病情反复,甚至加重。因此,对长期服用抗痫西药,但病情控制不佳者,不应立即撤去西药,可与中药并用,中西药服用时间相隔 1 小时即可,若病情许可,逐步撤减西药直到停用。在对癫痫患者治疗的同时,还要关心患者的思想顾虑,鼓励其心情舒畅,保持其情绪稳定。因为恼怒、惊恐、紧张等情志因素,往往会诱发癫痫发作,同时,还应注意饮食调理,忌辛辣刺激性的食品,如辣椒、浓茶、咖啡、煎炸食品等,尤其酒类及羊肉最易诱发癫痫,必须终生禁绝。

杨甲三临床经验

〔《中医教育》〕

中医认为,本病多由七情失调、暴受惊恐、外感六淫、饮食失调、劳累过度、跌仆损伤或先天不足引起。论其病机,虽各型有异,但阳升风动,即为癫痫。其发病主要是风痰气逆所致。杨老通过多年实践,认为对于发作期的治疗,由于发病急、时间短,门诊极少遇到,一旦遇到可取人中、涌泉、百会、合谷、太冲等穴;肢体抽搐明显者可加后溪、申脉,以开窍醒神,镇静止痛。缓解期的治疗相当重要,针对风痰这一主要病机,杨老采取熄风化痰、安神定志的治疗方法。处方如下:外关、足临泣、风池、大椎、本神、神庭、四神聪、天枢、气海。手法:外关直刺透关至内关穴,泻法;足临泣直刺 0.3~0.5 寸,泻法;风池向鼻尖方向刺 0.5~0.9 寸,泻法,不留针;大椎直刺



0.8~1.2寸,泻法,不留针;本神、神庭、四神聪斜刺0.3寸至皮下,泻法;天枢直刺0.8~1.2寸,泻法;中脘直刺0.8~1.2寸,泻法;气海直刺0.8~1.2寸,平补平泻。

按:外头为手少阳三焦经络穴。手少阳三焦经主气所生病,功可理气化痰,透至内关时,亦可治神志病;足临泣为足少阳胆经之输穴,功可平肝熄风,化痰。二穴为八脉交会穴之固定配穴,配伍应用可使其平肝熄风、理气化痰之作用更强,为治疗癫痫之主穴。风池为足少阳胆经穴,位于脑后,乃风邪汇集入脑之门户,少阳主风,风池乃熄风之要穴。大椎属督脉,为诸阳之会,督脉直接入脑,故大椎可安神定志。风为阳邪,易化热,亦取大椎清热之功。神庭为足太阳督脉之会,本神乃足少阳阳维之会,治癫痫吐白沫,少阳经风、火、痰所致之症,皆可泄之。四神聪为安神定志之经验效穴,脾为生痰之源,脾胃互为表里,故取胃募穴中脘以化痰,治胃必通肠,故取胃经所属的大肠募穴天枢,化痰需理气,故取诸气之海——气海,四穴合称四门,功可理气化痰,健脾和胃。

张奇文临床经验

〔《中国农村医学》〕

1. 重视痰壅脾虚的病机 小儿癫痫,病因多端。先天禀赋不足,胎中受惊,六淫外感,饮食所伤,跌仆损伤等皆可诱发。其病机变化主要为脏腑气机逆乱,郁而生痰,阻塞经络,蒙蔽清窍,引动肝风所致。而痰浊之生成,又重在脾虚,中焦气机升降失常。治痰之法,虽有上者吐之、里者下之、半表半里者和之诸法,然临床具体运用常分别主以导痰、涤痰、化痰、清痰等。在治痰诸法中,重在健脾。健脾之用不全在补,而在和胃、消导、助运、醒脾等法中以健脾运,凡小儿面黄,上下眼



脸虚浮,唇舌淡,四肢不温,兼见癫痫诸症发作者,治疗在镇惊熄风、豁痰开窍的同时,一定要重视调理脾胃,升降气机,选方用药也应着眼于痰的排除。此是治疗痫的关键,不可忽视。

2. 治疗以涤痰与开窍兼施 痰为之病,阻塞经络,经络闭塞,郁久化火化痰,上蒙神明,致癫痫发作。痰本起于脾,而其表现在肝、脑、心3经。治疗癫痫,应抓住生痰之源这个本质,但不能忽视清心开窍这个环节。健脾法的应用,时间宜长宜久,而开窍法的应用则宜暂而不宜久,蒙蔽于清窍,可致人以昏迷,神志不清,五脏失调,六腑不通。治疗可吐之、下之,而在小儿又易损伤脾胃,可效法古人,用清心开窍为伍,自拟镇惊散:牛黄1.5g,珍珠3g,白僵蚕、全蝎各9g,石菖蒲9g,麝香0.5g,天竺黄4.5g。共研细末,瓶贮,每次服1g,每日服3次,既可镇惊开窍,又可清热豁痰。方中可以胆结石替代牛黄、梅片代替麝香。

3. 注重活血化瘀和巩固治疗 临床治疗癫痫患者,凡见有疼痛,无论在发作前或在发作后,且痛有定处不移者,均参以活血化瘀之药,轻则用丹参、桃仁、红花、赤芍之类,重则用虻虫、水蛭、干漆之类,均可视病情而加入。张老曾治疗多例头部受伤而发癫痫的患儿,仿王清任通窍活血汤,其见证多在犯病之前,头痛如劈,小儿常抱头自摇,或握拳捶击,且伴有唇舌紫暗,舌下静脉瘀阻。通窍活血汤重用葱、姜、黄酒,使其药力直达巅顶。用原方往往效果不明显,可在原方中加入半夏、天竺黄、白附子、白僵蚕之类,效果更好。可见,痰瘀互结是小儿癫痫的一个重要病机。腹痛型癫痫,也多痛有定处,除痰瘀之外,多兼夹食积,用药须加通里攻下之药,如牵牛子、巴豆霜、皂角之类,并参以消导理气止痛,药用槟榔、莱菔子、木香、九香虫、焦三仙等。但活血药必用,且重用芍药甘草汤以缓急



止痛。

对于癫痫病的巩固治疗,张老习用紫河车丸或琥珀散加减化裁,前方出自《证治准绳》。后方乃张老所学的家传方。药用钩藤、茯神、酸枣仁、贝母、生龙齿各 4.5g,连翘、天花粉、竹茹、梔子、人参、白术、白芍、石菖蒲各 3g,焦山楂、神曲各 6g,珍珠 0.3g。羚羊角、朱砂、琥珀 1.5g,生甘草 1.5g。共研极细末。6 个月至 1 岁患儿,每次服 0.3g;1~3 岁,每次服 0.5g,每日服 3 次。

张鹰临床经验

〔《中国中医药信息杂志》〕

天南星善于燥湿化痰、开窍定惊、祛风止痉。但由于其性燥烈有大毒,故在临床上一般多采用加工炮制之品。而张教授认为“有病病受之,中病即止”的要领,在临床 30 余年中,灵活运用天南星治疗癫痫数百例,疗效显著。

1. 立论依据——痰涎壅塞、迷闷孔窍 本证之形成多由七情失调、先天因素、脑部外伤、饮食不节、劳累过度或患其他疾病后引起脏腑功能失调、痰浊阻滞、气机逆乱、风阳内动所致。本病的根本在于“痰邪作祟”,即所谓怪病多由痰所生。风阳痰浊,蒙闭心窍,流窜经络是痫证发作的基本病理因素。

2. 临床用药与辨证紧密结合 中医将痫证分为发作期和缓解期进行治疗,即“急则治其标,缓则治其本”。在治疗时应严格分清标本虚实,频繁发作期则以治标为主,着重豁痰顺气、熄风开窍定痫;缓解期以治本为重,宜健脾化痰、补益肝肾、养心安神。本证用药常与痰浊的深浅、正气的盛衰密切相关。一般初起正气未衰、痰浊不重,应采用涤痰开窍定痫之剂,生天南星用量在 3~6g,不可过之。常以生天南星 3g,郁



金 9g 等药,组成专方醒脑汤治疗。如反复发作、痰浊不化,愈发愈频,当以治标为主,着重豁痰顺气、开窍定痫。生天南星的最大用量为 9g。但临床运用时应临证细审,辨证施治,伐邪不伤正,万不可乱投。

缓解期治疗尤为重要。因为要从根本上减少和控制痫的发作,必须要提高脏腑自身的防御能力,即“正盛则邪退也”。当以治本为主,标本兼治。缓解期是痫证的最佳时期,应以健脾、补肾、养心为治疗大法,在临床上把握良机,灵活运用。常以醒脑汤配合丹参 9g,麦冬 9g,炙甘草 6g,远志 10g,熟地黄 10g,何首乌 10g 等补肝肾、益精血、宁心安神之品。

治验:闵某,女。曾患原发性癫痫。间歇发作 3 年多。症见神疲乏力、头晕目眩、心悸、健忘,舌质淡润、苔薄微腻,脉沉细无力。分析认为患者正处于缓解期,且癫痫发作日久不愈,而致心肾亏虚。应在化痰开窍、定痫醒脑大法的基础上,加以补肝、健脾、宁心安神之品。方用生天南星(先煎)6g,石菖蒲 9g,山茱萸 10g,白芍 10g,丹参 10g,麦冬 10g,炙甘草 6g,郁金 9g,合欢皮 9g,远志 5g,橘红 5g,薏苡仁 30g,茯苓 10g,车前子(包煎)10g,莲子肉 15g。连续服用 1 个月。复诊时患者自觉有所好转,其间曾发作 1 次,次数减少,用前方继服,以善其后。第 3 次就诊,自诉 2 个月未发作,继服前方巩固治疗。

赵建军临床经验

[《长春中医学院学报》]

1. 在辨证上,注重肝脾在发病中的作用 痰与癫痫的关系密切,故有“无痰不作痫”之说,初病实证,多由痰热迷塞心窍所成;久病虚证多由痰湿扰乱神明而致,湿痰则由脾失健运聚湿生痰。虽然积痰内伏是癫痫发病的主要原因,而痰的产



生则责之于肝、脾。肝主疏泄,性喜条达,忧思郁闷、恼怒等情志刺激,使肝失条达,气机不畅,肝气乘脾,肝脾不和,健运失调,使生化失司,不能化精而化饮化痰。现代社会竞争日益激烈,紧张、压抑、劳累等因素均会导致肝的生理异常,不能正常的疏泄、运化,从而导致各种疾病的发生。因此,调治癫痫,从肝入手,兼顾脾胃,他擅长结合现代中药药理学的成果,遣方用药,收到较好的疗效。

人体各脏腑活动皆需要肝胆生发之气的鼓舞,脑也不例外。肝有疏泄气血之功,而肝的藏血充足依赖于脾的运化升清,若脾气不足不能散精于肝,肝失所养,则肝阴不足,血不养肝,肝不荣筋,阴不制阳则阳亢,亢极生风,出现抽搐。反复的癫痫发作,不仅会对大脑产生缺血缺氧性损害,也会对患者心理上产生较大的影响,压抑忧虑,使脾胃受损,精微不布,痰浊内聚,或痰随气上逆,或痰随风而动,蒙闭心神清窍而使癫痫发作。二者相互影响,使病情反复,迁延不愈。

2. 在治疗上,注重疏肝健脾化痰,佐以镇痉安神 正确的理解肝的生理病理特点,对于指导临床、辨证论治具有重要的意义,肝体阴用阳,肝以血为养,治疗上宜维护其阴柔之质,不宜使用峻烈克伐之品,伤及肝之生发之气,应时时顾护其柔润之体。

治验:李某,女,10岁。发作时表现为头痛,持续约3~5min,影响患儿情绪,每天均有发作。家长因对服用西药有顾虑,而来求治。组方:川芎25g,细辛5g,水牛角30g,柴胡15g,当归15g,白芍15g,白芷15g,香附15g,栀子15g,郁金30g,全蝎5g,白僵蚕10g,夜交藤30g,柏子仁30g,炒酸枣仁30g,琥珀粉75g,服药后1个月症状明显减轻,发作次数减少,每周发作1~2次,继服上方1个月,无头痛发作,经脑电



图检查,大致正常。随访1年无发作。

按:肝气调畅,则诸脏腑、经络功能调和,水津、气血敷布正常;若肝气郁滞,影响水津敷布,聚而成痰,气郁为其病机关键,痰浊为其病理产物,因此,疏肝健脾尤为重要,结合实际情况,佐以柔肝、平肝、泻肝之品。遣方多选《张氏医通》柴胡疏肝散化裁,方中柴胡、白芍疏肝解郁;枳壳、陈皮助肝气条达;郁金、川芎行气活血,取血行则气行之意;胆南星、珍珠母、石菖蒲、全蝎豁痰、开窍、止痉以治其标;茯苓、白术健脾燥湿,使痰不再生,甘草调诸药。配党参、白术、茯苓、山药、远志能益气健脾,和胃化湿,前者使后人得以滋养,后者以绝生痰之源。结合现代药理研究也证明,柴胡、芍药具有提高机体对非特异性刺激的抵抗能力,对中枢神经系统具有明显的抑制作用,因此,从肝脾论治癫痫,可能与疏肝健脾药具有中枢镇静及抗惊厥作用有关。

王晶辉临床经验

[《中国民康医学杂志》]

中医对癫痫病的认识与治疗具有悠久的历史。从古至今,癫痫病的方剂有2700多个,只是在用药上,剂量配伍方面各有所长。其中,常用的抗癫痫药物有朱砂、天麻、全蝎、琥珀、钩藤、牛黄、麝香、虎骨(代)、胆南星、紫石英、明矾、大黄、桂枝、蝉蜕、黄连、白僵蚕、雄黄、珍珠、水银等。这些仍然是目前研究治疗癫痫不可缺少的药物。但由于每个人病因病机不同,存在着个体差异,因此,在治疗上就不能局限于一方一药。要通过辨证施治,灵活用药。临床根据不同的病机将癫痫分为七类:惊恐型癫痫;气郁痰盛型癫痫;热盛扰心型癫痫;气血虚弱型癫痫;食痫型癫痫;脑病后遗症癫痫;脑外伤型癫痫。



根据各类癫痫病的特点加以组方用药治疗,几年来通过临床验证,收到了好的效果。

1. 对于惊恐引起的癫痫实行“镇惊安神、宁心定志”的治疗原则 在用药方面,较常用的有大青膏、镇惊丸、钩藤饮。惊恐伤及心、胆、肾 3 脏引起的癫痫。这类癫痫的临床表现为:发作前,多数有心悸、心慌不安、有被人追捕之状,头晕、耳鸣、视物不清,面青、手足不温等症状。发作后,腰膝酸软,四肢无力。脑电图检查可见棘慢波,脑电地形图可见病灶性功率增高。白细胞检查,在发作前后 24 小时内,白细胞可明显增多,查体时,又没有任何炎症病灶。对于这种类型的癫痫,中医的治疗原则是“镇惊安神,宁心定志”。古人治疗这类型癫痫病的方剂比较多,较常用的药方有大青膏、镇惊丸、钩藤饮。大青膏原为宋·钱乙方,《医宗金鉴》作了加减。大青膏方为:天麻 9g,白附子 6g,青黛 3g,全蝎 3g,朱砂 3g,天竺黄 6g,麝香 1g,乌梢蛇 3g。上药共研细粉,制成蜜丸,1 日 3 次,1 次 3g,石菖蒲汤送服。此方熄风镇惊力强。

镇惊丸:茯苓 15g,麦冬 15g,朱砂 9g,远志 9g,石菖蒲 9g,酸枣仁 9g,牛黄 45g,黄连 9g,珍珠 6g,胆南星 15g,钩藤 15g,天竺黄 15g,犀角(代)9g,甘草 9g。诸药共研细粉,炼蜜为丸。1 日 2 次,1 次 3g。此方重在清心安神镇惊,与大青膏配合应用效果更佳。《普剂方》中的钩藤饮:钩藤 15g,黄芩 15g,甘草 15g,石膏 30g,龙脑 30g,蝉蜕 1 枚,共研细粉,1 日 2 次,1 次 3g。

治验:张某,男,42 岁。患者大惊后突然出现四肢抽搐,口吐白沫,双目斜视,神志丧失,不省人事,每 7~8d 发作 1 次。每次发作出现脱衣乱跑、发作前惊恐不安,如被人追捕之状先兆。给苯妥英钠不见好转。经查,脑电图提示广泛中度



异常,双颞导联有暴发棘慢波。病理反射(一),舌质红、苔黄厚、脉细数。诊断:惊恐伤神型癫痫。投镇惊安神丸,每日3次,每次5g,连服9个疗程(每个疗程3天),停药5年未发。

2. 对痰盛型癫痫病采用“疏肝解郁、豁痰开窍”的治疗原则 中医认为痰盛型癫痫是由于肝郁日久、疏泄失职、中焦运化失调所导致。这类癫痫是本虚标实、浊气上逆所致。所谓本虚:一为先天不足;二为后天脾胃失调。所谓标实:肝风痰热,痰致癫痫。痰自脾生,脾虚痰盛是癫痫病主要的病变基础。这类癫痫患者多有明显的气郁病史,或大怒之后,或小儿生气后哭中睡觉都可引起癫痫病发作。发作前多有情绪不稳定,易伤感,心烦躁,胸脘满闷,口中痰盛。妇女月经来潮前有乳房胀痛、口苦,咽干等先兆。发病时的临床表现为:发作前头晕、目眩、胸闷、两胁胀痛。继而昏仆、不省人事、口流痰涎、喉中痰鸣、双目上视、四肢抽搐、小便失禁,多发于睡眠时或情感变化之后。发作后鼾睡,醒后头痛、体倦,对发作情况无记忆。舌淡,苔白腻,脉弦滑。现代医学检查:脑电图提示有棘慢波,脑电地形图提示有局部病灶。对于这类癫痫的治疗原则是“疏肝解郁、豁痰开窍”。用“加味白金丸”效果更好。“加味白金丸”,其方药为:明矾 50g,郁金 70g,朱砂 10g,柴胡 15g,枳壳 15g,石菖蒲 30g,胆南星 20g,上药共研细粉,制成水丸,1次4g,1日2次,小儿减量。方中的柴胡、枳壳疏肝理气,郁金行气解郁,以破气滞。配明矾、胆南星豁痰消热,使痰浊下行大肠,随大便而解。朱砂有宁心定志、镇惊安神之功,故可止痫解痉,使癫痫病愈。

3. 对热盛型癫痫病应“清心泻火、止痫熄风” 由于火热之邪上扰神明所致的热盛扰心型癫痫。这种病外感六淫之邪,内伤七情,久则实热内盛,上扰心神。这种高热是人体素



有实热,感受外邪之后,正气邪气相搏引起实热。这与现代医学的高热惊厥引起的抽搐有异同之处。其相同之处,都是高热引起的抽搐。所不同的是:现代医学认为是细菌感染所致;而中医认为是实热所致,是正邪相争的结果。这类癫痫患者,多有明显的高热抽搐史,常见婴儿高热惊厥后,最初发作都因高热而发,一般在 39°C 以上者多见。发作前有高热、心烦之先兆,并多在外感后发作。其临床表现为,卒然昏仆、神志丧失、不省人事、四肢呈强直状抽搐、口吐痰涎、目赤面红、身热、口渴、大汗出、大便秘结、小便黄赤。发作后昏睡,对发作情景无所记忆。舌质红绛、苔黄厚、脉弦数而有力。脑电图检查提示有棘慢波、棘波,脑电地形图提示有明显局部病灶。中医对此的治疗原则为清心泻火、止痛熄风。在治疗上我们应清泻其火热,常用“清热熄风散”:石膏 50g,石决明 50g,紫石英 50g,寒水石 50g,芒硝 30g,川大黄 30g,赤石脂 30g,龙骨 30g,牡蛎 50g,犀角 5g(代)。上药共研细粉,成人 1 日 2 次,1 次 5g。从方中可以看出,使用大量石膏、寒水石、犀角、芒硝、川大黄等清心泻火药,以清泻其实热,用龙骨、牡蛎、石决明、紫石英镇惊安神、止痛、止痉;赤石脂养胃,用以防芒硝、大黄之过。所以此方适用于治热盛扰心型癫痫。

治验:张某,女。患者突然昏仆不省人事,二目直视,口吐白沫,意识完全丧失 2 分钟,四肢呈强直状抽搐,面红,身热汗出,大便秘结,小便黄赤。发作后昏睡、头痛、四肢无力。醒后对发作时情景无所记忆。每次发作前有躁动不安先兆,继而抽搐。经查,脑电图广泛中度异常,全部导联可见暴发棘慢波。舌质红绛、苔黄厚,脉弦数有力。投清热熄风散,每日 2 次,每次 5g,连服 17 个疗程停药,至今未发。

4. 对于气血虚弱型癫痫病 由于肌体气血虚弱,脑失所



养,从而使神昏、筋失所养而抽搐,故为气血虚弱型癫痫。这类癫痫可以从两个方面加以认识。其一是由于气血虚弱,造成肝血不足、肝失所养,引起肝风内动;其二是由于气血虚弱,血不养心,心神失去所养,引起大脑供血不足而引起抽搐,发生癫痫病。这类癫痫病患者平素表现体质虚弱,检查多有贫血、缺钙,血压低等症状,发作前有头晕、目眩、耳鸣、目涩、四肢无力,婴儿常有夜啼,妇女多有月经后发作,并有气短等先兆。其临床表现为:头晕、目眩、心悸、气短、食欲不振、体倦无力、面色苍白;发作时昏仆不省人事,四肢抽搐、口吐白沫、双目上视、四肢不温、自汗出,发作后全身无力、昏睡,对发作时情景不能记忆,舌质淡、苔薄白、脉浮细。其治疗原则为“补气养血、安神定志”。常用的方剂是“补气宁心散”,其中白芍 40g,红参 30g,龙眼肉 30g,珍珠 10g,琥珀 30g,朱砂 10g,赤石脂 30g,赭石 50g。方中用白芍、红参、龙眼肉以补气血,珍珠、琥珀、朱砂安神镇静、止痫,赤石脂、赭石平肝和胃。本方在治癫痫的同时,配用健脾和胃、补气养血之药,效果甚佳。

5. 用“健脾止痛散”治疗食痫 食痫是由于饮食不当或饮食不节所致。由于饮食不节,引起脾虚,脾失运化,湿饮停于中焦,日久化热生风则上扰神明,引起神昏,或阻塞经络令人抽搐。这类癫痫发作时与饮食有着密切关系,故在查问病史时,要问其饮食过度或饮食不节时是否有癫痫发作。在临床表现上,这类癫痫在发作前有胃脘胀满或脘腹疼痛、呕逆先兆,继而抽搐,双目上视,口吐白沫或呕吐食物,食顷方醒。醒后对发作时情景无所记忆。值得注意的是,这类癫痫有时可不抽搐,主要表现在胃脘疼痛难忍,所有止痛药无缓解,服用抗癫痫药后停止。这在临床诊断上需要给予重视。舌质胖



大、脉弦缓,同样脑电图可出现棘波、慢波,发作前后 24 小时内白细胞会明显增多。在治疗上,我们常用“健脾消食,涤痰止痛”的原则。常用方药是健脾止痢散。其中:白参 30g,陈皮 30g,芒硝 30g,赭石 30g,琥珀 30g,茯苓 20g,赤石脂 30g,上药共研细粉,成人 1 日 2 次、1 次 5g,小儿应减量。方剂中用人参、陈皮、茯苓以健脾消食,与芒硝、赭石、赤石脂配伍其意在于健脾消食的同时起涤痰、使痰浊化解的作用,并用琥珀镇静安神、止痢、止痉。本方不仅适用于饮食不节型癫痫所引起的各种发作,也同时可用于胃肠神经官能症的患者。

治验:马某,女。患者因吃东西不适,腹胀哭闹后抽搐。抽前腹痛,呕吐后四肢抽搐,抽时口吐白沫、神志丧失,抽后四肢无力、困倦。服苯巴比妥好转,但不久又复发。经查:脑电图轻度异常,在颞叶有阴性棘波。生理反射(+),病理反射(-)。舌质淡、苔薄白,脉浮细。诊断为饮食不节型癫痫。投健脾止痢丸 4 个疗程,停药至今未发。

6. 对脑病后遗症引起的癫痫应清热解痉、豁痰开窍 由一些脑病所引起的属脑病后遗症,患者多具有脑病、高热史。它在诊断上是指那些局部有脑病,并同时伴有抽搐的患者。这类型癫痫病,发作前有高热病史,同时出现病理反射,发作前有头痛、目眩、智力低、反应迟钝的表现。发作突然,无先兆,卒然高叫一声,四肢抽搐、口吐白沫、双目斜视、神志丧失,有时咬破嘴唇、小便失禁,多数患者出现记忆力减退,重者出现痴呆。有些人甚至会出现肢体偏废不用,发作后昏睡,对发作时情景不能回忆。在治疗这类脑病后遗症型的癫痫应把握的原则是“清热解痉,豁痰开窍”。常用的方剂为定痫丸。方中紫石英 60g,钩藤 50g,麝香 5g,天麻 30g,全蝎 30g,寒水石 50g,石膏 50g,犀角(代)5g,石决明 50g,明矾 30g。上药共研



细粉,制成蜜丸,成人1日2次,1次5g。方中用石膏、犀角、寒水石、明矾清热安神,配钩藤、紫石英、天麻、全蝎定痫熄风,用石决明、麝香平肝熄风、开窍,故本方具有清热解痉、豁痰开窍之功效,适用于脑病后遗症引起的癫痫发作。

治验:参某,男。患者6岁时患脑炎高热抽搐1次。病愈半年后开始抽搐。抽时口吐白沫,神志丧失,咬破唇舌,小便失禁,抽后昏睡,头痛。经查脑电图广泛中度异常。诊断为脑炎后遗症型癫痫,投以清热熄风散7个疗程,至今未发。

7. 对脑外伤造成大脑损伤引起的癫痫应活血化瘀、安神止痛 各种脑外伤造成大脑损伤,致使大脑内血瘀而导致的脑外伤性癫痫,是由于大脑内血行不畅,致使大脑内缺血缺氧,脑失所养而发癫痫。产生脑外伤癫痫的原因,不仅因为颅脑外伤,还可由难产引起的颅内出血、脑肿瘤手术后脑出血、脑梗死引起。这类癫痫的发作形式比较固定,多偏向一侧,或局部抽搐,发作前多有局部麻木,尤其是末梢神经麻木。临床表现为突然抽搐,不省人事,多数人有明显定位性抽搐,口吐白沫、双目斜视,小便失禁,发作后体倦无力,对发作情景不能回忆。有些患者,由于脑外伤后的抽搐而变成了进行性的脑病,出现了记忆力减退、痴呆等,脑电图、脑电地形图有明显癫痫波及明显局限性病灶,CT可明显提示有占位性病变。发作前后24小时的白细胞数明显增多。在治疗这类癫痫上,中医所采用的治疗原则是活血化瘀、安神止痛,通常用“活血化瘀止痛散”来治疗。其方药为天麻30g,全蝎30g,郁金30g,桃仁20g,朱砂15g,琥珀20g,麝香5g。方中用全蝎、天麻、桃仁、麝香活血化瘀改善大脑血液循环,促进病灶的吸收,琥珀、朱砂安神镇静止痛,郁金行气化瘀。所以该方有活血化瘀、安神止痛之作用,适用于脑外伤型癫痫各种类型发作。



朱良春临床经验

[《辽宁中医杂志》]

癪和病是痰瘀迷阻清窍之病，是精神疾患。而痰瘀是病理产物，究其内因多由机体功能失调，气道闭塞，脏腑不和，津液凝聚或水湿停留，气化不利而成，其外因有脑部外伤者，乃因气血瘀阻、脉络不和之故。抓住痰瘀两端，随证选药，往往取得较佳疗效。但必须知常知变。前贤云：“不识成法，焉有准绳？”但拘守成法，何能治变？如何通权达变？应究前贤“见痰休治痰，见血休治血”之说，本节阐述扶正祛邪、标本同治、虚实兼顾之法。

1. 抓住痰、气、郁，治癪扶正元 痰之为病，有缓慢发病者，有卒然而生者；有投剂即瘥者，有缠绵难愈者，究其病态万千，故有“怪病多属痰”之说。痰为水液所化，其性属阴，其与热合邪，或郁久化热，亦成阳邪，故临证必须首分阴阳。阴证者乃有口干不欲饮、纳少不饥、痰黏不爽、口流涎水、喉中痰鸣、昏聩嗜睡、头昏脑胀、心中悸动、口吐白沫、便黏如涕、眼神呆滞、面色暗晦（或眼眶周围青暗）、形体丰腴、手足作胀、皮肤油垢异常或面色光亮如涂油、舌体胖大或淡嫩、苔白厚腻、脉滑或弦滑等症。属阳证者症见抽搐痉挛、烦急躁动、胡言乱语、便秘口苦、两颊色红、易惊悸、不寐、舌红、苔黄厚腻、脉滑数或弦滑等症。以上辨痰之要，不必俱悉，只要见其一二，即可考虑治痰之法。吾师朱良春教授据金元以降，张子和、朱丹溪等前贤从“痰迷心窍”论癪之说，又赞赏张景岳着眼“痰气”两字之发挥。认为治癪宜理气、解郁、化痰。可选“顺气导痰汤”加减。自拟“加减顺气导痰汤”，药用：制半夏、陈皮、茯苓、白矾、郁金、石菖蒲、陈胆南星、制香附、炒枳壳。病久心脾两



虚者,选“养心汤”加减。抓住痰、气、郁治疗癫证乃是朱师活用张景岳治癫之法,所拟“加减顺气导痰汤”是仿前贤之法而不拘泥其方。历年来,朱师用此方愈癫疾者甚众。笔者仿朱师之法,结合临床研究,在朱师的“加减顺气导痰汤”基础上化裁,自拟“扶正醒癫散”,由丹参、炒酸枣仁、柏子仁、茯苓、姜半夏、陈皮、石菖蒲、陈胆南星、制香附、炒枳壳、白矾、郁金共粉组成(每次服6~10g,每日3次,蜜水或温开水送服),历年来治疗癫证颇感应手。

治验:曾治黄姓男,年届不惑,因车祸惊恐加受刺激,精神失常已2年,平素忧郁不安,时有恐惧表现,精神呆滞,沉默寡言,又时言心中悸动,惊恐莫名,头昏嗜睡。言语答非所问,或低头不语,百问不答,或有冷笑、暗泣之状,甚至常有悲观自尽之语,家人见状,莫可奈何,2年来,经多方求治,服中西药数百剂,症状如旧,诊见形体丰腴,面色暗晦,眼神呆滞,皮肤油腻异常,舌胖嫩、苔白厚腻,脉象弦滑。辨证:《素问·阴阳应象大论篇》云:“怒伤肝……恐伤肾……恐为肾志,大惊辛恐、恐则精气内损,肾气受伤……”患者因惊恐太过,气机逆乱,加上精神刺激,肝气受郁,痰气两结而发癫,张景岳认为,癫证多由“痰气”而致,凡气有所逆,痰有所滞,皆能壅闭经络,阻塞心窍而发癫,盖惊恐、郁怒、忧思导致肝木犯脾,脾失健运,痰涎内生,以致气郁痰结,当察痰察气,因其甚而先之。笔者据前贤及朱师理气、解郁、化痰之说综合斟酌,考前医曾多次用过豁痰开窍、镇肝熄风、清心开窍、平肝熄风、疏肝解郁、顺气导痰等法,共用过中药汤剂数百剂(除西药之外)未效,辨属病久心脾两虚,因药不对证,更伤脾胃,故痰涎内生终不得解,前医运用上述诸法,乃均从“实”论治。张景岳指出,“忧郁病者,则全属大虚”。设想,忧则气沉,必伤脾肺;惊则气乱、恐则气下,



必伤肝肾,故笔者自拟虚实同治、标本兼顾之“扶正醒癲散”。本案经投用“扶正醒癲散”(每次 10g,每日 3 次),另嘱配合心理疏导,2 周后,诸症好转,自说忧郁不安,时有恐惧感减少,纳食增加,家人颇感患者比前清醒多了,嘱续服“扶正醒癲散”60 天,诸症基本消失,精神状态完全恢复正常,语言礼貌一如常人。乃嘱守服此散 2~3 个月予以巩固,并再嘱配合心理疏导,追访 2 年无复发。

按:治疗癲证因忧郁过度,加之惊恐发病的患者,仅以药物治疗是不能根治的,故必须结合心理疏导,精神疗法。张景岳指出,“以情病者,非情不解;其在女子必得愿遂而后可释,或以怒胜思未可暂解;其在男子,使非有能屈能伸,达观上智者,终不易邪也。”故治疗癲证和治疗抑郁症,深入了解患者发病之因,配合循循善诱,说理开导之法,是提高疗效根治癲疾之万全之策。傅青主说:“饮食入胃,不变精血,反去生痰,痰迷心窍,遂成癲狂。”“扶正醒癲散”取平调脾胃之“二陈汤”加胆南星、枳壳,名曰“导痰汤”。治顽痰胶固非二陈所能除者,可以理气,可以除痰。方中胆南星助半夏除痰,则除痰之力大;枳壳助陈皮理气,则理气之功宏,脾为生痰之源,肺为贮痰之器,脾湿生痰,上注于肺;半夏、枳壳由上而导之使下,降之即所谓导之,故谓顺气导痰也;合用“白金丸”(白矾、郁金)加制香附,意在利胆、舒肝、解郁又能扫荡凝结经窍之痰涎,《长沙药解》云:“矾石酸涩燥烈,最收湿气而化痰腐,善吐下老痰宿饮。缘痰涎凝结,黏滞于上下窍隧之间,牢不可动,矾石收罗而扫荡之”本方加石菖蒲开窍化痰;用丹参、炒酸枣仁、柏子仁取其安神定志,养心和血,意在补虚扶正。近贤张锡纯谓“柏子仁味微甘微辛,气香性平,能补助心气,治心虚惊悸怔忡;能涵肝木……滋肾水……且气香味甘,实能有益脾胃。”调



养心脾,滋润肝肾,盖正复邪自去。痰、气、郁“三症”分消,痼疾自能根治也。《医学集成》说:“良医用药,必如良将用兵……心有主宰而不惑,兵有纪律而不乱……虽三军之士,性情不同,而我驾驭有法,同心克敌则一也……如人病后不服补药,营卫其无以固,元气其何以复乎?”此乃痼症久治不愈,取攻补兼施之理也。前贤谓“治病不难,贵在善后。”亦是经验之谈,不可忽视。证有虚实之分,病有新久之别,正虚邪实之证亦多有偏重,故治法和用药亦不可一成不变,中医用“散剂”是最灵活的剂型,可按患者寒热虚实所偏,症状不同,治疗过程的变化,随时增减或调整一二味药的剂量,即能平衡阴阳和寒热。且“散剂”能缓缓图功,颇合正虚邪实之难症痼疾的治疗规律。用“散剂”可节省 3~10 倍药材,亦即可减轻患者的经济负担 3~10 倍,这就是中医的廉验优势。

2. 定痫拟丸散、善用虫类药 古今医家治疗痫证多偏用重镇之品,虽有一定疗效,但久用多有不同程度的毒性,尤其对儿童患者久用多有不良反应。朱师擅用虫类药。80 年代初,自拟“涤痰定痫丸”由炙全蝎、炙蜈蚣、炙白僵蚕、广地龙各 60g,陈胆南星、川石斛、天麻、青礞石、天竺黄各 45g,炒白芥子、化橘红、石菖蒲各 30g,共粉碎,水泛为丸如绿豆大,每服 3~5g,每日 2 次,临床治愈者甚多。笔者仿朱师之法,历年来,用“涤痰定痫丸”改“散剂”,嘱患者家属自装胶囊,每服 3~5g,每日 2 次,治疗成人痫证发作期,屡屡应手。中医对痫证的传统治法为,发作期以熄风止痉、化痰开窍为主,缓解期(或间歇期)以扶正固本为要。但痫证的病因除脑外伤外,不越惊、痰、火、虚、瘀、食,治疗须辨标本缓急。临床发现痫证属实者寡,属虚者多,如痫证频繁发作,更易耗伤气阴,每多导致体质的虚弱状态,此时单纯使用熄风定痉、豁痰开窍之药,往往



疗效不佳。所以,笔者赞同前贤主益气健脾扶正用于治疗痫证的全过程,更能取得理想的疗效。实践证明,痫证发作期治愈后,多因外感发热或饮食不慎复发,此属上虚之象,故张景岳指出,“不得谓癫痫尽属实邪,而概禁补剂”,《医学入门·痫》论云:“化痰必先顺气,顺气必先调中。”盖中气虚弱,脾不运化,痰湿最易困脾;脾气失升,胃失和降,气机运行升降不利,必加重痰浊的滋生。“痫由痰致,痰自脾生”之理昭然也。张景岳治疗癫痫失志,症见真阴人损、气不归根而时作时止、昏沉难愈者擅用“紫河车丸”(人参、当归、紫河车)治本,即是治痫重虚的明证。笔者曾自拟“药麦参蝎散”(山山药、生麦芽、西洋参、紫河车、全蝎五药共粉碎组成,每服3~8g,蜜水或开水送服)治疗老年和儿童痫证多例,屡收理想效果。

治验:陈姓老妇,年届天命,周期性发痫,发时意识全失,右半身或右上肢强直抽搐,牙关紧闭,两眼上翻,口吐白沫,每次持续2~3min,昏睡1小时左右,神志渐清醒后,头昏痛,周身酸软,疲乏无力。经大医院脑电图检查,诊为“癫痫”。2年来,多方求治,服抗癫痫中西药多种,均用时有效,停药后易复发。笔者根据全身症状和舌脉互参,辨证属中气素虚,脾不运化,饮食精微不化营血而生痰,痰湿困脾,气机不利,使脾不升清,胃不降浊,反复加重痰浊的滋生,形成恶性循环,故因虚致病,又因病致虚,是痫证久治不愈的原因。因此,必须扶正气,健脾胃,增强患者的抗病能力,即所谓增强免疫功能。如果只重视常规治法的镇痉、熄风、豁痰开窍,忽视提高免疫功能,则根治痫证乃永无时日。本案投“药麦参蝎散”(每服5g,每日3次)守服2个月后,痫证发作消失,嘱患者守服1年,逐渐减量乃至间日服药,患者体质恢复较速,追访5年无复发。“药麦参蝎散”,方简效宏,灵活变化寓于其中,山药、麦芽、西洋参益



气健脾、固肾涩精、疏肝解郁；紫河车大补气血，有返本还元之功；全蝎熄风定痉，药性较蜈蚣平和，老、小、弱患者通用，五药补、疏、通相伍，药性平和，调和阴阳，燮理寒热，虚实兼顾，久用无不良反应，乃老、弱、小痫证患者之理想效方也。妙在 5 药配伍的比率，随痫证患者的体质、病史、年龄、症状和服药后病情、体质转归而灵活调整，这是丸散亦可随症变化的巧用之法。读者大可举一反三，以减轻患者的经济负担。

按：痫证的病因病机复杂，临床必须辨病和辨证相结合，分清痫证为原发性或继发性，实践证明，以一方统治各型痫证疗效往往不很满意。笔者体会，癫痫无论是因虚致痫或因痫而致虚，病程迁延者多为虚实夹杂，在治疗中应不忘标本兼顾，既要注重熄风止痉以治标，又要益气健脾、固本培元以治本。治疗中一旦取效，不可随意易药或停药，更不可单独治标或单独治本。前贤张景岳不囿旧说，独抒己见，凡见解精辟，足以启人心智。其治疗癫痫，主张药宜清润，治在心、肝、脾、肾，治虚为本，虚实兼顾，治分缓急等学术创见，值得仿效和发扬。

黄培新临床经验

〔《中医药学刊》〕

1. 病因病机 中医学认为癫痫病位在脑，属于本虚标实之证，肝、脾、肾亏虚是主要的病理基础，而风阳、痰火、瘀血是造成发作的基本病理因素。一般多由先天禀赋不足、七情所伤或跌仆撞击脑部等因素，使肝、脾、肾等脏腑受损，导致风阳内动、痰浊内蕴或瘀血内停，或饮食不节或惊恐或劳累过度或感受风邪等引动，造成风火挟痰挟瘀、流窜经络、蒙蔽心窍或上扰清窍而致突然昏仆，不省人事，口吐白沫，两目上视，四肢



抽搐等症状。正如《普济方·婴儿一切痫门》所云：“其脏坚固不受邪。若风热蕴积乘于心，则令心慌惚不安，精神离散，营卫气乱，阴阳相病，故发为癫痫也。”导致癫痫持续状态的原因是多方面的，如各种原因骤减、骤停或更换抗痫药，抗痫药量不足、失效，感染控制不理想，精神创伤，疲劳，饮酒等等。癫痫发作的轻重程度与风火痰瘀的盛衰、正气的强弱有密切关系，若癫痫持续发作，正气渐虚，风火痰瘀益盛，愈发愈频，则正气愈亏，互为因果。因此，当出现癫痫持续状态时，往往呈现正气虚衰、风火痰瘀愈结愈深，临床表现为持续不省人事，频频抽搐，伴面红身热、躁动不安、息粗痰鸣、呕吐频频，甚则面色苍白，汗出肢冷，鼻鼾息微，脉微欲绝等证候。

2. 癫痫持续状态的治疗 癫痫持续状态应积极控制发作，基本治则是豁痰熄风、活血化瘀、开窍醒神。一般情况下以治标为主，控制发作为当务之急，因病情危急，不及煎药可先用针刺治疗、中成药制剂治疗等措施以促其苏醒，控制四肢抽搐，然后再采用清热泻火、平肝潜阳、熄风涤痰定惊、佐以扶正等治法投以中药煎剂，以防止癫痫再发。

一般处理：①将患者平卧，迅速松解衣扣、袜带等束缚并扶持好抽搐肢体，以免受伤；②将头偏向一侧，呈体颈位，用开口器或缠纱布的压舌板置于患者上下臼齿之间，以防咬伤舌体或口颊部，有活动性假牙应及时取出；③保持呼吸道通畅，吸出口腔内唾液、食物残渣和呼吸道分泌物；④迅速吸氧；⑤严密观察患者之脉搏、呼吸、血压和体温等生命体征变化。若全身抽搐尤其要注意患者的呼吸变化，如呼吸未能恢复，应立即行人工呼吸协助恢复，必要时作气管切开或呼吸机辅助呼吸。

针刺治疗：取穴为百会、风府、大椎、后溪、腰奇。若正在



发作或昏迷加人中、内关、足三里、十宣、涌泉、太冲等穴位以促醒；牙关紧闭加下关、颊车；夜间发作加照海；白昼发作加申脉；小发作加内关、神门、神庭；局限性发作配合谷、太冲、阳陵泉、三阴交；精神运动性发作用间使、神门、丰隆、巨阙和中脘。根据病情酌选 4~5 个穴，用较强刺激法或配合使用电针，发作过后每日或隔日 1 次。

3. 药物治疗 元·曾世荣《活幼心分》曾把癫痫分为“阳痫”和“阴痫”两种，易于掌握又很实用。同理，癫痫持续状态亦可以阴阳为纲。阳衰者，持续不省人事，频频抽搐，伴面色苍白，汗出肢冷，鼻鼾息微，脉微欲绝；急以开窍醒神，回阳救逆，予灌服苏合香丸，参附注射液静推或静滴。阴竭者，持续不省人事，频频抽搐，伴面红身热，躁动不安，息粗痰鸣，呃逆频繁，急以开窍醒神，养阴清热，予灌服安宫牛黄丸，参麦注射液、清开灵静推或静滴。若抽搐甚者予紫雪丹；喉中痰声沥沥者，予竹沥膏开水化溶后灌服；高热者选用物理降温或柴胡注射液 4ml，肌注。值得指出的是：①中医辨证之中药煎剂治疗宜按标本缓急原则，癫痫持续状态早期以痰涎壅塞、抽搐有力之邪实为主证者，当宜治标为主。若癫痫持续时间较长，虚实相杂者，当宜标本兼顾。因病情骤急，中药煎剂应据具体病情给予鼻饲或待患者意识苏醒后给予；②适时地使用熄风定痫通腑之中药煎剂作保留灌肠；③在癫痫持续状态过程中，任何时候首先应维持生命功能，必须严密注意患者之呼吸、血压等生命体征，危重患者当采用中西医结合方法。

钱荣江临床经验

〔《实用中医药》〕

1. 痰瘀互结是发病关键所在 痰与瘀同为病理产物，又



是致病因素,脑髓空虚则使痰瘀阻滞脑髓有可乘之机。肾精的盛衰,影响脑髓的充盈,肾精是运动的,有藏即有泻,肾精藏泻适宜、运行有度是维持人体生命的重要功能。同时,肾精是人的基础,肾精虚则影响其他脏腑功能的发挥。痰和瘀的产生缘于体内脏腑功能的失调,脾虚则健运失常,精微不布而生痰;肾虚则水无所主,泛而为痰;肝郁不舒,气滞水停而生痰。瘀血的生成,多由于正气亏虚,阴阳失调,与痰结合而为痰瘀互结,脑髓空虚则使痰瘀阻滞脑髓有可乘之机。一遇诱因,则阴阳失调,气机逆乱,引动痰瘀上阻脑髓,阻碍脑脉,使气血滋养脑髓受阻,破坏脑髓至清至纯的状态,使脑髓枯萎,神明失常,气血逆乱,清窍蒙蔽故发为癫痫之疾。

2. 治疗重在益肾清浊 基于以上认识,我们认为癫痫的治疗原则重在益肾清浊。肾精亏虚,无以化髓充脑是其根本原因,正气存内,邪不可干。只有肾精旺盛,脑的功能才能正常发挥。可用生地黄、熟地黄、淫羊藿、巴戟天、菟丝子、紫河车、山茱萸、山药、黄精、阿胶、桑椹、枸杞子等。清浊者,即清痰浊,清瘀浊,痰瘀同为病理产物,阻于脑髓,对癫痫的发生发展过程起重要作用,痰瘀不除,则脑髓难养,脑神不用,所以治疗中清痰瘀亦为主要原则。可用丹参、川芎、益母草、红花、桃仁、水蛭、地龙、半夏、天南星、瓜蒌、竹茹、茯苓、薏苡仁、天竺黄等。同时,肾虚血瘀痰阻,必有气虚血少,因此,益气养血之品如黄芪、党参、当归等也应灵活应用。益肾清浊同用,则痰瘀被除,肾精健旺,脑髓得养,脑神得用,癫痫之疾自可除之。

但是,癫痫是一组反复发作的脑神经功能失常的慢性疾病,病机复杂,时作时休,可分为发作期和休止期。中医药治疗特点强调整体调理,辨证施治,防治癫痫亦有悠久的历史,积累了丰富的经验。因此,我们在治疗上以益肾清浊为基本



治法的同时,应根据不同的临床表现综合施治,当在发作期或发作较频繁时期内,则以清痰瘀为主,并与开窍醒神、熄风定痫等法并用;当在休止期时,则以补虚固本祛邪为主,以补肾填精、清瘀化浊诸法并用,同时注意调养精神,保持心情舒畅,注意饮食适宜,劳逸适度等,亦是综合施治不可缺少的环节。

龚文德临床经验

[《中华实用中西医结合杂志》]

1. 大发作类型 以全身肢体阵挛、抽搐、伴意识障碍为主症。如兼脉弦滑、苔腻、喉中多痰、口吐白沫者,乃系气逆动风、气痰郁闭心窍之证。宜温胆汤加沉香、远志、郁金、石菖蒲、石决明、钩藤等涤痰开窍、降气平肝、熄风镇痫。舌红苔黄腻、脉弦滑、情志烦者,乃系气、风、痰、火互激、心窍闭甚之证。宜芩连温胆汤加柴胡、栀子、石菖蒲、郁金、石决明、钩藤、沉香等清泄心胆痰火之闭、降逆平肝而熄风镇痛。抽搐热甚,不省人事,频繁发作,发作前感气冲胸闷、咽窒、头痛剧烈,乃气机逆乱、风甚痰壅之证。宜五磨饮子顺气降逆为主,加白芥子、半夏、天南星、石菖蒲、远志、郁金涤痰开窍,加入石决明、赭石、钩藤等,疏郁通阳,熄风开窍。大发作兼脉象细散,舌绛或红光无苔者,证系气火益耗真阴,淫肝动风,心神失舍之证。宜大定风珠峻补真阴,镇潜熄风。全身抽搐意识障碍,面色苍白,肢冷汗出,小便失禁,脉缓细弱,舌淡苔白者,此系气火耗损真阳,阳虚风动,心神失舍之证。宜人参、附子、熟地黄、山茱萸、五味子、龙骨、牡蛎、巴戟天、肉苁蓉、菟丝子、龟甲、鳖甲、益智仁等扶阳济阴,镇潜固涩、熄风安神。

2. 局限性阵挛 以单侧肢体阵挛为主症,如舌淡苔红,脉弦滑者,属气逆动风,夹痰浊淫筋之候。宜柴胡疏肝汤加木



瓜、石决明、钩藤、半夏、天南星、沉香等。疏泄平肝、涤痰熄风。舌红少苔者，属气火耗损肝肾阴血、虚风内动之证，宜生地、当归、白术、枸杞子、菊花、女贞子、梔子、黄芩、石决明、钩藤等，滋益肝肾，清泄气火，平肝熄风。

3. 小发作 以失神、梦游、幻觉、神志狂躁等为主症，如痰多，苔腻，脉弦滑者，则为气痰郁闭心胆、神失守舍之证。宜温胆汤加石菖蒲、远志、郁金清泄少阳、三焦气机，开泄心胆、气痰郁闭；舌红苔黄厚腻者，宜上方加黄连、黄芩、梔子、大黄、竹沥泻火涤痰、泄闭宁神。如舌红苔薄，或不苔者，属气火伤耗肾阴、心火扰神之证，宜黄连阿胶鸡子黄汤，滋阴降火、宁心安神；舌红无苔者，宜上方加天冬、麦冬、玄参、百合以增滋阴功效，更助气火从速降泄。另有小发作前常见心悸、恐惧、面潮红、汗出之兆，继而则失神，其脉虚弱，舌淡嫩苔薄，系气火耗损心阳、心神浮越之证，宜桂枝龙牡汤助心阳，镇潜敛神，加生地黄、麦冬、五味子生津敛阳，且防温药复燃气火之虑。如心悸、恐惧、舌淡嫩、苔白滑、脉虚滑者，此乃气火耗损心阳、水气凌心之候。宜上方加茯苓、白术，健脾利水。

4. 自主神经性发作类型 以头晕、头痛、面部潮热、胃痛、腹痛、呕吐等为主症。其辨证：头痛如劈伴呕吐，心烦易怒，面赤，脉弦数，舌偏红苔黄者，属气火上逆，宜龙胆草、黄芩、柴胡、梔子、薄荷、石决明、川芎等清泄气火、平肝降逆；头痛，呕吐涎沫，苔白腻，脉象弦滑者，乃肝气犯胃夹饮邪上逆，宜吴茱萸汤合小半夏加茯苓汤，加石决明、赭石平肝和胃、降逆散饮。头痛，头晕，舌红无苔，面潮红，脉弦数者，属肝肾阴虚、虚阳上亢。宜大补阴汤加龙骨、牡蛎、石决明、钩藤等滋补肾阴、平肝潜阳。头晕且重、呕吐、痰多、脉弦滑、苔腻者，属肝风夹痰浊上扰清空，宜导痰汤加天麻、钩藤、石决明等平肝熄



风、导痰化浊。如腹痛剧作，痛则欲泻，面青唇紫、脉弦、舌淡苔薄者，属肝气犯脾。宜痛泻要方疏肝健脾、敛肝缓急。如卒然胃痛，面青唇紫，脉弦，舌淡苔薄者，属肝气犯胃，宜香苏饮加佛手、八月札疏肝理气、平肝和胃。

杨杏林临床经验

[《中医文献杂志》]

癫痫虽然病因复杂，症状多样，但其因痰邪面作则一。若痰浊凝聚，阻于胸膈之间，影响气机，瘀阻脉络，进一步可引起风、火、气、瘀等病理变化，并相互搏结，冲扰心神，蒙蔽清窍，因此，发生癫痫。婴幼儿病证，虽多由胎产、惊恐、热毒等引起，其实也与痰邪有密切关系。婴孩神气未充，气机易乱，或因母腹中受邪，或卒受惊恐，或由热邪肆虐，致使痰涎内生，脏气逆乱，神不守舍，舍空而痰乘之。所以，痰邪是癫痫发病之根源。

痰为阴邪，性质黏腻而胶着，本不易消除。对于深遏潜伏、黏腻胶着的病痰，在治疗时若仅用一般的化痰之品，则较难动其毫末而取得满意疗效。《内经》说：“甚者折之，结者散之，留者攻之”，病痰既胶腻痼着，就需用破涤力劲、开导推动之药物，以驱实邪之积聚，辛热开破法即为此目的而设。乌头、半夏、天南星、附子、白附子、石菖蒲、姜等，以振奋阳气，推动气化，起到开气机之壅闭、捣沉痼之胶结、破痰邪之积聚、促顽痰之消散的作用。这种治法在汉代就有所见，《中藏经》中治风痛，用天南星为末，姜汁糊丸，以人参石菖蒲汤送服。宋元之后此法则日益倡行，如《圣济总录·卷十五》载有五生丸，用干姜、乌头、附子、半夏、大豆等治疗痼疾。《杨氏家藏方》用天南星、半夏、附子、白附子、天麻、白矾、朱砂等，治疗头目眩晕、风痰、头眩臂痛等症。《和剂局方》中有三生饮，由生天南



星、生附子、木香、生川乌等组成,治疗痰厥气逆,以及中风口眼歪斜等症。《证治准绳·类方》用川乌、附子、天南星、半夏、干姜、生姜等治疗风痫有痰者。现代应用如《实用中医内科学》治疗阴痫,法以温阳除痰,顺气定痫,用五生丸以二陈汤送服。

古代使用本法时,对辛温药物大多生用,主要取其飙疾刚悍之气,而尽开破结聚之功,可直达病所。《韩氏医通》中就说:“标病攻击宜生料,气全力强”。但此类药大多有一定毒性,特别是乌头、附子、天南星、半夏等药生用毒性较大,故宜谨慎。笔者在临床应用时,处方煎剂多用炮制药;而制作丸剂时,选择生药,但应按照炮制规范加以漂制,以减轻毒性。现代药理学研究表明,川乌、天南星均有一定的抗惊厥作用,半夏虽无抗惊厥作用,但有较强化痰散结功效,故临床上常作为治疗癫痫的药物。为减少此类药的毒副作用,在处方配伍时可使用一些监制毒性的药物,如生姜可解半夏之毒,黑豆善解乌头之毒等。给药时,还应注意处方用量和给药方法,量不宜大,服用间隔时间适当延长,以8小时为宜。

在临床应用时常配伍蜈蚣、白僵蚕、全蝎等虫类药,熄风平肝,搜剔经络之风邪;丹参、川芎等血分药化瘀通经,疏通脑络;枳壳、柴胡、八月札等行气消痰;白芍、当归等养血柔筋。若有郁火者,加用黄芩、栀子;抽搐频作,肝风明显者,加生龙骨、生牡蛎、羚羊角粉;症见脾气虚弱者,加党参、茯苓;有肾气不足者,加桑寄生、杜仲。临床中可根据患者的发作情况,使用汤剂或丸剂。大抵发作期给予汤剂煎服;休止期可制成丸剂服用。此法既善开破散结,又能祛风止痉,标本兼顾,休作两宜,从而促使顽痰消散,癫痫停止发作,故能作为主要治法,用于各类癫痫发作和癫痫的各个阶段,贯穿治疗的始终。



周仲瑛临床经验

[《江苏中医药》]

治验：李某，女，20岁。患者10余年来反复发作昏厥抽搐之症，多在黎明之时发作，发时突发昏仆，伴有肢体抽搐、口吐白沫、咬破舌肌等症，发后昏睡，醒后如常人。多家医院诊断为癫痫病，但服苯妥英钠等抗癫痫药不能控制，遂求中医诊治。平素常苦头角昏痛，口干喜饮，纳可，二便正常。舌苔薄，舌质红，脉细弦兼数。病属痫厥无疑，证属心肝火盛，风痰内闭，久病阴伤。治以化痰熄风，清心平肝，滋养肝肾。处方：钩藤15g，紫贝齿30g，蝉蜕5g，白僵蚕10g，陈胆南星5g，大生地15g，白芍12g，炒黄芩10g，阿胶10g（烊冲），丹参12g。7剂，常法煎服。另：定痫丸，每次1包，每日2次，口服。二诊：药后昏厥抽搐之症发作减少，仅发作过1次，现自觉心慌、内热，舌苔薄、舌质偏红，脉细滑。药已中的，原意再进，佐清虚火。原方加白薇12g，7剂，常法煎服。继续口服定痫丸，每次1包，每日2次。后未再发作。

按：痫之为病，“无非痰涎壅塞，迷闷心窍”（《丹溪心法·痫》）。痫病主要病理因素为痰，病位主要在于心肝二脏，关于脾肾。然痰聚为病，每因气郁痰聚，或痰聚气郁，气逆不顺，乃致风火内动，挟痰上蒙清窍，内扰神明，横窜经络，痫证始可作矣。因此，治痫除熄风化痰外，必须参以顺降气机、清心安神之品。黎明阳气始升，外阳引动伏痰，故患者每于黎明之时发病，亦提示患者素为心肝火盛之体；舌苔薄质红、脉细兼数，且病已历10年，证明其有肝肾阴伤之证。

全方以钩藤、紫贝齿平肝熄风；以蝉蜕、白僵蚕、陈胆南星熄风化痰；炒黄芩清泻肝火，有加强大脑皮质抑制之镇静作



用；阴津耗伤，不能正常输布运化，聚而成痰，因此，加入生地黄、白芍、阿胶 3 品，养阴扶正，以冀津液充沛而濡化黏聚之痰。阿胶一味兼能滋阴补血，用于女性病家尤宜；久病络瘀，且痰瘀同源，因此，佐入一味丹参活血化瘀通络，以防瘀血阻滞，影响津液正常输布而加重痰浊之患。丹参并有安神宁心作用，故用于此十分贴切患者病机。诸药合用，共奏熄风化痰、清心平肝、养阴活血之功。定痫丸一药，亦以天麻、川贝母、胆南星、姜半夏、陈皮、茯苓、石菖蒲、全蝎、白僵蚕熄风化痰，以茯神、丹参、远志、琥珀、辰砂宁心安神，配合麦冬养阴，故与汤药相得益彰，协同奏功。故一诊 7 剂药物即已显效。二诊又加入擅清虚热的白薇一药，以除新添心慌、内热之症。白薇并能“主暴中风，身热肢满，忽忽不知人，狂惑邪气，寒热酸痛，温疟洗洗，发作有时”，陶弘景云白薇“疗惊邪、风狂”。盖虚热除则津自生，津生则津气流布畅达，自然不能聚而成痰为痫，故诚为治痰之本也。因此，药虽 14 剂，治仅旬余，但由于用药贴切，10 年顽痰竟能除矣。先生用药之神，于此可见一斑。

熊杰临床经验

〔《武警医学》〕

1. 大发作 大发作为小儿癫痫中常见的类型。发病率约占小儿各型癫痫中的 75%~80%。主要临床表现：突然昏倒、四肢强直性抽搐、口吐白沫、神志不清等，醒后如常人，伴头痛、乏力。从中医而言，“诸风掉眩，皆属于肝”、“诸暴强直，皆属于风”。故治疗当镇惊熄风，采用《儿科准绳》的“涤痰汤”加减，药用石菖蒲、茯苓、陈皮、太子参、胆南星、半夏、青果，旨在益气安神、豁痰熄风。加减：抽搐频繁发作加生铁落（先



煎)、磁石(先煎)、羌活;便秘加大黄、芦荟;阳虚伴智力低下加八味丸。

2. 精神运动性发作 以精神症状为主,主要表现:周期性发作,伴语言兴奋、恐怖、精神抑郁、幻听、幻视、反复发作等。多因痰气逆乱而伤心神,属中医的“惊痫”、“痰痫”等范畴。治当顺气豁痰、清心开窍。治疗用自拟的抗痫散、药用石菖蒲、胆南星、茯苓、天麻、羌活、枳壳。加减:夜泣加磁石、铁落;寐不安加琥珀、远志。

3. 小发作 有的癫痫患者仅表现为一过性意识丧失,如愣神、头目眩晕,或仅限于某一局部肌肉的抽动。此证型较难治。药用《幼幼集成》的定痫丸,药用石菖蒲、天麻、远志、茯苓、胆南星、丹参、全蝎,意在理气健脾、豁痰熄风。加减:频繁发作加莲子心、琥珀;头晕、目眩重者加大麻以疏肝风;夜寐汗出者加龙骨、牡蛎,以敛液止汗、滋阴潜阳。

张介安临床经验

[《辽宁中医杂志》]

1. 豁痰治痫消积导滞 中医认为:“痫因痰生”。如《医学纲目·癫痫》曰:“癫痫者,痰邪逆上也”。在发作时常呈现昏不识人、喉中痰鸣、或口吐涎沫等痰涎壅盛、蒙闭心窍之症。张师认为:痰是脏腑功能失调的病理产物,也是导致各种疾病的根本因素之一。主张由痰致痫,当治生痰之因。正如张景岳所说:“然痰之为病,亦唯为病之标耳,就必有生痰之本。”小儿因痰致痫有平素脾胃积热生痰、惊风之后余热不尽生痰、脾虚生痰3种,而以脾胃积热生痰者最为常见。因近年来,人们生活水平提高,父母过于溺爱,常以高蛋白、高脂肪饮食,致小儿脾胃功能受损,食谷难化,停于中焦,积久生热,热灼津液,



炼津成痰，痰阻清窍而致病。这种由脾胃积热致痫，中医又称“食痫”。也是小儿诸痫中发病率较高的一类。食痫的发生与痰有关，是继发于饮食停积之因，故张师擅长导滞豁痰法治疗食痫，能明显减少或控制痫证发作。药用：厚朴、茯苓、鸡内金、焦山楂、麦芽、白僵蚕、天竺黄各 10g，建曲、陈皮、蝉蜕各 6g。方中厚朴辛苦温、行气宽中，消除膨胀为主药；辅以鸡内金、焦山楂、麦芽、建曲消食化滞；茯苓、陈皮健脾和中为佐；天竺黄、白僵蚕、蝉蜕化痰熄风为使。诸药配合共奏消积导滞、豁痰熄风之功。若痰热重加川贝母、胆南星；顽痰不化加青礞石。

2. 熄风定痫平肝为要 中医认为：“风性善行数变”“风性主动”《内经》曰：“风胜则动”、“诸暴强直，皆属于风”。临床将卒然昏倒，不省人事，四肢抽搐，甚至颈项强直，包括搐、搦、掣、颤、反、引、窜、视等八候，都归属风的病变。这些证候反映在体表与人体的筋、目和精神状态有关。而肝主筋，开窍于目，又和精神活动有关。故痫证从风论治责之于肝。临床常言“肝风”。即身中阳气之动变，因其不同于外风，故又称“内风”。如《素问·至真要大论篇》曰：“诸风掉眩，皆属于肝。”基于以上，张师在痫证治疗过程中，一是重视肝经药物的应用，可使药物直达病所，而充分发挥作用。二是重视动物、矿物药物的应用，取其重镇潜阳、祛风解痉，达到止痉目的。如石决明、磁石、龙骨、牡蛎、鳖甲、龟甲、全蝎、白僵蚕、蝉蜕、琥珀等。三是在各种类型的痫证中都佐以熄风药。张师认为：痫证的发作，无论症状轻重，往往诸型交错互见，不同程度的伴有风动的临床表现，如常见有热极生风、血虚生风、痰浊生风等。因此，熄风药是治疗各种痫证必不可少的。常用药物除动物、矿物药外，尚有天麻、钩藤、白蒺藜、白芍等。



3. 补虚断痫、治本之谋 前人提出：补虚断痫，以图其本。张师认为：痫证无论处在缓解期，或是发作期，其主证以一派虚象呈现，都要从补虚的角度出发。这样既可达到断痫，又可达治本防复发的目的。小儿痫证久发不愈，慢脾风久治不愈而成痫者，多属虚痫一类。临床以抽搐无力，少气懒言，神倦体乏，两目乏神，面色少华，形体消瘦，表情淡漠，或反应迟钝，或多涎，便溏为主证。张师补虚断痫常从养血、健脾两方面着手。前者宗“治风先治血，血行风自灭”这一要旨，采用养血熄风法治疗由肝血不足所致血虚风动之证。并依据“气为血帅”、“气旺血自生”之理论及“脾为气血生化之源”的生理。常常肝脾同治，选以当归补血汤合参苓白术散。若因肝阴不足累及到肾阴亏虚，则宜肝肾同治，以六味地黄丸为主加味应用。肾水壮则能涵养肝木所谓“乙癸同源”也。后者以健脾化痰法治脾虚痰浊生风证。由脾虚痰湿内生，其本于脾失健运。如《幼幼集成》曰：“盖病源深固，但可徐图，惟以健脾补中为主，久服痰自不生，痫自不作矣”。故以参苓白术散加化痰剂，并少佐熄风之药。张师强调：本病往往缠绵难愈，虚损之证又难复。固治疗不要随便更弦易辙，须坚持服中药控制不发作1~2年左右，方能停药，或改间断服药，直至痊愈。

总之，在治病中，豁痰重在辨治生痰之因，熄风则注重择其入肝经平肝风之动、矿物药物，补虚不离养血、健脾之法，验之临床，实为治病诸法中之要义。

杨廉德临床经验

[《甘肃中医学院学报》]

1. 理升降、取任督相配 杨老认为，痫证多因气机逆乱，痰涎壅塞，蒙蔽清窍所致。气机逆乱，则必升降失常，以致清



不升而浊不降。杨老经验：当此时宜通调任督阴阳气机，以升清降浊，开窍醒神。杨老临证处方常分为2组：①主穴：腰俞。向上刺入骶骨裂孔中2寸许，得气后使针感上传。配百会、四神聪、风府、风池。②主穴：气海。得气后使针感下传。配百会、四神聪、风池、风府、神门、申脉、照海。以上诸穴针刺手法均为平补平泻，留针半小时，间歇行针3~4次。上述两组处方分别以督脉的腰俞和任脉的气海为主穴。督脉总督诸阳脉，并于脊里，上至风府，络脑，贯心属肾。取督脉之腰俞，针刺时力求使针感上传，意在升举清阳，配以百会、风府、风池及四神聪等穴，兼具化痰熄风、开窍醒神之功能，同时可增强升举清阳之功，清阳升，则浊阴自降；任脉为阴脉之海，取其生气之源气海穴，针刺时力求使针感下传，其意在降浊阴。当此时，昼发者配阳跷之申脉穴，夜发者配阴跷之照海，再配以百会、四神聪，使降中有升，升降相因，开合相配，从而达到清升浊降，开窍祛邪之功。

2. 细辨证、宜针药合用 中药治疗须辨证分型，按证处方；针灸治疗则须辨病位与辨经络相结合。病位为人体之脏腑，经络则是联系脏腑、反映气机与病势的重要途径。疾病的发生和发展及临床证候虽然错综复杂，但究其实质，则不外乎脏腑与经络功能的失调。杨老临证，尤其强调此点，常谓辨准病属何脏何腑，即可起到提纲挈领的作用。对于痫证，杨老认为其病与脑相关，因“脑为元神之府”；此外，在病位方面还与心脾相关，心藏神，脾藏意主湿，二脏功能失调，神不安位，痰气凝结，成为痫证的发病因素。但其发生所最关重要者，莫过于阴阳阻隔，气机逆乱。此又与督任二脉密不可分。基于这一认识，杨老治疗痫证常取督脉之腰俞与任脉之气海为主穴，欲以通调任督，恢复气机正常运行。治疗痫证时，督脉有一经



验效穴腰奇,杨老即取位于腰奇,同时结合解剖学知识,以腰俞易腰奇,使毫针刺入骶管裂孔,加大刺激量,提高疗效。在通调任督阴阳气机的基础上,再加取丰隆、太白、神门、内关以调理气机,健脾利湿,宁心安神。

第二节 精神异常

常蔚临床经验

[《陕西中医》]

单纯型精神分裂症具有中医学的“脏躁”和“百合病”的证候特征,运用上述两病的病理分析和临床治疗来对待单纯型精神分裂症具有一定的临床治疗意义。中医学认为本病发生的主要原因:①突受惊恐,情志不遂,气血瘀滞,阴阳失调;②素体阴亏,恼怒思虑,郁久化火,阳亢阴损。因此,这类疾病在临床上常可见到失眠倦怠,疲乏无力,精神错乱,哭笑无常,不由自主等,但做体检却没有器质性损伤的证据。因此,对于这类病变中医学则从解郁清热,养阴宁心着手进行辨证施治。笔者近年来对这类疾病常用四逆散合用百合阿胶鸡子黄汤加减进行药物治疗,对于病情较重者可结合针刺有关穴位、按摩、理疗等方法同步进行施治则效果更为理想。方药:醋柴胡、枳壳、芍药、甘草、百合、阿胶(烊化)、鸡子黄冲服。临证加减:若临床见失眠、心悸重者上方加炒酸枣仁、夜交藤;若心烦懊恼急躁重者上方加黄连、朱砂;若神昏迷乱、哭笑无常重者上方加石菖蒲、胆南星、鲜竹沥等。

治验:患者,女,32岁。因家事不遂,心情不舒,长期郁闷不乐。又与家人生气致使食少、倦怠、神昏、失眠、哭笑不自



主,孩子不知照顾,家务活农活不知料理,喜一人独处。症见:面色憔悴、神情呆滞、目睛不灵、舌淡苔薄白、少津、脉沉细弦。诊断:单纯型精神分裂症。治则:解郁清热,益心安神。处方:醋柴胡 15g,枳壳 12g,赤芍 20g,百合 30g,阿胶 12g(烊化另包),石菖蒲、炙甘草、胆南星各 9g,鲜竹沥水 30ml,鸡子黄 1 枚冲服。上方 3 剂后症状缓解,10 剂后痊愈,嘱其经常服逍遥丸、补心丹以善后,并嘱其家人改变家庭状况,经常给予精神上的安抚照料,使其心情舒畅,气血和调,自乃康复。

按:本类患者所用方药的临床作用原理前人早有阐述。黄竹斋:“四逆散解郁泄热,调和肝脾,柴胡、枳壳能升能降能开泻,芍药、甘草能收能敛能舒和,四药并用具有升降开合,通阳宣郁之效”。又“百合病者,精神病之一”。陈修园:“百合病……或繁多思不断,情志不遂,或偶触惊疑,猝临异通,以致行走、坐卧、饮食等皆若不能自主之势。”现代医学研究,本方具有解热、镇静、护肝、消炎等作用。《医宗金鉴》:“百合性善清热解郁而气味甘平,微苦,最宜于元气虚弱之证。”《本草经》:“鸡子黄,安五脏,治热疾。”另外,阿胶乃血肉有情之品,滋补肾阴,与鸡子黄合用则可交合心肾,使水火既济而烦躁可除”。

丁德正临床经验

[《河北中医》]

涤痰化痰理神汤是治疗精神疾病的经验方,对肌肤暗滞,或皮肤粗糙,眶区晦暗,目光呆滞,神情惶惑疑虑,舌质暗紫,或有瘀斑,苔厚腻,或无苔而舌质纹理粗糙,脉沉滑或沉涩等具有痰瘀互结之各种精神疾病治疗效果较好。

药物组成为:枳实、半夏、茯苓、郁金各 15g,海浮石 20g,



胆南星 10g,川贝母、石菖蒲、桃仁、红花、莪术、水蛭、土鳖虫各 15g,丹参 20g,甘草 10g,大黄(后下)15g,琥珀(研末分 3 次冲服)3~6g。水煎分 3 次服。本方中以半夏、茯苓健脾燥湿化痰;枳实、海浮石、胆南星、川贝母、郁金、石菖蒲逐痰开结;丹参、桃仁、红花、莪术、水蛭、土鳖虫、琥珀破瘀通窍;另藉大黄通腑泻下之力以助痰瘀下行。本方涤痰化瘀,通窍理神,适用于痰瘀垢结、滞碍神明所致各种精神疾病。

1. 人格解体综合征 人格解体综合征呈痰瘀证者,病程较久,缠绵难愈,其非真实感和同自身或环境的疏远感甚重,患者甚为焦虑苦楚。治疗可于涤痰化瘀理神汤中加独活 15g,羌活 12g,生姜 15g,葱白 3 根,藉此类药物之辛散通阳之力,宣散透泄心脑痰瘀,能较快改善和缓解症状。

2. 强迫性神经症 此症呈痰瘀证者,病程亦较久,强迫性动作及为某个问题之穷思极虑殊重,明知无谓,甚难自制。治疗可于涤痰化瘀理神汤中加开郁镇心之品,如柴胡、香附、甘松各 15g,磁石、龙齿、珍珠母各 30g。

3. 焦虑性神经症 此症呈痰瘀证者,阵发性恐惧焦虑感出现较频,昏厥时发,治疗可于活痰化瘀理神汤中加宁心解虑之品,如酸枣仁、柏子仁各 15g,龙齿、磁石各 30g,柴胡 15g,合欢花 12g。

4. 抑郁症 抑郁长期不愈,反复发作,气郁阻津生痰,或气滞致血行不畅为瘀,导致痰瘀互结证。此症患者抑郁忧悔,疑虑多较重,且痛不欲生。治疗重在涤痰化瘀,少辅疏郁之品,涤痰化瘀理神汤中郁金加量为 30g,另加柴胡 15g,青皮 9g,木香 9g,香附 15g。

5. 躁狂症 躁狂病久,内为燔盛,炼液为痰,或灼血为瘀,易成痰瘀证。痰瘀扰乱心脑神明,使躁狂发作之间歇期缩



短,症状加重,呈重躁狂及谵妄性躁狂,语不连贯,狂乱,且有错觉、幻觉出现。予涤痰化癥理神汤去半夏、厚朴、远志;心火盛者加黄连 15g,木通 9g,生地黄、玄参、栀子、天竺黄各 20g,赤芍 15g;肝火盛者,加石决明 30g,龙胆草 24g,黄连、黄芩、天竺黄各 15g,生铁落(布包先煎)30g。

6. 精神分裂症青春型 此型多由痰火上扰所致,病久不愈,痰火渐增,呈痰热癥浊内蕴之证;此时兴奋狂乱大减,幼稚呆甚,独语独笑,问之多不答,或答非所问,舌质暗红,苔黄浊厚腻,或中后焦黄,脉沉滑。治疗将涤痰化癥理神汤中郁金量加为 30g,大黄加量为 50g,并以开泄痰热力大之浙贝母 24g 易川贝母,另加逐泄窍隧痰癥浊热之天竺黄、青礞石、芒硝各 20g,于首煎 1 次冲服。

7. 精神分裂症偏执型 此型发病缓慢,由痰或癥单独致病而多演变到痰生癥,或癥生痰之痰癥交垢之证。多种妄想如迫害、夸大等相继丛生且多种幻觉悉具。予涤痰化癥理神汤痰癥并祛。若敌视一切,冲动攻击,伤人毁物,面目红赤,舌质暗红,苔灰黄厚腻面干,脉滑数,属痰癥浊热者,加天竺黄 24g,赤芍、栀子、牡丹皮各 15g,大黄加量为 50g;若虚烦不寐,恐惧紧张,叹息忧虑,胁肋拘急,目疏,脉弦细,舌质淡红而暗,兼肝气虚者加补肝之品,如黄芪 30g,党参 20g,酸枣仁 24g,五味子 20g;若孤僻怪异,独语妄笑,神情惶怯,目光冷凝,肌瘦肢冷,唇色淡,舌质淡暗,苔灰白滑腻,脉沉细而兼阳虚者,加益气扶阳之品,如黄芪 30g,桂枝 20g,白术 24g,炙甘草 20g;若肌瘦,而色萎黄而暗,神情惶惧,目光少神,怔忡悸慌,心烦不寐,健忘眩晕,唇舌色淡,脉细弱而兼血虚者加益血之品,如当归 24g,熟地黄 30g,酸枣仁 30g,柏子仁 15g;若肌肤略虚浮,肤色黄暗,纳差便溏,呕恶欲吐,或腹胀满,舌质淡暗,



苔灰白水滑,脉细弱,兼脾虚湿盛者加健脾利湿之品,如白术 39g,川厚朴 15g,炮姜、砂仁、白扁豆各 15g,陈皮 10g。

痰瘀内蕴日久,可蕴酿为毒,痰瘀毒邪侵害心脑血管神明,神明更加淆乱,精神症状更加严重,毒偏于阳者,颜面唇舌红而隐晦,或紫晦,口干,烦躁,或皮肤生疮疖,痒疹,搔之流黄水,宜于涤痰化瘀理神汤中加苦参 20g,野菊花、蒲公英、连翘、牡丹皮、栀子各 15g,大黄 50g;毒偏于阴者,颜面唇舌多青晦而暗,或呕吐清涎,躁急难耐,鼻淌腥臭浊涕,或大便骛溏,宜于涤痰化瘀理神汤中加苦参、藿香、苍术各 15g,干姜 12g,丁香 6g,大黄 30g。

病久则痰瘀垢结日深,胶结心脑血管隧愈甚,诸种妄想与幻觉愈加牢固,治之甚难缓解。可将方中水蛭、土鳖虫皆加量为 24g,加蜈蚣 3g,重用此善行钻透之虫类药,以尽其搜剔胶结心脑血管痰瘀之能事;或每隔 1 周加服麝香 0.18g(吞服),以开窍慧神,助心脑之速清。

邹锦山临床经验

[《中国中医基础医学杂志》]

《医林改错》癫狂梦醒汤,方由桃仁、当归、大黄、紫苏子、前胡、芒硝、牵牛子、沉香、甘草、陈皮、厚朴组成。以理气破血两组药物为主,达到气行血畅、脑气与脏气相接,具有醒脑开窍之功。若有兴奋激越、彻夜难眠者,去牵牛子,加龙胆草、制酸枣仁、远志、龙骨、牡蛎。若见症状呈周期性发作者,去芒硝、牵牛子,加红花、郁金、三棱、柴胡、枳实。若有头部跌打损伤者,去芒硝、前胡、紫苏子,加红花、郁金、丹参、远志、石菖蒲。

1. 精神分裂症 患者表现:言语增多、错乱,兴奋躁动,



如见鬼状或疑人相害妄听狂语,行为紊乱,喜怒无常或无故痴笑,甚则登高而呼,弃衣而走,伤人毁物,彻夜不眠,面红易怒,纳食不振,大便秘结,舌质红、苔黄或厚腻,脉弦涩。方选癫狂梦醒汤加减,药用桃仁 9g,红花 6g,当归 9g,大黄 12g,龙胆草 12g,紫苏子 10g,沉香 9g,芒硝 20g,陈皮 9g,制酸枣仁 20g,龙骨、牡蛎各 30g,每日 1 剂,水煎服,2 个月为 1 个疗程。

2. 周期性精神病 患者表现:兴奋躁动、语无伦次、行为紊乱、高歌哭闹、伤人毁物,或表情呆滞,反应迟缓,痴笑发呆,懒床不食,每月准时发作 1 次,症状相同。间歇期症状消除彻底,抗精神病药物治疗无效,发病至少 3 个周期。方选癫狂梦醒汤加减。药用桃仁 9g,红花 6g,当归 9g,三棱 15g,莪术 15g,柴胡 10g,郁金 15g,枳实 10g,香附 10g,陈皮 9g,厚朴 10g,大黄 12g,赤芍 12g,牡丹皮 10g,每日 1 剂,水煎服,3 个月为 1 个疗程。

3. 颅脑外伤所致精神障碍 患者表现有确切的颅脑外伤史,往往伴有短暂的意识障碍或昏迷史。经抢救治疗后出现失眠多梦、头晕、躁动不安、敏感多疑及孤僻、乏力健忘,甚则兴奋不安、语言错乱、秽语冲动、伤人毁物、自伤自残、目不识人,其舌质红、苔薄黄、脉细涩。方选癫狂梦醒汤加减,药用桃仁 9g,红花 6g,当归 9g,生地黄 15g,陈皮 10g,厚朴 10g,丹参 15g,郁金 15g,赤芍 10g,茯苓 12g,远志 10g,石菖蒲 20g,每日 1 剂,水煎服,1 个月为 1 个疗程。

患者“瘀”的症状不明显,舌脉如常,但却有明显疗效,特别对周期精神病可收顿挫之效,并体会到精神疾病之“瘀”与其他疾病不同。理气活血化瘀法治疗精神疾病时,对兴奋躁动、阳狂有余者疗效尤佳。但如果患者有出血倾向,要注意用药调整,预防患者大出血。



郝万山临床经验

〔《光明中医》〕

精神抑郁症是躁狂抑郁性精神病的发作形式之一。郝万山教授运用独特的中医辨证理论及治疗方法,单用中药或适量配合应用抗抑郁西药,取得满意疗效。郝教授认为本病的病机为心胆阳虚,脑神失养,肝气郁结,神窍痰蒙。

根据以上分析,本病治疗应温补心胆阳气,益肝兼助疏泄,养脑涤痰醒神,当属对本症的根本治法。选柴胡桂枝汤、温胆汤、定志小丸、四逆散等合方化裁,各以柴桂温胆定志汤,并据病情予以加减。

方药组成如下:柴胡、黄芩、桂枝、赤芍、白芍、半夏、生姜、陈皮、茯苓、人参、石菖蒲、远志、枳壳、竹茹、大枣、炙甘草。方用人参补五脏、益元气、安精神、定魂魄、开心健脑。茯苓利窍去湿导浊,补心益脑醒神。石菖蒲、远志豁痰开窍、振心阳、益智慧、醒脑神。但温补心阳、振奋肝胆、疏达郁结、涤痰导浊之力均不足。于是配小柴胡汤疏达郁结、振奋肝胆脾胃;伍桂枝汤,取桂枝、甘草等辛甘化阳以温补心阳;配温胆汤以增强涤痰醒神定志之力。

方中黄芩、竹茹不宜轻去,因抑郁发作期间,虽以阳衰、气郁、痰蒙为主,但气郁之处必有伏热,痰郁既久,每易生火。当抑郁症状基本控制,舌质转为红活时,应去“善鼓心包之火”的石菖蒲、远志,人参易以太子参或党参,桂枝减量,以防阳复太过,火邪复起而转为躁狂症。

此外,《伤寒论》小柴胡汤可治邪郁少阳、枢机不利、胃气失和所致默默不欲饮食、心烦、胸胁苦满等症。和本症肝胆郁结、疏泄失司,胃纳呆滞所致的情感抑郁、食欲不振、胸胁烦闷



等颇同。《伤寒论》桂枝汤可治邪伤经脉、气血失和所致的“肢节烦痛”、“身痛不休”，倍芍药又治腹满时痛。和本症阳虚失温、痰浊阻滞、气血不畅、脉络失和所致之肢体、内脏窜痛、四肢麻木无知觉等相似。

治验：管某某，女，42岁。患者因心情抑郁、头昏头痛5个月，加重3个月，由家属陪同来就诊。5个月前，因不明原因的疲劳无力，反应慢，完不成工作而心情郁闷，并常有自责自疚感。至就诊时已逾3个月不能正常工作及料理家务，因痛苦不堪忍受，时时有自杀念头。现症见两目呆滞、愁容满面、端坐不动、问而不答。病情由家属代述，且手足冰凉、脉细小而弦而数，舌体胖大，舌质暗淡，舌苔白厚腻。西医诊断：躁狂抑郁性精神病，抑郁型，重症。中医诊断：郁证，辨证为心胆阳虚，脑神失养，肝虚气郁，神窍痰蒙。治疗即用温补心胆、舒郁涤痰之法。方用柴桂温胆定志汤和西药多塞平。中药处方如下：柴胡、黄芩、桂枝、赤芍、白芍、半夏、生姜、陈皮、枳壳、竹茹、远志各10g，茯苓20g，人参5g，石菖蒲6g，炙甘草6g，大枣5枚，水煎2次，分2次服，每日1剂。用药后3日，头痛身痛已减，用药5日，上午可起床活动，食欲不振好转，不再想死。用药后4周诸症已得到控制。此时中药去石菖蒲、远志，以太子参易人参，桂枝减量，隔日服1剂，继服2周。用药6周后已可正常上班，停腹中药。

胡珍香临床经验

〔《中医函授通讯》〕

精神情志疾病表现多样，应用针灸治疗效果卓越。

1. 十七鬼穴的运用 十七鬼穴包括人中、承浆、颊车、少商、大陵、隐白、间使、风府、舌下中缝、会阴、曲池、申脉、上星、



神庭、乳中、阳陵泉、行间。此法可治一切精神疾病，使用方法有两种：其一，根据病证辨证属于何脏何经，则专用该经上的鬼穴治疗；其二，将十七个穴位轮流使用，每2~3穴，或针或灸，视病情而定。

2. 五心针的运用 五心针是指顶心百会、手掌心劳宫和定掌心涌泉，最好左右5针同时进针，不然则先针涌泉，继而劳宫，最后百会，且强调“男左女右”，即针男患者时，先取左涌泉、左劳宫，女患者则反之。此3穴具有很强的醒脑开窍、清利神明的功效，涌泉还兼有滋水抑阳之功。5穴同时进针，更加功专效宏，尤其适用于痰火蒙蔽心神之证。

3. 四关穴的运用 四关穴指双合谷、双太冲，二穴同为原穴，上下相配，调气和血总理气机运化，针对精神情志病气机逆乱的病机，如因思而气结，因恐而气下等，临床疗效显著。

4. 鬼哭穴的运用 鬼哭穴在手指双侧少商及拇指指甲，在足趾双侧隐白，只有灸法，着肤重灸，每用一壮，让患者产生一定的疼痛，临床疗效可靠。

5. 膀胱经背部第二条经线的运用 膀胱经背部第二条线善于调理五脏六腑之“神气”，主神明的穴位相当集中，如魄户、神堂、魂门、意舍、志室等。用皮肤针轻扣该线全程，左右交替，至皮肤潮红，微有出血为度。此法可用于一切精神情志病。

6. 跷脉的运用 调理阴阳跷脉尤其能治疗失眠、多梦，以及某些夜间发作或加重的疾病，因为卫气的昼夜流注与跷脉关系密切。治疗方法是针刺阳跷与足太阳膀胱经的3个交会穴——跗阳、仆参、申脉及阴跷脉与足少阴肾经的3个交会穴——照海、交信、然谷，轻者2组穴位交替使用，重者并用，甚者加用阴阳跷之交会穴睛明和阳跷与足少阳胆经之交会穴



风池,针用平补平泻。

7. 调魄法的运用 魄属肺,肺主皮毛,因此,一切痒麻胀痛都归结于魄的功能失调。应在辨证取穴的基础上,加用“调魄”之法,具体方法是选用肺经的俞穴肺俞配合募穴中府,或随意选用手太阴经上的 1~2 个穴位,交替使用。临床表明能显著提高疗效。

陈家建临床经验

[《中国医刊》]

1. 肝胃实热型 狂躁不眠,登高而歌,弃衣而走,两目红赤,大便干结,小便黄赤,舌苔黄厚粗糙,或起芒刺,脉象洪大长数有力。此属实邪,《内经》云:“热淫于内,治以咸寒,佐以甘苦”。方用当归承气汤(当归、大黄、芒硝各 30g,甘草 10g,枳实 15g)。体温增高,汗出者白虎承气汤主之(石膏、大黄、芒硝各 30g,知母、川厚朴各 15g,枳实、甘草各 10g)。若外无表邪,里无痰食,唇焦舌燥,谵语狂乱者,大承气合黄连解毒汤(大黄 50g,黄连、黄芩、黄柏、栀子、石膏各 30g,芒硝 15g,枳实、川厚朴各 10g)急下攻邪,待二便通利,再予清神醒脑之品,如党参、茯神、远志、酸枣仁、木香、石菖蒲等。

2. 心肝实热型 兴奋烦躁,阵发狂越,口苦咽干,胸胁满痛,小便短黄,舌苔粗糙黄薄,脉象弦劲而滑。乃木从火化有余之证,宜开结生铁落饮(前胡、大黄各 15g,生铁落 60g,郁金、玄参、橘红、麦冬、赤芍、生地黄各 10g,沉香 8g,朱砂 5g 冲服)或当归龙荟丸(当归、芦荟、黄芩、黄连、黄柏、龙胆草各 20g,青黛、栀子各 12g,郁金、茯苓、大黄各 20g,龙骨、牡蛎、磁石、青礞石各 30g,木香 10g,麝香 0.5g,朱砂 3g 冲服)平定风火,镇抑躁动。



3. 心肝偏虚型 多言喜笑,细语喃喃,或沉默倦怠,轻度冲动,舌苔白薄或光滑,脉象沉细或细弦。乃心阳偏旺、肝胆郁结所致,治宜疏肝解郁、清心豁痰等法。继用柔肝熄风之属,药用何首乌、菊花、茯神、当归、石斛、续断、郁金各 10g,白蒺藜、远志各 6g,川芎 3g,明矾 15g 溶于药液温服。

4. 心脾偏实型 情绪波动,时悲时欢,歌哭无常,食欲不振,二便正常,脉象多缓,寸部独浮。妇女情欲不遂,或月经闭断而致精神障碍者,则化痰解郁理气。若脉沉弦,舌质红边紫苔白腻者,轻则丹栀逍遥散吞服白金丸 6~10g,或通瘀散加味。重则癫狂梦醒汤,或血府逐瘀汤。蓄血发狂,脉必沉弦,舌色紫暗,小腹硬满而痛,小便自利,大便反黑者,轻则清热地黄汤,重则代抵挡汤加減,终以四物绛复汤养血活络以善其后。太阳病不解,热在下焦,其人如狂,此与久病迥异,当用《伤寒论》桃仁承气汤。产后瘀血上攻,亦宜此汤攻逐,俟大势稳定,再以参茯安神之剂收功。

5. 心脾偏虚型 病起缓渐,多因思虑太过而成。表情郁结悲伤,惊惕不安,事物善忘,面色萎黄,大便稀溏,舌质淡红,苔白涎多,脉象细缓短涩,重按则无。乃心脾两虚,气血损耗,神不守舍,故自惊惕迷瞀善忘,脾气郁结不行,故悲伤倦怠叹息。治宜补气养血,滋益心脾。若病期迁延郁结深固,则重用木香以醒脾、加麝香以通利。

6. 心肾不交型 病积时日,迁延失治,表情轻荡痴笑,心悸怔忡,失眠多梦,耳鸣眼花,舌或赤或光滑,或枯涩而裂如龟纹,舌根润黑或燥黑,脉沉细而数,或微弱难寻。乃心肾不交,非水亏即火弱,如水亏火旺,治宜补北泻南;知母、黄柏、熟地黄、山药、茯苓、山茱萸、牡丹皮、泽泻重剂顿服以制之。如心火炎上,原方佐水牛角,喜笑加酸枣仁、远志、石



萸蒲。躁而不眠，黄连阿胶汤主之。命门火衰，脉沉细微弱，而色惨白，行动呆滞者，又当“益火之源，以消阴翳”，宜附子、肉桂、熟地黄、山药、山茱萸、肉苁蓉、巴戟天、淫羊藿之属或四逆、真武等汤加辰砂冲服。肾为藏精之所，真阴之源，其命门真阳乃生命重要之处，宜蛰藏充盛，不宜泄损亏耗，故治法不用攻克。

包祖晓临床经验

[《四川中医》]

精神抑郁症是临床常见病。根据景岳《大宝论》“一身之活者，阳气也”，“热为阳，寒为阴，热能生物，寒无生意”的论述，认为上述诸症属于阴证，为阳气不足之象。而阳气不足的脏腑归属主要在肝，即肝气虚是抑郁症的基本病机，补肝气法为其治疗的重要方法。

本病的临床特点为：①恹恹不乐、对日常生活丧失兴趣、无愉快感为主的情感障碍，可伴有焦虑、烦躁；②精力减退、思考能力下降、神疲乏力、行为懒散为主的思维和运动迟缓；③腹胀纳呆、面色灰滞萎黄、失眠或早醒或睡眠过多，伴肝经所过部位出现不适；④脉象和舌象呈虚寒之象或变化不大。如出现上述种种征象即可运用补肝气法治疗。《诸病源候论》提出的“肝气不足，则目不明，而胁拘急筋挛，不得太息，爪甲枯，面青，善悲恐，如人将捕之”及张锡纯提出的“左脉不起”可作辨证时参考。

治疗抑郁病肝气虚证，宗《内经》提出的“辛补”、“酸泻”、“甘缓”和张仲景提出的“补用酸，助用焦苦，益用甘味药调之”之大法，临床常用滑伯仁的补肝散（山茱萸、当归、五味子、山药、黄芪、川芎、木瓜、熟地黄、白术、独活、酸枣仁）为基本方。



方中以黄芪、山茱萸、白术补肝气。张锡纯认为黄芪、山茱萸为补肝气要药,谓:“黄芪性温而升,以补肝有同气相求之妙”,“萸肉得木气最厚,温补酸收中大具开通之力,其性不但补肝而兼能通利气血。”(《医学衷中参西录》)宜重用。用山药补脾肾,培补生气之源。因气血互根,气少血必虚,且肝有体阴用阳的生理特点,故用熟地黄、当归养血,酸枣仁、五味子、木瓜酸甘养阴,补肝体以助肝用,以收阳生阴长、刚柔既济之用。配川芎调血,李时珍谓其“升补肝气”。风气通于肝,用独活可引药入肝,助肝用事。本方辛散配酸收,温而不燥,补而不腻,体现了肝脏的用药特点。然后根据病情进行加减,五心烦热、潮热盗汗、口咽干燥者加牡丹皮、地骨皮;脘腹痞闷、舌苔腻者加香附、石菖蒲、苍术;烦躁、烘热者加黄连、肉桂;胸胁刺痛、月经色黑有块、舌暗者加郁金、丹参。

李树年临床经验

「《内蒙古中医药》」

七情即喜、怒、忧、思、悲、恐、惊,是入体对客观事物的不同反应,人皆有之。若遭受突然强烈或长期持久的情志刺激,超过入体本身的正常生理活动范畴,使入体的气机紊乱,脏腑阴阳气血失调,就导致疾病的发生。郁怒不解,常先伤肝,影响肝的疏泄功能,肝气郁滞,气郁日久不愈,气病及血,变生多端,引起多种症状,产生各种疾病。根据精神障碍的发病特点,分为5个证型辨治。

1. 肝气郁结型 症状:抑郁寡欢,表情淡漠,语无伦次,时哭时笑,多疑善虑,妄闻、妄想、妄见,动作离奇,胸闷胁痛,脘腹痞胀,不思饮食,或腹痛,大便失常,或咳嗽喉痒。口燥咽干,妇女多伴乳房胀痛,或月经不调,或行经小腹疼痛,舌苔薄



腻,脉弦细或弦滑。治法:疏肝解郁,化痰开窍。方药:柴胡疏肝散合顺气化痰汤加减。柴胡、香附、木香、川芎、枳壳、当归、半夏、胆南星、茯苓、陈皮、石菖蒲、远志、郁金。

2. 气滞痰郁型 症状:自觉咽中不适,有物梗阻如炙脔,咳之不出,咽之不下,或见咳嗽气急,痰黏稠或如败絮,或见气机郁结而呼吸急促,甚则鼻张引息,或见暖气,恶心呕吐,胸闷多汗,惊惕,咽燥不安等症,舌苔薄腻或厚腻,脉弦滑。治法:理气化痰解郁。方药:半夏厚朴汤合痰郁汤加减。半夏、厚朴、茯苓、紫苏叶、枳实、沉香、香附、川贝母、前胡、桔梗、瓜蒌仁、海浮石。

3. 气郁痰火型 症状:性情急躁易怒,或狂乱无知,叫骂不休,打人毁物,不避亲疏,胸闷胁痛,口苦咽干,渴喜凉饮,嘈杂吐酸,或目赤耳鸣,大便秘结,小便黄赤,舌质红苔黄腻,脉弦数。治法:清泻肝火、镇心涤痰;方药:丹栀逍遥散合生铁落饮加减。牡丹皮、栀子、生铁落、贝母、橘红、玄参、当归、天冬、麦冬、白芍、黄柏、木通、黄芩、泽泻。

4. 气滞血瘀型 症状:情绪不稳,时高涨时低落,或忧郁呆滞,幻觉幻想,惊恐不安,哭笑无常,骂詈歌唱,兴奋叫喊,忿怒伤人,胸胁刺痛,痛有定处,胸膈满闷,四肢无力,小便淋沥痛涩,舌质紫暗,脉弦涩或结促。治法:疏肝通络,活血祛瘀。方药:复元活血汤加减。柴胡、香附、郁金、当归、丹参、桃仁、红花、穿山甲(代)、大黄、大花粉、通草、降香、苏木。

5. 惊伤肝胆型 症状:善惊易恐,时而烦躁不宁,起卧不安,情绪低落,思维困难,或奔走叫喊,或孤独少动,舌苔薄白脉弦。治法:镇肝安神定惊。方药:许氏惊气丸合十味温胆汤加减。朱砂、生铁落、白僵蚕、全蝎、天麻、橘红、白花蛇、姜南星、磁石、石决明、白芍、远志、沙苑子、酸枣仁。



梁静玉临床经验

[《山东中医杂志》]

梁师将常见之精神、情志症状归为“惊”、“恐”、“哭”、“笑”4大类别,以此为辨证要点,临床施治简单明确,执简驭繁。梁师认为精神、情志异常,多为心、肝2脏作祟。

1. 惊乃肝气实 主要表现为易惊易怒,烦躁不安。治宜疏肝泻热,重镇安神,方拟柴胡加龙骨牡蛎汤加减。常用药:柴胡、龙骨、牡蛎、茯苓、桂枝、半夏、栀子、黄芩、大黄、紫贝齿、蝉蜕、炒酸枣仁。

治验:患者,男,38岁。主诉:烦躁易惊、强迫行为3年,加重1年。易惊易怒,强迫行为,心烦少寐,胸闷憋气,口苦口干,不欲饮水,纳呆腹胀,大便干结,舌暗红,苔白腻,脉沉细。证属肝郁化火,上扰心神,此乃肝气实。治宜疏肝泻热,重镇安神。药用:柴胡10g,黄芩10g,栀子12g,半夏12g,赭石15g,郁金12g,茯苓10g,大黄6g(后入),龙骨30g,牡蛎30g,紫贝齿15g,琥珀粉1g(冲服),桃仁10g,芒硝6g,蝉蜕12g,炒酸枣仁30g。服药6剂,大便通畅,胸闷烦惊大减,仍有强迫症状。依方加减,续治3个月,诸症消失。

2. 恐乃肝气虚 主要表现为胆小怯懦,惧怕见人。治宜养血柔肝,泻子补母,方拟四物汤重用白芍加琥珀、灯心草、麦冬、炒酸枣仁等。

治验:患者,女,23岁。主诉:抑郁寡欢6年,伴少寐怯懦1年。就诊时情志忧郁,自卑多虑,胆小怯懦,惧怕见人,心烦少寐,口渴引饮,近1年月经色黑量少,舌红苔少,脉沉细。证属精血亏耗,肝失所养,此乃肝气虚,治宜养血柔肝,清心安神。药用:生地黄、熟地黄各30g,当归12g,川芎10g,白芍



30g,麦冬 15g,炒酸枣仁 30g,灯心草 2g,合欢皮 10g,益母草 30g。服药 15 剂,心烦少寐明显改善,能与家人主动谈话。2 个月后停药全部西药。依方加减,调理半年,诸症消除。

3. 笑乃心气实 主要表现为精神欣快,多语喜动,其笑不休。治宜清心泻火,育阴安神,方以黄连解毒汤合百合地黄汤加减。常用药:黄连、黄芩、栀子、百合、生地黄、合欢皮、龙骨、牡蛎、生甘草、芒硝、桃仁、石菖蒲。

治验:患者,女,34 岁。主诉:嘻笑无常、语无伦次 1 个月。患者大龄未婚,性格内向,1 个月前出现精神错乱,嘻笑无常,时时笑而不休,坐卧不宁,入睡困难,醒后喃喃自语,多食易饥,大便干结,舌红赤,苔薄黄,脉滑数。予清心泻火,育阴安神,使水火相济,心神自宁。药用:黄连 9g,黄芩 6g,栀子 9g,生甘草 9g,百合 30g,生地黄 30g,桃仁 10g,赤芍 12g,龙骨、牡蛎各 30g,琥珀 1g(冲服),芒硝 6g,炒酸枣仁 30g,莲子心 9g。服药 3 剂后头脑清醒,语言清晰,逻辑性强,夜寐已安,大便通畅,但沉默寡言。上方加天竺黄 12g,胆南星 9g,石菖蒲 12g,灯心草 2g,再进 36 剂,症状全部消除。

4. 哭乃心气虚 主要表现为情志忧郁,悲伤欲哭。治宜益气养心,健脾化痰开窍。方拟甘麦大枣汤合温胆汤加减。常用药:小麦、甘草、大枣、半夏、茯苓、陈皮、枳实、竹茹、天竺黄、天南星、炒酸枣仁、百合、合欢皮。

治验:患者,女,69 岁。主诉:悲伤欲哭 1 个月。患者近 1 个月来无明显原因常感心中委屈,悲伤欲哭,忧思多虑,心烦少寐,腹中空虚,纳呆恶心,口干厌饮,二便自调,舌红绛,苔薄黄腻,脉沉滑。既往健康,52 岁绝经。证属脏阴亏耗,心失所养,脾失健运,以心气虚为主。治宜益气养心,健脾化痰,醒神开窍。药用:小麦 30g,生甘草 10g,大枣 10g,百合 30g,合欢



皮 15g,半夏 6g,茯苓 10g,陈皮 12g,枳实 10g,竹茹 10g,天竺黄 10g,麦冬 12g。服药 9 剂,精神较前愉悦,腹中空虚感消失,纳、寐改善。依方加减,调治 2 个月诸症缓解。

孙忠人临床经验

〔《中医药信息》〕

1. 整体调节治失眠,头体穴伍神自安 许多失眠患者,有的因常服地西洋类镇静药,耐药后失眠加重,甚至彻夜不寐。其治疗不能单纯镇静,应以整体调节为主,首取头穴,如百会、四神聪、神庭、风池,再根据患者的辨证分型,如肝郁气滞加太冲、膻中理气开郁;心脾两虚配神门、三阴交、足三里健脾、养心安神,经过 1~2 周,多则 1~2 月的针刺治疗,大部分患者能够安然入睡,有的严重患者、耐药患者经过针刺治疗后睡眠亦明显改善。

2. 中毒脑病哈欠频,头穴开窍兼醒神 对于中毒性脑病(如煤气、乙醇等)及动脉硬化性脑病的治疗,孙老师常选头部具有益智健脑、醒神开窍的穴位相互配伍,主要有:百会、四神聪、神庭、头维、印堂、太阳、风池、翳风等,以头穴治疗为主,多有良效。

3. 抽动 秽语综合征,滋阴熄风显奇功 患抽动-秽语综合征的儿童,近年有增多的趋势。患儿表现不自主点头、挤眉弄眼、耸肩、鼻腔或喉中作声,注意力不集中,学习成绩下降。孙老师认为,儿童为稚阴稚阳之体,发育尚未成熟,“阳常有余,阴常不足”,且喜食零食,儿童小食品越来越多,许多是辛香干脆、膨化食品,过食伤阴,阴虚风动,如树干风摇作响,“诸风掉眩,皆属于肝”,“高巅之上,惟风可到”,肝风上扰清窍,则出现点头、挤眉弄眼、喉中作声等动作。其治疗,孙老师主张以滋阴潜



阳、镇肝熄风为主,常用镇肝熄风汤加减,取得较好疗效。

4. 多疑焦虑神抑郁,四关开郁兼理气 抑郁症患者多数表现为神经质、多疑、焦虑、急躁易怒或抑郁寡欢、孤僻少语,孙老师经常耐心地给患者做思想工作、心理疏导,帮助患者解除思想负担,积极配合治疗。孙老师认为,肝郁脾虚、痰凝气滞是主要病机,常选“四关”、膻中、百会、神庭、内关、丰隆、足三里、三阴交;患者狂躁者配“孙思邈十三鬼穴”,如人中、少商、隐白、风府等。“四关”即合谷、太冲,有开郁启闭、理气之效;膻中为气会,理气宽胸必用之穴;内关、丰隆化痰;足三里、三阴交健脾;百会、神庭醒神益智,“十三鬼穴”可加强开窍醒神的作用。

李书林临床经验

[《陕西中医》]

在对本病治疗之前,首先要对癫狂正确分类,癫狂可分为两类,“重阴者癫、重阳者狂”。癫证以精神抑郁,表情淡漠,沉默痴呆,语无伦次,多疑多虑,哭笑无常,不思饮食,不语不动,神疲蜷卧,少动懒言,妄闻妄见,呆若木鸡,目睛不瞬,静而多喜为特征。可见舌质淡、舌体胖、苔白腻、脉滑或脉弱无力,多属阴证之气虚痰结型,治宜益气涤痰,药用党参、白术、茯苓、半夏、陈皮、竹茹、石菖蒲、远志、茯神、生甘草等。

狂证多以精神亢奋、狂躁刚暴,喧扰不宁,打人毁物,情绪高涨,言语增多,语多杂乱,逾垣上屋,登高而歌,弃衣而走,哭骂叫号,四处奔走,面红目赤,气力超常,渴喜冷饮,动而多怒,便秘溲赤为特征。舌质红绛、舌苔黄腻、脉象弦滑或滑数有力,多属阳证之痰火扰心型,治宜涤痰泻火,镇心安神。药用青礞石、赭石、生石膏、生大黄、黄芩、沉香、牡丹皮、生龙骨、生



牡蛎、生甘草等。

属癫证者选用治癫证之药；属狂证者选用治狂之药。将选定之药加透皮剂（即渗透剂）与苏合香加水煎煮 2 次。第 1 次 1.5 小时，第 2 次 1 小时，合并药液并浓缩，将浓缩之药液涂抹在头部之百会、四神聪、后顶、强间、脑户、络却、天冲、浮白穴上，每穴涂数次，涂至形成直径为 1.5 厘米的圆形药层而不流淌为度，然后戴上浴帽，防止药液挥发变干，失去效用。每晚休息前用 1 次，使药液在头部保持一昼夜。若病情严重，每个白天再用 1 次，给头部穴位敷好药液后，仍要戴上浴帽，使药液保持到晚饭前。如此昼夜交替使用，用数次药后，洗 1 次头，洗净头上陈腐药液，头皮变干后再用，1 个月为 1 个疗程，一般连续用药 4 个疗程，稍息再用，直至病愈。

汪履秋临床经验

〔《南京中医药大学学报》〕

1. 奔豚气 吴某，女，40 岁。少腹筑筑跳痛，上窜胸胁咽喉，已有多时，妇科诊治多次，一无效果，据症诊为肝气窜络和奔豚之证，治以疏肝理气，通阳化气，调养心肺。方取柴胡疏肝饮、茯苓桂枝甘草大枣汤、百合知母汤、甘麦大枣汤加减，药如：柴胡 5g，甘草 3g，白芍 10g，百合 10g，知母 10g，麦芽 10g，茯苓 10g，桂枝 10g，泽泻 10g，制香附 10g。二诊明显好转，从少腹上冲咽喉已不明显，仅在左侧咽喉不适，原方出入，加利咽化痰之甘桔梗、白僵蚕、木蝴蝶而瘥。按：此病例较少见，奔豚发病机制与肝肾有关，冲脉起于下焦，上循咽喉，故气循冲脉而上冲。其证有心肾不足型，用伤寒之奔豚汤；有肾寒水饮型，用茯苓桂枝甘草大枣汤。本例为肝郁挟水气上冲，汪师药证合拍，多年病苦两诊而愈。



2. 癔症性瘫痪 王某,女,19岁。病起1年,头目眩晕,甚则昏倒,反复发作,有时耳鸣,容易紧张,四肢疲乏无力。汪师从补气血、养肝肾、益心脾、平肝风治之。药用黄芪10g,当归10g,白术10g,泽泻10g,熟地黄10g,山药10g,钩藤10g,白蒺藜10g,白僵蚕10g,石决明15g,牡蛎30g,甘草5g,百合10g。连续三诊,上方稍事出入调理巩固而未再发。该患者发作常在坐着交谈时,发时如瘫痪,不能动,但心中明了,不属气厥、昏厥一类。病者与家人感情疏远,从不与父亲讲话。汪师从患者体质素弱,气血肝肾不足,心脾失常之虚风辨治,用补益心脾、平肝熄风法加甘草益脾气而养心,加百合清心安神。因此,虚体得补,心脾得充,病去不发。

3. 梅核气 李某,女,50岁。胸闷、咽喉似痰阻塞1月,似有痰阻于胸膈咽喉,痰白黏,吐之不出,口苦而干,苔黄腻干燥。汪师辨析,病者疑虑重重,气郁化火,火郁生痰,气血痰交阻不化,实为梅核气。从养肺胃、清气泻火、消痰治之。药用南沙参10g,麦冬10g,半夏10g,厚朴5g,紫苏梗10g,黄连3g,栀子10g,郁金10g,桔梗5g,甘草5g,木蝴蝶3g,桑白皮10g,瓜蒌皮10g,竹茹10g。服7剂后自感轻松,咽堵痰黏渐化,原方去厚朴加牛蒡子继服自愈。按:本病多为肝脾失和,气机阻滞,痰浊内生,痰气搏结于咽喉所致。咽中有炙脔感,其病轻重多与情绪波动有关,治疗多以导痰开郁,清热顺气,例方半夏厚朴汤。本案有郁火痰黏之证,故加栀子、黄连泻火,与沙参、麦冬清养肺胃,还加利咽喉化痰热之品,两诊而愈。

张铁英临床经验

[《辽宁中医杂志》]

泻南补北法,即泻南方心火,补北方肾水,为中医临床常



用的治疗方法,即在五输穴中,根据子母补泻的原则,运用五行生克规律,做相应取穴,针对肾阴不足、心火偏旺、水火不济之类的疾病,所选用的滋阴降火疗法。泻南补北法主穴为神门、少海、复溜、曲泉,该4穴即为真阴不足,不能上交于心,心火独亢之证而设。针对此症,治疗时须从两方面着手,首先取神门、少海泻心中邪热,其次取复溜、曲泉补肾中真阴。在针灸治疗各类精神病中,各证应做相应加减,但各病均为肾阴不足、心火独亢之证型。

1. 癫狂 取穴:主穴加双合谷、太冲。陈士铎在《石室秘录》中云:“惊恐者,乃肾气不入于心。”在癫狂等精神类疾病中,心肾不交占多数,该病主要因素是阴阳平衡失调,不能相互维系,以致阴虚于下,阳亢于上,心神被扰,神明逆乱而致。针对此类疾病,采用滋阴降火法治疗,早在《黄帝内经》中已有论述,“狂而新发先取曲泉,左右动脉,及盛者见血,有顷已”。在此基础上,取穴更丰富、完整,加之四关的平肝潜阳、疏肝降逆作用,共达镇静安神之作用。

2. 脏躁 取穴:主穴加肝俞、肾俞。中医学认为,本病多由肝郁化火,耗伤肝肾之阴,以及各种原因导致的阴血亏耗,而引起的肝肾不足,不能濡养五脏,志火内动,干扰心神,神躁不安,而致脏躁发生。以女性为多见,主要表现为意识障碍,感情反应强烈,心烦,躁动及部分内脏功能紊乱。治宜育阴清热,交通心肾。主穴中的4穴配伍即起到此作用。配合肝俞,既能够泄肝胆之火,又能养肝肾之阴;肾俞内应于肾,是肾气转输、输注之处,《甲乙经》云:“心下愤痛,心如悬,热,面黑,目荒荒,少气,肾俞主之。”肝俞、肾俞与主穴配合,共同起到养阴清热作用。

3. 失眠 取穴:主穴加百会、神庭。失眠,可由多种原因引



起,在此仅对心肾不交之证而论。《格致余论》云:“人之有生,心为火居上,肾为水居下,水能生,而火有降,一升一降,无有穷已,故生意存焉。”该病多由于长期的忧郁思虑、愤满恼怒等导致肝气郁滞,日久化火,耗伤肝肾之阴,水火不济,心失所养而致失眠。治疗中,主穴即起滋补肝肾之阴,而降心火之用,加之百会、神庭的定神醒脑、宁心安神作用,共达交通心肾作用。

张志浩临床经验

[《中医文献杂志》]

1. 思虑过度引起的胆怯心悸 症见:时常自觉心悸,惊惕不宁,易惊善恐而不能自制,夜寐不佳,时有惊梦而醒。舌质淡,脉虚弦。此类患者大多由于心思过度,琐事缠扰所致。久不能自解,暗耗气血,伤于本神,神不守舍,故以惊怯不宁为主要临床表现。治疗当以补养心气、安神镇惊为主。方药选择:归脾汤加琥珀、柏子仁、合欢皮、夜交藤、龙齿。夜不寐者,酌加朱砂;口干心烦,舌暗红或舌红无苔,加女贞子、沙苑子、麦冬。

2. 肝气郁结引起的忧郁不解 症见:素性内向,忧郁而不能以言词外泄,常常多愁善感,或悲泣不已,或烦闷自语,胸中痞满,舌淡或淡红,脉弦。患此证者以女性为多,多因情绪低沉压抑,气结于心胸而不能上通下达,脏腑功能缺乏活泼条达的原动力。反过来,又促使气塞更甚,壅滞于内。总之,以气结郁塞为病机要点。治当以疏利气机为主。方药选择:越鞠丸或柴胡疏肝散为主,加用郁金、枳壳、青皮。若伴有咽如物阻的梅核气,可选逍遥散合四七汤;若久郁化热,口苦胁肋胀痛,可加川楝子、延胡索;前胸痛者,加木香、郁金、薤白。

3. 心肝火旺引起的暴怒胁胀 症见:素性躁烈,每遇不



和而动怒,或时时自相烦扰,面赤口苦,胸胁撑胀,心烦不寐,溲黄便燥,舌红或舌尖鲜红,脉象弦数或弦大。中医认为,气有余便是火,肝气妄动,气逆上行,常可引动心肝君相之火,以致火胜阴耗气,故虽初期大多为实证,但久不愈者则必伴有阴血不足之象。治疗应以平肝理气与滋敛肝阴为主。方药选择:丹栀逍遥散合导赤散。口苦甚加金钱草;胀痞暖气加枳实、青皮;伴有头胀痛、目赤生翳,加生石决明、菊花、夏枯草。

4. 痰浊蒙窍引起的昏聩自语 症见:精神呆滞,喃喃自语,神识恍惚,或语无伦次,喜怒无常,胸闷,恶心不食,嗜寐。舌苔白腻,脉濡或滑。其病多为宿积气郁,痰湿内停,偶因七情所伤,引动痰浊随气而动,上蒙清窍,以致神识不明,多属正气虚而邪气实。治当温化痰湿,清心开窍。方药选择:天麻白术半夏汤或温胆汤,加琥珀、天竺黄。若肥胖或嗜酒,痰浊湿盛者,可酌加葶苈子、竹沥、白矾;涎多少食者,加白豆蔻、藿香;多寐嗜睡,加黄芪、葛根。

5. 痰火上扰引起的狂妄躁动 症见:躁动不宁,赤足蓬头,骂詈不休,不避亲疏,不惧水火,面红目赤,毁物伤人,甚则登高而歌,弃衣而行。舌红苔燥或厚,脉滑数。病多缘于内有宿积,郁久化热,或素体肥盛少动,或嗜酒过度,以致痰火相结蒸上,扰乱心神,神明蒙蔽,精神内乱。此为邪实证,体壮者多见。治疗原则为清利痰火。方药选择:涤痰汤加竹沥、黄连、朱砂、胆南星。大便燥结者,酌加承气汤类;若狂躁渐缓,舌红少津或无苔者,加麦冬、玄参。

谢衡辉临床经验

[《北京中医药大学学报》]

针刺治疗神志疾病自古即有效显法捷的特色,如众所周



知的“孙真人十三鬼穴”，即是一例。另外，《千金翼方》云：“凡诸孔穴名不徒设，皆有深意。”十二经穴与经外奇穴中有许多便是以“神”字命名的，如神门、神庭、神堂、神道、本神、四神聪等。这些腧穴的名称即说明了它们对于治疗神志疾病的特殊疗效。

1. 神机上朝，重点取头穴 脑是人体生命活动的指挥中枢，也是人精神意识思维之所出。而头作为脑之所寄，通过经络与五脏发生联系，组成了一个相对独立的系统。比如手足三阳经皆上达于头面，手足三阴经通过相表里的阳经经别与头发生联系。而奇经八脉中，除带脉外，其余七脉均上达头面。正如《灵枢·邪气脏腑病形》所云：“十二经脉，三百六十五络其血气皆上于面而走空窍。”所以，选取头部腧穴是治疗神志疾病的重要方法。通过辨证取穴，施以适当的手法，从而达到针其穴、调其经、和其脏、畅其志的目的。笔者常用的腧穴有：七神针（即四神聪、本神、神庭，左右共7穴），大椎、百会、哑门、风府、率谷、天冲等。

2. 三焦升降，重调脏腑 五脏六腑的功能活动正常是神志活动正常的内在基础。因此，笔者认为三焦脏腑间气机升降协调是维持正常神志活动的重要因素。根据临床观察，神志疾病的常见的病机有：心肾不交；中焦失和，肝郁气滞；肝肾阴虚，亢阳扰神。对于心肾不交的患者，调治当滋水清火，是以常取神门、内关清心安神，以太溪补肾，泻行间以引火下行，从而达到水火既济的目的。中焦乃一身气机之枢纽。若因饮食不节，损伤脾胃而致虚气留滞；或因情志失调，肝气不舒，木不疏土，均可导致中焦失和。所以治疗此证，当以调和脾胃、兼疏肝气为法，旨在恢复中焦气机之顺畅，取穴以肝脾经穴以及募穴为主；运脾胃则常用公孙、内关、中脘、丰隆、天枢；疏肝



气则常用膻中、章门、太冲、足临泣。肝肾虚损的患者,常见于老年人和有压力的知识分子阶层,其主要原因为肝肾精亏、气血虚弱、阴不制阳而导致心悸、失眠、健忘等症。其本为虚,其标为实。根据“急则治其标,缓则治其本”的原则,当先急镇其亢阳,后缓益其虚阴,从而达到标本兼治的目的,故以取肝肾经穴与俞募穴为主,如太冲、行间、照海、肝俞、肾俞等。以上三种病机,临床兼见并见者亦不在少数,故在运用上应辨证施治,方可得心应手。

3. 从根引末,依标本而刺 针灸学中有一套重要理论即是“标本根结”,它形象地把人的躯干比作树木,而把四肢比作树根,从而强调了四末与躯干的密切联系。临床最常用的五输穴、原穴、络穴、八脉交会穴、下合穴、郄穴均位于四肢末端、肘膝关节附近或以下的位置。正如《标幽赋》所云:“更穷四根三结,依标本而刺无不痊。”所以在治疗精神神志疾病时,采用标本相应、根结相引的方法,可取得较好的疗效。患者王某,男,45岁。失眠,舌红脉弦。诊为肝郁化火,脾胃失和。针风池、安眠、头临泣、侠溪、内庭、神门、三阴交,针用泻法,6次基本痊愈。按:本例中以风池、安眠、头临泣与侠溪,上下相应,标本相依,主清其肝火,配合内庭、三阴交,以调理脾胃,顺畅气机。

胡海燕临床经验

[《湖北中医杂志》]

中医药治疗精神疾病的主要法则归纳如下。

1. 理气解郁法 根据《素问·至真要大论篇》“逸者行之,结者散之,高者抑之”的理论,以及沈金鳌之“气升则降,气逆则调”的治疗原则,临床采用理气解郁之法以舒畅气机,调整脏腑功能,达到调治精神之目的。常用药物有柴胡、香附、



延胡索、青皮、枳壳、川楝子、薄荷、佛手等,代表方剂有逍遥散、四逆散、柴胡疏肝散、越鞠丸等。

2. 清热泻火法 临床上治疗火热证主要有寒凉泻火法和清热养阴法 2 种。对兴奋躁动、狂乱不安、行为冲动等明显阳明火盛的狂证患者,多采用寒凉泻火法,常用药物有龙胆草、黄芩、黄连、黄柏、栀子、大黄、生石膏、木通等。代表方剂如龙胆泻肝汤、大承气汤、泻心汤、泻肝汤、当归龙荟丸等。而对子久热伤阴,“阳盛阴虚则水弱火强”(《格致余论》)的患者,应在清热泻火的同时给予大剂量的养阴药物,以达壮水熄火的目的。常用药物有知母、生地黄、玄参、麦冬、天冬、沙参、黄柏、熟地黄、龟甲等。代表方剂有加减玉女煎、清营汤、二阴煎、大补阴丸、知柏地黄丸等。

3. 涤痰开窍法 《景岳全书》中有“癫病多由痰起,凡有所逆,痰有所滞,皆能壅闭经络,格塞心窍……”。指出了治疗癫病应注意豁痰开窍。后世医家也多以痰立论,逐渐形成了对癫狂病因、病机以痰论治的主流学派。以痰论治精神病,其治法在临床分为两大类:一类以“涌吐顽痰”为主,用峻药猛攻,以求迅速控制病情。常用药物有瓜蒂、巴豆、砒霜、大黄、甘遂等。代表方剂如三圣散、瓜蒂散、控涎丹、将军汤等。另一类以“清下痰火”为主,用大量较缓和的祛痰药物以消化体内的痰浊。常用药物有胆南星、浙贝母、瓜蒌、郁金、半夏、竹茹、陈皮、青皮、石菖蒲、白芥子、天竺黄等。代表方剂如温胆汤、宁志化痰汤、解郁化痰汤、涤痰开窍汤等。因这类治疗方法作用较缓和,不会产生严重吐泻,故临床上运用较多。

4. 活血化瘀法 血瘀做为病理机制之一,自古有之,仍为精神疾病不可忽视的病因之一。治法当不离活血化瘀,常用药物有丹参、当归、牡丹皮、赤芍、川芎、郁金、生地黄、三七、



益母草、泽兰、牛膝、延胡索、乳香、没药、红花、桃仁、虻虫、水蛭、廋虫、三棱、莪术、大黄、干地龙、血蝎等。代表方剂如癫狂梦醒汤、血府逐瘀汤、桃核承气汤、开迷散、镇脑汤等。

5. 养血安神法 祖国医学治疗癫狂也有用补法者,如安神定志、补虚养血、调中扶正、补益心脾等法。虞抟《医学正传》有“癫为心血不足”之说,李挺认为:“此血虚神耗也”,故因血虚而致精神失常者,可用补法治疗。常用药物有当归、白芍、川芎、熟地黄、人参、黄芪、茯神、柏子仁、酸枣仁、山茱萸等。代表方剂如加味归脾汤、大补元煎、养心汤、养血安神汤等。

6. 温阳补肾法 运用温阳补肾法治疗精神疾病方面也有一定的进展,如采用大剂量壮阳振奋药物治疗情绪淡漠、呆滞退缩、孤独等阴性症状为主的精神分裂症,取得较好疗效。常用药物有附子、肉桂、巴戟天、肉苁蓉、淫羊藿、细辛、干姜、仙茅等。代表方剂如地黄饮子、逐呆仙丹、温阳振奋汤等。

周正保临床经验

[《天津中医》]

1. 痰火内扰型 临床表现为紊乱性兴奋,言语杂乱无章,情绪不稳,行为怪异,大便秘结,溲赤,面红目赤,喜冷饮,舌质红或绛,苔黄厚腻,脉滑数有力。多见于精神分裂症青春型和精神分裂症的急性期。治宜清热涤痰开窍,方选礞石滚痰丸与龙胆泻肝汤加减。一般药物选用:青礞石、大黄、芒硝、黄芩、龙胆草、牡丹皮、木通、泽泻、甘草。其中大黄以生大黄为主(10~30g),芒硝适量(5~10g),生礞石先煎。易怒烦躁者龙胆草用量可达20g,加柴胡15g;神志不清则应加用开窍之品,以人工牛黄、石菖蒲为宜。本方不宜久用,一般服用7~10天,然后酌情更改方药,选用清热安神之品继续调理,可选



黄芩、黄连、胆南星、远志、淡竹叶等药物。

2. 痰湿内阻型 临床表现为言语散漫,妄闻妄见,想法离奇,活动迟钝,生活被动,表情呆板,心烦失眠,倦怠乏力,纳少便溏,舌体胖或有齿痕,舌苔白腻,脉沉滑或沉缓。此型多见于精神分裂症偏执型、未定型。治宜化痰理气、祛湿开窍,方选涤痰汤加减,方中重用胆南星、枳实、半夏、石菖蒲,一般不用人参。便秘可加用芦荟、当归之类;幻觉明显加用磁珠丸。此方一般服用 20~30 天见效。

3. 气滞血瘀型 临床表现为行为动作幼稚、愚蠢,言语零乱,妄闻妄见,躁动不安,周身不适,肌肤粗糙,面色晦暗,妇女可有痛经、闭经、经少色暗或有血块,舌质紫暗,有瘀斑,少苔,脉涩或弦。此型多见于精神分裂症青春型、未定型。治宜理气活血、化瘀开窍,方选癫狂梦醒汤加减,重用桃仁、红花、柴胡、香附、赤芍、半夏、陈皮、枳壳之类药物,一般不用方中的桑白皮、紫苏子。如有秘结内热,可用桃仁承气汤合用化裁。本方常用 30~60 天方可见效。

4. 阴虚火旺型 临床表现为病情迁延不愈,偶有冲动,妄闻妄见,情感平淡,语乱,孤独退缩,大便干燥,小便短赤,颧红,口干不渴,舌红无苔或舌绛苔剥,脉细数。此型常见于精神分裂症衰退期、慢性阶段,或一些年龄偏大的患者。治宜滋阴降火开窍,方选服蛮煎加减,重用生地黄 30~50g,石斛 20g,麦冬、牡丹皮、佛手、知母、郁金、石菖蒲、甘草可选用。伴有幻听可并用柴胡龙骨牡蛎汤,磁石重用 30~50g;如仍有内热,可加用生石膏、淡竹叶等药。此方一般服用 30 天。

5. 阳虚亏损型 临床表现为病情迁延不愈,情感淡漠,生活懒散被动,少语,行为退缩,想法离奇,面色无华或萎黄,体虚乏力,形寒肢冷,食物不化,纳少,舌淡,苔薄白,脉沉细弱。此



型常见于精神分裂症衰退期或年老患者。治宜补肾健脾、壮阳开窍，方选壮阳汤加人参归脾汤加减，重用肉苁蓉、炙龟甲、淫羊藿、炙附子、党参、生黄芪，酌情选用半夏、陈皮、竹茹、胆南星、石菖蒲、远志类药物。一般服用3个月为1个疗程。

精神分裂症，祖国医学属于癫狂的范畴。在治疗精神分裂症时无论哪个类型，均应选用理气、祛痰药物配伍，疾病早期注重涤痰理气、活血清热，晚期以滋补阴阳为主。根据不同类型，所用方药服用时间也不同，开窍之品用于各个类型。至于用大剂量磁石、龙骨、牡蛎配伍消除幻觉，多为临床经验。

程士德临床经验

[《北京中医药大学学报》]

1. 调营卫，通阳和阴 神志活动的失常，首先表现在睡眠紊乱上，临床上以不寐、多梦、多寐等多见。程老治疗睡眠紊乱多从调和营卫气血、通达脏腑阴阳之气入手，善用桂枝汤、小柴胡汤等方增损。患者王某，女，42岁，嗜睡、困倦1月余，头昏沉，记忆力减退，时有汗出，月经量少，舌淡，有齿痕，脉沉细。治法：调和营卫，通阳益阴。处方：炙黄芪40g，桂枝10g，白芍20g，柴胡10g，郁金30g，香附10g，石菖蒲10g，胆南星10g，当归10g，川芎10g，枳壳10g，桔梗10g。本方以桂枝汤调和营卫为主；辅以通阳利气的柴胡、石菖蒲；补血行血之当归、川芎；升清降浊之枳壳、桔梗。营卫气血和利，脏腑阴阳通达，嗜睡自消。

2. 化痰瘀，泻浊通窍 程老治疗神志病多采取以下三个步骤：一是“百病多因痰作祟”，故从痰治，善用温胆汤、半夏厚朴汤；二是活血化瘀，消滞通窍，善用血府逐瘀汤、通窍活血汤等；三是泻下通便，以大小承气汤为主加减。他认为痰浊、瘀



血、积滞均为病理性产物,在体内堆积过多,会对神志活动产生不良影响,必须及时予以清除。患者王某,女,56岁,头痛,失眠1年余,时觉胸闷不舒,咽部不适,有堵塞感,吞不下,吐不出,易烦躁,大便干燥,舌质紫暗,苔黄厚腻,脉弦滑。治法:活血通窍,化痰消滞。处方:半夏10g,厚朴10g,茯苓10g,紫苏梗10g,柴胡10g,川芎10g,赤芍10g,桃仁10g,红花10g,竹茹10g,石菖蒲10g,胆南星10g,生大黄4g。服药1周,头痛、失眠明显好转,咽部堵塞感消失。服药2周,胸闷烦躁消失,追踪随访1个月,未再发。

3. 培本源,滋补肝肾 神志活动是脏腑功能的重要组成部分,它从不同的角度反映出脏腑功能活动的不同情况,程老治神志病亦常从调理脏腑功能入手,尤重视培补肝肾。因肝藏血,血舍魂,肾藏精,精舍志,而精血是神志活动的物质基础,故临证多用六味地黄丸平补肝肾;用二仙汤温肾助阳。辅以珍珠母、灵磁石、生龙骨、生牡蛎、琥珀、夜交藤、炒酸枣仁等重镇安神之品,对于记忆力减退者,则常加桑椹、女贞子、菟丝子、枸杞子、益智仁等补肾填精、益脑生髓之品。刘某,女,49岁,1年前行子宫切除术,失眠(入睡困难,甚者整夜不能入睡),劳累后加重,多梦,近日恶梦频作,盗汗,心中郁闷,时有坐卧不宁,烦躁易怒,易疲倦,舌质淡,苔薄白,脉沉,尺脉无力。治法:补肾培源,养血疏肝。处方:仙茅10g,淫羊藿10g,当归10g,知母10g,黄柏10g,白芍15g,杜仲10g,何首乌10g,紫河车粉10g(冲),阿胶珠10g,生地黄、熟地黄各30g,珍珠母40g(先煎),夜交藤30g。服上方15剂,痊愈。程老认为肾乃生命之本,精血之源,女子以血为本,如阴血亏虚,不养心神,特别是肝肾不足,阴阳失调,常常是妇女神志病产生的重要原因。



4. 重气机,升清降浊 程老临床善用逍遥散、柴胡疏肝散等来调畅气机,抓住气机这一关键环节来治疗神志病,并总结出调畅气机的方法与良药。如:用旋覆花、紫苏子(梗)宣肺利气;香橼皮、绿萼梅、郁金、香附疏肝理气;木香、砂仁、陈皮健脾和胃,升清降浊;金樱子、芡实、蛤蚧补肾纳气等。辛某,男,42岁,近半年情志不舒,善太息,失眠,多梦,晨起头昏蒙,记忆力明显减退,反应迟缓,言语时有不利,甚则口误,急躁易怒,大便秘结,胸腹胀闷,舌质红,苔黄腻,脉弦数。治法:疏肝理气,宁心安神。处方:柴胡 10g,香附 10g,香橼皮 10g,川楝子 10g,枳实 10g,厚朴 10g,大黄 6g,木香 10g,砂仁 6g,珍珠母 40g(先煎),磁石 40g(先煎)。全方有升有降,有收有散,升降出入适宜,气机调畅,脏腑协调,神有所归,志有所养,诸症自消。

5. 清郁热,交通心肾 程老认为,神志疾病,如神昏、谵语、失眠、癲狂等多与郁热有关。或因七情内伤,气郁化火;或脾胃中焦蕴热生痰,痰火蒙蔽清窍;或肾精不足,肾水不能上济于心,而致心火独亢,扰乱神明。临证多以生栀子、青黛、胆南星、石菖蒲、龙胆草、夏枯草清热化痰开窍;以厚朴、枳实、大黄、泽泻、猪茯苓通利二便,泻热消积;以黄连、石膏、知母泻热除烦;以交泰丸并菟丝子、女贞子、枸杞子滋肾水,交通心肾,使心火不亢,心神守舍。

第三节 老年痴呆

李鲤临床经验

[《河南中医》]

1. 病因病机 老年痴呆病的形成主要责之心、肝、肺、



肺、肾五脏功能失调,尤与心、肾关系密切。其病位在脑,证属本虚标实。其发生与痰、瘀、虚有关,且三者互相影响。其病机多为:情志不遂、五志内伤;痰瘀阻络,清气不升;心血不足,肾精衰少。虚:气血亏虚,脑脉失养;阴精亏空,髓海不足。痰:痰浊中阻,蒙蔽清窍;痰火互虐,上扰心神。瘀:瘀血阻滞,脑气不能与脏气相接,灵机、记性皆无。肝肾不足,虚火炼津灼痰,痰滞碍血,终致痰瘀互阻。

2. 三步疗法 ①第一步:和中化痰,以资化源。中焦为生化之源,亦为生痰之源,痰浊阻滞脉道,使血流受阻,清阳不升,则元神失养。中焦健运,则痰源乏竭,血行流畅,而元神得养。此法适用于该病兼有纳呆、胸腹胀满、舌苔腻、脉弦滑的患者,方选保和丸加远志、石菖蒲、郁金。若苔黄腻者,加胆南星、川黄连、天竺黄;苔薄黄者,加炒枳实、竹茹;纳差者,加炒鸡内金、焦麦芽。②第二步:化痰祛瘀,疏通经络。痰可使血行黏滞,脉道变细,血脉不畅,由痰阻而渐致血瘀,痰瘀互结,血行不利,清气不能上荣元神,则痴呆由生。若痰瘀祛,脉络通,则呆症可除。此法适用于该病兼有面色晦滞不泽、舌质暗紫不华、舌底脉络迂曲或有瘀点、脉沉涩或弦细及患有高脂血症、高黏血症、红细胞聚集症、脑血管供血不足或颈椎骨质增生的患者。方用保和丸合荆菊四物汤(四物汤加蔓荆子、菊花)加丹参、桃仁、红花。若舌尖红、心烦不宁者,加焦栀子、牡丹皮;大便秘结者,加大黄(后下);失眠者,加紫石英、甘松。③第三步:补肾益髓,增进智能。经过前两步的治疗,患者纳食增进,脉道渐通,则其虚可补。在补的同时,仍要兼顾痰、瘀这两大病理因素,随证治之。若偏于肝肾阴虚者,用左归丸加减;偏于肾阳虚者,用右归丸加减;偏于肾精不足者,用还少丹加减。中成药脑萎雾露散功能滋补脑髓,益肾开窍,为治疗该



病之良药。

治验：张某，男，65岁。患者曾患“脑血栓形成”，出现半身不遂，经治2个月余病情好转，但渐见表情呆滞，反应迟钝，沉默寡言，言语不清，记忆力、计算力、识别力、判断力均明显减退，呈进行性加重，伴纳少、口泛痰涎，舌质暗，有瘀点，苔白厚，脉沉弦滑。中医诊断：老年呆病。西医诊断：脑血管性痴呆。证属痰瘀互阻，肾精不足。治疗首以和中化痰为主，方用保和丸加减：陈皮10g，半夏10g，茯苓30g，炒莱菔子15g，石菖蒲15g，远志10g，郁金15g，白僵蚕10g，丹参30g，焦三仙各15g，炒鸡内金15g。水煎服，每日1剂。服药12剂后，纳食增加，舌苔稍退，余症稍有改善。又在原方基础上加用桃仁12g，红花20g，川芎10g，当归20g，蔓荆子10g，菊花12g。经治3个月，患者主症明显改善，反应较前灵敏，记忆力增强，饮食正常，舌苔转薄白，遂将治疗改为补肾填精为主，佐以祛瘀化痰，方用还少丹加减：熟地黄15g，枸杞子15g，山茱萸15g，肉苁蓉15g，何首乌15g，当归15g，石菖蒲15g，远志10g，桃仁10g，红花20g，丹参30g，焦三仙各15g，大枣5枚。配服脑萎雾露散，每次2g，每日2次。以上方随症加减治疗半年余，患者临床症状消失，智能恢复正常，生活完全自理。随访2年无复发。

李玉梅临床经验

〔《实用中医药杂志》〕

1. 髓海不足 症见头晕耳鸣，记忆力及计算能力明显减退，懈怠思卧，齿枯发焦，腰酸骨软，步履不稳，舌质淡，苔薄白，脉沉细。治宜补肾益髓，填精养神。方用补肾益髓汤加味。药用当归、熟地黄、肉苁蓉、山茱萸、黄精、紫河车、酸枣



仁、远志、枸杞子等。

2. 肝肾阴亏 症见头晕耳鸣,腰酸膝软,两目无神,表情呆滞,记忆力明显减退,形体瘦弱,两颧潮红,盗汗,步履艰难,筋惕肉瞤,舌质红,少苔,脉弦细数。治宜补益肝肾,滋阴养血。方用杞菊地黄汤加减。药用熟地黄、当归、山药、枸杞子、白芍、山茱萸、茯苓、黄精、何首乌、阿胶、桑椹等。阴虚火旺明显加知母、黄柏、鳖甲、龟甲等。

3. 脾肾阳虚 症见表情呆滞,沉默寡言,腰膝酸软,四肢不温,记忆减退,失认失算,言语含糊,言不达意,腹胀便溏,少食纳呆,口涎外溢,舌质淡胖,苔白,脉沉细弱。治宜健脾补肝肾,醒脑开窍。方用金匱肾气丸(汤)或归脾汤合真武汤化裁。药用当归、枸杞子、熟附子、干姜、茯苓、党参、白术、山药、黄芪、续断、杜仲、山茱萸等。

4. 心肝火盛 症见性情急躁,焦虑不安,心烦不寐,头痛眩晕,记忆减退,判断错乱,口干苦,小便短赤,大便秘结,舌红,苔黄,脉弦数。治宜清热泻火,安神定志。方用黄连解毒汤合龙胆泻肝汤加减化裁。药用龙胆草、生地黄、黄连、黄芩、栀子、大黄、夏枯草、柴胡、黄柏、柏子仁、合欢皮、酸枣仁等。

5. 痰浊阻窍 症见头重如裹,表情呆滞,智力衰退,记忆力甚差,自言自语或哭笑无常,腹胀便溏,口多痰涎,倦怠嗜卧,舌淡、苔白腻,脉沉细。治宜健脾化痰,豁痰开窍。方用半夏白术天麻汤加味。药用半夏、白术、天麻、茯苓、石菖蒲、远志、郁金、胆南星、砂仁等。

6. 气滞血瘀 气滞血瘀:症见表情迟钝,言语颠倒,判断错乱,行为古怪,易怒,口干不欲饮,肌肤甲错,两目晦暗无神,步态不稳,伴肢体麻木不遂,舌暗红有瘀斑,苔薄白,脉弦细涩。治宜理气活血,逐瘀通窍。方用通瘀活血汤加味。药用



桃仁、红花、当归、川芎、地龙、川牛膝、赤芍、香附、木香、郁金、枳壳等。

治验：刘某，女，68岁，1996年6月初诊。近1年来头晕耳鸣，倦怠无力，表情呆滞，步履不正，日渐加重。患者于2月前渐出现痴呆面容，记忆力明显减退，时常呆坐，自言自语，情绪改变明显，舌红少苔，脉细数。经某院CT检查示双侧脑萎缩。经用西药对症治疗，症状改善不明显。西医诊为老年性痴呆。中医辨证为年老久病，肝肾阴亏，髓海失养。治宜补益肝肾，滋养脑髓。处方：生地黄、鳖甲（先煎）各20g，何首乌、枸杞子、山药、白芍、阿胶（烊化）、丹参各15g，天麻6g，山茱萸、茯苓、桑椹、酸枣仁各12g，郁金、柏子仁、女贞子各10g。水煎服，每日1剂，连服6剂。服药后自觉头晕、睡眠好转，走路较前有力，情绪有所改善。续服20剂后表情呆滞消失，步态变稳，可独自行走，思维较前敏捷。守上方稍事加减，连服1个月，症状消失，生活可自理，能进行正常的社会活动。为巩固疗效，改服杞菊地黄丸，每日2次，随访半年未复发。

吕继端临床经验

〔《中医教育》〕

1. 病变在脑，其本肾虚，标实痰瘀 老年痴呆主要是由肾虚、精亏血少而致脑海失养、神明无主所成。本病除肾虚外，多兼挟痰瘀内阻。痰浊阻络，蒙蔽清窍则神机不爽，神志混淆。《景岳全书》曰：“痰迷心窍，则遇事多忘”；或因脾虚不运，痰湿内盛，导致清阳不升，浊阴不降，上犯于脑，蒙蔽清窍，扰乱神明。由于痰为有形之物，痰浊形成后，久必影响气血运行，由痰生瘀，阻滞脑络，使脑气不能与脏气相接，肾之精气不能上输，脑络失养，则灵机、记忆渐无，甚则痴呆。



2. 治疗以补肾为主,兼以涤痰化瘀 陈士铎曰:“不去填肾之精,则血虽骤生,而精乃长涸,但能救一时之善忘,而不能冀长年之不忘也”。故临床治疗采用补肾为主,兼以涤痰化瘀之法。方药组成如下:菟丝子 24g,熟地黄、丹参各 20g,浙贝母 15g,党参、天冬、辛夷、胆南星、半夏各 10g,炙远志、川芎各 6g。舌红少苔、脉细者,加服杞菊地黄丸 10g,以滋补肝肾;苔黄腻、脉弦滑者,加黄连 3g,竹茹 10g,以清化痰热;舌淡边紫,或见瘀斑、紫暗,脉涩者,加川芎、泽兰各 10g,以化瘀通络。方中天冬、熟地黄、菟丝子益肾填精生髓;党参补脾益胃,健运中气;远志祛痰利窍,安神益智,《药性本草》载其有“治健忘,安魂魄,令人不迷”的作用;法半夏燥湿祛痰,和胃调脾;浙贝母清热化痰,开郁散结,《本草正义》载其“最降痰气,善开郁结”;川芎、丹参化瘀通络;辛夷上通脑络,下通心肾,又助化痰开郁,活血通络之功。

治验:陈某,男,68岁。患者2年前患“脑梗死”,经治疗好转后遗下肢肌无力。近半年来精神进行性衰退,头晕,健忘,语言蹇涩,步履艰难,失眠多梦,大便欠通畅,舌质红,苔黄腻,脉滑动。证属髓海不足,痰瘀阻络,治宜补肾涤痰,化瘀通络,佐以清热。处方:菟丝子 24g,熟地黄、丹参各 20g,浙贝母 15g,党参、天冬、胆南星、辛夷、半夏、竹茹各 10g,炙远志、川芎各 6g,黄连 3g。服药 7 剂,头晕消失,睡眠正常。上方去黄连、竹茹,再服 28 剂后,情绪稳定,记忆力基本正常,发音清晰。

孙明韵临床经验

[《右江民族医学院学报》]

1. 肾虚髓少是发病的主要病机 祖国医学虽没有老年



性痴呆的病名,但类似本病病证的记载却不少。如《灵枢·口问篇》云:“上气不足,脑为之不满,耳为之苦鸣,头为之苦倾,目为之眩”。《灵枢·海论篇》曰:“髓海不足则脑转耳鸣,胫瘦眩冒,目无所见,懈怠安卧”。王清任认为“年高无记性者,脑髓诸空”等等。属祖国医学的“呆病”、“文痴”、“郁证”、“癰疾”等范畴,并认为一系列症状与年龄的衰老有关。人体肾气随增龄而渐衰。肾主精生髓,肾精不足,髓海必虚,脑海则失养;或肾水不足,水不涵木,肝阳夹痰上扰神明;或下元不足,心火独旺,水火不济,神明被扰;或肾衰火不生土,脾虚痰浊上蒙清窍;或肾气不足,心失所养,血脉运行乏力,血瘀阻脑,致人精神智力和运动失调而发生衰退和痴呆,出现精神恍惚,健忘,眩晕,语言颠倒,失眠或嗜寐等一系列症状。脑为元神之府,病位在脑,其本则在肾。肾虚髓少是主要的发病病机。

2. 补肾生髓是治疗的基本大法 老年痴呆症,病位在脑,病本在肾,常累及心、肝、脾多脏功能紊乱。临床以本虚标实多见,无论临床证情如何多变,肾虚髓少是其主要病机。补肾填髓是治疗本病的基本大法。根据这一治法,笔者在临床上治疗该症常以生地黄、熟地黄、山茱萸、枸杞子、菟丝子、茯苓、淫羊藿、女贞子、山药等为基本方,随症加减治疗。兼脾虚湿浊不降者,加黄芪、石菖蒲、半夏等,兼肝阳上亢者,加天麻、钩藤、牛膝等;兼木火不交者,加川黄连、肉桂、夜交藤等;兼血瘀者,加桃仁、红花、当归、赤芍、川芎等。治疗常能收到满意效果。

治验:王某,男,66岁。离休后几年来,在家无所事事,情绪不畅,初起头晕头痛,不寐健忘。近年来出现性格改变,记忆力衰退,计算力下降及定向力模糊,经常出门不能识路返家。经行头颅CT检查,提示大脑萎缩,就诊时患者由家属陪



同并代述病情。见患者消瘦,表情呆滞,行动迟缓,舌质偏红,边有瘀点,脉沉细偏数。辨为肾虚精亏血瘀。治拟补肾生髓佐以活血。药用生地黄 15g,熟地黄 15g,山茱萸 10g,枸杞子 10g,菟丝子 10g,淫羊藿 10g,女贞子 10g,丹参 10g,红花 10g,当归 15g,赤芍 15g,泽泻 10g,茯神 10g,川黄连 5g,服药 20 剂,症状明显改善,继续加减服药 2 月余,同时嘱患者调节情志,参加一定社会活动和体育锻炼。患者自觉症状逐渐消退,记忆力和计算力增强,并逐渐恢复了生活自理能力,随访 2 年病情无反复。

3. 积极的摄生是防病祛病的有效措施 老年痴呆症是一种逐渐形成的病理变化过程,人的衰老、肾气的衰退虽是一个自然的生理过程,但并不是每一个老人都会患痴呆。从临床发病情况看,其发病除与自身身体素质如肾精亏虚有关外,与自身的性格、生活习惯及社会环境等亦有密切的关系。中医提倡“不治已病治未病”。对老年痴呆的治疗强调未病先防,治在早期。人在未老之时即开始注意摄养,使机体生理功能保持正常。进入老年期更应积极摄养,建立良好的生活习惯,就可以延年防衰,防病于未然。其摄生主要是精神摄养,主张多用脑、勤用脑,防止老年不用脑,并坚持适度的体育锻炼,以保持机体气血流畅,生命充满活力。

袁德培临床经验

〔《湖北民族学院学报》〕

1. 病机 脑为元神之府,机灵记性皆出于脑,脑病则机灵记性俱乏,脑与脏腑密切相关,脏腑功能失调则脑亦为之受损。脑为奇恒之腑,诸髓所聚,肾主骨,其髓上通于脑;肝藏血,为魂所居,精血同源,肝肾阴虚,肝阳上亢,化火生风,挟痰



挟瘀，上窜脑府；心主血脉，心气贯通则气血流利，上濡于脑则脑气清灵，思维敏捷；心血亏虚，脑脉失充；心气不足，血运不力，脑脉阻滞；心阴暗耗，心火亢盛，引动肝炎，扰乱神明；脾虚则气血生化乏源，脑脉不荣；脾不健运，痰浊内生，与肝风、瘀血为伍，神明清窍被蒙。总之，老年痴呆一病，病机责之于肝、脾、心、肾 4 脏失调，虚、瘀、痰互为影响。肝肾不足，阴虚火旺，炼津灼痰，痰滞碍血，则痰瘀互阻；气血亏虚，脑脉失养，肾精亏损则髓海渐空；心独旺，水火不济，神明被扰；痰浊中阻，蒙蔽清窍；痰火互虐，上扰心神；瘀血阻滞，脑气不能与脏气相接，机灵智慧渐失。

2. 治疗 由于肾与脑的特殊关系，故应着重补肾。代表方剂为补肾益髓汤，临床常用药物可选用：熟地黄、山茱萸、紫河车、当归、山药、续断、远志、石菖蒲、黄精、枸杞子等。其次应注重化痰浊、益气活血。人体随着年龄的增长，脏腑功能衰退，气血生化不足而出现气虚；气虚则行血无力，导致血瘀。配合化痰化瘀治疗老年痴呆，疗效明显，疗程明显缩短。如陈士铎所说：“治呆无奇法，治痰即治呆”。代表方剂为洗心汤、转呆汤、通窍活血汤、桃红四物汤，临床常用药物可选用党参、白术、泽泻、半夏、天南星、陈皮、石菖蒲、桃仁、红花、地龙、川芎、生地黄、枳壳、香附、川牛膝等。

在治疗老年痴呆的过程中还应注意配合交通心肾、柔肝潜阳 2 法。《辨证录》曰：“夫心肾交而智慧生，心肾离而智慧失，人之聪明，还生于肾而生于心肾交也……而不相交则势必致于两相忘也……治法必须大补心肾，使其相离者重复相亲，自然，相忘者能想忆耳。”《清代名医医案精化》吴鞠通案：“中风神呆不语……与柔肝法。细生地黄、白芍、生牡蛎、生鳖甲、麦冬、炙甘草”。《临证指南医案》也指出：“初起神呆、遗尿、老



人厥中显然,数月来夜不得寐,是阳不交于阴……乃下虚不纳,议与潜阳”。

夏翔临床经验

[《江苏中医》]

1. 病因病机 老年痴呆属中医“呆证”、“癡证”等范畴。其临床表现为:神情呆滞,头晕耳鸣,倦怠思卧,语言颠倒,记忆力、判断力减退,计算失误,语言表达及书写能力障碍,以及原有性格的改变,性情孤僻、喜怒无常等。探究其病因病机:老年痴呆为本虚标实之证,本虚以气虚(兼有阴虚、阳虚、血虚)、肾虚(可兼有他脏之虚)为主,标实以血瘀、痰浊为多。因人至老年,肾气渐衰,肾精亏损,髓海空虚,脑失充养,神明无主,则头晕、健忘、神呆,正如《灵枢》所述:“髓海不足,则脑转耳鸣,胫酸眩冒,目无所见,懈怠安卧。”另一方面,又因脏腑虚亏,气血不足,以致气滞血瘀,痰浊蕴留,阻滞于脑,则蒙蔽神明,发为老年痴呆。总之,老年痴呆的病机为肾元亏损,阴阳两虚,气虚瘀滞,痰浊阻窍。

2. 治则方药 根据老年痴呆本虚标实的病机特点,采用标本兼治之法,拟定“回春饮”方,功能益气活血,育阴助阳,化痰醒脑。“回春饮”由生黄芪、川芎、葛根、麦冬、何首乌、锁阳、石菖蒲、制天南星等组成。方中以生黄芪为主,能补益升提脑气、髓气、肾气;配以何首乌、锁阳以调补肾阴肾阳;麦冬、葛根以增强补阴生津之功,而且此二药尚有保护动脉、改善脑部血液供应、提高心脑血管之耐缺氧能力;佐以川芎、石菖蒲、制天南星可活血化瘀,祛痰降浊,醒脑开窍。全方共奏益气补元、活血化瘀、开窍醒神之功。主治:老年痴呆、脑血管疾病所致之头目掉眩、神萎痴呆、精神淡漠、健忘乏力、反应迟钝、行动不利、



胸闷气短等症。加减法：①症见面色萎黄、神疲气短、心悸者，可加重黄芪之用量，并加用当归、白芍以补气养血；②症见腰膝酸软、头晕耳鸣者，加生地黄、杜仲、山茱萸以滋养肝肾；③症见烦躁易怒、目赤口苦者，可加用天麻、知母、生石决明、黄芩、钩藤等以平肝泻火，育阴潜阳；④症见胸闷泛恶、头重如裹、苔厚腻等症者，可加用天竺黄、制天南星、白附子、白术、青礞石以豁痰降浊。

治验：蔡某，男，78岁。因记忆力明显衰退，健忘寡言，词不达意加剧1月而就诊。症见精神萎顿，少气懒言，头晕耳鸣，腰膝酸软，善忘乏力，反应呆滞，夜寐欠安。近月以来，上述症状加剧，日寐夜醒，呆木不语，衣食不理；舌淡胖有瘀斑、边有齿印，苔薄白腻，脉细涩。患者年迈体衰，元气亏损，肾精枯耗，无以荣脑，髓海空虚，加之痰瘀阻窍，故头晕耳鸣。心血不足，无以主神，故神情萎顿，善忘呆滞，夜寐不安。治以益肾补元，益气活血，豁痰开窍，宁心安神。投以“回春饮”加减：生黄芪30g，潞党参15g，粉葛根30g，全当归15g，生何首乌15g，大川芎15g，杜红花9g，广地龙12g，石菖蒲15g，制天南星12g，大麦冬15g，锁阳片15g，川牛膝9g，夜交藤30g，合欢花12g。叠进60余剂，诸恙均减，言语流利，衣食自理，夜来寐安，面有悦色，日有神气。惟头晕、耳鸣、神萎、呆滞诸症减而未尽，续服“回春饮口服液”半年，诸症又减，病情稳定。

按：本案以黄芪为君药，配党参以补益元气、提升中气，加葛根以升清通脑，此3药能益元荣脑。臣以何首乌、麦冬益肾养阴，锁阳补肾温阳；辅以当归、川芎、红花养血和荣，活血化瘀；佐以石菖蒲、制天南星、牛膝、广地龙豁痰开窍，降浊通络；配以夜交藤、合欢花宁心安神。



郑绍周临床经验

[《现代中西医结合杂志》]

1. 病因病机 老年痴呆属中医“呆证”、“癡证”、“痰证”、“瘀证”等范畴。临床症见：表情呆滞，双目无神，头晕健忘，计算失误，记忆力减退，词不达意，或哭笑无常，寡言少语，步履不稳等。历代医家多有论述，如《景岳全书》中说：“痴呆之证……言辞颠倒，举动不经，或多汗，或善愁，其证则千奇百怪，无所不至”。《临证指南》曰：“神呆脉沉、语言不甚明了……神呆不食、不饥、不便”。《辨证录》说：“如病而默默不言，如饥而悠悠如失也，意欲癡而不能，心欲狂而不敢……与人言则无语而神游，背人言则低声而泣诉”。究其病因病机，郑教授认为，老年痴呆为本虚标实之证，其本虚为肾虚（兼有五脏之虚）、气虚（兼有阴虚、阳虚、血虚），其标实以血瘀、痰浊为多。因人至老年，脏器虚衰，元气不足，阴阳俱亏，尤以肾脏之元气精血亏损为主，髓海空虚，脑失所养，元神无主，故头晕、善忘、痴呆乃作。另一方面而又因脏腑亏虚，气血不足以至气血不利，气滞血瘀，痰浊蕴留，阻滞于脑，则蒙蔽元神，发为老年痴呆。因此，老年痴呆主要病机为肾精亏虚，瘀血痰阻，病性属本虚标实，以虚为主。

2. 治疗原则及方药 根据老年痴呆本虚标实的病机特点，采用标本兼治的原则，治疗以补肾活血为大法，佐以豁痰开窍，自拟经验方健脑复智饮：黄芪、葛根各 30g，炒葶苈子、赤芍、麦冬、蒸何首乌、巴戟天、淫羊藿各 15g，全蝎、制半夏、天竺黄各 10g。每日 1 剂，水煎分 2 次服。腰膝酸软者加生地黄 12g，山茱萸 9g，以养肝滋肾；心悸心烦者加桂枝 12g，煅龙骨、牡蛎各 30g，以温通心阳，安定心神；胸闷呕恶、食少多



寐者加白术、苍术、青礞石各 15g,以豁痰开窍;激动易怒、口苦目赤者加钩藤、黄芩各 15g,生石决明 30g,以平肝泻火。

治验:患者,男,60岁。因记忆力减退,健忘寡言而来就诊。症见头晕脑鸣,耳聋目花,神情萎顿,善忘呆滞,寡言少语,夜寐不安。近2个月以来,诸症转剧,呆木不语,衣食不理;舌淡胖,有瘀斑,边有齿痕,苔薄白腻,脉细涩。据证按脉,乃年届花甲,元气亏虚,肾精不足,无以荣脑,髓海空虚,痰瘀阻窍,心血不足,心神失守所致。治当益气活血,豁痰开窍,宁心安神,投以“健脑复智饮”加味:黄芪、葛根、夜交藤、炒酸枣仁各 30g,赤芍 25g,天竺黄、合欢皮 20g,蒸何首乌、沙苑子、淫羊藿、当归、石菖蒲、麦冬各 15g,全蝎 10g。服药半个月,自感神志清、记忆力有恢复。上药加黄精、补骨脂各 12g,叠进 60 余剂,诸恙均减,衣食自理,夜来眠安,面有悦容,且有神气,惟神萎、呆滞诸症减而未尽。续服 30 余剂,诸症又减,病情稳定。

朱良春临床经验

[《实用中医药杂志》]

1. 久病痴呆拟妙法,缓缓斡旋“健脑散” 朱师指出“中医的肾虚是以神经内分泌紊乱为主的机体内环境综合调控功能的障碍。这些障碍既导致衰老的出现,也是血瘀的根源,肾虚和血瘀互为因果”。朱师精心拟制益气化瘀、补肾健脑之“健脑散”。方中以人参、鹿茸为对,制马钱子、地龙为对,紫河车、甘草为对,枸杞子、益智仁为对,天麻、炙全蝎为对,鸡内金、土鳖虫为对,当归、川芎为对,郁金、红花为对,上药研粉,每次服 5g,每日服 2 次。早晚空腹蜜水送服。加水蛭者忌用蜜水。加减法:大便秘结见实热者加水蛭、制大黄为对;见痰



浊中阻,郁闷不乐,动作迟滞,呆板哭泣,胸闷恶心,咳吐痰涎,多寐纳呆,形体丰腴,舌淡胖,苔白腻者加制天南星、石菖蒲为对;阴虚阳亢,见性情急躁,烦恐不安,语言颠倒或口干口苦,午后潮热,多汗,失眠健忘,耳鸣头晕,舌红少苔者,用剂量较大之“六味地黄汤加柏枣仁”送服散剂;气滞血瘀,见表情淡漠,健忘惊恐,头痛如刺,舌紫暗或半身不遂,肢体麻木或面色暗黑等症加桃仁、赤芍。因“健脑散”中取古方“九转回生丹”之主药马钱子、地龙为对,马钱子峻猛,服后必有眩晕者,属正常反应。

2. 新病痴采用汤方,益肾化痰有殊效 曾治患者张某,年逾花甲,原有高血压史,经常失眠,头眩肢麻,近年来记忆力显著减退,头目昏眩,情绪不稳,易急躁冲动,有时疑虑消沉,言语欠利,四肢困乏,腰酸腿软,行走不稳。舌尖红,苔薄腻,脉细弦尺弱,诊为脑血管性痴呆症,属中医“呆病”。治以益肝肾,化痰瘀,药用枸杞子、菊花为对,一以养肝补肾,滋补益气,润肺生津;一以清肝明目,降压降火,疏风清热,清金平木,盖木平则风熄,火降则热除。天麻、地龙为对,一以熄风痉,善治头痛眩晕,善惊失志,语多恍惚;一以泄热定惊,镇肝阴压。生牡蛎、制龟甲为对,咸寒软坚,补肾、清热、除惊以安神,乃因牡蛎可补肾,龟甲通心益肾以滋阴。方中亦选用生地黄、熟地黄为对,桑寄生、淫羊藿为对,生白芍、甘草为对,丹参、赤芍为对,桃仁、红花为对,乃均取益肾化痰之功。另选制胆南星、远志为对,亦取熄风化痰、消痰、宁神、补肾之意。本病例仅投以上药10剂,即诸症大减。朱师指出,活血化瘀药能改善血液循环,防止血栓形成,调节细胞代谢功能,也说明活血化瘀药能增加脑组织血流和营养,从而改善和延缓脑的衰老,提高其功能。



张琪临床经验

[《中国社区医师》]

1. 病因治法 要注意斟酌运用补肾化瘀法,年老肾气已衰,治当补肾无疑,但不宜一味蛮补,张景岳“瘀血有所留脏,病久至羸,似乎不足,不知病本未除,还当治本”。瘀血未去,一味蛮补,使气血壅滞加重,而犯实实之戒,故在组方用药上一定要消补兼施,进补与化瘀并重,不能一味蛮补或一味猛攻,总以祛邪而不伤正,扶正而不碍邪为要略。标本兼治。补肾方药浩如烟海,滋肾阴与助肾阳要根据病情阴中求阳,阳中求阴,协调应用,药物偏温偏凉,临证自当仔细权衡。老年痴呆为慢性病,选药宜多侧重于性平力缓、不过温过凉之平庸之品,如山茱萸、何首乌、菟丝子、枸杞子、沙苑子之类,选方也以阴阳水火互济之剂为佳,如杞菊地黄丸、地黄饮子等。

2. 强调补肾填髓 肾为封藏之本,内寓元阴元阳,肾虚虽有阴虚阳虚之别,但阴阳互根,久病常易相互累及,即“阳损及阴,阴损及阳”转而变为阴阳两虚,为肾病虚损的常见证候,在治疗上须滋阴与扶阳兼顾,既可促进生化之机,又可避免互伤之弊。滋阴之品,其性多柔润滋腻常影响脾胃的运化,导致胀满腹泻,扶肾阳之品其性多辛温燥热,易伤阴液,故古人制方,于补肾阴药中加助阳之品,如地黄饮子,原书用以治由于下元虚衰,虚阳上浮,痰浊随之上泛,堵塞窍道所致之瘖喑,具有滋肾阴、补肾阳、开窍化痰之功。方中以熟地黄、山茱萸滋补肾阴,肉苁蓉、巴戟天温肾壮阳,附子、肉桂之辛热协上药以温养真元,摄纳浮阳,麦冬、石斛、五味子滋阴敛液,使阴阳相配,石菖蒲、远志、茯苓交通心肾,开窍化痰,全方温补下元,摄纳浮阳,开窍化痰,宣通心气,使水火相济,痰浊得除,则瘖喑



可愈。经过临床大量实践证明,凡是慢性消耗性疾病,证见肾中阴阳俱虚、精髓不足者,用地黄饮子壮阳滋阴,填精益肾,往往收效满意。脑为髓海,肾主骨生髓,肾中阴阳化合为髓,对于脑及脊髓病变,如老年痴呆,脑萎缩、脊髓空洞症、蛛网膜炎等辨证属肾阴阳两虚、精髓不足者,用之皆有佳效。

3. 注重活血化瘀 癫狂梦醒汤出自《医林改错》“癫狂一症,哭笑不休,骂歌唱,不避亲疏,许多丑态,乃气血凝滞,脑气与脏腑气不接,如同作梦一样”。联系本病的发生,如头脑发生血瘀气滞,使脏腑化生的气血不能正常地充养元神之府,或因血瘀阻滞脉络,气血不能荣脑髓,则可造成灵机混乱,神志失常发为癫狂。本方作者是根据气滞血瘀立论,除桃仁、赤芍为活血药之外,其余柴胡、香附、青皮、紫苏子、陈皮为疏肝理气之品。在临床辨证要注意辨其气滞血瘀,除情绪躁扰不安,恼怒多言,甚则登高而歌,弃衣而走,或目妄见,耳妄闻,呆滞少语,妄想离奇多端外,经常兼见面色滞暗,胸胁满闷,头痛心烦,妇女痛经,经血色紫暗有块,舌质紫暗有瘀点瘀斑,脉弦数或沉弦。本证由于血气凝滞使脑气与脏腑气不相接续而成,若瘀兼实热,舌苔黄,脉弦数则多表现为狂躁症状,若瘀兼虚寒,舌苔白,脉沉弦而迟,则多表为痴呆症状,临床应用本方时要注意灵活加减,肝郁症状严重加郁金、枳实,痰多加天南星,痰热症状明显可酌加青礞石,或大黄泻其瘀热,伴有脑梗死加地龙、水蛭、葛根,惊恐不安明显加珍珠母、琥珀、生龙骨、生牡蛎。

颜乾麟临床经验

[《上海中医药杂志》]

1. 躁狂打骂,亟当泻火祛痰 脑为元神之府,主宰五脏



之志，脑失其常，则五脏失和，神机失用。老年期痴呆的行为障碍以激越行为最为常见，症如躁狂妄动，吵闹不休，起坐无常，寤寐失度，白日神呆嗜睡，入夜喧扰不宁，语言失伦，或歌或笑，或哭或怒，多伴有颜面潮红，饮食无度，胸痞痰多，便秘尿赤，舌红脉数等。此乃心肝之火挟痰浊上蒙清窍，扰乱神明所致，即《内经》“诸躁狂越，皆属于火”，及《难经》“重阳为狂，阳主发越，风痰是也”之证。亟当清心泻火，祛痰开窍。方宜黄连解毒汤合温胆汤化裁：取黄连、黄芩、黄柏、栀子清泄心肝之火；辅以枳实、半夏、茯苓、陈皮理气化痰；并佐以石菖蒲、远志、丹参开窍安神；甘草调和为使。若入夜不安，加少量肉桂与黄连同用，以奏交泰之效；声音壮厉，饮食无度，加石膏、知母兼泻胃火；大便干结者，加生大黄釜底抽薪。

2. 妄言妄见，治宜活血化痰 脑髓纯则灵，杂则钝，人休十二经脉，三百六十五络，其血气皆上行而走空窍，脑惟有气血不断滋养，方能发挥元神主宰之功能。若瘀凝气滞，蒙蔽清窍，则灵机呆钝，神识迷乱，魂魄失宁，而症见幻觉妄想，或日时妄见，耳时妄闻，鼻时妄嗅，或喃喃妄言，动作离奇，多伴有神态忧郁，面色晦滞，唇青舌紫，脉涩不畅等，故老年期痴呆患者后期出现妄言妄见等严重的精神障碍每与瘀血相关，诚如《血证论》所谓“瘀血在内，亦谵语见鬼”。治当活血化痰，安神宁魂。方用血府逐瘀汤合柴胡加龙骨牡蛎汤加减：取桃红四物汤活血祛瘀，通脉安神；臣以柴胡、黄芩、龙骨、牡蛎清泄肝热，镇静定魂；佐以桔梗、枳壳、牛膝疏通周身血气；使以甘草调和诸药。若幻听频发，加石菖蒲、磁石平肝开窍；妄言不止，加栀子、水牛角清心定志；神态忧郁，加合欢皮、郁金以解郁醒神。

3. 恍惚惊骇，法当养心复神 老年期痴呆病程缠绵，脏



腑日衰,气血渐弱,势必致使脑府失养,心无所倚,神无所归,而症见精神恍惚,惊恐胆怯,善悲哭泣,或跟人进出,寸步不离,或独自外出,游荡迷失,多伴有面白少神,目光呆滞,形寒肢冷,舌淡苔白,脉细弱等。此即《金匱要略》“邪哭使魂魄不安者,血气少也。血气少者,属于心,心气虚者,其人则畏,合目欲眠,梦运行而精神离散,魂魄妄行”之证。治宜益气养心,补血复神,方用平补镇心丹(《和剂局方》)出人:取党参、熟地黄补气益血,以养心神;配以宁心安神之茯神、远志,养心安神之酸枣仁、五味子,重镇安神之龙齿,俾心得所养,神能守舍;佐以麦冬清心,肉桂温肾,使心肾相交。诸药同用,共奏平补气血、镇惊复神、交济心肾之功。若善悲欲哭,加炙甘草、淮小麦、红枣以养心安神;恍惚胆怯,加沉香、木香、川芎以芳香醒脑;肢冷嗜睡,加仙茅、淫羊藿、巴戟天以温补阳气。

第四章 专家经验良方

第一节 癲 癇

一、内服方

方1 自拟止癲汤(王红石)

【组成】 钩藤、生龙骨、生牡蛎、川芎、当归、红花、白芍、白僵蚕、牛膝、郁金、延胡索、柴胡。

【功效】 熄风定痛，活血化瘀。

【主治】 头痛性癲癇。

【用法】 每日1剂，水煎，早晚分服。

【方解】 头痛性癲癇多为气血郁滞、痰浊上扰而致。又因为小儿神气怯弱，时有惊恐，惊则气乱，则神志失守而成痛证；或由于生气导致气滞血瘀，气逆于上不得下则发病；或血滞于心，心窍不通，邪气在心，可成痛证；或肝气郁滞，肝风内动，也可致痛证。方中红花、延胡索活血化瘀，止痛；川芎、白僵蚕祛风化痰，定痛活络；柴胡、郁金清心解郁，行气破瘀；钩藤通心包于肝木，有平肝熄风、镇痛作用；当归入肝、心、脾经，性温，能散之、缓之，专入肝以助血海，使血行流畅。上药合用，起到活血化瘀、定痛活络作用。因此，可以治疗头痛性



癫痫。

方2 自拟抗痫汤(金淑梅、王有胜)

【组成】 黄芪 20g,蜈蚣 1g,白僵蚕 15g,全蝎 5g,胆南星 15g,半夏 10g,天竺黄 15g,丹参 15g,石菖蒲 15g,远志 15g,白芍 15g,天麻 15g,钩藤 20g,羚羊角 1g。加减:肝肾阴虚加熟地黄 20g,牡丹皮 15g,黄精 15g;脾虚便溏去黄精,加党参 20g,白术 15g;舌暗红,有瘀点加丹参 15g,红花 10g。

【功效】 益气活血,熄风化痰,止痉定痫。

【主治】 痫证(气虚、风痰瘀阻)。

【用法】 每日 1 剂,水煎,早晚分服。

【方解】 方中重用黄芪健脾益气以治本,脾气健运绝其生痰之隙。蜈蚣、白僵蚕、全蝎性善走窜,熄风镇惊,镇痛。胆南星、天竺黄、半夏燥湿化痰,助黄芪燥脾湿以健脾化痰。反复发作不愈,正气愈虚,风痰瘀愈结,甚则入络阻窍,用丹参活血化瘀化痰,黄芪得丹参则益气活血,共调气血,清窍得通。石菖蒲、远志化痰浊,开心窍,开心神,提神醒脑。白芍柔肝以解痉,羚羊角、天麻、钩藤平肝熄风,清热定惊。诸药相配,集寒热并用,攻补兼施,虚实兼顾,宜通上下内外,和调阴阳气机。

方3 自拟宁神镇痫汤(黄金铭)

【组成】 西洋参 10g,茯神、炒酸枣仁、白芍、龙齿各 30g,郁金、丹参、石菖蒲、半夏各 15g,胆南星、远志、白芥子、甘草各 10g,生铁落 60g。加减:如大便秘结,舌苔黄腻,脉象偏于弦滑者,去西洋参、白芍,加大黄、竹沥,配合每日静脉滴注 40ml 清开灵 5~7 天;舌紫暗,脉沉涩,挟瘀者,白芍改赤芍,加桃仁,每日配合滴注 60ml 刺五加注射液 5~7 天;舌红,脉细数为阴虚火旺者,加生地黄、玄参、麦冬,去半夏、白芥子;迁延日久,极度懒散、退缩者加肉桂、附子、紫石英。



【功效】 宁神养脑，平肝开郁，通络豁痰。

【主治】 癫证(精神分裂症)。

【用法】 每日 1 剂，加水 5 碗，先煎生铁落、龙齿，后入诸药浓煎成 2 碗，分 2 次凉服。1 个月为 1 个疗程，连续 3 个疗程。

【方解】 方中西洋参不温不燥，养阴益气，健脑益志，生津镇静；茯神、炒酸枣仁、远志养心宁神补脑；白芍柔肝养血荣脑；郁金、丹参解郁通络；半夏、胆南星消痰降逆；石菖蒲化浊开窍；龙齿、生铁落平肝潜阳。全方具有宁神养脑、平肝开郁、通络豁痰之功效。

方 4 自拟镇痫止眩汤(贺新玉)

【组成】 清半夏 10g，白术 10g，泽泻 30g，天麻 10g，陈皮 15g，赭石 30g(先煎)，党参 20g，白僵蚕 10g，全蝎 10g，胆南星 9g，甘草 6g。加减：伴有耳鸣，每次烦躁、恼怒而诱发或加重者，加用生石决明 30g，川牛膝 15g，夏枯草 15g；伴胸脘痞闷、泛泛欲吐、少食多寐者，加竹茹 9g，苍术 9g，生姜 6g；伴面色苍白、神疲懒言者，去泽泻，加当归 10g，酸枣仁 20g，黄芪 20g；伴耳鸣、头部刺痛、失眠、舌质紫暗者加红花 10g，丹参 20g；对 CT 示有囊虫影者，加用南瓜子、槟榔煎剂，另加用西药驱虫药。

【功效】 健脾祛湿、镇痫止眩。

【主治】 眩晕性癫痫。

【用法】 每日 1 剂，水煎，早晚分服。15~30 天为 1 个疗程。

【方解】 方中以党参、白术以健脾祛湿，清半夏、泽泻、胆南星、白僵蚕以祛痰开窍止痫，以天麻、赭石以平肝止眩，全蝎以搜络除风止痫，另以随症加减，药随证出。治疗中，可让患



者多参加体育锻炼,调节情志,解除思想包袱,坚持用药,多数在用药1周后可有显效,对于头颅CT检查有实质性病变者,辅以西药针对性治疗。

方5 自拟抗痫灵(崔红海)

【组成】 白术 20g,郁金 20g,橘红 20g,枳实 15g,白矾 15g,半夏 12g,龙骨 12g,远志 12g,丹参 30g,石菖蒲 12g,制天南星 12g,全蝎 10g,海浮石 30g,山楂 30g,茯苓 30g,炙甘草 6g。

【功效】 祛风化痰、补中健脾。

【主治】 癫痫。

【用法】 上药共研末,制成散剂,装入胶囊,每粒重0.4g。每日3次,每次2g,温开水送服。连服2个月为1个疗程。有效者可再连续治疗3个疗程以上。如无效则停药。在服用抗痫灵前已服西药者,不可即停,宜仍维持原剂量服用1~2周,第3周开始逐渐减少西药的用量,一般在30天内减至停药,不再服西药。

【方解】 癫痫俗名“羊痫风”,时发时止,反复发作。中医认为本病属本虚标实之证,发作期因痰蒙清窍而神昏,风性主动而抽搐颤动,故癫痫发作期应着重除痰熄风、开窍定痫,以治标为主;发作间期则以治本为主,重在扶正。作者所拟抗痫灵胶囊标本兼顾,祛邪而不伤正,具有祛风化痰、补中健脾之功,对癫痫时发时止、迁延日久者具有较好的疗效。临床观察,本方对儿童的疗效较成年人好;病程短者较病程长者疗效好;未使用过西药者较已使用西药者好。

方6 自拟止痫丸(雍履平)

【组成】 熟地黄、当归各 210g,水蛭、土鳖虫、蝉蜕、露蜂房各 42g,白芷、白僵蚕、广地龙、制胆南星、川郁金、远志、石



菖蒲、姜半夏、炒竹茹、紫河车各 70g,全蝎、蜈蚣各 14g。

【功效】 补肝益肾,化痰熄风。

【主治】 癫痫。

【用法】 诸药粉碎、过筛,水泛为丸如小绿豆大小,每次服 5g,每日服 3 次。或将药粉装入空心胶囊,每次服 3g,每日服 3 次。3 个月为 1 个疗程,连服 2 个疗程。凡服抗癫痫西药则剂量逐渐递减,第 1 月减量 1/3,第 2 月减量 2/3,第 3 月减完。儿童用量酌减,孕妇忌服。

【方解】 方中半夏化湿痰,竹茹化热痰,胆南星、石菖蒲、郁金、远志化顽痰,水蛭、土鳖虫、地龙祛血瘀,全蝎、蜈蚣、白僵蚕、蝉蜕、白芷等熄风通窍,露蜂房祛风攻毒,重用熟地黄、当归和紫河车等补肝肾益精血,标本同治,以治本为主。然癫痫发作规律甚难掌握,经较长时间服用中药止痫丸后,尽管能控制 1~2 年不发,但仍须密切注意观察,必要时,服药疗程可适当增加。

方 7 自拟活血止癔汤(付万仓)

【组成】 三棱 15g,莪术 15g,红花 10g,赤芍 15g,生大黄 15g(后下),丹参 15g,甘草 6g。加减:症见心悸、失眠者加酸枣仁 5g,茯神 30g;有幻觉者加牡蛎 25g,龙骨 25g;大便干加大大黄用量至 30g;月经有血块者加桃仁 20g。

【功效】 活血养血、破瘀止癔。

【主治】 癔狂(周期性精神病)。

【用法】 每日 1 剂,水煎,分 2 次温服。于经前 10 天开始服用,服至月经来潮停药,10 天为 1 个疗程,连服 3 个疗程。

【方解】 方中三棱、莪术破血行气;桃仁性润可除沉痼之瘀血;大黄功逐瘀血、加强活血养血、宁心安神;甘草甘缓和



中,诸药合用,具有破血行气、养血活血、宁心安神之功能。运用活血止癲汤治疗周期性精神病,疗效满意,可避免患者长期服用西药不易接受的弊端,且痛苦小,患者易于接受,疗效好,值得临床推广应用。

方8 追风定痛丸(张晓红、相彩枝)

【组成】 全蝎 32g,蜈蚣 32g,朱砂 32g,钩藤 30g,白僵蚕 30g,郁金 26g,木香 24g,白蜂蜜适量。

【功效】 追风定痛,豁痰开窍,润脏理气,开郁宁神。

【主治】 癲病。

【用法】 上药除朱砂、蜂蜜外,余6味共研末过120目筛,蜜炙为60丸,每丸重约5g,朱砂为衣。服法:成人每日早晚各1丸,开水送服,小儿减半。

【方解】 方中全蝎、蜈蚣、朱砂为镇惊定志而设,旨在熄风抗痉、平肝化痰,为君;钩藤熄风镇惊,安神益志,预防癲病发作;白僵蚕豁痰开窍,助君之力为臣;郁金为郁中之金,具祛痰涎、开心窍之功,木香理气解痉而降压为佐;蜂蜜味甘性平,和营卫、润脏腑、通三焦、调脾胃、除心烦、明目,为使;金箔亦助君药追风祛痰、抗痉定志之力。

方9 自拟五虫散加味(据坚)

【组成】 自拟五虫散加味:全蝎、白僵蚕、蜈蚣条、十蟹虫、蝉蜕、人黄、黄连、炒黄芩、天竺黄、川贝母、郁金、石菖蒲、丹参、玄明粉、青洋参、胆南星、竹茹等味。

【功效】 豁痰开窍,祛风止痉,活血化瘀,补脾宁心。

【主治】 癲病。

【用法】 五虫散各药共研成粉,混匀,每次6g(12岁以下患者每次3g),每日2次。3个月为1个疗程。视病情服3~4个疗程,到完全控制1年以上无大发作时停用。



【方解】 方药中全蝎、白僵蚕、蜈蚣性善行，独入肝经以搜深伏之风邪，为虫药中熄风止痉之要药，且能化瘀散结；蝉蜕亦入肝经，能祛风定惊止痉；土鳖虫最善祛瘀破血通经；半夏辛温性燥，燥湿化痰；胆南星、天竺黄、竹茹、贝母、青礞石清热豁痰，兼能凉心定惊，镇肝止痉；川芎、丹参、郁金行气活血祛瘀，丹参兼能除烦安神，郁金兼能清心开窍；石菖蒲化痰开窍，镇惊止痉；川黄连、炒黄芩大苦大寒，清热燥湿泻火，川黄连更善于泻心火；酸枣仁、柏子仁、炙远志养心安神，炙远志亦能祛痰开窍；龙骨、牡蛎镇惊安神，平肝潜阳；陈皮、茯苓健脾和中渗湿，茯苓兼宁心安神，陈皮理气消导，并可防虫类、石类及贝类药久用碍胃；生铁落镇心坠痰，安神定志；青洋参《滇南本草》为云南所特有的草药，其尤善治痫证；炙甘草健脾益气，调和诸药。

方 10 定痫丸(黄勇坚、李园园)

【组成】 定痫丸：由天麻、川贝母、姜半夏、茯苓、茯神、丹参、麦冬、石菖蒲、胆南星、全蝎、白僵蚕、琥珀、远志肉、陈皮、飞朱砂、甘草等组成。

【功效】 豁痰开窍，熄风定痫。

【主治】 癫痫。

【用法】 上药和为丸，温开水送服。

【方解】 中医学认为癫痫乃由于心、肾、肝、脾、脏气失调、阴阳紊乱、阳升风动、痰阻清窍所致。中药定痫丸以竹沥、胆南星、半夏、贝母、茯苓、姜汁、陈皮化痰降逆；石菖蒲、远志、天麻、全蝎、白僵蚕开窍熄风；琥珀、朱砂、茯神、丹参、麦冬定痫安神。

方 11 愈痫散(李素香、吴振刚、冯黎)

【组成】 全蝎 60g，蜈蚣 30 条，白僵蚕 60g，野天麻 60g，



生没药 12g,天竺黄 30g,生半夏(姜制)60g,胆南星 30g,木香 30g,南沉香 15g,琥珀 24g,朱砂(水飞)24g,天然牛黄 12g。加減:痰火盛加青黛、硼砂;气郁加香附、郁金、建曲;肾精亏损加紫河车、山药、益智仁;久治不愈或有外伤史者加桃仁、血竭、麝香。

【功效】 镇静安神,豁痰理气,祛风通络。

【主治】 痫证。

【用法】 上药均须选择上品药物,去杂质,分别研为细末,再称准药量混合均匀,装瓶备用。成人每次 6g,儿童酌减(1~3 岁每次 1.5~2g,4~6 岁 2~3g,7~14 岁 3~4g,15~20 岁 4~5g)。每日服 2 次,早晚各服 1 次,用铁锈水 100ml 送服。发作频繁者可每日服 3 次。(附:铁锈水制法取 2 块生有铁锈洗净加水磨之,下面以容器收纳,在将此水煮沸装瓶备用,服药时将此水摇荡后加温即可服用。)就诊前若患者从未服过抗癫痫西医(如苯巴比妥、苯妥英钠、卡马西平等),或已停药半年以上者,一般不再服用西药;若已服用超过 2 个月以上者,应仍用原药、原量,并配服愈痫散,若能有效地控制症状,可以逐渐减少西药用量,一般在 2~3 个月内减完,千万不要急于减少或停药抗癫痫西药。服药期间忌食猪肉、猪油、生冷及辛热刺激性食物,保持情绪乐观,避免精神刺激及房劳过度。

【方解】 方中天竺黄、胆南星、半夏、白僵蚕祛风通络,为止痉之要药;乳香、没药活血化瘀,理气止痛,兼有化痰之功;朱砂、琥珀镇心定志;牛黄清心利窍。诸药合用,豁痰理气,祛风通络,镇惊安神,标本兼治,故痫症可愈而不复发矣。

方 12 血府逐瘀汤(陈发青)

【组成】 当归 15g,桃仁 10g,红花 6g,川芎 15g,赤芍



12g, 怀牛膝 15g, 柴胡 5g, 枳壳 10g, 天麻 10g, 钩藤 12g(后下), 全蝎 10g, 生龙骨 25g(先煎), 生牡蛎 25g(先煎), 制天南星 10g, 半夏 10g, 石菖蒲 10g。

【功效】 活血化瘀, 平肝熄风, 涤痰开窍。

【主治】 痫证。

【用法】 每日 1 剂, 水煎, 早晚分服。

【方解】 《本草纲目》云:“脑为元神之府。”本例系头部外伤后颅脑受损, 气血瘀阻, 加之肝胃不和, 积痰内伏, 肝阳挟痰瘀上扰心窍, 神明闭塞, 经脉壅滞为患, 故以血府逐瘀汤活血化瘀, 行气解郁; 加天麻、钩藤、全蝎平肝熄风, 通络止痉; 配以半夏、胆南星、石菖蒲降逆和胃, 化痰开窍; 生龙骨、生牡蛎镇惊安神。全方使瘀化痰消, 气机调畅, 五脏安和, 故痫证乃愈。

方 13 抑痫散(张学斌、滕利萍)

【组成】 天麻 90g, 全蝎 90g, 丹参 90g, 当归 90g, 硼砂 30g, 明矾 45g, 制香附 90g, 木香 90g, 郁金 90g。

【功效】 豁痰开窍, 清心安神, 镇肝祛风。

【主治】 “肝风痰浊”所致的癫痫大发作。

【用法】 上药中除硼砂、明矾外都要烘干, 然后与硼砂、明矾共为细末, 混合均匀。每次 8g, 每日 3 次, 白开水送服。对癫痫发作频繁, 一直服用西药者, 不能立即停用西药, 而是随着中药服用时间的延长而逐渐减少药量。随着病情的控制, 而逐渐停药西药。服药 30 天为 1 个疗程。

【方解】 方中天麻具有平肝熄风作用, 全蝎为肝经风痰之要药, 能祛风止痉。二药为主能熄风、祛痰、止痛。配以明矾、硼砂祛痰、清热, 合以郁金清痰除烦, 木香、香附疏利气机, 共奏安神豁痰、镇肝理气、熄风止痉之效。此外丹参、当归均能活血、补血、益气以促进大脑功能恢复。



方 14 自拟方(单人骥)

【组成】 白附子 10g,细辛 6g,黄连 6g,生大黄 8g,生龙骨、生牡蛎各 30g,当归 10g,制蜈蚣 1~3 条,生甘草 5g。加减:伴头痛或头部有外伤史明显者,服王清任龙马自来丹 1.5g,每日 2 次;夜间或睡眠中发作明显者,加酸枣仁、夜交藤;记忆力下降者,加石菖蒲、炙远志;痰多、舌苔白腻、脉滑者,加半夏、白矾 1~3g;腰膝酸软、耳鸣或发作与月经有关,尺脉虚弱者,加山茱萸、淫羊藿等;经常由感冒诱发者,加服玉屏风散;体虚羸弱者,以黄芩易大黄。

【功效】 豁痰开窍。

【主治】 癫痫。

【用法】 水煎。每日 2 次分服,症状较平稳者,可隔 1~2 天服 1 剂。

【方解】 本方师《伤寒论》附子泻心汤之意,白附子、细辛为大辛大热之药,振奋阳气以消阴凝之顽痰,陈百平先生称“辛热之药开气机之闭塞,破痰邪之积聚”(《辽宁中医杂志》1991 年第 7 期),谢海洲先生认为细辛对中枢神经有抑制及明显镇痛、镇静、抗惊厥的作用(《中医杂志》1993 年第 7 期),且用于抢救癫痫持续状态,故方中以白附子、细辛为君,以振奋阳气,宣开心窍,消涤顽痰,即所谓辛开,“离照当空,阴霾自散”。其次,由于肾中龙火上升,肝火助之,癫痫大发作的患者多表现痰热内蕴(烦躁寐差,口干口苦,或大便干结,舌苔黄腻,脉滑数等症),选用龙胆草、黄连、生大黄苦降泄热降浊,通腑利气,佐以生龙骨、生牡蛎育阴潜阳,胆南星、天麻祛痰通络,当归、蜈蚣养血熄风。值得一提的是:赣东小区民间有一种土方法治疗癫痫病,且历史久远,亦获得一些疗效,即民间用长年山间流水沟中的小鹅卵石,放在铁锅中炒热,然后加入



红糖水,饮用此水,亦有控制症状者。

方 15 熄风涤痰汤(方婷娜、方思远)

【组成】 天麻 10g,茯苓 12g,半夏 10g,胆南星 9g,石菖蒲 9g,陈皮 5g,川芎 6g,制白僵蚕 10g,全蝎 5g,郁金 10g,甘草 5g。

【功效】 熄风涤痰,健脾化湿,行气活血。

【主治】 儿童癫痫。

【用法】 水煎服,每日 1 剂,服至控制发作后上药做成散剂,每次服用 3g,每日 3 次开水冲服,加服丙戊酸钠,每日 20~30mg/kg,分 3 次服,共服 6 个月。

【方解】 历代医家对癫痫病多有论述,其病因病机不外乎风、痰、惊、火、瘀。笔者认为,风与痰是本病的关键因素。风性善动,故抽搐时发;痰蒙清窍,故神志不清。特别是小儿为“纯阳之体”,脾胃易伤,故风痰常见,脾虚痰生,痰聚气郁,化火化风,火升风动,风痰上壅,蒙蔽心窍,扰乱神明而突发癫痫,故治病必须抓住治痰这一重要环节。另外,癫痫发作,治以熄风为要务,健脾化痰为原则,立熄风涤痰法辅以健脾化湿,组成方剂,治疗本病。

熄风涤痰汤,以天麻熄风止痉,其性辛润不燥,为风中之润剂,治风之妙药,且其具有祛痰之功,一药兼具熄风涤痰之能,为治癫痫要药,以为君;配以石菖蒲辛香逐秽,祛痰开窍;全蝎、白僵蚕熄风止痉、胆南星化痰熄风为臣;以二陈汤健脾燥湿化痰为佐;本病反复发作,日久不愈,久病必痰,久病入络,故用川芎、郁金行气活血为使。诸药合用,共奏熄风涤痰、健脾化湿、行气活血之功,切中病机而获效。

方 16 熄风化痰汤(陈四清)

【组成】 钩藤 15g,紫贝齿 30g,蝉蜕 5g,白僵蚕 10g,陈



胆南星 5g, 生地黄 15g, 白芍 12g, 炒黄芩 10g, 阿胶 10g(烊冲), 丹参 12g。

【功效】 熄风化痰、清心平肝、养阴活血。

【主治】 癫痫。

【用法】 水煎服, 每日 1 剂, 早晚分服。配合定痫丸, 每次 1 包, 每日 2 次, 口服。

【方解】 全方以钩藤、紫贝齿平肝熄风; 以蝉蜕、白僵蚕、陈胆南星熄风化痰; 炒黄芩清泻肝火, 有加强大脑皮质抑制之镇静作用; 阴津耗伤, 不能正常输布运化, 聚而成痰, 因此, 加入生地黄、白芍、阿胶三品, 养阴扶正, 以冀津液充沛而濡化黏聚之痰。阿胶一味兼能滋阴补血, 用于女性病家尤宜; 久病络瘀, 且痰瘀同源, 因此, 佐入一味丹参活血化瘀通络, 以防瘀血阻滞, 影响津液正常输布而加重痰浊之患。丹参并有安神宁心作用, 故用于此十分贴切患者病机。诸药合用, 共奏熄风化痰、清心平肝、养阴活血之功。定痫丸一药, 亦以天麻、川贝母、胆南星、姜半夏、陈皮、茯苓、石菖蒲、全蝎、白僵蚕熄风化痰, 以茯神、丹参、远志、琥珀、辰砂宁心安神, 配合麦冬养阴, 故与汤药相得益彰, 协同奏功。

方 17 通络熄风汤(徐荣谦)

【组成】 乌梢蛇 6g, 蕲蛇 6g, 白花蛇 1~2 条, 白檀香 3g, 地龙 6g, 水蛭 3g, 石菖蒲 10g, 远志 10g, 钩藤 10g, 生龙骨、生牡蛎、珍珠母各 15g(先煎), 青礞石 6g。加减: 头痛为主加川芎 6g, 菊花 10g; 腹痛明显加赤芍、白芍各 15g, 炙甘草 10g, 延胡索 10g; 惊惕不安加酸枣仁 10g, 龙齿 10g; 瘀血症状显著加丹参 15g, 红花 6g; 痰涎壅盛加葶苈子 5g, 胆南星 5g。

【功效】 通络熄风, 醒脑开窍。

【主治】 癫痫。



【用法】 用药6个月内,以汤剂口服:3个月以内每日1剂,分3~4次服,3个月以后按每周6剂,每周5剂,每周4剂,每周3剂递减,一般每半个月至1个月减量1次。6个月以后改为丸剂或散剂继服6个月以上,以巩固疗效。

【方解】 癫痫虽然分型复杂,但其根本的发病机制却基本一致。以腹型癫痫为例,临床表现以腹部疼痛为主,但病之根本却在脑,这一点各型癫痫均不例外。基本病机是络脉不通,或为风痰阻络,或为瘀血阻络,或惊恐气逆,或阴虚风动,皆与风有关。治疗应抓住关键,以通络开脑窍为主,络通风熄,则癫痫自止。而癫痫的络脉闭塞,非寻常通络之药所能奏效。因此,重用善于通络搜风的蛇类药,再配以活血通窍之地龙、水蛭;镇惊开窍之石菖蒲、远志;化痰之青礞石、牡蛎、珍珠母;芳香开窍白檀香等药物,其通络开窍之力大增。络脉通畅,脑窍开启,则其风自熄,癫痫之病得以痊愈。

方18 桃红四物汤加味(陈园桃)

【组成】 当归10g,川芎10g,赤芍10g,生地黄10g,桃仁10g,红花10g,胆南星10g,天竺黄10g,石菖蒲10g,全蝎5g,蜈蚣2条。

【功效】 行气活血,祛痰开窍。

【主治】 癫痫。

【用法】 上药煎汤,每日1剂,分早晚服,连服1个月后,改用上药研成细粉,5~10岁早晚各服1.5g,11~15岁早晚各服2g,16岁以上早晚各服3g,开水送服。连服3个月为1个疗程。

【方解】 中医学认为癫痫发病的原因是由于胎中惊或难产手术或惊恐跌仆、脑部受伤等使血络受损而气滞血瘀,内伤而积滞,形成痰在膈间,阻塞经络,上逆窍道而使脏腑升降失



调,阴阳不相顺接一时蒙蔽因而作痫。因脑为元神之府,神志逆乱,昏不知人,气血瘀阻则络脉不和,肢体抽搐。痰阻窍道、瘀血不行为其主要的病理过程,而外感六淫、内伤饮食、惊骇恐惧是其诱发因素,故在治疗上活血化瘀而治其本、涤痰开窍以定其痫。因为人的生命活力全赖血的流畅,气行则血行,血瘀则气滞,气滞则痰滞,血行则痰亦行。作者选用桃红四物汤加味就是承此之意。方中当归、川芎、赤芍、生地黄、桃仁、红花活血化瘀,加石菖蒲涤痰涎、开心窍,胆南星、天竺黄祛痰,全蝎、蜈蚣开窍而熄风定痫。

方19 天麻钩藤煎(吴东泽)

【组成】 天麻 10g,钩藤 15g(后下),煅石决明 15g(先煎),丹参 12g,郁金 10g,蝉蜕 10g,白芍 12g,延胡索 10g,甘草 6g,川芎 10g,红花 6g,全蝎(冲)1.5g,夜交藤 15g。加减:气血两虚加黄芪、当归;腹痛甚重用白芍、甘草、延胡索;头痛头晕重用天麻、川芎、延胡索、全蝎。

【功效】 平肝熄风,活血化瘀。

【主治】 小儿腹型癫痫。

【用法】 水煎,每日1剂,早晚分服。6剂为1个疗程。连服1~3个疗程。

【方解】 小儿腹型癫痫临床较为常见。中医学认为:“小儿肝常有余,脾常不足”。肝为风木之脏,体阴而用阳;脾为后天之本,主运化,为生痰之源。若肝阳化风,上扰清空,则头痛头晕;肝气乘脾,气机逆乱,筋脉挛急,则腹痛而作。肝脾功能失调进一步导致痰浊、瘀血病理产物的形成。因此,腹型癫痫的病机多与肝风和痰瘀相关。由于反复发作,治不得法,正气虚损,虚实夹杂,每每呈现气虚血瘀之象。调整阴阳、气机平衡,以肝脾二脏为辨证中心立法是治疗本病的关键。方中天



麻、钩藤、石决明平肝熄风，川芎、丹参、红花、郁金活血化痰，白芍、甘草、延胡索、全蝎缓急止痛，黄芪、当归益气补血。诸药相配，标本兼施，恰中病机，故疗效显著。

方20 疏肝理脾汤(肖旭腾、钟建岳)

【组成】 柴胡、枳壳、川楝子、白术、甘草各 6g，郁金、佛手、延胡索、白芍、麦芽、蒲公英各 9g，茯苓 12g。加减：脾虚者，加党参、山药、陈皮；食滞者，加神曲、鸡内金、莱菔子；伴呕吐者，加半夏、竹茹、藿香；大便秘结者，加生大黄、枳实、莱菔子；腹痛部位走窜者，加全蝎、蜈蚣；腹痛部位刺痛不移者，加桃仁、赤芍；肝火旺者，加栀子、牡丹皮。

【功效】 健脾舒肝，缓急止痛。

【主治】 小儿腹型癫痫。

【用法】 前 2 周每日服 1 剂，后 2 周隔日服 1 剂，4 周为 1 个疗程，连服 3 个疗程。有效者，亦可在第 2 个疗程改为隔日服 1 剂或每周服 2 剂，坚持服药 3~6 个疗程以巩固疗效。

【方解】 腹型癫痫属间脑癫痫，是一种少见类型，国内报道约占癫痫的 1.1%。其发作以自主神经功能紊乱症状为主，以反复发作、剧烈腹痛为特点，除伴有消化道症状外，亦可伴有头痛、意识障碍、抽搐等神经系统症状。本病属中医的食痛、腹痛、呕吐等范畴。《医宗金鉴》指出：“食痛者，其病在脾，因小儿乳食过度，停结中脘，乘一时痰热壅盛，遂致成痛。”本病病机与肝、脾密切相关。脾主运化，胃主受纳，饮食不节，则脾胃受伤。脾虚则不运，气滞不行，不通则痛。胃伤则传导失职，升降失常，上逆则为呕吐。肝主疏泄，调畅气机，助脾消化。若肝失调达，肝气横逆，木旺侮土，则见胁痛、腹痛、呕吐等症状，故在治疗上应以疏肝理脾为大法。本方以茯苓、白术



健脾渗湿；柴胡、郁金疏肝解郁；佛手、枳壳、川楝子、延胡索行气止痛；蒲公英、麦芽清肝消滞；白芍柔肝缓急；甘草补中调和诸药；全方有健脾舒肝、缓急止痛之功。

方 21 三虫抗痫汤(张宽智、张宗芹)

【组成】 制全蝎、白僵蚕、蜈蚣、石菖蒲、姜半夏、天竺黄、胆南星、当归、红花、龙骨、生姜汁。

【功效】 活血化痰，安神开窍。

【主治】 癫痫。

【用法】 制成煎剂，每次服 150ml，每日 2 次。另服朱蝎散(朱砂、制全蝎、黄连、天麻、白芍，按 1：2：3：6：10 的比例，共研细末)，成人每次服 2g，饭后 30 分钟服，每日 2 次，小儿酌情减量。

【方解】 癫痫多由情志不畅，而致脏腑功能失调，气血津液运行障碍，而生痰致瘀，或以痰为主，或以瘀为先，或痰瘀并生。痰来自津液，瘀本乎血，痰阻血难行，血凝痰难化，瘀血内阻，久必生痰，痰浊停留，更能致血瘀，二者相互转化，互为因果，则成痰瘀互结之证。由于痰聚而气逆不畅，气郁化火，火升风动，挟痰瘀上蒙心窍，扰动神明则致突然发作癫痫。张景岳曰：“凡气有所逆，痰有所滞，皆能壅闭经络，格塞心窍。”临床施治，常以活血化痰融为一体，可相得益彰，协同增效，使痰化瘀消，脏腑平调。自拟三虫抗痫汤方中用石菖蒲、姜半夏、胆南星、天竺黄、生姜汁、龙骨开窍化痰，凉心定惊，使痰化窍开，心定神安；当归、川芎、红花活血化瘀，行气通络，祛瘀生新，使气顺血畅，心神自安；全蝎、白僵蚕、蜈蚣除祛风解痉、止痛散结外，清热化痰之力甚著；更配朱蝎散以增强三虫抗痫汤活血化痰安神之力。诸药合用使血活痰化，窍开神安，痼疾自愈。



方 22 宁痫散(杨宗正)

【组成】 天麻、牛黄、全蝎、白僵蚕、蝉蜕、川贝母、白附子、木香各 5g, 茯神、酸枣仁各 7.5g, 朱砂 2.5g。

【功效】 熄风定痫, 豁痰开窍, 宁心镇惊, 顺气降逆, 扶正固本。

【主治】 小儿癫痫。

【用法】 诸药共为细末, 装瓶备用。用时取鸡蛋 1 个, 将其一端打一小孔, 倒出蛋清少许, 然后放入药粉, 每次药量是未满 1 岁 0.5g, 1~5 岁 0.75g, 6 岁以上 1g。用竹筷伸入蛋内轻轻搅匀, 再用湿草纸将蛋包 7 层, 放入火炉内烧; 待 7 层纸烧干, 将蛋取出去壳, 饭前服; 先饮黄酒 5~10ml 为引, 然后食蛋。每日 1 次, 1 个月为 1 个疗程, 连服 3 个疗程。

【方解】 宁痫散以天麻、牛黄为主药, 天麻有熄风定惊之功, 《开宝本草》谓其主治小儿风痫; 牛黄功能清心开窍, 豁痰定惊, 清热解毒。《日用本草》谓其“治惊痫搐搦烦热之疾, 清心化热, 利痰凉惊”。全蝎、白僵蚕、蝉蜕、白附子皆为祛风止痉之要药, 与天麻配伍, 熄风定痫之力倍增; 白附子、全蝎、白僵蚕兼能化痰, 蝉蜕又可清热。川贝母乃祛痰之妙药, 兼能开郁下气、润心肺、安五脏, 可增白附子、全蝎、白僵蚕荡涤痰涎之力, 助牛黄逐痰以开窍。朱砂、茯神、酸枣仁宁心安神, 镇惊定痫, 与牛黄配合, 相得益彰; 木香顺气降逆; 久病必虚, 而鸡蛋滋阴养血, 扶正固本。诸药配伍, 共奏熄风定痫、豁痰开窍、宁心镇惊、顺气降逆、扶正固本之功, 故用于临床颇能得心应手。

方 23 宁痫汤(张丽萍)

【组成】 白僵蚕 15g, 蝉蜕 10g, 姜黄 10g, 竹茹 10g, 半夏 10g, 三七叶 10g, 大黄 6g。加减: 痰多加橘红 10g; 热盛加黄



芩 10g;舌质暗或有瘀斑加丹参 15g,郁金 10g。

【功效】 调畅气机,升清降浊。

【主治】 癫痫。

【用法】 每日 1 剂。2 个月为 1 个疗程,每 2 个疗程复查 1 次脑电图。经上方治疗后如癫痫发作间歇时间明显延长,则服药改为隔日或 3 日 1 剂,巩固治疗至癫痫发作基本控制、脑电图基本恢复正常后停药。

【方解】 方中白僵蚕气味俱薄,可散逆浊结滞之痰;蝉蜕质轻气寒,能祛风胜湿散热;姜黄苦平,利血中之气而散郁;大黄苦寒,荡涤瘀浊,推陈出新;竹茹、半夏相配,清利痰浊而调畅气机;三七叶行血以增和血调气之功。全方配伍注重升降并施,内外通和,故能奏调畅气机、升清降浊之功,使痰、瘀、风、热等致病之浊邪得除,元神得养,而获治病之良效。

方 24 祛癫汤(李新纯、李庆、唐武)

【组成】 人参 15g,白术 30g,肉桂 3g,干姜 3g,白芥子 15g,石菖蒲 6g,半夏 10g,陈皮 10g,甘草 3g。

【功效】 补虚、散寒、化痰。

【主治】 癫痫(精神分裂症阴性症状行为)。

【用法】 水煎,每日 1 剂,分 2 次服。

【方解】 精神分裂症阴性症状行为中医多归属于癫痫范畴。对于癫痫的认识,古今医家多有阐述,《七松岩集》载:“癫痫……虽有痰有火,实不足之虚病,宜补不宜泻。”董建华以为“癫症大多以虚证为主,治疗多以健脾益肾化痰开窍为法”。陈士铎云:“癫痫之生也,多由于脾胃之虚寒。脾胃虚寒,所食水谷不变精而变痰,痰凝胸膈之间不得化,流于心而癫症生矣”。其所创的祛癫汤,确实切合癫痫病机,实为治癫良方。笔者在多年治疗精神分裂症阴性症状行为的临床实践中,发



现该病的病机实以虚、寒、痰三者居多,采用祛癔汤治疗多有疗效。

祛癔汤从总体来看,补虚、散寒、化痰,三擅其功,方中人参、白术专补脾胃;干姜、肉桂以祛寒邪;白芥子、半夏以消顽痰;甘草、石菖蒲以引入心经而开窍。现代药理研究表明,人参对高级神经活动具有双向调节作用;白术具有抗血凝作用;肉桂具有扩张血管、促进血液循环、增加冠脉及脑血流量使血管阻力下降,其提取物桂皮醛有抗神经活动的作用,从而达到治疗精神分裂症阴性症状行为的作用。至于能否调节脑内DA系统与5-HT系统之间的失衡状态尚有待于进一步研究。

方25 平肝熄风汤(常冬梅、杨絮、甄薇)

【组成】 柴胡、郁金各15g,当归、天麻各10g,钩藤、天竺黄各15g,胆南星、石菖蒲、丹参各10g,半夏15g,人参5g(包),云茯苓、白术各15g,羚羊角1.0g(包),白芍15g。加減:惊癔加琥珀10g,全蝎5g,朱砂1.0g(包);食癔加枳壳10g,焦山楂、川楝子各15g;痰癔加胆南星15g,半夏20g;风癔加天麻、白僵蚕、钩藤各15g。

【功效】 平肝熄风、清心豁痰、健脾益气。

【主治】 癔病。

【用法】 水煎服1次30ml,每日3次。疗程1~2个月。

【方解】 现代医学对癔病的治疗,多采用镇静止痰药,中医学认为多由于脏腑功能失调、痰浊阻滞、气机逆乱、风阳内动所致,其病因多由惊、食、痰、风引起。笔者根据《素问·至真要大论篇》曰:“诸风掉眩,皆属于肝”的理论,按中医辨证施治,以平肝熄风、清心豁痰、醒脾益气为治则,自拟方中柴胡疏肝解郁;天麻、钩藤、全蝎、白僵蚕平肝熄风;胆南星、天竺黄、



半夏化痰开窍；羚羊角清肝胆热；丹参、当归、白芍养血活血；人参、茯苓、白术益气健脾，扶助正气；石菖蒲、郁金、远志、琥珀、朱砂醒脑开窍，宁心安神，使气顺血行，风熄神清。此方对各类型癫痫均有较好的疗效。

方26 痫痛宁(王喜聪)

【组成】 川芎 15~30g, 天麻 6~12g, 钩藤 6~12g, 葛根 10~20g, 全蝎 4~10g, 地龙 6~12g, 蔓荆子 6~12g, 藁本 5~10g, 石菖蒲 5~10g, 白芍 6~10g, 羌活 6~12g, 胆南星 3~6g, 枸杞子 8~14g, 灵芝 6~12g。加减：瘀血症状明显者加桃仁 6~12g, 红花 6~12g；痰浊症状明显者加天竺黄 3~6g, 半夏 6~10g；脾肾虚者加黄芪 6~12g, 龟甲 6~10g, 牛膝 6~12g；食积者加莱菔子 6~12g, 槟榔 4~10g, 山楂 6~12g；伴呕吐者加竹茹 6~12g, 半夏 5~10g；伴腹痛者加延胡索 6~12g, 高良姜 4~18g；伴抽搐者加蜈蚣 1~3 条, 白僵蚕 6~12g。根据疼痛部位不同可以酌加引经药。前额痛加白芷 6~10g, 两侧痛加柴胡 5~10g, 巅顶痛加吴茱萸 3~6g。

【功效】 平肝通络, 化痰补虚。

【主治】 头痛型癫痫。

【用法】 水煎, 每日分 3 次温服, 每日 1 剂。

【方解】 方中川芎用量大, 有活血通络止痛之功用；天麻、钩藤平肝熄风；白芍养肝柔肝以熄风, 缓解血管痉挛以止痛；全蝎、地龙通络止痛, 熄风止痉；胆南星、石菖蒲化痰安神；灵芝、枸杞子健脾益肾以补虚；葛根、藁本、羌活、蔓荆子皆为治头痛之要药。全方共具平肝潜阳、化痰通络、补虚止痛之效。

现代药理研究证明天麻、钩藤、石菖蒲、全蝎、地龙都有不同程度的抗惊厥、抗痫作用；川芎能降低外周血管阻力, 抗血



小板凝聚,降低血液黏度,能透过血脑屏障,在脑干分布较多,可改善脑组织的供血状态;灵芝能增强中枢神经系统功能;黄芪、灵芝、枸杞子等都能增强人体免疫功能,使下降的免疫球蛋白上升。由此可见,本方组方合理,恰合病机,故疗效肯定。

方 27 克痫灵(李志彬)

【组成】 石决明 20g,白僵蚕 10g,全蝎 1g,蜈蚣 1g,石菖蒲 15g,丹参 20g,茯神 20g。加减:如痰盛者加半夏 15g,竹茹 6g,胆南星 10g;火旺者加龙胆草 15g,木通 6g,生地黄 20g;久病瘀血者加当归 15g,红花 6g,川芎 10g;气虚者加党参 15g,黄芪 15g;肾阴虚者加熟地黄 20g,山茱萸 10g,枸杞子 15g。

【功效】 祛瘀通络,熄风镇痉。

【主治】 癫痫。

【用法】 以上为每天内服药量,水煎服,其中全蝎、蜈蚣烘干研末冲入药汤同服。病情完全控制 2 个月以后以黄芪 15g,白术 15g,当归 15g,丹参 12g,山茱萸 15g,熟地黄 15g,杜仲 12g,龟甲胶 10g,枸杞子 10g 为基础方根据病情随症加减进行调气补血、强脾健胃、调节阴阳等巩固治疗 2~5 个月。1 个月为 1 个疗程,共治疗 6~8 个疗程。

【方解】 中医认为癫痫病其病因以痰、风、火、惊、瘀为主,病久损及五脏,导致经脉不通,阴阳失调。在临床上发现以痰、瘀致病者居多,因而自拟克痫灵方中,用全蝎、蜈蚣、丹参、白僵蚕等祛瘀通络,熄风镇痉;石菖蒲化痰开窍;石决明、茯神安神定惊,并在此基础上随症加味。尤其对有头部外伤史、病久有瘀血阻络者重用祛瘀通络药往往能较快地有效控制病情。休止期以调气补血、强脾健胃、滋补肝肾为主,杜绝生风积痰之源,从而达到标本兼治的目的,有效控制复发。



方28 抗痫散(逯建存、王忠良、汤明双)

【组成】 柴胡 20g,黄芩 15g,半夏 15g,党参 15g,桂枝 10g,白芍 20g,石菖蒲 20g,胆南星 15g,枳实 10g,陈皮 15g,茯苓 15g,远志 15g,地龙 20g,天竺黄 15g,黄芪 30g,当归 6g,丹参 30g,全蝎 6g,白僵蚕 6g,生龙骨、生牡蛎各 30g,白术 20g,炙甘草 5g,天麻 20g,钩藤 15g,川芎 15g,紫河车 1具。

【功效】 化痰开窍、祛风散邪、化痰定痫、益气养血。

【主治】 癫痫。

【用法】 上药研末,每次 3~6g,每日 3 次,儿童酌减,30 天为 1 个疗程。本组病例最短治疗 30 天,最长 12 个月,平均 6 个月。

【方解】 方中柴胡桂枝汤调和阴阳。有报道称,柴胡桂枝汤能延长巴比妥酸盐的睡眠作用,动物实验证实可控制痉挛发作,细胞水平研究证实可使戊四氮痉挛引起的突发性活动得到控制。陈皮、半夏、茯苓、石菖蒲、枳实、胆南星等化痰开窍,《本草纲目》云石菖蒲能“治中恶卒死,客忤癫痫”,胆南星“治惊痫、口眼歪斜”。动物实验表明石菖蒲有镇静和镇定作用,临床用其治疗各种原因引起的癫痫大发作总有效率为 75%,与苯妥英钠同用可明显提高苯妥英钠的疗效。远志、生龙骨、生牡蛎定痫安神,全蝎、白僵蚕、天麻、钩藤、地龙祛风散邪。现代药理学研究证明龙骨、牡蛎含有的无机盐和钙离子,能增强大脑皮质的抑制过程,通过增加钙离子浓度,可使神经细胞兴奋性减弱。天麻浸膏能明显对抗戊四氮引起的小鼠阵发性惊厥,减少发作次数,推迟发作时间,对豚鼠实验性癫痫有效。钩藤煎剂有明显镇静作用,可预防豚鼠实验性癫痫的发作。地龙也被证实有明显的镇惊止痉作用。全蝎有抗惊厥作用,可对抗戊四氮、硝酸士的宁及烟碱引起的惊厥。丹参、



川芎、当归等祛瘀活血，四君子汤、当归补血汤益气养血。《日用本草》云“紫河车能治男女一切虚损劳极，癲痼，神志恍惚，安心养血，益气补精”。上药合用，起到了调和阴阳、协理枢机、化痰开窍、祛风散邪、化瘀定痫、益气养血的作用，故收到了良好效果。

方 29 抗痫方(时澄、苏莉、李青)

【组成】 桃仁 12g,红花 12g,当归 12g,党参 12g,川芎 12g,天麻 12g,蝉蜕 9g,白僵蚕 12g,胆南星 12g,钩藤 15g,郁金 12g,牛膝 12g,石菖蒲 10g,全蝎 6g,蜈蚣 1 条。

【功效】 熄风止痉、祛瘀定惊。

【主治】 癲痼。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，15 天为 1 个疗程，小儿药量酌减 1/2~1/4。

【方解】 风与痰为痫证的发病基础；痰瘀相关，因此，在癲痼的发病过程中，瘀血的因素总是存在的，故治疗方法以熄风止痉、祛痰、活血化瘀、定惊为主。抗痫方中，桃仁、红花、当归、川芎、郁金、牛膝活血祛瘀，引血下行；天麻、蝉蜕、钩藤、石菖蒲熄风止痉，开窍宁神定惊；天南星、白僵蚕、全蝎、蜈蚣熄风止痉，化痰散结；党参补中益气且防伤正气。整个组方配伍意在熄风止痉、祛瘀、祛痰、定惊，祛除致病因素，疾病自愈。

方 30 健脑豁痰汤(熊杰、马融、张果忠)

【组成】 山茱萸、紫河车、茯苓、石菖蒲、天麻、全蝎、赭石、羌活。加减：头痛加菊花、川芎、薄荷；便秘加大黄、芦荟等；食积加焦三仙、炒莱菔子等。

【功效】 豁痰祛风。

【主治】 小儿癲痼。

【用法】 水煎服，每天 2 次。小于 3 岁，每次 50~100ml；



3~9岁,100~200ml;9~17岁,200~250ml。

【方解】 本病的发生可由多种原因导致脏腑失调、气机逆乱。《医林改错》云:“元气一时不能上转于脑髓”,“脑无灵机之气使然”,即髓海空虚,脑失所养为病发之关键。同时,痰不仅为治病之因,也是痛证发作之因。因此,治痛当豁痰,痰去则气机通畅,脏气得平,风必自熄,阴阳顺调,癫痫可止。脑由髓聚而成,而髓之本在于肾,故本方以熟地黄、紫河车为主药益肾健脑;天麻其性不燥,为风中之润剂,治风之妙药;配石菖蒲豁痰开窍;全蝎熄风止痉、平肝潜阳。

方31 加味通窍活血汤(刘炳志、于仙福)

【组成】 赤芍 3g,川芎 3g,桃仁 9g,红花 9g,老葱 3根,红枣 5g,麝香 0.15g(冲服),黄酒适量,羚羊角粉 1.2g(冲服),全蝎 2g,蜈蚣 0.6g,鹿茸粉 1.2g(冲服)。

【功效】 活血化瘀,醒脑开窍。

【主治】 外伤性癫痫。

【用法】 每日1剂,水煎分2次服,20日为1个疗程。一般治疗4个疗程可见效,特殊重症患者可酌情延长治疗时间。

【方解】 外伤性癫痫是神经系统顽症,西药治疗虽可改善症状,但无法根治,且其毒副作用较多。加味通窍活血汤可全面调理脏腑及阴阳升降功能,扶正与祛邪并举。其中赤芍清热活血,川芎逐瘀,桃仁祛瘀生新,红花行血,麝香开窍醒脑,老葱、黄酒通顺气血,红枣健脾,全蝎、蜈蚣熄风止痉,羚羊角平肝熄风,鹿茸益肾填精。现代药理研究显示本方可有效改善脑部血液循环,激活修复休克休眠损伤的大脑细胞,逆转变性大脑细胞的损伤,可抗惊厥,营养脑细胞,调节机体生物物质代谢平衡和下丘脑的功能失常,阻止大脑异常放电的扩



散,故可有效治愈外伤性癫痫。

方 32 建中汤加生铁落饮(周丽华、刘传珍)

【组成】 桂枝、白芍、甘草、生姜、大枣、饴糖、黄芪、当归、全蝎、延胡索、生铁落。

【功效】 益气温里、祛瘀解痉。

【主治】 小儿腹型癫痫。

【用法】 每日 1 剂,水煎 2 次服。3 个月后改为上药研末吞服,每日 3 次,每次 1~5g。并外用贴脐药膏:珠砂、琥珀、三七、肉桂,调以桂氮酮溶剂,每天换 1 次,贴敷 1 个月为 1 个疗程。治疗半年以上,除发热外,服药不可间断。

【方解】 腹型癫痫,中医古名“内钓”。明·万全《幼科发挥》曰:“内钓者,肝受寒,则少腹痛,大叫哭,目直视,但不抽耳。”又曰:“内钓腹痛多啼,唇黑囊肿,伛偻反张,眼内有红筋斑血者是也。此寒气缠结,只宜温散,木香丸主之。”说明中阳不足,脏腑虚寒是本病发生的关键,建中汤能温中补虚、和里缓急而止腹痛。生铁落饮为《内经》十三方之一,原治怒狂,能“下气疾”。生铁落中以四氧化三铁为主,兼有其他微量元素,宋《大明诸家本草》曰:“治惊邪癫痫,小儿客忤,消食及冷气,并煎服之。”可知其功伟哉!另加黄芪以补气扶正,增加患者免疫力。当归、延胡索祛瘀活血、解痉止痛,使全身微循环得以改善,脑局部供血得以提高。全蝎及虫类搜剔之品,擅熄风定惊、镇静、抗惊厥。上述各药合而成方,共奏益气温里、祛瘀解痉之功。

内服与外治相配合,外用药中,三七善行瘀散血,使其他药物借助三七之力渗进皮肤,透行于脉络之中,直达病所,改善了机体的微循环和血液流变性质,肉桂擅长温里祛寒;琥珀镇惊安神,利水消瘀;朱砂镇惊定心。四味配伍,互相促进,通



过脐部神阙穴,渗透患儿机体,药末用皮肤渗透促进剂桂氮酮调配,收效更快。总之,药物外敷同时具有穴位刺激及从皮肤吸收的双重作用。

方33 加减桃仁承气汤(王伟、栗明兰)

【组成】 钩藤、石菖蒲各 30g,桃仁、水蛭、炒蒲黄各 15g,桂枝、远志各 12g,全蝎、白僵蚕各 10g,制大黄、朴硝各 6g。加减:心烦、失眠、舌红加黄连 12g,朱砂 5g;颅内瘀血明显或有软化灶重用 水蛭 30g;抽搐频繁加白芍 30g,羚羊角粉、全蝎各 5g;痰涎多加沉香、煅青礞石各 10g。

【功效】 活血化瘀。

【主治】 脑外伤癫痫。

【用法】 水煎服,每日服 3 次,每日 1 剂。儿童用量酌减。

【方解】 脑外伤癫痫,是因外伤而致血瘀气滞,瘀浊阻闭清窍,脏腑气血失调、阴阳之气不相顺接而出现的一种阵发性神志异常的疾病,故方中的水蛭、桃仁、蒲黄逐颅内之瘀血;桂枝祛瘀通血脉;制大黄、芒硝导瘀浊下行;石菖蒲、远志醒神开窍;全蝎、白僵蚕、钩藤、龟甲熄风止痉。其药证相符,故痼得愈。

方34 加减癫狂梦醒汤(叶德梁)

【组成】 桃仁 10g,赤芍 15g,柴胡 12g,香附 10g,半夏 10g,青皮 9g,紫苏子 10g,全蝎 3g,石菖蒲、川芎各 15g,当归 12g,瓜蒌 10g。

【功效】 豁痰开窍、熄风定惊。

【主治】 癫痫。

【用法】 上方每日 1 剂,水煎,分 3 次服用,小儿用量酌减,1 月为 1 个疗程,用药期间停用其他抗惊厥药,3 个疗程后复查脑电图,待脑电图基本恢复正常再逐渐停药观察,一般服



3~5 个疗程。

【方解】 癫痫病中医认为可由先天失养、产后受伤、情志失调、遭受惊恐、饮食失节、劳累过度、外伤等多种因素所致，但其病机不外乎风、痰、火、惊 4 种，日久必致气血运行不畅，瘀滞脉络，闭阻心窍。单用豁痰开窍、熄风定惊之法，往往难以奏效，若在此基础上配以活血化瘀之品，常可收效。

方 35 葛根僵蚕汤(陈忠伟)

【组成】 葛根 30g，白僵蚕 10g，制半夏、制天南星各 12g，猪牙皂 6g，石菖蒲、郁金各 10g，黄连、龙胆草各 6g，蜈蚣 3 条，全蝎 5g，露蜂房 12g，局方牛黄清心丸 1 粒(另吞)。加减：风痰偏盛加天麻 10g，竹沥 30ml(冲)；痰火内盛大便秘结者加生大黄、玄明粉(冲)各 10g；虚者适减黄连、龙胆草剂量或不用，兼心脾两虚加党参 20g，白术、远志各 10g，酸枣仁 15g；肝肾阴虚加熟地黄、枸杞子各 15g，山茱萸 10g；血瘀明显者加桃仁、赤芍、川芎各 10g，丹参 15g。

【功效】 清热熄风、开窍定痫。

【主治】 癫痫。

【用法】 儿童剂量酌减，每日 1 剂，水煎服。

【方解】 方以制天南星、制半夏、石菖蒲、郁金、猪牙皂豁痰开窍；黄连、龙胆草泻肝清热；白僵蚕、露蜂房、蜈蚣、全蝎平肝熄风镇痉；局方牛黄清心丸清心安神定惊。然而久病入络，脑伤则瘀。本方妙在重用葛根，有改善脑微循环及外周循环的作用。动物实验证实，葛根素能明显扩张脑微血管，增加脑血流量。因而，在大剂豁痰熄风药中，寓葛根以微通络脉，俾血气和剂，顽痰渐化，则痫证可瘳。范老冠以“葛根白僵蚕”立方，寓意深矣！另外，现代药理研究证明，白僵蚕、天南星、石菖蒲、蜈蚣、全蝎具有镇静抗惊厥作用，临床报道用于治疗癫



痢均有疗效。综观全方有清热涤痰、熄风镇痉、疏通络脉、开窍定痫之功,故治疗痫证能收良效。再者,遵先哲“新病势急,宜治以重剂;邪气已退,药宜间服”之训,治疗组采用服药方法亦是巩固疗效的重要环节。

方 36 抗痫面饼(庄振裕)

【组成】 石菖蒲 30g,远志 20g,制天南星 30g,半夏曲 30g,神曲 50g,白僵蚕 100g,天竺黄 25g,蜈蚣 10 条(焙),地龙干(焙)50g,茯苓 100g,枳实 30g,川浙贝母各 25g,陈皮 20g,丹参 50g,琥珀末 50g,水牛角(挫极细末)250g,上料研成极细末与面粉 750g 拌匀加清水成面团,成人量分成 60 等份,儿童量分成 90 等份,擀成厚如纸板样圆形面饼,在热锅上烘干,以面粉熟为度,表皮呈微黄色。不得油煎或油炸,不得烘焦。待药饼凉透收藏饼干盒或塑料袋中备服。若风痰久蕴兼有痰火者,症见口干、微烦、舌质偏红、苔黄,上药料加栀子仁 70g,服药时以竹沥汁 1 支送服。

【功效】 涤痰开窍、熄风定痫。

【主治】 风痰闭阻型癫痫。

【用法】 每日早、晚空腹服 1 个面饼,白开水送服,30 天服 1 料,可连续服数料。

【方解】 癫痫为临床上常见难治之病。其病因以痰为主。《丹溪心法·痫》认为“痫证……无非痰涎壅塞,迷闷孔窍、发则头旋颠倒,手足抽搐,口眼相引,胸背强直,叫吼吐沫,食顷乃醒。”其病理变化以痰聚气逆、风痰阻窍导致脑气与脏气不相顺接而引发痫证,脏气不平、痰浊肝风为癫痫临床各型所拥有的特征。历代医家常以从痰入手为治疗癫痫之常法,故本药面以涤痰开窍、熄风定痫面取效。方中天南星、半夏曲、石菖蒲、远志、川浙贝母、天竺黄豁痰开窍;蜈蚣、白僵蚕、



干地龙、水牛角平肝熄风镇痉；陈皮、枳实理气降气，气顺则痰降；琥珀末镇心安神；丹参与化痰药同用，可消除痰瘀互结之弊；小麦粉、茯苓养心补虚，厚肠胃，益脾气，脾健则痰消。且小麦粉为良好的赋形剂。本药面饼治疗癫痫，因缺乏长期观察，从疗效显示，似以近期疗效为著。

方 37 风引汤(王冉、陈霞)

【组成】 寒水石 30g，滑石(另包)10g，赤石脂、白石脂、紫石英、石膏、龙骨、牡蛎各 30g，干姜、大黄各 10g，桂枝 15g，甘草 10g。

【功效】 镇肝熄风、化痰开窍。

【主治】 脑梗死继发性癫痫。

【用法】 水煎服。首次发病后，每日 3 次口服或鼻饲汤药 50ml；局灶性发作不予西药治疗，大发作和癫痫持续状态，首次发病用地西洋 20~40mg 静脉注射，病情控制后用鲁米那 0.1g 每隔 6 小时肌注 1 次，治疗 3 天。注意保持呼吸道通畅，对脑水肿、感染、水和电解质失衡要对症处理，全部患者在控制癫痫发作的同时应用治疗脑梗死的药物；出院后随访 1 年未复发。

【方解】 脑梗死并发癫痫，主要是脑动脉突然闭塞，引起急性缺氧、脑水肿、缺血，使一些细胞产生病理改变； γ -氨基酪酸能使神经元丧失，使抑制性递质释放减少；神经元树突状分支减少与突触棘丧失，使抑制性递质释放减少；星形胶质细胞增生，使细胞外液钾的浓度及 pH 值调节失常，产生膜电位变化，这些变化常发生于缺血缺氧时，尤其多见于软化灶的周边部，形成局部致痫灶，使皮质神经元大量异常放电所致，其发作类型主要为局灶性癫痫和癫痫大发作，癫痫发作多在脑梗死急性期。祖国医学对本病早有认识，张仲景《金匱要略·中



风历节病脉证并治》附方，风引汤云：“除热癰痢”，后世医家对此曾有误解，如明·楼英在其《医学纲目》中改“癰痢”为“癰痢”，陆渊雷亦力主“癰”是“癰”字笔误，其实仲景断无笔误之错，“癰”是指半身不遂，肢体瘫痪，是中风常见之症；“痢”是指有癰痢抽搐发作，二者合一的一类特殊病证，仲景谓之“癰痢”。

癰痢的病因病机：癰病肢末，痢病心窍，盖厥阴风木与少阳相火同居，火发必风生，风生必挟木势侮其脾土，故脾气不行，聚液成痰，流注四末，因成瘫痪；风阳痰浊流窜经络，蒙蔽心窍发为惊痢抽搐。方中石膏、寒水石、滑石、甘草，即三石汤，用寒凉以清火，辛凉以散风热；配伍大黄以逐邪热，协同三石，可以直折风火；龙骨、牡蛎重镇潜阳；用干姜、赤白石脂温养心脾之气，以补脾除痰湿之根；紫石英补心气不足，定惊悸，安魂魄；桂枝祛风，通窍利阳。诸药和而成方，重镇心肝，则风引癰痢可去，风阳、痰浊亦能自去。

方 38 定痢证散(陈丕烈)

【组成】 白矾、郁金、石菖蒲各 60g，白胡椒、白僵蚕、琥珀、三七粉各 30g，朱砂 15g。

【功效】 活血化痰、镇惊安神。

【主治】 痢证。

【用法】 将以上前 6 种药共研极细末，然后与后 2 味药和匀，装入 0 号胶囊中，成人每次 6 粒，儿童 2~3 粒；儿童服药 1 个月，成人服药 3 个月为 1 个疗程。服药期间避免惊怒、禁食羊肉、鸡肉、酒类、饮料类。自服药到病情停止发作，须继续连服 3~6 个月药方可停药，以免复发。

【方解】 《三因极-病证方论》云：“夫癰痢者，皆有惊动，使脏气不平，郁而生涎，闭塞诸经，厥而乃成，……。”说明本证之形成，多由骤受惊恐或跌仆撞击等外伤因素而导致风痰闭



阻,气血瘀滞,引发痫疾。《医学纲目·癫痫》云:“癫痫者,痰邪逆上也。”说明痰邪作祟是其病机重点。故治疗大法亦当以祛痰熄风化瘀滞为主。

综观本方中白矾入脾化痰,石菖蒲、郁金、白胡椒、白僵蚕祛风痰,开窍醒神;琥珀、朱砂镇惊安神;三七活血化瘀,全方共奏豁痰开窍、解郁祛风、镇惊安神之功,而见“定痫”之效。

方39 定痫复健丸(相修平、孙世山)

【组成】 人参 45g,茯苓 90g,白术 60g,胆南星 60g,半夏 60g,天竺黄 45g,皂角(焙焦)30g,明矾 30g,硼砂 30g,朱砂 30g,琥珀 45g,白僵蚕 60g,全蝎 60g,蜈蚣 50条,当归 60g,川芎 60g,甘草 45g。

【功效】 祛痰开窍、养肝活血。

【主治】 癫痫。

【用法】 上药共研细粉,水泛为丸,每服 6g,每日 2 次。

【方解】 癫痫是神经内科临床疑难病证之一,是一种短暂性发作性脑系统病。中医对本病历代论述颇多,其病因病机多属本虚标实,虚实错杂,既有气虚、气逆、痰浊、肝风、郁火、血瘀等标实之证,又有多脏俱虚、气血阴阳皆不足之象。

定痫复健丸方中半夏、胆南星、天竺黄、皂角、明矾祛痰化浊开窍;朱砂、琥珀、硼砂重镇潜阳解痉;白僵蚕、全蝎、蜈蚣化痰通络熄风;人参、白术、茯苓、甘草健脾益气,绝生痰之源;当归、川芎养血活血,且益心肝。综观本方,诸药相伍,以求痰浊祛、肝阳平、经络通,则火不能亢,气无所逆,风势自孤,诸标实之邪皆祛,对抑制脑部神经元异常放电而引起的一过性大脑功能紊乱有良好作用。方中配四君子汤健脾益气,扶正祛邪,且防止肝脾两虚,肝虚则生风,脾虚则生痰,风痰又成为癫痫再发作的诱因。总之,标本同治,虚实兼顾,俾正气盛,风痰



消,癫痫渐自愈。

方40 癫痫消散(付江)

【组成】 胆南星 60g,制半夏 100g,天竺黄 90g,远志 60g,冰片 20g,天麻 100g,全蝎 90g,白僵蚕 90g,蝉蜕 60g,磁石 90g,朱砂 10g,红花 90g,郁金 90g,车前子 60g,茯苓 90g,琥珀 30g。

【功效】 清热豁痰,熄风止痉,镇惊安神,化瘀通络。

【主治】 癫痫。

【用法】 上药研成细面,装入胶囊,每次服 6g(儿童减半),每日 3 次,3 月为 1 个疗程,儿童及体弱者可停药 6~7 天,再进行第 2 个疗程,一般 2~3 个疗程即可。服药禁忌:服药期间避免情绪刺激,强体力劳动,少进辛辣食物。

【方解】 癫痫中医又称为痫病,其发病与痰浊闭窍、瘀阻脑络有关,正如《医学正传》所述:“痫病之疾,因火动所作”。说明本病之形成大抵由于七情失调,先天因素,饮食不节,劳逸过度,或是他病之后,造成脏腑功能失调,痰浊阻滞,气机逆乱,风阳内动,清窍被蒙所致,而其病因是痰,病机为火动气逆。因此,本病治疗应清热豁痰。方中胆南星、制半夏、远志、冰片豁痰开窍;天竺黄清化热痰,清心定惊;天麻、全蝎、白僵蚕、蝉蜕平肝熄风,定惊止痉;磁石、朱砂安神定志;红花、郁金、车前子、茯苓、琥珀活血散瘀,通脑络降低脑水肿,促进脑部血液循环。

方41 涤痰活血汤(叶莲、吕向阳)

【组成】 天麻、石菖蒲、川贝母、胆南星、姜半夏、川芎、赤芍、丹参、柴胡、生龙骨、生牡蛎、远志、茯神、炙甘草。

【功效】 熄风宁神、涤痰化瘀。

【主治】 癫痫。



【用法】 水煎,早晚分服,每日1剂。

【方解】 方中川贝母、胆南星、姜半夏、石菖蒲共奏豁痰开窍之功;川芎、赤芍、丹参有活血化瘀之力;天麻、柴胡、生龙骨、生牡蛎有平肝熄风之效;远志、茯神、炙甘草则用于宁心安神。

方42 柴胡加龙骨牡蛎汤(闫炳远)

【组成】 柴胡 12~24g,黄芩、半夏各 6~9g,党参 12~15g,桂枝、茯苓各 9~12g,生龙骨 12~30g(先煎),生牡蛎 12~30g(先煎),铅丹 1~9g(包煎),大黄 6~12g,生姜 6g,大枣 6~12枚。加减:若痰扰心神者,加石菖蒲、远志化痰开窍止痛;若抽搐甚者,加全蝎、白僵蚕熄风镇痉;若气血亏虚者,加黄芪、当归补气生血;若虚烦不眠者,去铅丹加酸枣仁、柏子仁宁心安神。

【功效】 和解少阳、调畅气机、镇心安神。

【主治】 癫痫。

【用法】 每日1剂,水煎服。5剂为1个疗程,一般需要5~10个疗程。因方中铅丹有毒,服5剂后去铅丹,改用朱砂或酸枣仁等。

【方解】 癫痫属中医痫病范畴。现代医学认为癫痫是一种突然发生短暂大脑功能失调的疾病,临床上分为原发性和继发性两种,原发性癫痫目前尚查不出病因,能查出病因者称为继发性癫痫,本文所论即为继发性癫痫。中医学认为痫病多因突受惊恐、饮食所伤、先天因素以及外伤等所致。临床上,选用柴胡加龙骨牡蛎汤用治惊恐所致的肝气郁结、气机不畅、气血逆乱、神魂不藏之痫病取得显著效果。主要取其和解少阳、调畅气机、镇心安神之功。本方为小柴胡汤之变方。方中柴胡、黄芩清解肝胆之郁热,调畅气机;加桂枝配柴胡使内



陷之邪得从外解；加龙骨、牡蛎、铅丹镇肝胆、安心神、止烦定惊；茯苓安神定志；半夏、生姜化痰以开心窍；病久重用党参，益气扶正；大黄清内热和胃气以治痢。另外，依据其临床兼证之不同灵活化裁，每获良效。因方中铅丹有毒，每剂用量一般不要超过 9g，用布包煎，以防止药粉直接入口，连续服用不能超过 9 剂。对体虚或有慢性肝、肾疾患者忌用铅丹。

二、综合疗法

方 1 埋线治疗癫痫 1(陶俊艳,刘玉伟)

【取穴】 以督脉穴为主,取风府、大椎、陶道、心俞、腰奇、鸠尾。

【功效】 醒脑开窍,祛风豁痰。

【主治】 癫痫(发作频繁者)。

【用法】 常规消毒后,在穴位两侧 1.5~3cm 处局麻用持针器夹住带羊肠线的三角针,由局麻一点穿过穴位,由另一局麻点穿出,多次来回牵拉羊肠线,使穴位产生麻胀感,然后紧贴皮肤剪断羊肠线,放松皮肤,轻轻揉按局部,使羊肠线完全埋入皮下组织,留在体内部分力求长些,不得外露。用酒精棉球盖针眼,并敷盖消毒纱布,用胶布固定 2 天即可。

【方解】 中医认为癫痫属于中医学痫证的范畴,其病机可概括为脏腑功能失调,经络气机逆乱,风痰上扰神明。风府为足太阳、督脉之交会,功擅醒脑开窍、祛风豁痰,取此穴可直接有效地调节大脑功能。大椎为手足三阳经、督脉之交会,最善调节经络气机逆乱,为通经解痉之要穴。腰奇为督、肾两经之交会,肾生精髓,髓充脑,取本穴有补肾健脑之功,为治痫奇穴。以上 3 穴合用,能最大限度地纠正大脑功能之异常,使神清气和,则癫痫可愈。



从现代医学角度看,督脉所处的解剖位置相当于脑脊神经中枢系统,具有特异性调神功能。羊肠线作为一种异物蛋白,在人体内经过逐渐液化吸收,对腧穴产生一种持久的非特异性刺激冲动,在大脑皮质中产生一种强烈而持久的良性兴奋性,使相应病灶的脑神经元放电被削弱乃至解除,大脑的血液循环也得到改善,因此,最适合于癫痫发作频繁者。

方2 针刺治疗运动性癫痫(任永霞)

【取穴】 取大椎透灵台,至阳透筋缩,脊中透命门,腰奇透长强,神庭透凶会,百会透后顶,鸠尾透中脘,内关(双侧)、丰隆、太冲再加用双侧顶颞前斜线。透刺任督脉穴时取26号3~5寸毫针,刺头部穴和四肢穴时取28号1.5~2寸毫针。

【功效】 解郁涤痰,熄风解痉。

【主治】 运动性癫痫。

【用法】 患者先取俯卧位,取3~5寸针分别快速从大椎、至阳、脊中、腰奇穴刺入皮下,然后放倒针柄呈小于15°角的方向沿皮下分别向灵台、筋缩、命门、长强穴透刺,每针施行强捻转手法1分钟,然后使患者取仰卧位,用2寸毫针从神庭向凶会、从百会向后顶透刺,刺在帽状腱膜下有吸针感为佳,手法为小幅度快速提插。再取头穴中双侧顶颞前斜线(运动区),所刺深度同神庭透凶会。璇玑透膻中、鸠尾透中脘的刺法同督脉背部诸穴,施捻转手法。双侧内关、丰隆、太冲常规刺法,接以电针仪用断续波式疏密波,频率为2~3Hz,电流以患者能耐受为度,时间30~45分钟。隔日1次,10次为1个疗程,间隔3~5日再行下1个疗程,连续5个疗程。

【方解】 癫痫是脑细胞异常放电所致反复突发性脑功能异常的慢性疾病。头皮投影位置相当于头穴中的顶颞前斜线(运动区),针刺顶颞前斜线并通以电流刺激可使病灶外形成



一个附加刺激兴奋场来抑制病灶自发电位,从而控制癫痫病的发作。癫痫属中医学的痫证,多由气、痰、惊、郁等因素引起,其中七情失调、劳累过度与发病有密切关系。其可导致阴阳升降失常,脏腑功能失调,痰浊内生,气机逆乱,风阳内动,气挟痰上窜清窍而发病。《丹溪心法》称该证无非痰涎壅塞迷闷孔窍。根据以上病因病机选可头针穴位,其他配穴可辨证选取。督脉总督一身之阳,任脉总司一身之阴。痰邪郁滞督任二脉,则阴阳平衡失调。肝阳上亢,挟痰上扰,蒙闭清窍而发病。选用长针透针督任诸穴,可以通达任督,解郁涤痰,熄风解痉;神庭、百会可醒脑神、开清窍、抑制脑细胞异常兴奋;璇玑透膻中可开胸解郁降气;鸠尾透中脘可定痫宁神、和胃化浊;内关、丰隆、太冲合刺可开郁化痰熄风。同用头穴和任督脉穴,可有效地控制癫痫的发作。

方3 脏腑点穴治疗小儿癫痫(赵鉴秋)

【取穴】 腹部取穴:阑门、建里、气海、带脉、章门、左梁门、右石关、巨阙。背部取穴:百劳、肩井、膏肓、心俞、肝俞、脾俞、肾俞。

【功效】 平肝熄风。

【主治】 小儿癫痫。

【用法】 推按手法:先施治腹部及任脉各穴。病儿仰卧,两手平伸放于体侧。医生坐在病儿右侧进行操作,用泻、调手法。向左旋转(即逆时针旋转)为泻,往返旋转为调,即平补平泻。腹部及任脉各穴治疗毕,扶病儿坐起,医生双手在背部及督脉各穴施以扣、按、拨法。以上治疗每日1次,10天为1个疗程。

【方解】 小儿癫痫病因复杂,证型不一。病机特点为邪实正虚,心、肝、脾、肾等脏腑功能失调。运用脏腑点穴法治疗



本病,应先开中焦之门。点阑门泻建里,调理脾胃功能。气海有通调任脉、调气滞、补肾虚之功,推按时感觉气机已开即止,久推伤气。放带脉可活动周身气血,有开结通经、疏滞散瘀之功。章门与阑门穴呼应治疗,有通顺小肠气分之功。左梁门、右石关两穴必须同时并用,以舒胃气。推按巨阙穴,可通顺食道之气,为开胃纳气主穴。以上各穴治毕,再加调上脘、中脘、建里、阑门1次,并压三把,引气归原,导气达于丹田。清升浊降,患者即有舒畅之感。背部及督脉诸穴,大都在骨缝之处,全以筋络通于脏腑。扣按各穴的筋络,应由上而下,节节放通,以通其脏腑之气。本病加按心俞、肝俞,可安神定痫,平肝熄风。调通任督二脉,脏腑正常功能恢复,则脾胃纳运有司,所进饮食化津生血灌溉全身,绝其生痰之源;心神安藏,肝风平息,肾精充足,阴平阳秘。邪祛正复,痫证蠲除。

方4 穴位埋植法治疗癫痫(李东海)

【取穴】 鸠尾、大椎、腰奇。

【功效】 化痰熄风,调理气机。

【主治】 癫痫。

【用法】 取上述穴位中的任一穴,常规消毒,局部麻醉下纵行切开0.3~0.5cm,分离组织肌膜,以钳按摩1~2min,患者有麻胀感时,将3号羊肠线3cm对折与消毒后的苯妥英钠0.3g一起同时埋入穴位深部,对皮,以敷料固定。疗程:每次取穴1个,间隔1个月轮换取穴埋植1次,3次为1个疗程。

【方解】 中医认为癫痫的成因是风痰阻络、气机逆乱、风阳内动、蒙蔽清窍所致。取传统的穴位治疗以化痰熄风,调理气机。鸠尾为任脉之络穴,大椎为六阳经交会之穴,两穴的使用具有协调阴阳的功能,腰奇为传统的治癫痫的经验穴,与鸠尾、大椎轮换使用,效果尤佳。穴位埋线是中医疗法之一,利



用羊肠线对穴位的持续刺激作用以达到通络熄风之功效,配合埋入消毒后的抗癫痫药物苯妥英钠可增加对穴位的刺激作用而取得更好的疗效。现代医学研究表明:穴位埋植法治疗癫痫的机制,可能是埋入穴位药、线以后,异性蛋白长时间刺激大脑皮质,形成一个优势兴奋灶,起不同程度的抑制作用,并在此基础上使高级神经系统功能得到恢复而达到治疗目的。综上所述,穴位埋植法治疗癫痫疗效可靠,埋药与埋线联合使用可提高治疗效果,降低复发率。可在临床上对症选择使用。

方5 羊肠线穴位埋藏治疗癫痫2(张俊卿)

【取穴】 膻中、曲池(双)、百会、大椎、肺俞、肝俞(双)。

【功效】 清热化痰,镇肝熄风。

【主治】 癫痫。

【用法】 将“3/0”号羊肠线打结(10~20个),将结两端多余部分剪去待用。以上选穴区皮肤常规消毒,用2%盐酸利多卡因注射液穴位局麻0.2~0.4ml,用尖刀片的尖部刺入穴位皮肤0.3cm,将羊肠线结用镊子放入穴位内(每个穴位1~2个),局部用4号线缝合1针,再用纱布包扎,胶布固定。20天埋1次,3次为1个疗程。

【方解】 癫痫是大脑皮质或皮质下神经结构的阵发性过度同步放电所引起的大脑功能短暂的、可逆的紊乱。用羊肠线埋藏于上述穴位之中,形成持久而柔和的刺激,对于癫痫的发作控制具有良好的调节作用。同时,羊肠线作为一种异性蛋白在穴位上刺激机体,可增强体质,提高免疫能力。而上述几种穴位正是对大脑神经调节的重要部位,用此种方式进行逆行性刺激而加强大脑皮质或皮质下神经细胞的免疫力,可以避免患者因长期大量服药带来的多种毒副作用。此法简单



易行,患者所受痛苦少,易被接受,无明显毒副作用,所以值得推广应用。

方6 穴位埋藏中药浸泡羊肠线治疗癫痫3(鞠录升、李秀梅)

【取穴】 大椎、长强穴。

【功效】 豁痰熄风,安神开窍。

【主治】 癫痫。

【用法】 豁痰熄风散:制半夏、白术、白附子、石菖蒲、天麻、钩藤、全蝎等共研细末,入75%的乙醇浸泡15天,取其滤液浸泡羊肠线10天,取出放无菌器皿中备用。操作步骤:患者反坐靠背椅,两手掌并拢重叠托于下颌,患者低头显示第七颈椎棘突,取棘突下正中,用龙胆紫棉签标志穴位,严格消毒后,用2%的利多卡因注射穴位标志处0.3~0.5ml局麻,先三棱针皮下刺入扩大针眼,拔出三棱针,用20号穿刺针将备好的羊肠线一小段(约2~3cm长)用针芯注入穴位内(边推针芯、边往外拔针头,缓缓如注射样),酒精棉球压迫针眼,无菌纱布包扎。

【方解】 经穴位埋藏治疗,部分患者可达根治之目的。中医学认为,长强穴为督脉与足少阳、足少阴交会穴,属督脉络穴,主治脊柱强直、角弓反张,此穴为经脉之气汇聚点。大椎穴主治颈项强直、强痛、眩晕等。用具有豁痰熄风功效的中药滤液浸泡羊肠线,将羊肠线置入上述穴位内埋藏,长期持久刺激穴位,达到了豁痰熄风、安神开窍之目的。本组药穴并施,既具有药物作用,又有腧穴作用。实践证明,该疗法见效快,疗效持久,不易复发,疗程短,操作简便,副作用小。

方7 穴位埋线法治疗癫痫4(冷钰玲、潘清蓉等)

【取穴】 百会、涌泉(双)、大椎、丰隆(双)、间使(双)、



腰奇。

【功效】 苏厥熄风、豁痰开窍。

【主治】 癫痫。

【用法】 要严格按照外科无菌操作进行。术者洗手,戴帽子、口罩、消毒手套,在给患者埋线之穴位处及周围皮肤用2%碘酒及75%乙醇消毒后,铺洞巾。消毒包内备套管针、手术剪、灭菌的0/2羊肠线。将备用羊肠线剪为2cm长度,穿入套管针内,刺入腧穴,深度为1~2寸,待患者出现酸、麻、胀、重的针感后,术者一手将针芯固定,另一手将套管针往外拔,使羊肠线呈直线埋入穴位,出针后用消毒棉球覆盖针孔2~3d,以防感染。每个月治疗1次,3次为1个疗程。

【方解】 百会穴属督脉,可苏厥熄风、醒脑开窍;大椎为诸阳之会,具有平调阴阳逆乱之功;丰隆能理脾胃、助运化、豁痰浊以杜绝生痰之源;间使能疏通心包经气,与腰奇同为治疗癫痫证之经验要穴。诸穴合用能醒脑、苏厥熄风、豁痰开窍而愈癫痫。穴位埋线是在针灸基础上发展起来的中西医结合新方法。

羊肠线在穴位上通过较持久的刺激调节机体的相对平衡。据实验报告:羊肠植入经穴后体内生化测定,经穴周围的合成代谢升高,分解代谢降低,从而增强了穴位及周围组织的营养和代谢,增强了腧穴的治疗作用。我们在大椎、百会、涌泉、丰隆、间使、腰奇等穴位上植入羊肠线,肠线在穴位内20~30d内逐渐融化,被穴位周围组织吸收,从而增强了上述穴位醒脑苏厥熄风、豁痰开窍之功,对控制癫痫发作程度、减少发作的次数、延长发作的间歇期均有良好治疗作用,又因穴位埋线法简单易行,1个月治疗1次,易于坚持,易为患者所接受,所以,穴位埋线治疗癫痫是一种切实可行的方法。



方8 穴位埋线治疗癫痫5(杨晓华)

【取穴】 第1组穴位:腰奇,丰隆,癫痫,内关;第2组穴位:筋缩,鸠尾,足理;第3组穴位:间使,心俞,肝俞,膻中。根据癫痫临床表现症状,随症加减,痰多加丰隆,头痛加百会,白天发作加申脉,夜间发作加照海,胸闷加膻中。

【功效】 健脾化痰、养心安神。

【主治】 癫痫。

【用法】 ①将穴位准确选好,常规消毒,注入普鲁卡因,使成皮球状,用手术刀切纵口约0.5厘米,行纯行分离至骨膜,强刺激1~2min,埋入0.5厘米3号羊肠线后缝合1针,7天后拆线。②穿刺针埋植法:皮肤常规消毒后将3/0号羊肠线穿入9号穿刺针内,刺入穴位内,用去掉针尖的针灸针,穿入9号穿刺中,将肠线推至肌层,针孔用消毒纱布包扎。每15~30d埋植1次,一般1~3d即可控制发作或发作时间缩短。

【方解】 癫痫病病情复杂,缠绵难愈,其发作程度有轻有重之分,病势有缓有急之别,此与痰邪深浅,正气盛衰,有密切关系,治疗时应分清标本虚实。新病多实以治标为主,重在豁痰开窍,熄风定痫;久病多虚,以培本为宜,宜健脾化痰,养心安神,补益肝肾。

用埋线疗法治疗癫痫,辨证选穴,疗效较好,本方法简便,易于推广。但结核活动期、严重心脏病、妊娠期、发烧患者,均应禁忌此种方法。

方9 头皮针治疗癫痫(李效芳、马志刚)

【取穴】 为额中带、额顶带后1/3、顶枕带中1/3为主。

【功效】 镇静安神,益肾健脑。

【主治】 癫痫。

【用法】 患者端坐,局部常规消毒后取30号毫针与头皮



呈 30° 快速刺入头皮下,进入帽状腱膜下层后将针体放平,继续捻转进针刺入 1~1.2 寸,捻转每分钟达 200 次,行针 3 分钟,同时嘱患者闭目,全身放松,设想有气直达患处,医者也将注意力集中在行针的指端,有意识地将针感向患处引导,其中额中带、顶枕带中 $1/3$ 由上向下刺,额顶带后 $1/3$ 由前向后刺,用小幅度提插泻法,行针时用手轻叩击患者头部,留针 4 小时,隔日 1 次,10 次为 1 个疗程。均在 4 个疗程后作疗效统计。

【方解】 癫痫是一种大脑皮质局部的异常放电引起的突发短暂意识丧失性疾病,多由于肾亏脾虚、痰浊内生、上犯清窍,久而作痫,若反复发作正气渐衰,痰结日深,愈发愈频,愈频愈虚。其病位在脑,中医认为脑与督脉和足太阳膀胱经关系最为密切,额中带、额顶带后 $1/3$ 、顶枕带中 $1/3$ 均属督脉与膀胱经穴带,不但有镇静安神之功,还有益肾健脑作用,且医者有意识的将针感引向患处,达到“气至病所”的目的,故对癫痫发作有较好控制作用。

方 10 针挑治疗癫痫(戴海玉、王海英、沈丽娟)

【取穴】 主穴:鸠尾至神阙之间的任脉经穴,大椎至长强的督脉经穴,每次先取 4~6 穴。配穴:上腹部任脉旁胃经穴,背俞穴或夹脊穴,背部阳性反应点,每次取 4~6 穴。

【功效】 健脾化痰,调节阴阳。

【主治】 癫痫。

【用法】 在选取的穴位上严格消毒,局麻成直径约 1cm 的皮丘,用针挑起皮肤,酌情进行上下、左右牵拉,用刀割断。再挑取皮下白色纤维拉断或割断,至纤维挑尽为止。最后用碘酒消毒创口敷上纱布。在选定的穴位上逐个挑治。注意:选取背部阳性反应点时应与红痣、毛囊炎等相鉴别。治疗中



注意无菌操作。2~3d后揭去纱布,1周内勿洗澡。禁烟、酒及辛辣食物,避免情志刺激。1周1次,10次为1个疗程。

【方解】 癫痫的病机主要是由于阴阳之气不相顺接,痰浊蒙闭清窍,流窜经络。笔者认为挑针治疗的作用机制同毫针针刺,主要是通过经络的作用。督脉“总督诸阳”,为“诸阳之海”;任脉“总任诸阴”,为“阴脉之海”,故取任、督脉经穴为主,以调整阴阳。选取胃经穴以健脾胃,助运化,化痰浊;背俞穴调整脏腑功能。诸穴相配共达“治病求本”的目的。而且,挑治比毫针针刺刺激强,留下的创口亦可造成较长时间的穴位刺激。临床观察发现,年龄越小疗效越好,女性患者孕期易复发,且疗效不如男性稳定。

方11 挑刺加埋线治疗癫痫(耿广升)

【取穴】 主穴:大椎、身柱、至阳、脊中、腰奇。配穴:风痰闭阻证加取风门、中脘;痰火内闭证加心俞、丰隆;肝肾亏虚证加肝俞、肾俞;心脾两虚证加足三里、三阴交;气血瘀滞证加膈俞、血海。

【功效】 熄风化痰,清热定惊,安神止痉。

【主治】 癫痫。

【用法】 每次取1个主穴和1个配穴,先用甲紫作标记,局部常规消毒。用2%利多卡因注射液在所取穴位作局部浸润麻醉,然后用消毒的三棱针挑破皮肤,挑净穴位内白色纤维,再用大号火罐吸拔于施术处,吸出血约2~3ml。创口再次消毒后,将长约1.5cm羊肠线放入12号注射针头或腰穿针管内。从挑刺创口内刺入,大椎透陶道、心俞透督俞、肝俞透胆俞、肾俞透气海俞等,用12号腰穿针芯从针头内将羊肠线送入,同时边退头。最后将创口用碘酊消毒,用创口贴固定。每周治疗1次,主穴与配穴依次轮流选用。



【方解】 癫痫属中医学“痫证”范畴,中医认为该病多因风、火、痰、瘀、虚等因素夹杂而致。《内经》云“督脉为病,脊强反折。”督脉经气不利,可致阴阳失调、气血逆乱、风火痰瘀夹杂而出现颈项强直,角弓反张,甚至抽搐等症。因此,笔者选用大椎、身柱等督脉经穴,采用挑刺埋线法,能宣通督脉经气,平衡机体阴阳,熄风化痰,清热定惊,安神止痉。癫痫病多为实证,或虚实夹杂,挑刺拔罐具有较强的清泻作用,因而可以迅速控制症状。而穴位埋线有机械物理刺激作用,且刺激时间持久,因而其疗效巩固。同时羊肠线是一种异体蛋白,埋入穴位后,经分解与吸收,对机体产生一种生物化学刺激,这种刺激可以直接作用于神经元,减少其过度放电,从而改变脑电图,达到治疗目的。一般埋线4周后达到最佳效果。挑刺拔罐控制癫痫发作取效快捷,而穴位埋线作用持久,二者合用,其效益彰。临床观察表明,挑刺埋线法治疗癫痫,其有效率明显优于单纯毫针疗法。挑刺埋线一般治疗1次就能明显控制发作次数,5次就能基本控制临床症状。在治疗时还应注意无菌操作以防感染。施术处3天内不得浸水和污染。

方12 深刺鸠尾穴治疗癫痫(王天才、任建梅等)

【取穴】 鸠尾。

【功效】 镇静豁痰。

【主治】 癫痫。

【用法】 患者仰卧,双手抱头,在前正中线剑突下0.5寸(剑突不明显者可在胸骨体下端1寸处)取穴。治疗前先叩触肝脾位置,确定肝脾下缘在所取穴位的上面。局部经严格消毒后,嘱患者双臂上举或双手抱头以使膈肌上抬。用26号毫针,在患者深吸气后进针,针尖微向下斜刺或直刺2~3寸,进针后略微转动针体。此时患者可感到局部胀闷,并向上下扩



散。禁止大幅度捻转和提插。

【方解】 鸠尾穴为任脉之络穴,《素问》曰:“任脉者,起于中极之下,以上毛际,循腹里上关之,至咽喉,上颈循面入目。”任督两脉在上会聚于脑,脏腑精气由任脉入目而居于脑,后出项中又注之于督脉,督脉统领一身之阳,任脉统领一身之阴,至元阳元阴之气无不上濡于脑。任督乃阴升阳降,阴阳交合,五谷和合而为膏,充养脑髓,补益脑髓而为脑神之用。鸠尾穴是任脉络穴,亦为膏之原,具有镇静豁痰之功,善治癫痫。因痰证属阴,其病深,非深刺不能奏效,故鸠尾穴深刺 2~3 寸,屡获良效。但因鸠尾穴对应腹内之肝脏左叶,故宜斜向下刺,垂直深刺可刺伤肝脏,故应避免;此外,亦应避免向上斜刺,以免刺伤横膈心脏。

方 13 背三针治疗癫痫(王进才)

【取穴】 主穴取大椎、神道、腰奇,急性发作期配人中、百会、内关、合谷、太冲;缓解期配足三里、心俞、肝俞、脾俞、肾俞;痰多配丰隆;白天发作配申脉;夜间发作配照海。

【功效】 补肾健脑,镇惊宁神,清热通络。

【主治】 癫痫。

【用法】 患者取俯卧位并尽量低头。大椎穴取 0.38mm×40mm 毫针,直刺进针 1.2 寸,采取捻转、提插手法,使针刺局部酸、胀、麻。神道穴取 0.38mm×75mm 毫针,顺督脉向上沿皮透至身柱穴,腰奇穴选用 0.38mm×75mm 毫针,顺督脉向上沿皮刺入 2.5 寸以上,两穴并要求针感向上传导。其他配穴按常规进针操作,施以平补平泻手法,要求出现酸、胀、沉针感,若沿经脉传导,则疗效更佳。每日 1 次,每次留针 30 分钟,每 10 分钟行针 1 次,10 次为 1 个疗程,疗程间隔 3~5d。3 个疗程统计疗效。



【方解】 癫痫属于中医学痫证范畴。其病机可概括为脏腑功能失调,经络气机逆乱,风痰上扰神明。《素问·骨空论》云:“督脉为病,脊强反折”,可见一些惊风抽搐的疾病,源于督脉。督脉经气不通,势必造成阴阳平衡失调,因而出现颈项强直,角弓反张,甚至抽搐等症状。脑为“元神之府”,与督脉联系最为密切,所以督脉上的大部分腧穴都有治疗癫、狂、痫的功能。因此循经选取督脉大椎、神道、腰奇作为治疗本病的主穴。大椎为手足三阳经与督脉之交会穴,善于调节经络气机逆乱,为通络解痉之要穴。神道透身柱,一针两穴,具有镇惊宁神,清热通络之功。《百症赋》曰:“风痫常发,神道须还心俞宁。”“癫疾必身柱。”腰奇虽为经外奇穴,但分布在督脉循行通路上,为督肾两经之交会穴,肾主骨生髓,髓聚为脑,取本穴有补肾健脑之功,为治疗癫痫病的经验效穴,故取上述3穴为主,根据辨证酌以配穴,诸穴合用,能最大限度地纠正大脑功能异常,使神清气和,则癫痫可愈。

第二节 瘰 症

一、内服方

方1 通天打地汤(王之良)

【组成】 荆芥 10g,防风 10g,连翘 30g,玄参 15g,枳壳 10g,桔梗 10g,赤芍 15g,天花粉 10g,浙贝母 10g,黄芩 6g,牵牛子 6g,白芥子 3g,灯心草 3g,甘草 3g。加减:咽喉部疼痛明显者加射干 10g,海浮石 15g。

【功效】 疏风散寒,清热解毒,行气化痰,活血利咽。

【主治】 梅核气。



【用法】 每日煎服1剂,早晚2次温服,7天为1个疗程。

【方解】 方中,荆芥防风发汗解表,疏风散寒;牵牛子、连翘清热解毒,散风除热;玄参、天花粉降火利咽,解毒清热;枳壳、桔梗理气宽胸,利咽升提,引药上行于咽;白芥子豁痰治胸胁痛;赤芍活血散瘀消肿;浙贝母化痰开郁,消瘰散肿;黄芩泻中焦实火,燥肠胃湿热;射干、海浮石均清热消痰,散结利咽;灯心草通便利湿;甘草调和诸药。

方2 自拟鲰鱼理咽汤(祁付有)

【组成】 鲰鱼1条约250g左右,冰糖30g,胖大海10g,银柴胡10g,桔梗20g,蝉蜕16g,白僵蚕10g,木蝴蝶6g,姜半夏12g,枳实15g,橘红12g,菊花20g,芝麻100g,玉竹15g,乌梅15g,砂仁10g,紫豆蔻10g,小茴香10g。

【功效】 疏肝理气,和胃健脾,清热利咽,润燥。

【主治】 梅核气。

【用法】 取鲜鲰鱼1条(约250g左右),野生最好,取出鲰鱼内脏填入白冰糖,将药物用白布包裹后盛入砂锅内,加水1200ml,待鲰鱼煮熟即可,食鲰鱼,药液可分3次服完(1日3次),服药液时加温服,3条鲰鱼为1个疗程。

【方解】 方中柴胡桔梗疏肝解郁,清热利咽。橘红、枳实理气化痰,利气导滞,化痰除痞。胖大海、半夏清宣肺气降逆,燥湿化痰。蝉蜕、木蝴蝶散风清咽,疏肝利咽。白僵蚕冰糖化痰散结祛风止痛,清喉利咽。砂仁、紫豆蔻、小茴香,理气和胃降逆。芝麻、菊花、玉竹、乌梅可增液润喉。本方用鲰鱼为主,妙在鲰鱼既可以补脾益胃,又身披黏液,有润咽利喉的作用。方剂组成针对病机,所以能够取得良好效果。

方3 自拟苇茎厚朴汤(周文荣)

【组成】 苇茎30g,冬瓜仁30g,薏苡仁30g,桃仁10g,厚



朴 15g,半夏 15g,茯苓 20g,柴苏梗 15g,桔梗 12g,川芎 15g,制香附 15g,生姜 20g。加减:痰气互结型石菖蒲 15g,浙贝母 10g,竹茹 6g,炒柴胡 15g,杭芍 20g;肝郁气滞型炒柴胡 15g,杭白芍 20g,佛手 15g,炒枳壳 8g,炒栀子 6g;心脾气虚型黄芪 30g,太子参 20g,白术 15g,木香 12g,砂仁 10g。

【功效】 辛香散结,行气开郁,降逆化痰。

【主治】 梅核气。

【用法】 水煎,每日 1 剂,分 3 次服用。10 天为 1 个疗程,连服 2 个疗程。

【方解】 梅核气为一常见病,多因情志不舒而发病。肝主疏泄,性喜条达。情志所伤,可使肝失条达,气机不畅,肝气郁结,循经上逆,结于咽喉;或因肝病乘脾,致脾失健运,津液不能输布,积聚成痰,痰气互结于咽喉而发病,故本病的关键为气郁痰结。郁者达之,结者散之,所以理气开郁,化痰散结便为其主要治法。本方以苇茎汤、茯苓、半夏化痰散结,以厚朴、紫苏梗、桔梗、川芎、香附理气宽胸、开郁畅中。诸药合用,共收辛香散结、行气开郁、降逆化痰之功。

方 4 自拟开胸降逆汤(郭杰、郭山鹰)

【组成】 全瓜蒌 20g,薤白 15g,半夏 10g,黄连 6g,炒枳实 10g,郁李仁 10g,川厚朴 10g,降香 10g,路路通 10g,姜黄 6g,木香 10g,佛手 10g。加减:肝郁脾虚,聚湿生痰或气滞津停,凝聚成痰,气滞痰郁交阻于胸膈之上者加白茯苓、紫苏叶等;气滞热郁,三焦不利者加栀子、通草等。

【功效】 开胸降逆,调合肝脾,通利三焦。

【主治】 梅核气。

【用法】 水煎,每日 1 剂,早晚分服。5 天为 1 个疗程,服药 1~3 个疗程,嘱改善性情。



【方解】 方中以全瓜蒌利气宽胸、开胸散结；薤白通阳行气、温中散结气；半夏、黄连辛开苦泄、燥湿化痰、降逆消痞散结、泻火解毒；枳实、厚朴除痞散满行气消痰；郁李仁泄肝而兼通利阳明、利水消肿；降香解血气中滞气，温通行滞、辟秽化浊；路路通、姜黄皆舒畅气机利水通路，外散风寒，内行气血；木香行气调中，能升降诸气；佛手舒肝理气、解郁和中、化痰。诸药合用，开胸降逆，调合肝脾，通利三焦气机，临床随症加减，治疗各种原因所致的梅核气无不达效。

方5 自拟化核丸(贾云)

【组成】 陈皮 45g，川贝母 45g，姜半夏 45g，山豆根 45g。

【功效】 推陈致新，理气化痰。

【主治】 梅核气。

【用法】 将4味药研成极细粉末，与蜂蜜按1:1.4之比例，炼蜜为丸，重6g，每丸含生药2.5g。约可做70丸。每日3次或不拘时，置舌上徐徐含化。

【方解】 陈皮：理气，调中，燥湿，化痰。《别录》：“气冲胸中。”《药性论》：“治胸膈闷气。”《本草经疏》：“橘皮，主胸中癰热逆气，……以肺主气，气畅则顺，气变则逆，逆则热聚于胸中而成癰，癰者，假也，如痞满闷郁之类……”《本草纲目》：“橘皮能泻能燥，能散能和，其治百病……同升药则升，同降药则降，脾乃元气之母，肺为摄气之时，故橘皮为二经气分之药，但随所配而补泻升降也，橘皮宽膈降气，极有殊功。”川贝母：润肺散结，止渴化痰。《药性论》：“主胸中逆气。”《本草汇编》：“妇人诸郁之症。”《药品化义》：“开郁散结。”《本草正》：“将胸中因热结胸及乳痈流痰结核。”《本草别说》：“能散心胸郁结之气”，“治心中气不快多愁郁者殊有功。”山豆根：清火、解毒、消炎、止痛。《本草经疏》谓：“清热解毒之上药”，《本草求真》：“解咽



喉肿痛第一要药”，“……多因心火挟其相火交炽，以至逼迫不宁耳，故常用此以降上逆之邪，脾火自上达下，而心气因而以除。”姜半夏：燥湿化痰、降逆止呕，消痰散结。《医学启源》：“大和胃气。”《主治秘要》：“消肿散结，除胸中痰涎。”《御院药方》：“壮脾顺气。”成无己：“半夏之辛以散逆气，以除烦呕，辛入肺而散气，辛以散结气……”。本组方陈皮理气，川贝母解郁，山豆根消炎，姜半夏散逆，四药组合，总司气病之气，推陈致新，直达病所，以蜜为丸服用方便，患者易于接受。

方6 益母草合剂加味(陶荣芬)

【组成】 益母草 30g，当归 15g，大黄 15g。加减：月经不调，舌质暗红，脉弦者加苏木 9g，香附 9g，厚朴 15g，川芎 9g，赤芍 10g，桃仁 12g，红花 9g。兴奋躁动，行为失控，舌质暗红，苔厚腻，脉弦滑者加用柴胡 15g，芒硝 15g，黄芩 15g。

【功效】 活血化瘀，消水解毒。

【主治】 难治性癔症。

【用法】 每日 1 剂，水煎，早晚分服。服用中药治疗期间，除临时服用地西洋类药物改善睡眠外，不用其他精神药物，连服 15 剂为 1 个疗程。

【方解】 本病临床症状复杂多样，常规治疗往往无效。其病机多由肝气郁结化热，随冲气上逆，狂痴不定，妄言妄见，肝郁则气滞，气滞则血行不畅，故腹中疼痛。益母草合剂作为祛瘀生新、活血调经的药物，擅治月经不调、腹痛症瘕，具有良好的活血化瘀、消水解毒之功效，一直广泛用于妇科疾病。中医学认为久病必瘀，瘀则血行不畅，影响脏腑的正常生理功能，而易发生癫狂。作者参考张仲景用桃核承气汤治疗“蓄血发狂”的方法，辨证施治以益母草合剂加理气活血、清热泻下药物，治疗难治性癔症收到良好效果，值得进一步验证使用。



方7 旋覆代赈汤加味1(吴成光)

【组成】 旋覆花 10g(布包),党参 12g,半夏 10g,炙甘草 6g,酸枣仁 12g,柏子仁 15g,赈石 30g(先煎),大枣 15g,生姜 6g。加减:气上冲者加紫苏梗、佛手、川厚朴各 10g。胸痛者加桃仁、延胡索各 10g;有阴虚者加生地黄、麦冬各 15g。

【功效】 行气开郁,降逆化痰。

【主治】 梅核气。

【用法】 每日 1 剂,水煎 3 次,分早晚服,待病情好转后改为隔日 1 剂。

【方解】 本病主要为精神因素所引起,思则气结,气滞痰凝,气机升降失常,而形成梅核气,故治疗以本方行气开郁,降逆化痰,宁心安神,扶正养胃,但精神治疗对本病提高疗效尤为重要。《灵枢·师传》篇指出“告之以其败,语之以其善,导之以其所便,开之以其所苦”,医生要有的放矢,以充满信心的话语对患者进行开导,一见好转,正面肯定,鼓励坚持。本病除个别患者体质较差者,一般不宜休息。实践证明患者长期休息会想入非非,顾虑重重,亲朋好友要多谈心,常疏导,增强信心,巩固效果,战胜病魔。

方8 旋降汤(张锐、孙中兰)

【组成】 旋覆花(布包) 20g,降香 9g,射干、威灵仙各 12g,玄参 15g。加减:口干舌燥者,加麦冬、石斛;失音者,加蝉蜕、诃子、白僵蚕;红肿疼痛者,加牛蒡子、金银花、山豆根;痰多苔厚腻者,加橘红、莱菔子、石菖蒲;泛酸者,加鱼骨;阳虚者,加附干、桔梗、生甘草;气虚者,加党参、黄芪;血虚者,加当归、阿胶。

【功效】 理气化痰,化瘀通络,利咽散结。

【主治】 顽固性梅核气。



【用法】 每日1剂,水煎分2次服。

【方解】 梅核气多由七情郁结、痰涎凝聚所致,日久顽固性者多有瘀血阻络,故治疗重在理气化痰,化瘀通络,利咽散结。旋降汤正是依此而立,验之临床,收效颇佳。

方9 四七汤加味(来志华、侯建钢、范广岩)

【组成】 半夏10g,制川厚朴10g,紫苏梗10g,茯苓10g,制香附10g,生姜3片,大枣5枚。加减:胸闷甚者,加郁金10g,枳壳10g;胸痛,加瓜蒌10g,薤白10g;胁痛者,加川楝子10g,延胡索10g;咽喉痛加玄参10g,牛蒡子10g,桔梗3g,生甘草6g;气郁日久,血流瘀滞加丹参10g,桃仁10g,川芎10g,赤芍10g。

【功效】 舒肝理气,除痰散结。

【主治】 梅核气。

【用法】 水煎服,每日1剂,15天为1个疗程。

【方解】 梅核气,为咽喉中有异常感觉,是以咽喉中如有梅核阻塞,哽哽不舒,吐之不出,咽之不下为主症的咽喉疾病,以中年妇女为多见,属祖国医学郁证范畴。多由情志所伤,致肝气郁结,肝郁气滞或气滞血瘀而成,为虚实夹杂之证。正如《古今医鉴》所云:“梅核气者,窒碍于咽喉之间,咯不出,咽不下,如梅核之状也。始因喜怒太过,积热蕴酿,乃成痰涎郁结,致其疾耳。”治宜舒肝理气,除痰散结,四七汤加味。方中半夏化痰开结,和胃降逆;香附、厚朴理气降逆,宽胸散满,助半夏化痰降逆;半夏降逆助厚朴、香附行气;紫苏梗宽胸,行气开郁;生姜温运和胃,助半夏降逆和中;茯苓健脾渗湿;大枣温脾合生姜以和脾胃。本病七情所伤,情志郁结所致,应对患者细心开导,解除顾虑,增强治愈的信心,同时嘱患者少食煎炸食品、辛辣香燥、油腻坚硬及生冷食物,方可事半功倍。



方10 逍遥散加减1(张香芝)

【组成】 柴胡 6g,川芎 9g,当归 10g,龙骨、牡蛎各 30g,陈皮 6g,白术 10g,茯苓 10g,夜交藤 15g,柏子仁 10g,甘草 3g。加减:如食少腹胀者加焦三仙、砂仁;暖气呃逆者加半夏、郁金;月经不调者加香附、益母草。

【功效】 疏肝健脾,宁心安神。

【主治】 瘵症。

【用法】 每日 1 剂,水煎分服,20 天为 1 个疗程。

【方解】 瘵症在中医理论中属郁证范畴,乃情志失调,肝气郁结,渐致五脏气机紊乱,升降失调,气血不和,血不养心,神失所藏而发病。方中柴胡调和阴阳表里;川芎、当归活血化瘀;龙骨、牡蛎平肝潜阳;陈皮、白术、茯苓扶土健脾;夜交藤、柏子仁养血安神。全方共奏疏肝郁、健脾胃、宁心安神之功。

方11 逍遥散加味2(戴春禧)

【组成】 柴胡 10g,当归 10g,白芍 20g,茯苓 30g,白术 15g,薄荷 6g,甘草 5g。加减:肝郁气滞证中有胸闷、暖气加香附、郁金;头痛、目赤、咽痛加栀子、菊花、射干、玄参;睡眠不安加夜交藤、珍珠母。痰气互结证中有胸脘胀满,咽中有痰加半夏、厚朴、桔梗。

【功效】 疏肝养血,理气化痰,开郁散结。

【主治】 梅核气。

【用法】 水煎,每日 1 剂,早晚分服,2 周为 1 个疗程,治疗 1~2 个疗程。

【方解】 现代医学中的咽神经官能症,以咽中似有阻塞感为特征,中医称之为梅核气。该症由七情郁结、痰涎凝聚、肺胃宣降失常致气滞痰阻而发生,故见喉中有物阻,吐之不出,吞之不下。此病的发生与中医的肝气有密切联系。若只



着眼于局部气郁痰结之标,而忽略病变之本,多难收效。肝属木,性喜条达,为藏血之脏,肝体阴而用阳。若忧虑太过,情志不遂,则肝失调达而郁结,肝郁则易伤阴血,肝体失于柔和,肝用则亢,肝郁抑脾,运化失常,聚湿成痰,气滞痰阻。肺胃宣降失常,痰气凝结咽部,而梅核气作焉。故肝郁脾虚是梅核气本源,痰气郁结则是其标。宜疏肝养血,补肝阴以和肝用治其本,理气化痰治其标。采用逍遥散辨证加味,用柴胡、郁金、香附、薄荷疏肝解郁,顺其调达,发其郁遏之气,即“木郁达之”之义;当归、白芍柔肝养血;玄参、射干滋阴利咽,白术、茯苓健脾燥湿,以绝生痰之源;厚朴、桔梗、半夏理气祛痰,宣郁散结;夜交藤、珍珠母平肝宁神,栀子、菊花清泄肝热。此方可使肝体得和,肝用不亢,气舒痰化,为补散并用、标本兼顾之剂,故疗效满意。

方 12 顺气导痰汤加减(徐新荣)

【组成】 黄连、半夏、白芥子、桔梗、陈皮各 10g,瓜蒌、蒲公英各 24g,枳实 6g。加~~减~~:肝气郁结(胸胁脘腹胀满,甚则两胁作痛,暖气叹息,脉弦等)显著者加厚朴、柴胡各 10g;病久血脉瘀阻,舌质暗滞者加郁金 10g,赤芍 15g。每日 1 剂水煎分 2 次服。

【功效】 清热除痰开结。

【主治】 梅核气。

【用法】 水煎,每日 1 剂,早晚分服。服药期间禁酒,忌油腻,注意情志调畅。

【方解】 本病多由情志所伤,致肝气郁结,积热蕴结,痰气交阻,结于咽喉所致。正如《仁斋直指方》中所谓:“梅核气者,窒碍于咽喉之间,咯之不出,咽之不下。如梅核之状者是也……,始因恚怒太过,积热蕴隆,乃成痰郁结,致有斯疾



耳。”本病治宜清热除痰开结，舒肝理气。顺气导痰汤方中黄芩苦寒清泄热结、泻火解毒；半夏辛开化痰，消痞散结；瓜蒌清热开结涤痰；配以陈皮、枳壳以理气行滞，消痰除痞；白芥子性善走散，能豁痰利气通络；桔梗辛苦泻破能宽胸膈，行滞气，祛痰浊；蒲公英苦甘性寒，不但能解火郁，化热毒，亦可祛湿热，散滞气，通络道。

方13 启膈散(李静)

【组成】 丹参 30g，郁金 10g，砂仁 6g，沙参 10g，川贝母 10g，茯苓 10g，荷叶 10g。加减：有痰者可加陈皮、半夏、瓜蒌；两胁满者可加香附、枳壳、赭石、厚朴；咽痒者可加蝉蜕、地龙；咽痛者可加桔梗、牛蒡子；反酸者可加乌贼骨、浙贝母。

【功效】 疏肝理气，健脾化痰。

【主治】 梅核气。

【用法】 水煎，每日1剂，早晚分服。

【方解】 启膈散本是用子噎膈早期吞咽困难、胸膈痹闷等，其症状虽与梅核气有所不同，但其发病机制却有相同之处。梅核气属郁证范畴，患者常感咽部不适有异物感，有如梅核之塞于咽喉而形成的吐之不出，咽之不下的自觉症状，但不碍饮食，与情志因素有关，多为情志不畅，肝失调达，气机郁滞，肝郁乘脾，横逆脾胃，脾失健运，生湿聚痰，痰气郁结而致诸症。

方用丹参、郁金、砂仁，化痰利气以开郁；沙参、茯苓、贝母润燥化痰以生津；荷叶化浊和胃而降逆；诸药合用则理气而不燥，滋阴而不膩，临床应用效果良好。

方14 三梗汤(曹建英、姜文英)

【组成】 新鲜紫苏梗、荷梗、桔梗各 25g，300ml 开水冲泡代茶饮；或干紫苏梗、荷梗、桔梗各 10g，微煎或冲泡代茶饮



(亦为 300ml)。

【功效】 理气宽胸。

【主治】 梅核气。

【用法】 每日 1 剂,代茶频服,7 天为 1 个疗程。

【方解】 根据梅核气的症状特点,我们体会到该病多因痰气郁结、上逆胸咽所致,以气、痰、郁、津伤为主要病机。方中紫苏梗利气散结,桔梗开宣肺气、祛痰利咽,荷梗通气利水,诸药代茶频饮,反复作用于局部,使药效明显增强,异物感迅速消散。总之,三药合用,共奏理气宽胸之功,治疗梅核气可收桴鼓之效。

方 15 利咽疏郁汤(高建民)

【组成】 利咽疏郁汤:半夏、厚朴、桔梗、茯苓、路路通各 10g,紫苏梗、黄连、甘草各 6g,炒酸枣仁、全瓜蒌各 20g,降香 30g,生姜 3 片。加减:咽干口渴者加沙参、麦冬各 10g;胸脘满闷加枳壳、青皮、陈皮各 10g;胃脘疼痛加白芍 30g,延胡索 20g;返酸加海螵蛸、煅牡蛎各 20g;咽中有痰、咳嗽加杏仁、枇杷叶各 10g;食欲不振加焦麦芽、焦神曲各 20g;大便秘结加大黄 6g(后下);失眠多梦加夜交藤 20g,朱砂 1g(研末分 2 次冲服)。

【功效】 疏肝解郁,化痰利咽。

【主治】 梅核气。

【用法】 水煎,每日 1 剂,早晚分服。

【方解】 梅核气多为痰气郁结所致,相当于咽部神经官能症或癔球。七情郁结,肝气不舒,肝失条达,气机不和,横逆犯脾,脾失健运,聚湿生痰,痰气交结上逆,郁阻胸膈之上,如梅核壅塞咽喉,吞之不下,吐之不出,没有疼痛,且不影响饮食。症状常随情志波动而轻重,检视咽喉并无异常,或虽有变异亦



甚轻微。在治疗本病的同时,应嘱患者调畅情志,精神愉快,并让患者做胃镜或食道钡餐检查,明确告之不是器质性病变。利咽疏郁汤方中半夏、生姜辛以散结,苦以降逆;厚朴消痰下气,茯苓淡渗健脾,佐半夏以利饮除痰,紫苏梗、降香辛温芳香,疏通郁气,行气宽中;黄连苦寒,清热燥湿;瓜蒌利气开郁,导痰浊下行,与半夏、黄连配伍治痰热结胸、胸膈痞满;桔梗主入肺经,祛痰利咽;路路通能通十二经穴,疏理肝气;酸枣仁养心安神,治失眠健忘,调节患者精神;甘草祛咽中之痰,并能调和诸药。

方16 六君子汤加味(方志扬)

【组成】 党参 20g,茯苓 20g,白术 15g,炙甘草 5g,陈皮 6g,半夏 8g,厚朴 10g,紫苏叶 8g,炒香附 10g,佛手 15g,乌梅 8g。加减:肝郁气滞,喉中梗阻感,暖气呃逆,胁下、胸膈胀闷,舌苔薄白,脉弦,酌加郁金、枳壳、柴胡等;肝阳偏旺,头晕目眩者酌加天麻、钩藤、菊花、夏枯草、牛膝、杜仲等;心脾气虚,咽中异物感,口淡纳呆,乏力气短,悲伤欲哭,夜寐不安,惊悸易醒,小便清长,大便溏薄,舌苔薄白,脉弱,酌加党参、炙黄芪、炒酸枣仁等;阴虚少津,咽干燥者去半夏、厚朴、紫苏叶,加山药、麦冬、桑叶等。

【功效】 健脾理气,化湿解郁。

【主治】 梅核气。

【用法】 每日 1 剂,水煎分早晚 2 次服,2 周为 1 个疗程。

【方解】 梅核气是因情志波动,气机不畅所致,以喉中似有梅核阻塞感为特征,相当于神经官能症。其病理主要是气滞痰郁,横逆犯脾,脾失健运,津液不能输布,生湿聚痰,痰气交结上逆,郁结胸膈,上发咽喉。治宜健脾理气,化湿解郁。



根据“善治痰者，不治痰而治气”的说法，用六君子汤健脾补胃，理气化痰。方中四君子汤健脾补气为主；陈皮、半夏理气化痰；佛手、香附、紫苏叶疏肝解郁而不伤津液；佐乌梅酸敛柔肝，生津化阴；厚朴宽中；鸡内金消食护胃；加姜、枣引药归经。诸药配伍，对肝胃气滞、脾虚痰阻有明显疗效。笔者在临床中发现梅核气以女性患者为多，且以性格内向者多见。随着社会竞争加剧，生活压力、工作压力增加，本病的发病率有增加的趋势，影响工作与生活。配合心理疏导，能够消除患者的忧虑，让患者树立信心，保持良好的精神状态，争取早日康复。

方 17 加味道遥散合二子二石汤(何忠俊)

【组成】 柴胡 12g，杭白芍 12g，茯苓 12g，当归 12g，白术 10g，牡丹皮 10g，栀子 10g，合欢花 12g，郁金 12g，佛手 10g，乌梅片 15g，诃子肉 15g，胖大海 12g，浙贝母 12g，月石 10g（分次含化），海浮石 15g，制胆南星 6g，半夏 10g，薄荷 6g（后下），生甘草 6g，山慈姑 15g。

【功效】 疏肝郁，敛肺气，散痰结，开窍利咽。

【主治】 癔症性失语。

【用法】 水煎，每日 1 剂，早晚分服。

【方解】 逍遥散出自《太平惠民和剂局方》，为肝气郁结、脾失健运而设。肝为藏血之脏，性喜条达而主疏泄，体阴用阳。若七情郁结，肝失条达，或阴血暗耗，或生化之源不足，肝体失养，皆可使肝气横逆，胁痛、寒热头痛、目眩等症随之而起。肝郁久而化火，灼伤肺津，咽失滋润而失语。方中用当归、白芍养血和血；柴胡配合欢花、郁金疏肝郁而降肺气；佛手理气散结而通畅气机；乌梅、诃子、胖大海收敛肺气，生津利音；甘草调和诸药而清利咽喉。月石化结痰、通喉；海浮石清肺火、化老痰。



方 18 加味逍遥散(戴春禧)

【组成】 柴胡 10g, 当归 10g, 白芍 20g, 茯苓 30g, 白术 15g, 薄荷 6g, 甘草 5g。气郁加香附; 咽痛咽干加射干、玄参、黄芩; 睡眠不安加夜交藤、珍珠母; 有痰加桔梗、紫苏梗或合用半夏厚朴汤加减; 气虚合用补中益气汤加减。

【功效】 疏肝解郁, 理气散结。

【主治】 梅核气。

【用法】 水煎, 每日 1 剂, 早晚分服。

【方解】 现代医学的咽异感症中有一部分属中医学郁证的范畴, 中医称之为梅核气。梅核气的发生多与七情郁结、气机不利有关。其中与肝的关系尤为密切, 若只着眼与局部气郁痰结之标, 而忽略病变之本, 则治疗多难收效。肝属木, 性喜条达, 为藏血之脏, 肝体阴而用阳, 若情志不遂则肝失调达而郁结, 肝郁则易伤阴血, 肝失于柔和; 肝郁抑脾, 运化失常, 聚湿成痰, 痰气互结于咽部, 而发为梅核气, 故肝郁脾虚是梅核气本源, 痰气郁结则是其标。治宜疏肝养血, 补肝阴以和肝用治其本, 理气化痰治其标。采用逍遥散加减。用柴胡、香附、薄荷疏肝解郁, 顺其调达, 发其郁竭之气, 即“木郁达之”之义。当归、白芍柔肝养血; 玄参、射干滋阴利咽, 白术、茯苓健脾燥湿, 以绝生痰之源; 紫苏梗、桔梗、黄芩理气祛痰, 宣郁散结; 夜交藤、珍珠母平肝宁神。

方 19 加味柴胡疏肝散(师会)

【组成】 柴胡 10g, 陈皮 10g, 芍药 10g, 枳壳 10g, 香附 10g, 川芎 10g, 桑枝 15g, 丝瓜络 15g, 木瓜 15g, 豨莶草 10g, 地龙 15g, 郁金 10g。加减: 肝郁血瘀者加用丹参、桃仁、红花、姜黄等活血化瘀之品; 肝郁痰阻者加茯苓、薏苡仁、石菖蒲等化痰之品; 肝郁血虚者加当归、熟地黄等养血之品。



【功效】 疏肝理气,舒筋活络。

【主治】 癥症性瘫痪。

【用法】 每日 1 剂,水煎,早晚分服。

【方解】 癥症属于中医学郁证、脏躁等范畴,而癥症性瘫痪则以肢痿为主,又可归属痿证范畴。如《临证指南医案》认为系肝肾肺胃四经之病,气血津液不足是形成痿症的主要因素。肝有藏血荣筋、主运动之功能,肝脏有病,筋爪不能所主,即可出现肢体痿弱不用。柴胡疏肝散出自《景岳全书》,由柴胡、陈皮、芍药、枳壳、香附等 7 味药物组成,具有疏肝解郁、行气活血之功效,主治肝气郁结、胁肋胀痛、往来寒热之证。采用本方加用舒筋活络药治疗本病,是针对本病始在肝,最后出现肢体痿弱不用,即精神刺激,情志所伤,导致肝郁气滞之故。

方 20 加味四七汤(王学民、张乐明)

【组成】 化橘红 10g,清半夏 6g,茯苓 15g,紫苏梗 10g,连翘 10g,海浮石 10g,瓜蒌仁 10g,枳壳 6g,厚朴 6g,枇杷叶 10g,青皮 10g,甘草 6g。

【功效】 舒肝和胃,理气化痰。

【主治】 梅核气。

【用法】 每日 1 剂,水煎,早晚分服。

【方解】 二陈汤燥湿祛痰,佐以枳壳、厚朴理气宽胸,海浮石配连翘专治咽喉中顽痰,紫苏梗下气宽中,青皮舒肝破结气,枇杷叶利肺气并能祛痰,瓜蒌仁降痰宽胸。气郁化火,致咽喉肿痛者,加射干、玄参、牛蒡子等,清热解毒;痰热重者,加竹茹清热痰,利肺气,并加桔梗载诸药上行,兼有开肺郁之功;兼咳嗽者加川贝母、款冬花、紫菀止咳化痰;肝气郁结,横逆上冲咽喉,加柴胡、香附、青皮舒肝理气。

中医理论认为,此病因七情郁结、痰滞咽喉而成。方中二



陈汤的治疗重点在于痰，四七汤的治疗重点在于气。从临床病例分析，患者以青壮年并从事脑力劳动者较多见，年少体质健旺，易于动气，化热生痰，又由于从事脑力劳动者活动少，气血不畅，因而形成气滞痰郁，用四七汤进行施治，能收到效果。

方 21 和胃涤痰汤(徐海虹、童林根)

【组成】 半夏 10g，旋覆花(包) 10g，白术 10g，浙贝母 10g，海浮石(先煎) 15g，夏枯草 15g，全瓜蒌 20g，白芥子 6g，厚朴 10g，茯苓 15g。加减：脾胃虚寒者去海浮石、夏枯草，加干姜 6g，砂仁(后下) 6g；胃阴不足者去白芥子，半夏减量，易厚朴为厚朴花，加石斛 10g，芦根 10g；思虑过度，劳伤心脾者，加合欢皮 10g，远志 10g；肝郁气滞者，加八月札 15g，广郁金 10g；久病瘀血阻络者，加丹参 15g，红花 6g。

【功效】 和胃降逆，行气化痰。

【主治】 瘰疬症。

【用法】 每日 1 剂，水煎，分 2 次温服。

【方解】 瘰疬症与中医学中“梅核气”临床表现相同。《医宗金鉴》曰：“咽中有痰涎，如同炙肉，咯之不出，咽之不下者，即今之梅核气病也。”西医将瘰疬症归于“食管功能紊乱”。食管为饮食之道路，《难经集注》称其为“胃之系”，故食管病变多从胃而治。梅核气多由脾胃升降失司，聚湿生痰，或气滞津停生痰，痰气互阻于胸膈之上而发。治以和胃降逆，行气化痰散结。和胃涤痰汤中，半夏、旋覆花和胃降逆，降气化痰，共为主药；辅以白芥子辛温透达，利气散结，逐经络之痰；海浮石味咸寒，清肺化痰，软坚散结，治顽痰胶滞；浙贝母苦寒开泄，清热化痰，开郁散结；夏枯草清肝火，散郁结，消痰核；全瓜蒌行气宽胸，化痰散结；复以厚朴下气化痰，消积导滞；茯苓利水渗湿，健脾安神；白术益气健脾和胃。方中寒温并用，共达和胃



降逆、行气化痰散结之功。据现代药理分析表明,半夏对咳嗽中枢有镇静作用,可解除支气管痉挛,使支气管分泌物减少,有镇咳祛痰作用,并能抑制呕吐中枢而止呕;旋覆花所含黄酮苷对组胺引起的动物支气管痉挛有缓解作用,对食管运动功能紊乱有双相调节作用;浙贝母碱有中枢抑制和镇静、镇痛作用。

方 22 蒺麦饮合苦酒汤(朱安龙)

【组成】 蒺麦饮:白蒺藜 15g,八月札、佛手、枳壳、桔梗、郁金、茯苓、赤芍、白芍、玄参、麦冬各 10g,生麦芽 30g,赭石 20g(先煎),沉香 3g(研细末冲服),合欢皮 15g,生甘草 5g。痰黏稠,咳出不爽加海蛤壳、川贝母各 10g;夜间咽干口燥明显加沙参 15g,石斛 10g;伴恶心、呕吐加旋覆花(布包)、竹茹各 10g;心烦失眠加夜交藤 30g,远志 10g。苦酒汤:制半夏 10g,加水 300ml,煎 20min,取药液兑入白醋 60ml,稍凉后加入鸡蛋清 2 枚,为 1 日量,当茶饮,每饮少许,徐徐含服。

【功效】 养阴润燥,化痰开结。

【主治】 梅核气。

【用法】 以上 2 方合用,每日 1 剂,水煎服,7 天为 1 个疗程。

【方解】 梅核气多发于妇女,常因肝郁气滞、痰凝气结所致,临床常用半夏厚朴汤之类治疗。但笔者临床发现有不少患者无效,甚至反增咽下唇燥。原因一是素体阴亏、复因肝气郁结,或气郁化火、火盛伤阴;二是辨证失误,投辛燥理气太过,损伤阴津。《临证指南》卷六·华岫云所述:“郁则气滞,久必化热,热则津耗而不流,升降之机失度,初伤气分,久延血分,而为郁劳沉痾。”高度概括了本病之病机。因此,治疗上要遵循“理气而不伤阴,养阴而不呆滞”之原则。笔者自拟蒺麦



饮,方中白蒺藜、八月札、佛手疏肝理气,而无香燥耗气伤阴之弊;麦芽生用不仅能舒肝理气,又能消食开胃;枳壳理气消胀,宽胸快膈,偏于降气;桔梗宣通肺气,祛痰利咽,偏于升提;二者相伍,一升一降,宣散条达,使三焦气机通畅;郁金入气分则能行气解郁,入血分与赤芍相配则活血化瘀;茯苓甘淡实脾,宁心安神;赭石重镇降逆,下气消痰;白芍养阴柔肝;玄参、麦冬养阴润肺,生津润燥;合欢皮功擅宁心悦志,解郁安神;沉香功专行气开郁,质体沉重,偏于平冲降逆,而笔者体会以藏沉香效果显著,用柴沉香则疗效较逊;甘草调和诸药。仲景苦酒汤方中半夏一味,功在化痰开结,弊在温燥太过,以苦酒(白醋)之酸敛阴降火,以制其燥性。且与鸡子白合用共奏养阴润燥、化痰开结之功,使阴复火降,痰化结散,则咽部之疾自愈。

方 23 加减麦门冬汤(周仕亮)

【组成】 半夏 6g,麦冬 10g,沙参 10g,粳米 12g,旋覆花 10g,广郁金 3g,大枣 3 枚,炙甘草 3g。

【功效】 降气散结,养阴生津。

【主治】 梅核气。

【用法】 每日 1 剂,水煎,早晚分服,1 周为 1 个疗程。

【方解】 梅核气,由于胸膈痰结与气相搏,逆上咽喉之间结聚而致;《金匱·妇人杂病篇》中有治“咽中如有炙脔”,《医宗金鉴》认为系“咽中有痰涎,如同炙肉,咯之不出,咽之不下者即梅核气也”。其主方半夏厚朴汤(半夏、厚朴、生姜、茯苓、紫苏叶)药性较燥热,如使用得当则效果显著,但临床上所见适应证多伴有神志方面的心悸、怔忡、健忘、不寐、善惊等症,且多系久病,气津每感不足,咽喉并有干燥感,往往与半夏厚朴汤不甚相宜。为扬长避短,随症应变,笔者根据该方主药半夏与麦门冬汤治咽喉不利,方中亦有半夏,且《本经》载麦冬主



心腹结气之论,相比之下,麦门冬汤对燥性者优于半夏厚朴汤。因麦门冬汤中缺乏调气之剂,如加旋覆花以降气散结,郁金以解郁调气,沙参以生津养阴,使其标本兼顾,化裁后移用于属于燥性者或能有效。笔者认为,麦门冬汤的适应证为:气津两亏、肺胃阴伤而现虚羸少气,咳逆,上气,并伴有痰涎凝聚以致咽喉不利及呕恶等症,因之对梅核气有良好临床效果,值得推广。

方 24 甘麦大枣汤(全世建)

【组成】 甘草 6g,小麦 30g,大枣 10g,柏子仁 9g,五味子 10g,生地黄 15g,麦冬 15g。若气阴两虚者,症见体倦乏力,头晕心悸,脉细弱,加黄芪 20g,党参 15g;若阴虚火旺者,症见烦躁易怒,失眠,脉细数,加菊花 18g,竹茹 15g。

【功效】 补养心脾,宁心安神。

【主治】 瘵症。

【用法】 每日 1 剂,水煎服,睡前服。4 周为 1 个疗程。

【方解】 甘麦大枣汤见于《金匱要略·妇人杂病》,原文指出:“妇人脏躁,喜悲伤欲哭,象如神灵所作,数欠伸,甘麦大枣汤主之”。脏躁虽古今说法不同,但现已基本公认为情志病,多由情志不舒,气郁化火,耗伤阴液,以致心失所养,心神不宁,而出现感觉、意识或运动障碍。甘麦大枣汤则可补养心脾,宁心安神。梁运通在《金匱释按》中指出:“小麦养心神,大枣补气养血,甘草补心脾之气而缓急,合用养心,宁神,缓急”。而瘵症的临床表现及成因与脏躁形成相似,因此,运用甘麦大枣汤治疗取得理想效果。

方 25 防己地黄汤(张国亭、杨晓)

【组成】 生地黄 150g,防己、防风、桂枝、甘草各 9g。加減:痰火重者加郁金、石菖蒲、白矾;肝气郁结重者加柴胡、白



芍、枳实、木香、合欢皮；若气滞血瘀者加丹参、桃仁、红花。

【功效】 滋阴降火，疏风清热，安神定志。

【主治】 瘵病发作。

【用法】 每日 1 剂，水煎分 3 次服，20 天为 1 个疗程。

【方解】 瘵症在祖国医学中属郁证、脏躁、百合病、气厥等病证范畴。本病主要病因病机是情志失调，气血逆乱，火郁痰结，食积湿聚，血瘀气滞，正气耗伤，以致脏腑气血阴阳升降失调，波及表里内外、四肢九窍而产生各种复杂多变的表現。张仲景《金匮要略·中风历节病篇》记载：“防己地黄汤，治病如狂状，妄行，独语不休，无寒热，其脉浮。”其病机是营血郁热。方中重用生地黄滋阴清热、养血固本为主，防己、防风、桂枝轻清升散风邪为辅。全方共奏滋阴、降火、疏风清热、安神定志之功，应用于治疗瘵症性精神病发作，疗效十分满意。

方 26 半夏厚朴汤加减 1(李明)

【组成】 制半夏 10g，厚朴 6g，紫苏梗 10g，茯苓 10g，生姜 3 片。胸闷胁痛者加制香附 10g，广郁金 10g，开心果 10g；失眠不寐者加合欢皮 15g，夜交藤 15g，茯神 10g；食欲不振者加炙鸡内金 6g，焦山楂、焦神曲各 15g；咽喉疼痛者减生姜，加桔梗 6g，牛蒡子 10g；腹胀便秘者加生大黄(后人)6g，炒枳壳、炒枳实各 10g。

【功效】 舒肝和胃，理气化痰。

【主治】 梅核气。

【用法】 每日 1 剂，水煎分 2 次服，5 天为 1 个疗程。一般需 1~2 个疗程。

【方解】 梅核气属祖国医学郁证范畴，临床上比较多见。本组患者大多是经五官科查无异常来我科就诊。该病的发生常因情志内伤，肝失条达，以致气郁不舒，形成肝气郁滞之证，



而气机郁结则易生火、生痰，痰气互结则出现咽中之梗，胸闷叹息，夜寐不佳。苔白腻，脉弦细滑为肝郁挟痰之症。《证治汇补·郁证》提出：郁证虽多，皆因气不同流，治当顺气为先。方中半夏、茯苓化痰开结，下气降逆；厚朴、生姜辛以散结，苦以降逆，下气散满、解郁调中；紫苏梗和胃畅中、消痰下气；夜交藤、茯神、合欢皮解郁安神；绿萼梅、开心果增强理气解郁之功；焦山楂、焦神曲、生麦芽消食健胃。同时对于一些情绪不振患者，必要时要做好一些耐心细致的思想工作。药物、心理同治，才能在短期内获愈。

方27 半夏厚朴汤加味2(张文才)

【组成】 制半夏、厚朴各12g，茯苓20g，苏叶6g，川芎、苍术各12g。加减：偏痰热者酌加栀子12g，浙贝母15g，鲜竹沥20ml；偏血瘀者加水蛭6g，土鳖虫10g；无大便者加大黄10~20g，以通腑泄浊开窍；阳虚重者加淫羊藿12g，杜仲、制附子各10g；气虚重者加黄芪15~60g，党参10~20g。

【功效】 醒脾化痰，行气解郁，祛瘀开窍。

【主治】 癔症性瘫痪。

【用法】 每日1剂，水煎，早晚分服。

【方解】 中医学认为“脾主四肢”，“清阳实四肢”，四肢的功能活动与脾之健运有关。肝郁犯脾、忧思伤脾、肥甘困脾、过劳损脾均能使脾的运化功能失调，聚湿生痰，痰浊又反过来困遏脾气，加重痰湿生成，痰浊郁结，阻碍气血，肢体失养，从而出现肢体瘫痪；痰浊蒙蔽心窍，致使无自知力、意识障碍等。所以本病之发生与脾（胃）、心、肝有关。病理关键为痰浊郁结，蒙蔽心窍。治疗上应以醒脾化痰、行气解郁、祛瘀开窍为大法。

方中半夏、苍术为醒脾化痰湿之要药；厚朴行气燥湿，以



助半夏散郁结化痰浊；紫苏叶芳香疏散，助厚朴理气宽胸，宣通郁气；茯苓甘淡渗湿健脾；气郁痰阻，每致血瘀，川芎为“血中之气药”，走而不守，为活血化瘀之圣品。诸药合用，共同起到痰浊得祛、瘀阻得化、气血经络通畅、脾醒心清之作用。临证再随症加味，并对患者进行暗示治疗，努力取得患者信任和合作，疗效会更加显著。

方 28 半夏厚朴汤 1(黄韶芳)

【组成】 厚朴 15g, 紫苏 10g, 半夏 10g, 云茯苓 10g, 生姜 3 片。加减：异物感明显者加川楝子 12g, 陈皮 10g, 绿萼梅 9g；胸胁胀满者加青皮 10g, 枳壳 12g, 瓜蒌皮 10g；呃气频作者加旋覆花 15g(布包煎), 赭石 10g(先煎)；膈塞不下食、惊怖者，加用远志散制汤内服。

【功效】 醒脾化痰，行气解郁。

【主治】 梅核气。

【用法】 水煎，每日 1 剂，早晚分服。每服 10 剂为 1 个疗程。配合意想法：向患者反复解释所患疾病不是“癌症”，是完全可以治好的，一定要放下思想包袱，配合治疗。每次服药 20 分钟后，嘱其牙关紧闭，做深呼吸，同时大脑想像药物进入胃后，上膈进心中，上冲咽喉直达病所，再从胸返回胃中。(见健康报第 4 版，1990 年 12 月 8 日)如此反复上下来回推动 10 次，1 天 2 次，10 天为 1 个疗程。

【方解】 梅核气相当于西医“咽喉异物感症”，中医属郁症。《素问·举病论》曰：“思则神有所存，神有所归，正气留而不行，故气结矣。”《证治汇补·郁症》曰：“郁病虽多，皆因气不周流，法当顺气为先，开提为次。”《金匱要略·妇人杂病》曰：“妇人咽中如有炙脔，半夏厚朴汤主之”。本病情志刺激是为主因，而性格内向是发病的体质因素。情志所伤加之性格内



向,则肝失条达,气郁气滞,脾失健运,聚湿生痰,痰气互结于咽喉而发本病。理气化痰、开郁散结是为本病治法。治疗本病,可谓三分药物,七分调理。药物治疗固然能缓解症状,但要彻底治愈,必须解除其思想顾虑。因此,胃镜或食管钡餐检查对于本病尤显重要,否则,向患者解释没有依据,便没有说服力,难以树立患者的治疗信心。药物疗法配合意想疗法,是将现代医学的精神疗法和中医学的经络疗法、气功疗法融为一体,较之单纯药物治疗具有见效快、疗效稳定等特点。梅核气病位在肝、心、脾3脏,而足厥阴肝经、手少阴心经、足太阴脾经均夹咽,且属心、络胃、上膈互为连贯,意想药物自胃上膈属心夹咽上下来回推动,直达病所,行气散结,故能奏效。

方29 半夏厚朴汤2(刘红、王泽山)

【组成】 半夏10g,厚朴10g,茯苓12g,紫苏叶10g,生姜10g。加减:痰气郁结、日久化热,症见口下、口苦、心烦者,加栀子10g,黄连10g;郁怒过甚,肝气郁滞加重,症见胸胁胀痛者,加郁金10g,青皮10g;脾虚失运,痰饮内盛,症见恶心呕吐清水者,改茯苓为15g,加白术10g,砂仁10g;思虑过度,劳伤心脾,症见少寐多梦者,加合欢花10g,远志12g。

【功效】 理气开郁,降逆化痰。

【主治】 梅核气。

【用法】 水煎服,每日1剂,早晚各1次。

【方解】 梅核气一证,多由肝郁脾虚,聚理生痰,或气滞津停生痰,痰气交结于胸膈之上而发。其治疗法则当是理气开郁,降逆化痰散结。半夏厚朴汤中半夏化痰散结,降逆和胃;厚朴下气除满,行气开郁;茯苓甘淡渗湿,利水化饮;生姜辛温散结,和胃止呕;苏叶芳香,宣气开郁。诸药合用,功在行气开郁,化痰降逆散结。用本方治疗梅核气一证,收效明显。



本方多辛温苦燥之品，阴虚津少者虽有梅核气特征亦不宜使用。

方30 百合地黄汤加味(胡辰生、景秋芝)

【组成】 百合 20g, 生地黄、太子参、丹参各 15g, 绿萼梅 6g。加减：纳差者加鸡内金、炒麦芽，大便干者加生大黄，大便溏者加炒白术。

【功效】 润养心肺、凉血清热。

【主治】 瘵症。

【用法】 水煎 2 次，共取 600ml，早晚分服，每日 1 剂。

【方解】 瘵症以饮食、行动失调，精神恍惚不定为主要特征，临床表现为不开朗、重感情、言不对题、阵发性哭笑或默默不语，或突然四肢抽动等症状，属祖国医学郁证范畴，与脏躁相类似，症状复杂多变，多在精神刺激影响下发病，以女性青壮年多见，其病因病机主要是因忧愁、思虑过度或情志不遂，肝气郁结，郁久化火，或热病之后，余邪留于经脉，营血亏耗，心肺阴虚，心神失养，神志不宁而发病。临床观察，其病属实者少，属虚者多，或虚实夹杂，变化多端。百合地黄汤有补正不助邪、攻邪不伤正之特点，并能安心、定胆、益气、养五脏，故选用此方为主，再加太子参、丹参、绿萼梅，益气养阴，理气活血。上药合用使气机条达，血脉通畅，百脉调和，故而病愈。

二、综合疗法

方1 针挑治疗梅核气(李红新、孙清军)

【取穴】 主穴：太冲、膻中、天突、丰隆、鱼际、间使、神门；配穴取咽喉部阿是穴及肺俞、肝俞和颈夹脊 3~6 穴。

【功效】 疏通经络，调畅气机，泻热解毒，祛痰散结。

【主治】 梅核气。



【用法】 每次选挑 2~4 穴,以挑筋法为主。穴位挑点常规消毒,用 2% 普鲁卡因注射液局部麻醉,用普通外科手术刀或“双面刀片”横切开皮层,取特制针具挑治,由浅而深逐层挑断皮下纤维组织。挑治过程中可施以牵拉、摇摆、震颤等手法,直至切口内皮下纤维组织全部挑完为止。挑毕,上涂碘酊,外敷无菌小纱垫包扎固定。间隔 5~7d 挑治 1 次,3 次为 1 个疗程

【方解】 梅核气多因情志内伤,肝失条达,气机郁结,循经上逆结于咽喉;或因肝气乘脾,致脾运失司,津液不得输布,积聚成痰,痰气互结于咽喉而发病。经临床观察,单纯药物治疗难以达到预期效果。针挑治疗可疏通经络,理气化痰。取肝胆、脾胃经穴及任脉膻穴为主,其中太冲、膻中、天突相配,功在疏肝理气开郁;鱼际、丰隆清火化痰利咽;神门为心经原穴,取间使乃《针灸大成》所载,二穴能调理心神,畅达情志。诸穴合用,即能达到疏通经络、调畅气机、泻热解毒、祛痰散结等治疗目的,配合局部阿是穴,可增强疗效,直达病所,对消除咽喉梗阻之症作用尤为显著。现代医学研究证明,针挑疗法可减轻急性炎症反应,有明显的消炎、消肿作用,能催化和激活机体免疫系统,提高免疫应答水平,增加免疫功能,从而加强机体的抗炎能力。该疗法简便易行,方法独特,安全有效,且愈后不易复发,因而深受广大患者的欢迎,值得临床推广应用。

方 2 针药并用治疗梅核气(张继红、赵藏朵)

【组成】 气滞痰凝型:药用半夏 12g,厚朴 9g,茯苓 12g,生姜 3 片,干紫苏叶 6g,杏仁 15g,桔梗 10g,海浮石 10g,甘草 6g。肺胃阴虚型:药用猫爪草 20g,生地黄 15g,麦冬 15g,百合 12g,贝母 15g,杏仁 15g,玄参 15g,牡丹皮 15g,桔梗 12g,



鳖甲 20g, 甘草 6g。

【取穴】 天突、廉泉、扶突穴。

【功效】 行气开郁, 降逆化痰。

【主治】 梅核气。

【用法】 中药均每日 1 剂, 水煎分 2 次服。针灸治疗要求针感放散至整个咽喉, 隔 10 分钟行针 1 次, 每次留针 30 分钟, 每日 1 次, 10 次为 1 个疗程, 疗程间休息 3 天。

【方解】 梅核气是指患者自觉咽喉如有梅核堵塞状, 此名首见于《赤水玄珠·卷三》,《金匱要略》喻作“咽中如有炙脔”。中医认为气滞痰凝型由于七情郁结, 气机升降失常, 痰涎凝结咽喉导致本病。方中半夏、厚朴、生姜辛以散结, 苦以降逆; 茯苓利水化痰; 紫苏叶芳香宣气解郁; 杏仁、桔梗宣肺化痰; 海浮石软坚散结化痰。诸药合用, 行气开郁, 降逆化痰。肺胃阴虚型由于肺胃津液耗损, 虚火上炎, 咽喉为肺胃之门户, 所以患者自觉咽中如有炙脔。方中猫爪草散结消肿化痰, 可消除咽后壁淋巴小结增生; 生地黄、麦冬、百合、玄参、牡丹皮、鳖甲养阴清热; 川贝母、杏仁、桔梗宣肺化痰。全方共同起到滋阴清热利咽的作用。针刺天突、扶突、廉泉可以疏通局部气血, 以缓其标, 故针药并用可达到标本兼治之目的。

方3 针药并用治疗癔症(刘芳琴)

【组成】 自拟醒脑汤: 礞石、灵磁石各 50g, 全瓜蒌、百合、夜交藤各 30g, 茯苓 20g, 香附、太子参、石菖蒲、远志各 15g, 炙甘草 10g, 胆南星 6g。便秘者加生大黄 10g; 心烦失眠重者加炒栀子 15g, 黄连 5g。

【取穴】 百会、印堂、内关、合谷、丰隆、太冲、涌泉。

【功效】 镇惊开窍, 醒脑调神。

【主治】 癔症。



【用法】 自拟醒脑汤每日 1 剂,水煎饭后服,1 个疗程 7 剂。配合电针:进针后先强刺激泻法,再取上述诸穴接 G6805 型上海产电针仪,取连续波频率升至最大,均匀地将输电量开至所需强度。强刺激:输出电压 60~70 伏,1 次 10~30 秒,若症状不缓解可重复 3~5 次,中间休息 5 分钟。弱刺激:电压 8~20 伏,1 次 20 分钟。发作期予强刺激控制症状,发作后予弱刺激巩固疗效。每日 1 次,可治 1~7d。

【方解】 从癔症的病因症状看,属于中医“郁证”、“脏躁”的范畴。大多发病复发前有外界精神刺激或自身所愿不能,郁久成疾。病因特点突出表现为“郁”、“痰”、“热”3 种内邪亢盛之实证。肝气郁结,痰热内盛,蒙蔽清窍,致哭笑无常,精神恍惚,不能自主。醒脑汤用大剂量青礞石、磁石重镇潜降以宁神,全瓜蒌、胆南星、百合、夜交藤清热化痰养心以安神,石菖蒲、远志醒脑开窍以醒神,香附疏肝解郁,茯苓、太子参、甘草扶正护胃。电针取穴百会、印堂、合谷、内关清热除烦,醒神开窍;丰隆、太冲、涌泉豁痰泻肝,降逆平冲。针药并用,切中病机,相得益彰,使郁得解,热得清,痰得化,共奏镇惊开窍、醒脑调神之功,故收立竿见影之效。

方 4 针刺治疗癔症 1(白晓英、周志杰、谢治稼)

【取穴】 主穴:百会、印堂。随症配穴:突然昏厥,呼吸急促,配人中,针尖向上斜刺,涌泉针尖向前斜刺,强刺激,至患者有明显针感反应,苏醒后出针。四肢抽搐,颈斜,嘴唇抖动,配人中、承浆、双侧曲池、合谷,丰隆、阳陵泉、太冲,用泻法。失语配下廉泉,双侧合谷,风池,太冲用泻法。肝气郁结,咽中梗阻,胸闷气短,配天突,沿胸骨后缘向下直刺 1~1.5 寸,勿提插,少捻转,脑中,针尖沿皮向下平刺 1~2 寸,补双侧内关,泻双侧太冲。肝火上炎,面红目赤,耳鸣,补双太溪,泻双太



冲,双侧听宫、医风平补平泻;手足发麻配双侧曲池,外关、合谷、阳陵泉、太冲、平补平泻;心虚肝郁,精神恍惚,神疲,悲伤善哭,如鬼神所作,补双侧神门、三阴交,人中平补平泻,泻双太冲。心脾两虚,心悸易惊,纳差,补双侧内关、神门、中脘、足三里;呃逆配中脘、内关、足三里、平补平泻,太冲穴用泻法。

【功效】 疏肝解郁,开窍宁神。

【主治】 癔症。

【用法】 患者取仰卧位,用 1.5 寸毫针斜刺入 0.5~1 寸,百会穴针尖向前,印堂穴针尖向上斜刺,进针后捻转行针,患者局部有酸麻胀困感为得气,此时留针,分别在针柄处接 G6805-1 型电针治疗仪,频率为 2Hz,疏密波型,强度以患者能耐受的最大限度刺激量为度,缓慢加大电量,保持一定量的持续刺激,针刺时间为每次 30 分钟,每日 1 次,12 次为 1 个疗程。

【方解】 癔症是一种较常见的神经症。好发于青年,女性较多。其发作多由精神因素作用引起,临床表现复杂多样。本症的各种症状与祖国医学的“气厥实证”、“郁证”、“奔豚气”、“脏躁”、“梅核气”等病证颇为相似。中医认为其病因为七情所伤,如所愿不遂,突受惊恐,精神紧张,遭遇不幸,过度悲哀,恼怒等,损伤心神,心神失守,精神惑乱所致。病机为气乱、气逆,临床表现涉及脏腑经络甚多。历代医家治疗本病均主张辨证分经,循经选穴,治其主病之经脉。百会穴为督脉与手足三阳经之会穴,位居高巅之上,督脉在后项风府穴处进入脑内,与脑联络,又为阳经之海,故针此穴不仅可以调整诸阳经经气且能熄风醒脑,印堂穴为奇穴,位于两眉间,与督脉临近,两穴相配有开窍宁神,平肝熄风,清利头目之效,故为主穴。对急性发作昏厥、气急、抽搐、木僵,为风痰闭阻清窍,流



窜经络,气机壅滞,针刺以泻邪为主,多从手少阴、手厥阴、足厥阴、足阳明经配穴;郁闷不畅,肢麻、梅核气等为肝气郁结,多以病变部位所属经脉选穴加经脉主病选穴。穴虚肝急,脏阴不足,心神不安,肝气不和,见烦躁哭闹,善表演,以补手厥阴、手少阴经、足阳明、足太阴经经气为主,以滋养益气安神。同时针刺手法也很重要,补泻得宜,不可太过,治疗过程中,避免语言诱导,保持环境安静。治疗中,我们体会到针刺治疗本病具有见效快、疗效确切的特点,配合适当的药物治疗有减少复发、缩短疗程的作用。实为治疗本病的有效方法之一。

方5 针电结合治疗癔症性构语障碍(王奎、张化利)

【取穴】 取主穴涌泉、内关、神门,配太冲、廉泉、列缺。

【功效】 疏肝解郁,通经活络。

【主治】 癔症性构语障碍。

【用法】 涌泉穴直刺1~2寸,可透太冲穴,用强刺激泻法,廉泉取穴时,针尖应向舌根斜刺0.5~1寸,其余诸穴均按常规针刺方法。针毕,即将WQ-6F型电针仪(北京东华电子仪器厂生产)的输出导线正、负极固定于已刺穴位的针柄上;将幅度调为2.0~4.0Hi,频率 $(6.0 \sim 10.0) \times 10.0\text{c/s}$,分别给以持续和间断通电各5分钟,取消通电后,仍可留针10~15分钟。

【方解】 癔症性构语障碍是以情志受到刺激、突发失语为特征的临床急性病证,又称情志暗、肝郁失音、癔病性失语症等,《内经》称之为“暗”、“声闭”、“倒音”。多由于情感不遂或心胆不宁,使肝气郁积,郁怒伤肝,气郁化火,虚火上炎,灼伤阴津,咽喉失于濡养,蕴结于喉,以致声门不利,故治疗以疏肝调经利气、通脉活血利肝为主。涌泉为足少阴肾经之井穴,少阴根于此,循行咽喉,挟舌本,能治喉闭、失音等症,即用强



刺激泻法,以疏通经络,行气化痰,开机窍,使得气出。内关乃心包经穴,通于阴维脉,功能宽胸理气;加心经原配穴神门,安神定志。肝经原穴太冲,善于疏肝解郁,通经活络。列缺为手太阴肺经之脉穴,其经脉通于任脉而上达咽喉,能宣肺利咽。直接针刺廉泉穴以引导气机,开咽窍,利声出。结合应用电针仪,增加了毫针的刺激强度和针刺效应。总之,诸穴配治,针电结合,则经脉相通,主治所及。

方6 针灸治疗梅核气(寿黎生)

【取穴】 主穴:人迎、水突;配穴:天突穴。

【功效】 行气开郁,降逆化痰。

【主治】 梅核气。

【用法】 治疗时本着“舍穴不舍经”的原则,视异物感具体位置,顺着足阳明胃经上下变动。针具采用特小毫针,雀啄法进针,手法以轻柔为好,留针30分钟。针感有别于其他体针,排除酸、胀、麻感,以鱼刺卡住或梗阻感、口中涌有口水为好,视病情可辅以艾灸、穴封、拔火罐等。每日1次,10次为1个疗程。

【方解】 此症系由于长期情绪抑郁,气滞痰凝所致。足阳明胃经乃十二经脉之长,而经络又是人体运行的通道,通过针刺足阳明胃经人迎、水突穴,起到疏通经络、调气血的作用,使胸膈痞闷得以宣泄,使患者原来阻滞不畅的喉部豁然开通,呼吸随之轻快。针刺人迎、水突还具有宁心神、利运化作用,能改善睡眠和胃纳。由于引起咽喉异物感症的病因很多,因而对此症的明确诊断、把握准适应证非常重要,病史应问详尽,并作全面检查,以排除邻近器官病变,以免误诊。对于比较顽固的病证,可在异物感的具体位置施以重灸(间接灸),并配合其他穴位加强刺激量。感冒是此症的主要诱因,因此,应



重视预防,以减少复发。同时应要求患者尽量戒烟酒,起居有节,加强营养,增加抵抗力。

方7 针刺治疗癔症性躯体障碍(刘茜、孙玲)

【取穴】 主穴:人中、内关(双)、涌泉(双)、劳宫(双)、百会、三阴交(双)、太冲(双)。配穴:上肢瘫痪配极泉、尺泽、曲池;下肢瘫痪配委中、秩边、环跳;精神症状配神门、郄门、通里、合谷。

【功效】 清心利窍,醒脑调神,疏通气机。

【主治】 癔症性躯体障碍。

【用法】 穴位常规消毒,先针内关穴,直刺1~1.5寸,施提插捻转泻法,使针感放散至肘和手指;人中穴向鼻中膈下斜刺,针2~3分后,向同一方向捻转3~4周,施雀啄泻法,以眼球湿润为度;涌泉穴快速进针,捻转泻法;百会穴沿头皮向后顶方向刺,其余腧穴均用直刺,每次留针15~20min,每日1次,10次为1个疗程,据临床表现不同,配选有关穴位,刺激量宜大,以气至病所为好。在上述治疗过程中,同时作言语疏导。

【方解】 根据祖国医学理论,本病多由心神失宜、机变不行而致,以清心利窍、醒脑调神为治则。人中为督脉之穴,督脉为阳脉之海,主一身之阳气,取人中穴有清心益脑、通阳疏气、通上导下、调理神机之功。涌泉穴为少阴肾经之井穴,是肾经经气之所出,可通肾窍,行气血,具有开窍醒神之功。内关穴为手厥阴之络,有宽胸利气、开郁调神、宁心安神之效,劳宫为手厥阴之荣穴,有开窍醒神作用。四穴合用有开窍醒神、清心利脑、通调机体内外之作用。三阴交为肝、脾、肾三经交会穴,可调气血、补肝益肾。百会穴位居巅顶,有醒脑开窍作用。太冲穴主血,有疏肝解郁、开关启窍之功。上述诸穴共奏



调理气机、开窍醒脑、疏肝解郁、养心安神之功。

方8 针刺治疗癔症性失音 1(沈小雷)

【取穴】 扶突穴。气滞型加针行间、经渠；气虚型加针太渊、足三里。

【功效】 疏通气血。

【主治】 癔症性失音。

【用法】 首先令患者明确其所患疾病本质是功能性而非器质性，是可以治愈。其次详细询问发病原因，帮助患者认识病因。然后施行针灸治疗。嘱患者仰卧位，用 1.5 寸毫针取一侧扶突穴（左右均可）进针约 0.5 寸。气滞型加针行间、经渠；气虚型加针太渊、足三里。行捻转手法，得气后间隙动留针 30min。其间同时配合发音练习，比如数数，医者每发一音，嘱患者跟着念，直至其发音部位准确。

【方解】 治疗上取扶突穴，该穴属大肠经，为肺之表里经，可直接疏通局部气血，培本生津，以治其标。气滞型加针行间，该穴为肝经之荥穴，属五行之火，为泻本经子穴，以疏泄肝气，调达气机。肺金肃降有制肝气的作用，由于肝失疏泄，木反侮金，使肺气壅盛，而加针经渠，可调肺气，宣肃降，润咽喉。气虚型，加针太渊，为肺经之原穴，《灵枢·九针十二原》所说“五脏有疾，当取之十二原”，太渊可调整肺经之气虚，加之该穴又为本经土穴，亦可收培土生金之功效。针足三里，可鼓舞中气，培生化之源。以上行间、经渠及太渊、足三里穴均为治本之穴，标本兼治，故临床常可获得满意疗效。

方9 针刺治疗癔症性失语 2(付万仓)

【取穴】 内关(双)、人中、百合、哑门、廉泉、通里。

【功效】 醒脑开窍，镇静安神。

【主治】 癔症性失语。



【用法】 患者取仰卧位,先取双侧内关,局部常规消毒,直刺1~1.5寸,采用提插捻转相结合的泻法,时间2min,使患者针感传至指端为佳,继针人中,斜刺0.3寸,采用啄雀法,至使双眼流泪为度;百合平刺0.5~1寸,局部以致胀为度;哑门直刺1~2寸,感应为局部发胀,刺时患者稍低头,向下颌方向刺2寸,不作捻转,向上肢放射时,出针;廉泉向舌根方向斜刺1~1.5寸,以局部发紧发酸为宜;通里直刺0.5~0.8寸,局部酸沉,并向上下传导。每次取2~3穴,可交替使用。在施治同时,操作者给予一定暗示,如张口说话的动作一定要让患者看到。

【方解】 瘈症,现代医学称为“歇斯底里”发作,主要因大脑皮质功能与皮质下相应关系的失调而产生。而中医认为:本病的发生纯属于“神”的失常,神是人体生命活动的外在表现,故用醒脑开窍、镇静安神之法能获良效。

内关属手厥阴心包经络穴,具有宽胸醒神、除烦宁心等功能。外邪入侵,心包代为受之,故针刺内关可以调整气机、镇静安神;人中为督脉穴,督脉上行入脑,脑为元神之府,具有醒脑开窍、回阳救逆之功效;百合为督脉之交会穴,具有苏厥熄风、醒脑、升阳固脱等功效。《针灸大成》曰:“……言语謇涩,口噤不开……,百病皆治”。《灵枢·经脉》曰:“手少阴之别,名曰通里,……虚则不能言……”。本穴具有利舌和营之功效。哑门具有通利机关、开窍醒神之功。《玉龙歌》曰:“偶尔失音言语难,哑门一穴二筋间,若知浅针莫深刺,言语音和照归安”。以上方法很好地说明了用上穴治疗本病有较好疗效。现代研究证明,针刺内关能改善心脏功能,增加心输出量,提高机体血氧供应;人中穴可明显促进脑血管循环,增加脑血管灌流量,促进了脑组织代谢和修复,改善脑生理功能,使大脑



皮质相应的区域有一定的调节功能。由于本病易接受暗示，故治疗多次不愈者，同时结合一定的暗示治疗，效果更佳。

方10 针刺治疗癔症性失语3(朱俊珂)

【取穴】 哑门、廉泉、膻中、内关(双)、神门(双)。

【功效】 解郁，安神，开音通窍。

【主治】 癔症性失语。

【用法】 操作治疗时周围环境应安静，根据患者病程长短和性格特征，作耐心的思想开导工作，以取得患者信任，让其主动配合治疗。针哑门，患者取伏案坐位，全身放松，暴露颈项部。常规消毒，取 $0.35\text{mm} \times 40\text{mm}$ 毫针选准穴位进针，针尖朝向患者下颌部，深刺约 $25 \sim 30\text{mm}$ ，使患者产生局部麻胀感，或单侧或双上肢、下肢放电样感传；然后将针提至浅层留针。边操作边引导患者讲话。起针后再让患者仰卧位，用同型号针，针刺廉泉穴，进针后向舌根方向斜刺约 $25 \sim 30\text{mm}$ ，捻转提插强刺激泻法。继针膻中穴，沿皮向下平刺进针 $25 \sim 30\text{mm}$ ，施捻转泻法。内关穴直刺约 $15 \sim 25\text{mm}$ ，行提插泻法，使针感传至手部及整个前臂。神门穴直刺约 $0.5 \sim 1.5\text{mm}$ ，行捻转泻法，使针感传至小指远端。以上各穴均得气后留针 30min ，每隔 10min 行针1次(哑门穴不行针)，边操作边引导患者讲话。经上述1~2次治疗后，一般患者均能治愈。对个别病程长，发作次数较多的患者，虽能讲话，但语言不流畅，音量较低，应连续治疗3~5次，行针手法视病情而定。

【方解】 哑门穴为督脉与阳维脉交会穴，为调神要穴之一，又是治疗聋哑的首选主穴，有开暗通窍、醒神宁志之功能，主治暴暗，舌强不语。廉泉穴位于舌咽部，为阳维脉、任脉的交会穴，有利舌启音之效。内关为手厥阴经络穴，八脉交会穴之一，具有宁心和胃、宽胸理气、安神解郁之功能。膻中为心



之募穴，八会穴之一，气会膻中，主要功能开胸顺气。神门为手少阴心经原穴，心藏神，主人的精神情志。“神门”顾名思义乃心神之门，为临床调神、治神的要穴，其宁心安神功能为历代针灸医家所重视，此穴是通治各种精神、情志疾病的首选穴位，有宁心安神、镇静解郁之功能。以上各穴配合以开窍醒脑、利舌通咽、调理气机、养心安神，使阴阳平衡，从而获得较好的治疗效果。

方 11 针刺治疗癔症 2(张玥)

【取穴】 内关(双)、合谷(双)。

【功效】 调理气机，开窍醒神，开郁解痉，养心安神。

【主治】 癔症。

【用法】 皮肤常规消毒，取双侧穴位，快速进针，直刺 1 寸，施以大幅度提插捻转，强刺激，泻法，得气后留针 10min。

【方解】 中医学认为，癔症多由七情过度，气机逆乱，脏腑阴阳失调而成，针刺疗法治疗本病，取内关穴为手厥阴心包经之络穴，也是八脉交会穴之一，具有调和气血、宽胸理气、开郁调神、宁心安神定志、理气和胃之功。合谷穴是手阳明大肠经原穴，肺与大肠相表里，具有调节阴阳气机、疏肝解郁、行血解痉之效。两穴合用共奏调理气机、开窍醒神、开郁解痉、养心安神之功。笔者运用针刺疗法治疗本病，同时进行语言暗示，大多数患者在 5min 内有效。医师对患者的语言暗示，可增强针刺的效果。现代医学常采用盐酸氯丙嗪肌肉注射或地西洋静脉注射治疗本病，促使患者入睡，但遗留头昏、头痛等症状。而针刺疗法治疗本病却无任何不良反应，并有良好的效果。

方 12 针刺治疗癔症性失明症(张晓玲、郑健男)

【取穴】 百会、四神聪、承泣、太阳、内关、合谷。



【功效】 疏散风热，行气通络，活血祛瘀。

【主治】 癔症性失明症。

【用法】 各穴均不提插，亦不捻转，留针 30min。出针后用消毒棉球轻揉针孔。

【方解】 本病属祖国医学暴盲的范畴。如《证治准绳》云：“平日素无他病，外不伤轮廓，内不损瞳神，倏然而不见也。”本例患者由于悲伤过度，终日哭泣，心情郁闷，致使肝气郁结，血瘀阻络，肝经风火上扰，目失血养，故目不能视，更难辨五色矣。本病治疗以疏散风热、行气通络、活血祛瘀为法，诸穴合用针到病除。

方13 针刺治疗癔症性失语 4(何继勇、何小翠)

【取穴】 内关(双)、人中、百会。配穴：肝气郁结加太冲；痰气中阻加丰隆、中脘；脾胃虚弱加足三里、三阴交。

【功效】 醒脑开窍，解郁宁心安神。

【主治】 癔症性失语。

【用法】 患者仰卧位，先针刺双侧内关，针尖朝向肘关节，快速进针，行提插捻转泻法，患者有明显的针感，并向上肢放射，针刺深度为 0.5~1 寸；再针刺人中穴，针尖朝向鼻中隔，斜向上刺 0.5~1 寸，行雀啄针法，使患者流泪或眼眶湿润为度；百会穴向后斜刺 0.5~1 寸，留针 30min，缓解期用平补平泻手法。

【方解】 癔症性失语，属中医学的“气厥”、“郁证”、“失语”，多由于抑郁恼怒、伤感等精神因素，使气机运行失畅，气逆痰阻，使经络阻滞，气血逆乱，清窍被蒙。《素问·生气通天论》：“阳气者，大怒则形气绝，而血菀于上，使人薄厥”。病变部位主要在心、肝，与脾胃有关，病变多属实证，久病多虚实夹杂。内关为八脉交会穴之一，属于手厥阴经之络穴，心包为心



之外卫,可代心受邪,也可代心行令,心藏神,主神明,故针刺内关能醒神开窍,心神复明。人中为手足阳明之会穴,主一身之阳气,为诸阳之首。百会为督脉、足太阳膀胱经之会穴,两脉均上行头部,针刺百会能醒脑安神。现代神经生理研究证实:针刺内关能改善心功能,提高脑血氧供应,针刺人中能直接兴奋上行激活系统,解除脑细胞的抑制状态,使减弱的脑活动增强,针刺百会能改善脑血液循环,提高脑血氧供应。综观辨证施治,诸穴配合共达醒脑开窍、解郁宁心安神、调节阴阳的作用。

方 14 针刺治疗癔症性失语 5(王家田、王家琪)

【取穴】 廉泉、内关为主穴,心神不宁加神门,肝气郁滞配太冲,脏躁取大陵,肾虚加太溪。

【功效】 疏肝解郁,理气活血,清利咽喉。

【主治】 癔症性失语。

【用法】 针廉泉向舌根斜刺,内关针刺时针尖取 45° 向上斜刺,行重刺激手法,针感向上肢故射为最佳,无此针感时,每隔5min行手法1次,共留针20min;太冲、神门、大陵、太溪皆直刺。以上诸穴,惟刺太溪时用补法,其他均用泻法。

【方解】 本病病因为情志抑郁,气郁化火,循厥阴经上入颞颥,声门不利而突发失语。情志活动与肝脏关系密切,正如吴崑所言:“肝气急而志怒,故为将军之官。”又如《素问·六节脏象论》说:“肝者……魂之居也。”这里所说的“魂”属于精神情志活动。太冲穴,为肝经的俞穴,以“治脏者,治其俞”为法则,所以取太冲,太冲为疏肝解郁之要穴。又根据“舌为心之苗”的理论,故急取手厥阴心包络之内关穴。内关穴属心包络穴,又为八脉交会穴之一,通于阴维,有安神理气、通畅心络之功。廉泉为局部取穴,穴属任脉、阳维之会,有通调舌络、清利



咽喉的作用。以上诸穴相伍,有疏肝解郁、理气活血、清利咽喉之功效。治疗时要了解患者的思想情绪,因势利导,取得患者信任。因精神因素对针刺疗效有着重要意义,患者的信任与否,直接关系到治疗的效果。针刺内关穴时,一定要获得向上肢放射的针感,这是治疗成败的关键。“刺之要,气至而有效”,“气速至而速效”。

方 15 针刺治疗癔症性失音 6(李丽英)

【取穴】 廉泉、人迎、涌泉。

【功效】 消肿散结,清热生津。

【主治】 癔症性失音。

【用法】 治疗前应使周围环境安静,通过详细了解病史和体格检查,与患者建立良好的关系,以增强患者治愈疾病的信心和决心,取得患者的信任与合作。嘱患者平卧,全身放松,穴位常规消毒后,选用 30 号 2 寸毫针,先针廉泉穴,进针后向舌根方向斜刺约 1~1.5 寸,采用提插捻转强刺激泻法,边针边引导患者发声,不留针。再针人迎穴,肩下置一小枕,充分暴露颈部,消毒后缓慢进针,深约 3~5cm,待有酸麻胀感后,留针 20min。再针涌泉穴,快速进针,以短促的重刺激,并予捣动,捻转,约 1min 后起针,同时加强语言暗示。经以上治疗后,一般患者均能 1 次治愈,如有的患者虽已恢复发音,但音量低,语言不流畅,第 2 天可再治疗 1 次,针刺手法视患者的耐受为度。

【方解】 癔症性失音,中医称暴暗,多因情志郁结,气郁化火,声门不利而突然发病。人迎位近咽喉,针之直接疏通患处的气血,消肿散结,清热生津。廉泉穴位于舌咽部,为阴维脉、任脉的交会穴,有利舌启音之功效。“肾为声音之根”,涌泉穴系足少阴肾经之井穴,取井穴主治急症。以上 3 穴合用,



以开窍醒脑,利舌通咽,疏通气机,令其阴阳平衡,从而获得速效。治疗癔症性失音,心理治疗与针刺治疗配合得当,许多患者可以在几分钟内恢复如常人,达到立竿见影的效果。

方 16 针刺治疗癔症性黑矇症(孙彦奇、徐珂民)

【取穴】 内关、神门、通里。

【功效】 宽胸理气。

【主治】 癔症性黑矇症。

【用法】 皮肤常规消毒,让患者闭目养神,用 1 寸毫针直刺内关穴,得气后留针 30min;运用卧刺针法自神门透通里,得气后,行摇柄法,用右手指持针如摇橹状,行青龙摆尾针法,使针感沿前臂向上传导入胸内。

【方解】 癔症性黑矇症属于中医“暴盲”的范畴。患者多为情志所伤,悲思太过,或暴怒之后而突然发病。“暴盲”患者虽目不能视,然非目疾,乃为情志所伤,脉气不畅,致使血瘀络阻,而使双目失去气血的濡养,从而目不能视。辨经从“心”论治,穴取神门透通里行青龙摆尾针法,使心经脉气畅通;内关穴为手厥阴心包经的络穴,针刺内关穴,可起到通利上、中、下三焦之功,也具有宽胸理气之作用。所以笔者认为治疗“暴盲”患者,应从心经和心包经辨证论治,此法收效好,取穴少,取穴容易,值得推广。

方 17 针刺配合电兴奋治疗癔症性失音(费立凤)

【取穴】 上廉泉、人迎(双)、大突、通里(双)。

【功效】 利舌通咽,调和气血。

【主治】 癔症性失音。

【用法】 患者仰靠坐位或平卧位,全身放松,选准穴位,常规消毒后,选 30 号 1.5~2 寸毫针针刺。上廉泉穴向舌根方向刺入 0.5~0.8 寸,行提插捻转手法,得气后留针;人迎穴



避开动脉缓慢进针,刺入 0.2~0.4 寸;天突穴从胸骨窝进针,先直刺 0.2~0.3 寸,然后沿胸骨柄后缘、气管前缘缓慢向下刺入 0.5~1 寸,以针感气流下行为度。以上均行平补平泻手法,留针 15min,行针 3~5 次,留针过程中鼓励患者练习发音,当有声音发出时,鼓励其重复发音数次,以巩固疗效。

【方解】 癔症性失音,属中医暴暗范畴。发病前常有明显的精神创伤因素。中医学认为本病多因情志郁结,气郁化火,声门不利而突然发病;或暴受惊恐,以致心胆气乱,神无所附,舌无所主,舌窍郁闭而致。正如张景岳曰:“心气通于舌,舌为心之苗,心病则舌不能转,此心为声音之主”。治以疏通气机,调和气血。上廉泉、人迎近咽喉,针之能直接疏通患处气血,行瘀散结,有利舌启音之效;天突针感极强,以通利气机,更能增加暗示效果;通里为心经络穴,善治暴暗。诸穴合用以利舌通咽,气血调和,阴阳平衡,使神有所附,闭窍得开。而电兴奋疗法在于调节皮质下的兴奋抑制过程,电兴奋疗法是感应电在病变部位做短时间大剂量的通电以兴奋组织,用强剂量感应电刺激之后,可发生继发性抑制,因此,针刺和电兴奋疗法二者配合应用,可相得益彰。

方 18 针刺配合甘麦大枣汤治疗癔症失语(许克洋、高先德)

【组成】 甘麦大枣汤:甘草 10g,小麦 30g,红枣 10 枚。煎服,每日 1 剂。

【取穴】 以天突穴为主,抽搐加刺人中;哭笑者加刺双侧合谷、神门;木僵加刺十宣穴;癔症瘫痪者加刺曲池、阳陵泉、足三里、三阴交。

【功效】 镇静安神。

【主治】 癔症失语。



【用法】 天突穴进针 0.2 寸达皮下,沿胸骨直刺 1 寸,平补平泻;人中穴针尖向上斜刺 0.5 寸;十宣穴针刺 0.3 寸,挤出血为度;其他穴针刺 0.5~1 寸,且可强刺激。

【方解】 瘖症失语又称“緘默症”(不言症),中医称“风瘖”、“暴瘖”,其发音器官无病变,声带活动亦正常,以运动和感觉功能障碍为表现。天突穴乃会厌下方任脉之穴位。《灵枢·忧恚无言》:“人卒然无音者,寒气客于厌,则厌不能发,发不能下至,其开阖不致,故无音。”以及“足之少阴上系于舌,络于横骨,终于会厌……会厌之脉上络任脉,取之天突,其厌乃发也。”《金匱要略》:“妇人脏躁,喜悲伤欲哭,象如神灵所作,数欠伸,甘麦大枣汤主治。”其实脏躁病与瘖症极相似,发病虽以女性为多,但男性亦可发病。据上所述,凡瘖症失语均可针刺天突穴促其言语,继则针刺其他有关穴位配合频饮甘麦大枣汤巩固疗效并兼治其他症状,故失语得治,其他表现随之消除。

方 19 针刺人中治疗瘖症性晕厥(李乐敬、朱守莲)

【取穴】 人中穴。

【功效】 醒神开窍。

【主治】 瘖症性晕厥。

【用法】 以 28 号 1.5 寸毫针斜向上刺。深度可达上颌骨,行捻转泻法,强刺激 1~3min。同时嘱患者睁眼、说话。留针 30min,行针 3 次。患者清醒后起针,开始暗示疗法并静滴生理盐水 500ml。

【方解】 瘖症性晕厥属中医厥症范畴。是由于气机突然逆乱,升降乖戾,气血运行失常造成。临床所见多为实证。由于恼怒惊骇,情志过极,以致气机逆乱,上壅心胸,蒙闭窍隧,而引起昏倒。人中属督脉要穴,具有清神志、苏厥逆、开关窍



的作用。凡一切猝然昏倒,不省人事者,皆可取用。瘧症性晕厥系明显心理因素致功能性疾病。未治前意识障碍较深,医患间难以沟通,故行暗示疗法不易成功,经针刺人中后,意识障碍已明显减轻,再予暗示,则病证豁然而解。

方 20 针刺少商、隐白治疗瘧症瘫(王长海)

【取穴】 瘫痪侧少商、隐白。

【功效】 疏通经脉,调畅气机。

【主治】 瘧症性瘫痪。

【用法】 取 1 寸毫针,选取瘫痪侧少商和隐白快速进针,重手法大幅度捻转,同时嘱患者活动肢体,约行针 3~5min 即可出针。如未愈,可等待 10min 后再次如上法治疗。如伴有失语者,取 1.5 寸毫针从廉泉穴向咽部刺入,行提插捻转手法后出针。

【方解】 瘧症属中医“脏躁”范畴,主要病机在于人体内上下阴阳之气不相续接而致,和现代医学的中枢神经功能紊乱的学说基本一致。所以治疗的关键是要通过各种方法转移患者的注意力。现代医学暗示、镇静和中医安神定志均属此法。但由于该病病情急、表现症状重,仅仅靠上述办法很难在短期内取得明显效果。传统针刺理论多根据“心主神明”之原理,取内关、神门、合谷、三阴交等穴治疗,虽有效果,但疗程却较长。

笔者根据五腧穴之特性,尤其是“井穴”多用于昏迷治疗的理论,选取“井穴”治疗瘧症瘫,后经反复筛选,将少商、隐白作为首选穴。《灵枢·九针十二原》说:“所出为井”,“井穴”乃经脉之气所出之处。《灵枢·顺气一日分为四时》也有“病在藏者取之井”之说,为“井穴”治疗瘧症瘫提供了理论依据。现代解剖学研究表明,四肢尤其是手指、足趾在大脑中枢运动感



觉区的投影面积要比其他部位大得多,也就是说,手指、足趾与大脑中枢的关系密切,刺激手指和足趾部的穴位,能最大限度地刺激大脑运动感觉中枢,调节紊乱的神经系统。临床实践证明,五腧穴(均位于肘、膝以下)较之躯干部位的穴位,具有针感强、治疗范围广的特性。而“井穴”位于四肢末端,其作用之强显而易见。由于少商、隐白为手太阴肺、足太阴脾经之井穴,为同名经配伍。泻此两“井穴”,可疏通经脉、调畅气机,使郁闭之气外散,阴阳之气续接,诸症自安。

方 21 针刺内关和天突穴治疗梅核气(白侠)

【取穴】 双侧内关、天突。

【功效】 舒畅情志,宽胸理气。

【主治】 梅核气。

【用法】 患者取仰卧位,选取 28 号 1.5 寸毫针,穴位常规消毒,取双侧内关直刺进针,行提插捻转,得气后再刺天突穴,先直刺进针 0.2 寸,后针尖向下,紧靠胸骨后方刺入 1~1.5 寸,得气后患者立刻感到咽喉部清爽润滑,留针 30min,留针期间每 10min 捻针 1 次,增强针感,每日 1 次,5 次为 1 个疗程。

【方解】 梅核气多见于女性,发病多与情志不畅有关,表现咽部异物感,咳之不出,咽之不下,查体无阳性体征。针刺内关能舒畅情志,宽胸利气。天突位于胸骨上窝正中,靠近咽喉部,深部为气管,针刺下去患者立刻会感觉咽部清爽润滑,主要是因为针刺该穴能降低气道阻力,针刺后无论吸气或呼气阶段的气道阻力,都能从增高状态明显下降,从而起到调畅气机、舒情利气的作用。两穴合用,作用协调。针刺天突穴要严格掌握进针的深度和角度,以防刺伤肺脏和有关动、静脉。这一疗法,选穴少,简单方便,疗效好。

**方 22 针刺内关治疗癔症(周晓燕、闫风祥、李耀辉)**

【取穴】 内关(双)。

【功效】 安神定志。

【主治】 癔症性瘫痪。

【用法】 患者取仰卧位,双内关穴常规消毒,30号毫针垂直刺入,针0.5~1寸深,得气后,行提插捻转泻法,在针刺过程中肢体功能已恢复者,停止运针,留针20min;未恢复者,每5min运针。

【方解】 癔症性瘫痪均由精神因素引起,或受惊恐刺激,或精神抑郁,或因他人瘫痪的诱导,导致突然单瘫、四肢瘫等。内关穴具有安神定志之功效,针刺内关,施以泻法,予以反复运针,可起到理气、开窍的作用,对患者的精神状态有良好的调节作用,从而解除瘫痪。

方 23 针刺并语言暗示治疗癔症性失音(李桂松、袁明华、许玲)

【取穴】 上廉泉、双人迎、天突、双通里。

【功效】 行瘀散结,利舌启音。

【主治】 癔症性失音。

【用法】 患者取仰靠坐位或平卧位,全身放松,选准穴位,常规消毒后,选30号1.5~2寸毫针针刺。上廉泉穴向舌根方向刺入0.5~0.8寸,行提插捻转手法,得气后留针;人迎穴避开动脉缓慢进针,刺入0.2~0.4寸;天突穴从胸骨窝进针,先直刺0.2~0.3寸,然后沿胸骨柄后缘、气管前缘缓慢向下刺入0.5~1寸,以针感下行为度。以上均行平补平泻手法,留针15min,行针3~5次,留针过程中鼓励患者练习发音,每日1次。配合语言暗示疗法:在进行穴位针刺前或针刺的同时进行语言暗示。通过详细询问病史,了解病因,将指导



性的语言说与患者,或在与陪人对话中让患者听到,形成间接暗示。也可在治疗中通过针感加以语言暗示。要让患者知道此类病证系功能性改变,而不是器质性问题,使患者相信这种疗法完全可以将疾病治好。

【方解】 本病的发病多有明显的精神因素,患者易于接受暗示,故而在针刺的同时,做好心理治疗,将会起到事半功倍的效果。通过说理开导,解除疑惑,疏导解郁,达到协助治疗的目的。在做语言暗示时,语气要坚定、确切,切忌含糊、疑问。诊断要明确,排除声带麻痹、痉挛性失音等器质性病变。

方 24 睛明为主穴针刺治疗瘖症(霍明霞)

【取穴】 主穴:睛明。配穴:瘖症性上肢瘫加内关;瘖症性下肢瘫加申脉;瘖症性失音加廉泉;瘖症性意识障碍加水沟。

【功效】 醒脑开窍。

【主治】 瘖症。

【用法】 主穴睛明用 30 号 1~1.5 寸毫针,常规消毒皮肤后,嘱患者闭目,医者以左手大拇指将患者眼球推向外侧,右手持针缓慢执着刺入目内眦上 0.5 分处 0.5 寸深,另一侧同样操作后留针 20min,同时嘱患者放松肢体反复运动或练习发音。若主穴效果不明显时,再取配穴以 30 号 2 寸毫针快速刺入,强刺激,不留针。

【方解】 瘖症的诊断必须经过完整的神经系统检查和相应的辅助检查,排除了脑肿瘤和其他器质性神经系统疾病后方可考虑。多因七情致病、伤及脏腑而出现一系列的症状。若脏腑功能失调,气血运行不畅,四肢经脉空虚,失于濡养,则出现肢体无力,举动不能(瘖症性瘫痪),在祖国医学中属于“痿证”范畴。瘖症性失音,中医称“暴暗”,有肺为声音之门、



肾为声音之根之说,可见声音源于脏腑之精气。若情志致病,伤及脏腑之精气,可突然出现失音。癔症性意识障碍,属五志化火,扰乱心神所致。治疗癔症时,如不消除致病的精神因素,针刺治疗很难奏效,做好心理治疗,将会使针刺起到事半功倍的效果。治疗开始前,医生应通过详细了解病史和体格检查,与患者建立良好的关系,以增强患者治愈疾病的信心和决心,取得患者的信任与合作。

针刺治疗根据中医的经络理论,睛明为手足太阳、足阳明、阴阳跷五脉之交会点,位于目内眦,与多经相联系。主治头目、四肢、脑之阴阳失调。其他配穴用来加强治疗效果。申脉、内关为八脉交会穴,可调整、渗灌与之联系的正经经气,补充其经气不足。水沟、廉泉为醒脑开窍之经验穴。当针刺上述穴位、患者出现针感时,随之以语言暗示,同时令患者立即抬起患肢,鼓励患者加强活动,或诱导说话。治疗癔症,心理治疗与针刺治疗配合得当,许多患者可在几分钟内恢复如常人,达到立竿见影的效果。

方 25 耳针与体针配合治疗梅核气(纪金国、刘希云)

【取穴】 耳部取穴:颈、咽喉、交感、胃、脾、肾上腺。体针取穴:天突、膻中、合谷、间使、劳宫、足三里、三阴交、内庭。

【功效】 疏肝解郁,利咽化痰。

【主治】 梅核气。

【用法】 耳穴常规消毒后用 1.5 寸毫针直刺,针尖透入耳软骨,然后行捻转手法,捻转时嘱患者作吞咽动作。每次 1 耳,每耳 3 穴交替应用体穴以天突、膻中为主,配左上肢右下肢或右上肢左下肢的穴位交替进行,进针后行提插、捻转手法得气后留针 30min。耳针 10min 行针 1 次,体针 5min 行针 1 次,行针时配合患者作吞咽动作每日 1 次,10 次为 1 个疗程。



【方解】 本证与情志有关,是由七情郁结、痰湿凝滞、郁怒化火而致,其特点是感觉咽部有异物存在,时时有梗阻感,咽又咽不下,咳又咳不出,患者常感难过。有的患者因久治不愈而有精神症状伴随;有的亦可影响饮食;有的虽经多方检查亦无异常发现。在治疗过程中,我们认为耳针与体针配合应用有较强的镇静安神、定志化痰、疏肝解郁作用。新病患者疗效较好,多在1~2个疗程内治愈,久病患者则见效稍缓,需耐心治疗,同时延长留针时间。总之梅核气的治疗,需医患互相配合,保持情志舒畅的同时,劳逸结合,禁食辛辣、刺激、动火之物,才能使疗效巩固。

方 26 耳压疗法治疗瘰疬(韩海生)

【取穴】 神门、脑干、皮质下、耳尖、枕、枕小神经、心、肝。

【功效】 镇静安神,熄风止痉。

【主治】 瘰疬。

【用法】 每次治疗前选用探针探压耳区找出穴位敏感点,常规酒精消毒后以 $0.7\text{cm} \times 0.7\text{cm}$ 方块医用胶布将冰片贴于敏感穴位上,每次选耳穴4~6穴,每日按压3~5次,每次2~3min,以感觉所压部位烧痛或酸麻却又能耐受为佳。发作期按压时间和次数适当增多,两耳轮换,3天更换1次,4次为1个疗程。每1个疗程后休息3~5d,接着进行下1个疗程治疗。

【方解】 中医认为:耳与经络、脏腑有密切的联系。《灵枢·口问》篇说:“耳为宗脉之所聚。”且分布于耳部的经脉均与脏腑有联系,说明耳与脏腑在生理病理方面息息相关。所以分布耳郭上的穴位可以作为针灸的刺激点治疗各部病证,瘰疬多为大脑皮质受到精神刺激引起的大脑皮质暂时性功能失调,属祖国医学“脏躁”、“郁证”、“气厥”等病证范畴。神门、



脑干、枕、耳尖、枕小神经穴具有镇静安神、熄风健脑作用；皮质下具有调节大脑皮质兴奋和抑制过程、肝具有熄风开窍、舒筋止痉作用；心具有宁心安神、疏经活络的作用。以上穴位共同作用达到镇静安神、熄风止痉之目的。采用冰片作压耳药物，取其通诸窍、散郁火、消肿止痛作用。

方 27 电针治疗癔症 1(王社平、谢瑞山、牛文)

【取穴】 双侧足三里和(或)合谷穴。

【功效】 荡涤经气，开郁豁痰，通关开窍，补虚泻实。

【主治】 癔症。

【用法】 针刺得气后，用 G6805 电针仪治疗，选疏密波。

【方解】 癔症属中医郁证、气厥、脏躁、癫狂、痿证等病证范畴，乃由肝气郁结、痰火上扰神明所致，日久则致心、脾、肝、肾亏损而变生他证。故治疗时宜疏泄经气、醒脑开窍为主。阳明经多气多血，取大肠经原穴合谷及胃经合穴足三里，皆是脏腑经脉之气汇聚之所，用电针强刺激该穴，属于针刺手法中的强通法，具有荡涤经气、开郁豁痰、通关开窍、补虚泻实之功。不论寒热虚实，也不管病程长短，临证用之，则针到病除。

方 28 电针治疗癔症 2(章慧英、王云彩)

【取穴】 主穴取人中、百会、印堂、天突、膻中、鸠尾、足三里。配穴取合谷(双)、太阳(双)、涌泉。

【功效】 调和阴阳，宽胸利膈，醒脑安神。

【主治】 癔症。

【用法】 根据主要症状辨证取穴。每次选 2 个主穴，4 个配穴或 2 个配穴 4 个主穴。进针得气后，接通 G6805 电针仪，用连续波，频率 4~12Hz，强度根据患者症状及耐受程度而定。实证输出量为强刺激，虚证输出量为弱刺激。如歇斯底里发作可加大刺激量至用电冲击疗法，电冲击每次不超过



20 秒,2 次间隔时间 30 秒,最多不超过 3 次。电针治疗每日 1 次,每次时间为 30 秒,每 10 次为 1 规定疗程。

【方解】 癔症属中医“脏躁”、“梅核气”、“奔豚气”,部分属“癫证”等范畴。一般认为起病与精神刺激、情志不畅有关。中医学把思维、神志都归于心,情志过度损伤可致心神失常。如《医宗金鉴》:“心静则神藏。若为七情所伤则心不得静而神躁扰不宁也”。由此说明过度的恼怒、抑郁、伤感等因素,而使气血瘀滞,气机运行失于通畅,甚则阻逆不通,或气盛火炎阳亢而不宁。或气逆痰阻,经络阻滞,阴阳失调,蒙蔽清窍。督脉有总督全身阳经作用,任脉有总督全身阴经作用。针刺取督、任二脉为主的穴位,人中、百会、印堂、鸠尾有升阴和阳、调气宁神、通经开窍的作用。取天突可利咽降气,膻中行气、调气、降气止呃,足三里为足阳明胃经的合穴,可健脾和胃、调气血,配以内关宽胸利膈,三阴交壮骨健脑,涌泉醒脑,治疗时按患者主要症状不同选配穴位,均可收到满意疗效。

电针有调节大脑皮质兴奋和抑制的作用,对有精神兴奋性症状的癔症患者可产生抑制使其安静,而对有抑制症状的癔症患者则可解除抑制而缓解症状。

方 29 催眠针法治疗癔症(刘安丰、薛迪中等)

【取穴】 1 组:哑门、内关、人中、后溪。2 组:内关、三阴交、太冲、合谷、间使。3 组:中脉、后溪。

【功效】 镇静安神。

【主治】 癔症。

【用法】 取 1~2 个穴位,常规消毒,在坚定有力、简单和清晰的言语暗示下,进行针刺,发作时强刺激,体质虚弱或久病者稍弱刺激;未发作时用平补平泻刺法,每日或隔日 1 次,每次时间为 30min 以上,每 5~7 次为 1 个疗程。



【方解】 情志过度损伤可致心神失常,治疗时按患者主要症状不同选配穴位进行针刺,加上成功的言语暗示,均可收到满意的疗效。

催眠术的方法之一是语言暗示加皮肤刺激,在此基础上改为语言暗示加穴位刺激,形成了一种新的治疗方法,即催眠针法,此方法由心理疗法与针灸疗法相结合而成,融治疗、预防、康复及开发人体自我恢复潜力为一体的综合措施,适用于各种心理疾病、身心疾病及躯体疾病,在临床上得到广泛应用。

方 30 采用远道刺法治疗梅核气(赵明智、陈兴文)

【取穴】 照海、太溪两穴,双侧交替使用。

【功效】 镇静安神,清咽化痰。

【主治】 梅核气。

【用法】 以毫针在穴位上直刺 0.4~0.8 寸,留针 20min,间隔 10min 捻针 1 次;每日行针 1 次,6 次为 1 个疗程,休息 2 天,再行第 2 和第 3 疗程。

【方解】 梅核气是中医病名,是因七情过度致脏腑功能紊乱所致,相似现代医学的癔症或神经官能症。诱发因素多由精神创伤或者是长期精神紧张而引起。一般均采用暗示疗法,但疗效不理想。采用远道刺法,即上病下治,临床上观察疗效满意。笔者认为,照海和太溪两穴,前者是八脉交合之一,通于阴跷脉。《针灸大成》“八脉交会八脉歌中‘列缺任脉行肺系,阴跷照海隔喉咙’”。由此可知,照海穴治疗咽喉部的病变有独特的疗效作用。后者是原穴,《灵枢·九针十二原》曰:“五脏有疾,当取之十二原”,说明针刺该穴有调整内脏功能的作用。因此,针刺太溪穴亦可治疗梅核气,所以,两穴合用,能提高梅核气的治疗效果,值得临床借鉴。



第三节 老年痴呆症

方1 补肾开窍汤(彭萌等)

【组成】 枸杞子、益智仁、补骨脂各 12g,桃仁、川芎、炙远志、石菖蒲各 10g,郁金、丹参、茯苓各 15g。加减:气虚明显者加人参、党参、白术;血虚明显者加黄芪、当归、阿胶珠;阴虚明显者加女贞子、麦冬、山茱萸;阳虚明显者加附子、巴戟天、肉苁蓉;热甚烦躁不安、口干便秘、苔黄腻者加黄连、大黄;气郁甚、胸闷、善太息者加柴胡、佛手;纳呆者加鸡内金、神曲;心悸不安、失眠多梦者加龙齿、柏子仁;肢体半身不遂者加地龙、白僵蚕。

【功效】 补肾活血,化痰开窍。

【主治】 老年痴呆。

【用法】 每日 1 剂,水煎,早晚分服。2 个月为 1 个疗程。

【方解】 老年痴呆是内科难治性疾病之一。中医学认为“脑为髓海”,是“精明之府”。“髓海不足,脑转耳鸣,胫酸眩暈,目无所视,懈怠安卧”。发病与心、肝、脾、肾有关,病理特点为本虚标实,临床多见以脏腑气血亏虚为本、痰浊瘀血阻络为标的本虚标实证。由于脏腑虚衰,阴阳气血失调渐致痰瘀阻络,脑髓空虚,所以治疗时应标本兼顾,攻补兼施。方中枸杞子、益智仁、补骨脂补益肾气,桃仁、川芎、丹参活血化瘀,石菖蒲、郁金、炙远志化痰解郁开窍,茯苓健脾化痰,全方共奏补肾活血、化痰开窍之功。

方2 补髓益智汤(朱玲、孙丽君)

【组成】 紫河车粉 10g,何首乌 20g,熟地黄 20g,蒸黄精



20g,女贞子 20g,山茱萸 15g,炒酸枣仁 15g,石菖蒲 10g,丹参 30g,川芎 15g,葛根 30g,远志 10g,加鲜猪脑 50g 另炖服。加減:唇紺舌暗紫加桃仁、红花以加强活血祛瘀之效;胸闷、呕恶、食少多寐、苔膩加胆南星、青礞石、半夏以豁痰开窍;激动易怒、目赤口苦加天麻、钩藤、石决明以平肝泻火;面色萎黄、心悸气短、唇舌色淡加当归、阿胶、黄芪以补气养血。

【功效】 补髓填精、通窍化痰、祛痰益智。

【主治】 老年痴呆。

【用法】 每日 1 剂,水煎,分 2 次服,1 个月为 1 个疗程。

【方解】 补髓益智汤以血肉有情之品紫河车以返本还元;何首乌、熟地黄、蒸黄精、女贞子、山茱萸补肾益髓益脑;丹参、川芎、葛根活血化瘀、通窍强脑,有报道此 3 种药能扩张脑动脉,改善脑部供血,提高大脑耐缺氧能力;石菖蒲、远志、青礞石、半夏、胆南星用于荡涤壅滞窍道的有形无形之痰,而开窍醒脑益智;鲜猪脑炖服,一为药引子,引药直达病所,二为以脏补脏,以脑补脑,共奏补髓填精、通窍化痰、祛痰益智之功。

方 3 呆聪汤(阎乐法、刘百波等)

【组成】 人参、水蛭、何首乌、葛根、黄芪、知母、锁阳、生地黄、川芎、淫羊藿、菟丝子。

【功效】 填精益髓,益气温阳,化痰涤痰。

【主治】 老年痴呆。

【用法】 先将人参、水蛭粉碎过筛装入大号胶囊(每粒 0.5g),每次 4 粒,早晚各 1 次,其余药物以冷水 800ml 浸泡 2 小时,然后以文火连煎 3 遍,合计 400ml,早晚 2 次分服。每日 1 剂,每周服 5 剂,休息 2 天,服药 40 剂(8 周)。

【方解】 方中知母、生地黄、枸杞子滋阴补肾,填精益髓;淫羊藿、菟丝子、何首乌、锁阳温肾壮阳,以达阳生阴长,精足



髓充；人参、黄芪大补元气，宁神益智；川芎、水蛭、葛根、石菖蒲、胆南星、山楂化痰涤痰，通利血脉。现代药理及动物实验证实，人参能增强脑能量代谢，促进脑内 DNA、RNA 和蛋白质的合成，提高神经元神经节苷脂含量和神经元的存活率，提高中枢 M 胆碱受体密度，改善脑智能；黄芪、淫羊藿、菟丝子、何首乌、锁阳对小鼠脑胆碱酯酶活性有非常明显的抑制作用，对神经生长因子(NGF)受体结合有不同程度的促进作用；生地黄、知母能提高衰老早期动物脑内 M 受体数，黄芪则提高衰老晚期动物脑内 M 受体数；水蛭、川芎、葛根具有扩张脑血管、增加脑血流量、降低血液黏稠度、抑制血栓形成的作用，葛根还具有提高胆碱乙酰转移酶(CAT)活性、增加皮质和海马乙酰胆碱含量、改善学习记忆功能的作用。

方4 二仙四物汤(李杜瑄)

【组成】 仙茅 30g，淫羊藿 30g，熟地黄 30g，当归 15g，川芎 15g，地龙 30g，石菖蒲 30g，远志 30g，桃仁 12g，红花 12g，沙苑子 30g。加减：肾阳虚较重者加附子；阴虚阳亢者加龟甲、鳖甲；痰浊偏胜者加制天南星、制半夏；瘀血甚者加水蛭、炮穿山甲；气虚者加人参。

【功效】 活血化瘀，化痰开窍。

【主治】 老年痴呆。

【用法】 水煎服，每日 1 剂，早晚分 2 次服，3 个月为 1 个疗程。

【方解】 方中仙茅、淫羊藿温补肾阳，肾阳为一身之红日，阳精得补则气旺神充，阴霾自散。熟地黄、沙苑子偏补肾阴，精充则五脏得养，神明白安，无狂躁之虞。二仙与之相配则阴得阳助，泉源不竭，阳得阴助，生化不息。当归、川芎、地龙、桃仁、红花、活血化瘀以通经络，使所补之精气通达脏腑、



经脉,而无瘀滞之弊。石菖蒲、远志化痰开窍,宁心安神,强志。全方共奏补肾益髓、活血化痰之效,且有健脑复智之功,因此,取得较好的疗效。

方5 地黄饮子加减(华刚)

【组成】 熟地黄 20g,山茱萸、巴戟天、肉苁蓉各 12g,石斛、麦冬、茯苓、远志、当归、附子、石菖蒲各 10g,党参、丹参各 15g,五味子 6g。**加减:**若心神不宁、失眠易惊者加酸枣仁、柏子仁、龙齿以安神定惊;阴虚有热者去附子,加黄柏、黄连、知母;痰湿症状明显者加半夏、陈皮;血瘀症状明显者加桃仁、红花。

【功效】 补肾生髓充脑。

【主治】 老年痴呆。

【用法】 每日 1 剂,水煎,每日分 2 次服用。

【方解】 老年痴呆症为脑组织退化性病变,其病机虚实夹杂,一般分为髓海不足、脾肾两虚、心肝火旺、痰浊阻窍、瘀血内阻等型。肾藏精,生髓通脑,为作强之官,出伎巧。老年之人,年高体弱,脏腑功能日趋衰退,心脾渐损,气血不调,日久肾亏,髓海空虚,脑失充养,不能奉养心神,渐致清窍失灵而成本病。老年痴呆症病变在脑,但其根源在肾,其治疗当以补肾为主。地黄饮子为肾虚阴阳两补之方,方中熟地黄、山茱萸、巴戟天、肉苁蓉、附子温养元阳,五味子、石斛、麦冬滋阴敛液,石菖蒲、远志、茯苓化痰开窍醒脑;黄芪、党参、当归益气养血,丹参活血化瘀通络,诸药配伍,切合病机,共奏补肾生髓充脑之效,故痴呆症遂除。

方6 还神转呆汤(党安琪)

【组成】 党参、黄芪各 30g,酸枣仁、山茱萸各 15g,制胆南星、远志、石菖蒲、巴戟天、当归、地龙各 10g,制附子 3g,白



芥子 6g。

【功效】 化痰开窍，温肾填精。

【主治】 老年痴呆。

【用法】 每日 1 剂，浓煎取汁 300ml，早中晚 3 次温服。
1 个月为 1 个疗程，治疗 3 个疗程。

【方解】 老年性痴呆症是一组慢性进行性退化性疾病，以痴呆为主要表现。病理改变以大脑萎缩和变性为主。临床表现：轻者神情淡漠，少语善忘，反应迟钝。重者表现为终日不语，或闭户独处，或口中喃喃，或言词颠倒，举动不经，或忽哭忽笑，或不欲食，不知饥饿等。中医认为，本病多因久病血亏气弱，心神失养，或肝肾不足，脑髓不充而致。本病进程缓慢，以虚中挟实者多见。病位在脑，涉及心、肾、肝、脾，治宜标本同治。还神转呆汤中，党参、黄芪补心脾之气；熟地黄、山茱萸、巴戟天、制附子温肾填精；当归养血和血；远志、石菖蒲、制胆南星、白芥子化痰开窍；地龙活血通脉；酸枣仁安神定志。诸药合用，可使髓海得充，血脉得通，从而取得改善老年痴呆症之效果。

方 7 益肾化痰汤(郝美华)

【组成】 熟地黄、山茱萸、枸杞子各 20g，当归、丹参、郁金、赤芍各 15g，川芎、石菖蒲各 10g。加减：肾阳虚明显者加淫羊藿、菟丝子；阴虚有热者加知母；痰湿明显者加陈皮、半夏；气虚明显者加党参、白术；血虚明显者加黄芪、当归、阿胶珠；阴虚明显者加女贞子、麦冬；热甚烦躁不安，口干便秘，舌苔黄腻者加黄连、大黄；气郁甚，胸闷，善太息者加柴胡、佛手；纳呆者加鸡内金、神曲；心悸失眠者加龙齿、柏子仁；肢体半身不遂者加地龙、水蛭。

【功效】 益肾化痰，补益肾气。



【主治】 老年痴呆。

【用法】 每日1剂，水煎取汁300ml，分早晚温服，2个月为1个疗程。

【方解】 老年痴呆是内科疑难病之一。中医学认为，“脑为髓海”，是“精明之府”；“髓海不足，脑转耳鸣，脘酸眩暈，目无所视，懈怠安卧”。笔者认为老年痴呆病位在脑，其本在肾，与心、肝、脾有关。肾中精气不足，则髓海失养；或肾水不足，水不涵木，肝阳挟痰火上扰神明；或兼肾气亏损，火不生土，脾虚不运，痰湿内盛，导致清阳不升，浊阴不降，蒙蔽清窍；肾虚必血瘀，而血瘀阻络，脑失所养。总之，脾、肾虚弱，肝阳上亢，瘀血阻络终致痴呆。本病为本虚标实之证，虚为髓海不足，实为瘀血、痰湿阻络，故治疗采用益肾化瘀法。方中熟地黄、枸杞子、益智仁、山茱萸补益肾气；丹参、郁金、当归、赤芍、川芎活血化瘀；佐石菖蒲醒脑开窍。临床观察和实验研究证明，补肾活血，既保证了老年患者的元阴元阳化源不绝，也使血脉经络畅通无阻，使老年人的五脏六腑、四肢百骸得到精气的滋养、温煦，从而维持正常功能，改善衰老机体的肾虚血瘀的病理状态，达到防治老年疾病的目的。

第五章 中 成 药

方1 牛黄宁宫片

【组成】 牛黄、黄连、栀子、胆膏、朱砂、石决明、钩藤、珍珠、琥珀、冰片、郁金、金银花。

【主治】 清热解毒，镇惊安神，熄风止痛。用于外感热病、高热神昏、惊风抽搐、肝阳眩晕、耳鸣头痛、心烦不寐及癫痫狂躁，对精神分裂症有一定的抗复发作用。

【用法】 口服，1次6片，一般头痛身热1次2~4片，每日3次。小儿酌减。

【宜忌】 ①孕妇忌服。②虚证及低血压者慎用。

方2 医痫丸

【组成】 天南星(制)、半夏(制)、生白附子、猪牙皂、白僵蚕(炒)、蜈蚣、全蝎、乌梢蛇(制)、雄黄、白矾、朱砂。

【主治】 祛风化痰，定痫止痛。用于诸痫时发，二目上窜，口吐涎沫，抽搐昏迷。本药适用癫痫等属风痰所致者。

【用法】 口服，1次3g，每日2~3次，小儿酌减。

【宜忌】 ①本品含剧毒药，不宜多服。②孕妇禁用。

方3 天麻钩藤颗粒

【组成】 天麻、钩藤、栀子、黄芩、川牛膝、杜仲、石决明、桑寄生、何首乌藤、益母草、茯苓。

【主治】 平肝熄风，清热安神。用于肝阳上亢型老年性



血管性痴呆。

【用法】 开水冲服,1次1袋,重症1次2袋,每日3次。

【宜忌】 阴虚之动风证忌用。

方4 全天麻胶囊

【组成】 天麻。

【主治】 平肝,熄风,止痉。用于头痛眩晕,肢体麻木,癫痫抽搐。

【用法】 口服,1次2~6粒,每日3次。

方5 越鞠丸

【组成】 香附(醋制)、川芎、栀子(炒)、苍术(炒)、六神曲(炒)。

【主治】 理气解郁,宽中除满。用于顽固性失眠、神经性头痛、癔症等属郁证者。

【用法】 口服,1次6~9g,每日2次。

【宜忌】 虚证郁滞者不宜单独服用本药。

方6 二十五味珊瑚丸

【组成】 诃子、木香、藏石菖蒲、铁棒锤、麝香、珍珠母、珊瑚、珍珠、青金石、丁香、肉豆蔻、磁石、沉香、紫菀、禹粮土、木桔、芝麻、狼牙菜、泉华、银朱、龙骨、羊脑石、红花、甘草、川西小黄菊。

【主治】 开窍通络,祛风止痛。用于白脉病,神志不清,身体麻木,头昏目眩,头痛,癫痫及各种神经性疼痛。

【用法】 药丸研细浸泡1夜后,次日晨空腹服用,1次1丸,1日1次。

方7 如意珍宝丸

【组成】 珍珠母、沉香、石灰华、金礞石、红花、螃蟹、丁香、毛诃子、肉豆蔻、余甘子、草果、香茅芹、檀香、黑种草子、降



香、高良姜、甘草膏、决明子、短穗兔耳草、芫荽、诃子、牛角、黄葵子、肉桂、毛诃子(去核)、乳香、木香、藏木香、麝香、牛黄、豆蔻。

【主治】 安神通窍,清热解毒,舒筋活络,活血化瘀。用于三叉神经病、坐骨神经痛、偏头痛、急慢性扭伤等。对白脉病有良效。

【用法】 口服,1次4~5丸,每日2次。

方8 安宫牛黄丸(胶囊)

【组成】 牛黄、麝香、水牛角浓缩粉、黄连、黄芩、栀子、冰片、郁金、珍珠、朱砂、雄黄、金箔衣。

【主治】 清热解毒,镇惊开窍。用于流行性脑脊髓膜炎、乙型脑炎、中毒性脑病、脑血管意外、中毒性肺炎、中毒性痢疾、中毒性肝炎、肝昏迷、尿毒症、癫痫以及小儿高热惊厥等见高热惊厥,神昏谵语证候者。

【用法】 蜜丸:成人,1次1丸,1日1次;小儿3岁以内,1次1/4丸;4~6岁,1次1/2丸,1日1次。胶囊剂:成人1次4粒(1.6g);小儿3岁以内1次1/4量;4~6岁1次1/2量;每日2~3次。

【宜忌】 ①孕妇慎服。②若患者病情较重,应及时送医院治疗。

方9 安脑丸

【组成】 人工牛黄、水牛角浓缩粉、猪胆汁粉、石膏、黄连、黄芩、栀子、冰片、郁金、朱砂、赭石、珍珠母、珍珠、雄黄、薄荷脑。

【主治】 清热解毒,醒脑安神,豁痰开窍,镇惊熄风。用于高血压、脑血管意外、流行性脑膜炎、乙型脑炎、精神分裂症及感染引起的发热等见上述证候者。



【用法】 口服,1次1~2丸,每日2次。或遵医嘱,小儿酌减量。

方10 局方至宝丸

【组成】 牛黄、冰片、水牛角浓缩粉、麝香、安息香、玳瑁、雄黄、朱砂、琥珀。

【主治】 清热解毒,开窍镇惊。用于乙脑、流脑、中毒性痢疾、脑血管意外、癫痫、肝昏迷、小儿热盛惊风、小儿痘疹不出以及周身感染性疾病等见上述证候者。

【用法】 口服。散剂:1次2g,小儿3岁以内1次0.5g,4~6岁1次1g;蜜丸及糊丸:均1次1丸,1日1~2次,小儿酌减或遵医嘱。

【宜忌】 ①忌辛辣油腻食物。②孕妇忌服。

方11 礞石滚痰丸

【组成】 金礞石(煅)、黄芩、熟大黄、沉香。

【主治】 降火逐痰。用于精神失常、精神分裂症、神经官能症、夜游症、癫痫神经系统、消化系统见癫狂惊悸,或咳喘痰稠,大便秘结证候者。

【用法】 口服,1次6~12g,1日1次。

【宜忌】 ①孕妇忌服。②病除即止,不能长期服用。

方12 苏合香丸

【组成】 苏合香、安息香、麝香、冰片、檀香、沉香、丁香、香附、木香、乳香(制)、荜茇、白术、水牛角浓缩粉、诃子肉、朱砂。

【主治】 芳香开窍,行气止痛。用于脑血管意外、癫痫。

【用法】 口服。大蜜丸:1次1丸,1日1~2次;水蜜丸:1次1丸,1日1~2次。

【宜忌】 孕妇禁用。



方 13 十香返生丸

【组成】 苏合香、麝香、安息香、沉香、丁香、檀香、青木香、香附、降香、广藿香、天麻、白僵蚕、金礞石、郁金、莲子心、琥珀、冰片、朱砂、牛黄、乳香、诃子肉、瓜蒌子、甘草。

【主治】 开窍化痰，镇静安神。用于脑血管意外、癫痫、精神分裂症、癔症等属子风动痰生或暑湿秽浊之气阻塞气机、内扰神明者。

【用法】 口服，1次1丸，每日2次，或遵医嘱。

【宜忌】 ①孕妇忌服。②忌食辛辣之物。

方 14 安神补心丸(胶囊)

【组成】 地黄、丹参、五味子(蒸)、菟丝子、墨旱莲、女贞子(蒸)、石菖蒲、合欢皮、何首乌藤、珍珠母。

【主治】 养心安神。用于神经衰弱、失眠、紧张型精神病或偏执狂型精神病轻症属于阴血不足、肝阳上亢者。

【用法】 口服。浓缩丸：1次15粒，每日3次；胶囊：1次4粒，每日3次。

方 15 朱砂安神丸

【组成】 朱砂、地黄、当归、黄连、甘草。

【主治】 清心养血，镇惊安神。用于神经衰弱、心血管神经官能症、精神分裂症等见胸中烦热，心悸不宁，失眠多梦证候者。

【用法】 口服。水蜜丸：1次6g，每日3次；小蜜丸：1次9g，每日2次；大蜜丸：1次1丸，1日1~2次。

【宜忌】 ①孕妇忌服。②忌食辛辣油腻之品，忌烟、酒、咖啡、茶等刺激物。③本药中朱砂主含硫化汞，不得过服、久服，以免引起汞中毒。④本药不宜与碘、溴化物并用。



方 16 十香定痛丸

【组成】 香附、高良姜、丁香、母丁香、半夏、白术、枳实、肉桂、片姜黄、红花、赤芍、白芍、五灵脂、蒲黄、延胡索、砂仁、豆蔻、木香、山楂、小茴香、槟榔、厚朴、三棱、莪术、牵牛子、降香、茯苓、安息香、苏合香、乳香、没药、朱砂、松罗茶、石菖蒲、檀香、沉香、甘草。

【主治】 疏肝解郁，和胃止痛。用于慢性胃炎、胃及十二指肠溃疡、慢性胆囊炎、子宫内膜异位症、瘰病等见胸胁胀满，胃脘疼痛，食积腹胀，经期腹痛证候者。

【用法】 口服，1次1丸，每日2次。

【宜忌】 ①孕妇及过敏体质者慎用。②本方辛燥药较多，气虚阴亏者慎用。

方 17 逍遥丸(颗粒)

【组成】 柴胡、白芍、当归、茯苓、白术(炒)、甘草、薄荷。

【主治】 疏肝健脾，养血调经。用于胁痛、郁证、低热、乳癖、月经不调、乳腺增生、男性乳腺发育症、慢性肝炎、慢性盆腔炎、痛经、情感性精神病、中心性视网膜炎等属于肝郁血虚证者。

【用法】 口服。水丸：1次6~9g，每日1~2次；大蜜丸：每次1丸，每日2次；颗粒剂：1次15g，每日2次。

【宜忌】 ①凡肝肾阴虚、气滞不通所致的胁肋疼痛，胸腹胀满，咽喉干燥，舌红无苔，脉象沉细者慎用。②孕妇忌服。③水丸用生姜煎水泛制；大蜜丸不含生姜。

方 18 平肝舒络丸

【组成】 柴胡、羚羊角粉、白僵蚕(麸炒)、钩藤、木香、香附、厚朴(姜炙)、枳壳(去瓜瓢炒)、青皮(醋炙)、陈皮、沉香、乌药、佛手、檀香、砂仁、白豆蔻、藿香、川芎、乳香(醋炙)、没药



(醋炙)、延胡索(醋炙)、牛膝、木瓜、桑寄生、威灵仙(酒炙)、人参、白术、茯苓、龟甲(沙烫醋淬)、何首乌(黑豆酒炙)、熟地黄、肉桂、丁香、白芷、羌活、防风、细辛、白及、胆南星(酒炙)、天竺黄、黄连、朱砂、冰片。

【主治】 平肝疏络,活血祛风。用于高血压、梅尼埃病、神经官能症、绝经期综合征、急性肝炎、慢性肝炎、肝硬化等见胸胁胀痛,肩背窜痛,手足麻木,筋脉拘挛证候者。

【用法】 温黄酒或温开水送服,1次1丸,每日2次。

第六章 食疗妙方

第一节 茶饮

方1 郁菖茶

【组成】 郁金、石菖蒲各 25g,丹参、乌药各 50g。

【制法】 将上药水煎 3 次后合并药液。

【功效】 活血化瘀,行气消痰。治疗癫证。

【用法】 分 2~3 次口服,每日 1 剂。5 剂为 1 个疗程。

方2 商陆汁

【组成】 商陆鲜根。

【制法】 将商陆鲜根块用清洁纱布包裹,拧出其汁(不要加入水分)。

【功效】 泻下利水,祛痰。治疗精神分裂症。

【用法】 空腹服用其汁 10~40ml。1 周后可服用第 2 次,一般 6~7 次为 1 个疗程。

方3 菊楂决明饮

【组成】 菊花 10g,生山楂片 15g,草决明子 15g。

【制法】 将决明子打碎,同菊花、生山楂片同煮。

【功效】 疏风散热平肝,润肠通便,益脑。适用于大脑软化痴呆患者。



【用法】 代茶饮，可酌加红糖。

方4 五宝茶汤

【组成】 玉米粉 500g，芝麻 200g，山药 200g，牛乳 100g，牛骨髓 100g，香油 100g。

【制法】 将芝麻、玉米粉炒香，芝麻、山药研细末、备用。用香油在锅中将牛骨髓化开，下玉米粉炒拌，再下牛乳、山药末，在锅中炒和均匀即成。

【功效】 养心脾，补肾精。可防治心脾不足、肾精亏损型老年痴呆。

【用法】 每早空腹用开水冲服炒面 50g，可代早餐。大便溏泻者不宜服用。

方5 核桃仁山楂茶

【组成】 核桃仁 150g，山楂 50g，白砂糖 30g。

【制法】 先将核桃仁加入适量的水浸泡半小时，洗净，放入研钵或石磨内，加少许清水，将其研磨成蓉浆，装入容器中再加适量清水稀释调匀待用；山楂用水冲洗干净，拍破，装入锅内，加入适量清水在中火上煎熬 3 次，每次 20min，过滤去渣，取汁，用文火浓缩到约 1 000ml。再把锅洗净后置于火上，倒入山楂汁，加入白糖搅拌，待溶化后，再缓缓地倒入核桃仁浆，边倒边搅均匀，烧至微沸即成。

【功效】 益肾精，养肝血，充脑髓。可防治肝肾不足、精血亏损型老年痴呆症。

【用法】 当茶细细饮服，每次服 150～200ml。每日可服 2～3 次。

方6 冬虫夏草茶

【组成】 冬虫夏草 2g。

【制法】 将冬虫夏草放入保温杯中，加入沸水冲泡，加盖



闷 30min。

【功效】 益精气，补肝肾，健脑安神。可防治肝肾不足、精气亏损型老年痴呆。

【用法】 当茶频频饮用，一般可冲泡 3~5 次，再嚼食冬虫夏草。每日 1 剂。

方 7 灵芝茶

【组成】 灵芝 10g。

【制法】 将灵芝切成薄片，放入保温杯中，加入沸水冲泡，加盖闷 30min。

【功效】 益精气，补肝肾，健脑安神。可防治肝肾不足、精气亏损型老年痴呆。

【用法】 当茶频频饮用，可冲泡 3~5 次，再嚼食灵芝草片。每日 1 剂。

方 8 二子延年茶

【组成】 枸杞子、五味子各 6g。

【制法】 将 2 味捣烂，放入茶杯中，用沸水冲泡，加盖闷 15min。

【功效】 补益肝肾，健脑安神。可防治肝肾不足、精不养神型老年痴呆。

【用法】 当茶频频饮用，一般可冲泡 3~5 次。每日 2 剂。

方 9 何首乌杜仲茶

【组成】 何首乌、杜仲各 250g，夏枯草 150g。

【制法】 将杜仲放入盐水中泡透，取出，置于锅内，用文火炒至微焦，凉透；何首乌用黑豆蒸煮熟透，晒干；然后分别将杜仲、何首乌、夏枯草制成粗末，和匀，用滤纸袋分装，每袋重 20g，备用。



【功效】 益肝肾，补精血，健脑益智。可防治肝肾不足、精气亏损型老年痴呆。

【用法】 取何首乌杜仲茶 1 袋，放入茶杯中，用沸水冲泡，加盖闷 20min 即成。代茶频频饮用，可泡 3~5 次。每日 1~2 袋。

方 10 五子健脑茶

【组成】 沙苑子、菟丝子、枸杞子、五味子、女贞子各 200g，熟地黄、山茱萸各 100g，神曲 50g。

【制法】 先将熟地黄、山茱萸放入锅中，加水 2 000ml 浸泡 1 小时，煮沸后改文火煎煮 40min，滤出药汁，加水 1 500ml，煮沸后改文火煎煮 40min，滤出药汁；如此再煎 1 次，滤出药汁，去渣；合并 3 次药汁，加入神曲粉搅匀，大火煎取浓膏。将上述五子焙干，捣成碎末。加入药汁浓膏，搅拌搓揉均匀，捏成团，以触之能散为度，用模具或压块机制成小方块，低温干燥，使含水量降至 3% 以下即成。密封贮存。

【功效】 养肝益肾，补脑安神。可防治肝肾不足、精血亏损型重症老年痴呆。

【用法】 取茶块 20g，放入茶杯中，用沸水冲泡，加盖闷 10min 即成。频频饮服茶汁。每日 1~2 剂。

方 11 西洋参茶

【组成】 西洋参 1~2g。

【制法】 将西洋参切成薄片，放入保温杯中，加入沸水冲泡，加盖闷 30min 即成。

【功效】 益气生津，补益心脾、宁神健脑。可防治心脾两虚、精气亏损型老年痴呆。

【用法】 代茶饮，可冲泡 3~5 次，再嚼食西洋参片。每



日 1 剂。

方 12 人参茶

【组成】 人参 5g。

【制法】 将人参切成薄片，放入保温杯中，加入沸水冲泡，加盖闷 30min。

【功效】 大补元气，补益心脾，养神益智。可防治心脾两虚、元气亏损型老年痴呆。

【用法】 代茶频频饮用，可冲泡 3~5 次，再嚼食人参片。每日 1 剂。

方 13 黄精茯苓茶

【组成】 黄精、茯苓各 100g，青茶 50g。

【制法】 将上 3 味研成粗末，分装于滤纸袋中，每袋重 15g，备用。

【功效】 养阴生津，益气宁心，安神定志。可防治心脾两虚、津气不足型老年痴呆病。

【用法】 取黄精茯苓茶 1 袋放入茶杯中，用沸水冲泡，加盖闷 10min 即成。频频饮用茶水，可冲泡 3~5 次。每日 1~2 袋。

方 14 龙眼红枣茶

【组成】 龙眼肉 5~10 枚，红枣 3~5 枚，乌龙茶 5g。

【制法】 将龙眼肉放入碗中，隔水蒸熟取出。将红枣用刀划破，放入茶杯中，加入龙眼肉、茶叶，用沸水冲泡，加盖闷 20min 即成。

【功效】 益心脾，补气血，安神定志。可防治心脾两虚、气血不足型老年痴呆。

【用法】 频频饮用茶水，可冲泡 3~5 次，再嚼食龙眼肉和红枣。每日 1 剂。



方 15 十仙茶

【组成】 梗米、山药、薏苡仁、赤小豆、绿豆(5味分别炒熟)各 750g,青茶 500g,净芝麻 375g,净花椒 75g,净小茴香 150g,炮干姜、食盐各 30g。

【制法】 将上 10 味研成细末,加入食盐,和匀,文火炒至色黄焦熟,凉透,装入瓷罐收贮。

【功效】 益气健脾,养心安神。可防治心脾两虚型老年痴呆。

【用法】 每次取细末 15~20g,放入茶碗中,加入核桃仁、南枣、松子仁、白砂糖适量,用沸水冲匀即成。当茶频频饮用,每日 2~3 次。

方 16 牛乳红茶

【组成】 鲜牛乳 100g,红茶 5g,食盐 3g。

【制法】 先将红茶用沸水熬浓汁,再把牛乳煮沸,盛在碗里,调入红茶浓汁,加入少许食盐,和匀即成。

【功效】 益精气,补脾胃,养心神。可防治心脾两虚、精气不足型老年痴呆。

【用法】 当茶频频饮用,每日 1 剂。

方 17 石菖蒲醒脑茶

【组成】 石菖蒲 250g,郁金 200g,普洱茶 150g。

【制法】 上药焙干,制成粗末,用滤纸袋分装,每袋重 20g,备用。

【功效】 化痰涤浊,开窍醒脑。可防治痰浊阻窍、神机闭阻型老年痴呆。

【用法】 取石菖蒲醒脑茶 1 袋,放入茶杯中,用沸水冲泡,加盖闷 10min 即成。代茶频频饮用,可冲泡 3~5 次。每日 1~2 袋。



方 18 苍术川芎三宝茶

【组成】 苍术 300g,川芎 150g,红茶 250g。

【制法】 上药焙干,制成粗末,用滤纸袋分装,每袋重 20g,备用。

【功效】 燥湿化痰,开郁醒脑。可防治痰浊阻窍、神机闭阻型老年痴呆。

【用法】 每次取三宝茶 1 袋,放入茶杯中,用沸水冲泡,加盖闷 10min 即成。频频饮服茶汁,可冲泡 3~5 次。每日 1~2 剂。

方 19 山楂荷叶茶

【组成】 鲜山楂 500g,鲜荷叶 750g。

【制法】 将上 2 味洗净,晒干,共研成粗末,分装于滤纸袋中,每袋重 20g,备用。

【功效】 健脾化痰,升清醒脑。可防治痰浊阻窍、神机闭阻型老年痴呆。

【用法】 取山楂荷叶茶 1 袋,放入茶杯中,用沸水冲泡,加盖闷 15min 即成。当茶频频饮用,可冲泡 3~5 次。每日 1~2 袋。

方 20 五宝普洱茶

【组成】 藿香、佩兰、竹茹、远志各 50g,陈皮 30g,普洱茶 200g。

【制法】 上药焙干,制成粗末,用滤纸袋分装,每袋重 15g,备用。

【功效】 健脾化痰,醒脑安神。可防治痰浊阻窍型老年痴呆。

【用法】 取五宝普洱茶 1 袋,放入茶杯中,用沸水冲泡,加盖闷 10min 即成。代茶频频饮用,可冲泡 3~5 次。每日



1~2 袋。

方 21 丹参茶

【组成】 丹参 250g,红花 100g,菊花 50g。

【制法】 上药焙干,丹参制成粗末,红茶、菊花研碎,3 药拌匀,用滤纸袋分装,每袋重 15g,备用。

【功效】 行气活血,通窍健脑。可防治气滞血瘀型老年痴呆。

【用法】 每次取丹参茶 1 袋,放入茶杯中,用沸水冲泡,加盖闷 10min 即成。代茶频频饮用,可冲泡 3~5 次。每日 1~2 袋。

方 22 川芎茶

【组成】 川芎 250g,香附 200g,桑叶 150g。

【制法】 上药焙干,研成粗末,拌匀,用滤纸袋分装,每袋重 15g,备用。

【功效】 行气活血,通窍健脑。可防治气滞血瘀型老年痴呆。

【用法】 每次取川芎茶 1 袋,放入茶杯中,用沸水冲泡,加盖闷 10min 即成。代茶饮用,可冲泡 3~5 次。每日 1~2 剂。

方 23 鸡血藤茶

【组成】 鸡血藤 300g,姜黄、莪术各 100g,红茶 400g,茉莉花 50g,面粉 20g。

【制法】 将鸡血藤、姜黄、莪术放入锅中,加水 4 000ml 浸泡 1 小时,煮沸后改文火煎煮 40min,滤出药汁;加水 3 000ml,煮沸后改文火煎煮 40min,滤出药汁;如此再煎 1 次,滤出药汁,去渣;合并 3 次药汁,加入面粉,搅匀,大火煎取浓膏。将红茶研成粗末,加入药汁浓膏,搅拌搓揉均匀,捏成团,



以触之能散为度,用模具压制成小方块,低温干燥,使含水量降至3%以下即成。密封贮存。

【功效】 行气散结,通窍逐瘀,安神定志。可防治气滞血瘀、脑窍闭阻型老年痴呆。

【用法】 取茶块20g,放入茶杯中,用沸水冲泡,加盖闷10min即成。频频饮服茶汁。每日1~2剂。

方24 三花活血茶

【组成】 月季花、凌霄花、红花各50g,红茶300g。

【制法】 3花拣尽杂物,晒干,与红茶共研成粗末,用滤纸袋分装,每袋重10g,备用。

【功效】 行气活血,通窍宁神。可防治气滞血瘀、脑窍闭阻型老年痴呆。

【用法】 取三花茶1袋,放入茶杯中,用沸水冲泡,加盖闷10min即成。频饮茶汁,可冲泡3~5次。每日1~2袋。

方25 柴龙牡蛎汤

【组成】 磁石100g(先煎20min),生龙骨、生牡蛎各30g(先煎20min),茯苓25g,柴胡18g,黄芩、半夏、太子参、石菖蒲、郁金各15g,桂枝12g,大黄、生姜、大枣各10g。

【制法】 水煎服。

【功效】 疏郁导滞,泄热蠲湿,重镇开窍。可治疗躁狂抑郁性精神病,证属肝胆郁结、痰火上扰者。

【用法】 每日1剂,分2次服用。

方26 清心泻狂汤

【组成】 生地黄30g,玄参24g,赤芍15g,黄连10g,黄芩、栀子各18g,大黄(后下)30g,珍珠母、寒水石各60g,淡竹叶10g,木通6g,甘草9g,朱砂6g。



【制法】 上药水煎服。

【功效】 能清心、泻火，益阴安神。可治疗躁郁症躁狂状态(单相和双相)，证属心气实者。

【用法】 每日1剂，早晚分服。

方27 补气养心振神汤

【组成】 黄芪60g，党参、炙甘草各30g，桂枝、白术各24g，茯苓18g，甘松15g，远志、五味子、酸枣仁各9g，大枣5枚，朱砂3g(研末分3次冲服)。

【制法】 水煎服。

【功效】 补益心气、益养振神。可治疗躁郁症抑郁型，证属心气虚者。

【用法】 每日1剂，分2次服用。

方28 酸枣仁汤

【组成】 酸枣仁60g，甘草10g，知母15g，茯苓12g，川芎9g。

【制法】 水煎服。

【功效】 滋补肝血，安定神志，清热除烦。可治疗内源性抑郁症，证属肝血虚者。

【用法】 每日1剂，分2次服用。

方29 解郁汤

【组成】 柴胡、制香附、炙甘草各6g，白芍、炒酸枣仁、郁金各12g，当归、朱茯神各15g，龙齿20g，石菖蒲10g，大枣7枚，陈小麦60g。

【制法】 水煎服。

【功效】 疏肝解郁宣窍，养血益心安神。可治疗抑郁状态，证属肝郁血虚者。

【用法】 每日1剂，早晚分服。



第二节 粥 汤

方1 龙眼莲子粥

【组成】 龙眼肉 25g, 莲子肉 15g, 红枣 5g, 糯米 50g, 白糖适量。

【制法】 先将糯米淘净, 莲子去皮心, 红枣去核, 洗净。再将糯米、红枣、莲子、龙眼肉放入锅内, 加水适量, 用武火烧沸, 再用文火熬熟。

【功效】 养心健脾, 宁神增智。可治各类老年痴呆症, 对心脾两虚型老年痴呆患者尤为适宜。

【用法】 食时加糖, 可当早餐食用。

方2 十全大补汤

【组成】 当归、酒炒白芍、党参、茯苓、熟地黄、炒白术各 10g, 炒川芎 8g, 炙黄芪 15g, 肉桂 4g, 炙甘草 5g, 姜块 25g, 猪肘 1 000g, 生鸡骨架 500g, 食盐、葱节、味精各适量。

【制法】 将当归、白芍、党参、茯苓、肉桂、川芎、熟地黄、白术、黄芪、炙甘草用清水快速冲净, 放入沙锅中加水煎煮 2 次, 取药汁 750ml, 滤净药渣待用。将猪肘残毛去净, 放在火上烤至微焦, 放在淘米水中泡 30min 取出, 刮去表层, 洗净, 用刀斜切成长 3cm、宽 2cm 的菱形块, 与鸡骨一起放入沙锅中, 加鲜汤烧开, 撇净血沫, 加入姜、葱、料酒, 用中火煨 90min, 再加入药汁、食盐, 改用小火煨至肘肉软烂; 取出肘肉, 加味精与汤汁, 盛入碗中即成。

【功效】 滋肝肾、养心脾, 益气血, 补精髓, 聪脑益智。可防治肝肾不足、心脾两虚、气血双亏型老年痴呆。

【用法】 吃肉喝汤, 中、晚佐餐。



方3 豆麦汤

【组成】 浮小麦 30g, 莲子 7 个, 黑豆 30g, 黑枣 7 个。

【制法】 先煮黑豆、小麦, 取汁去渣, 用此汁再煮莲子、黑枣至熟, 加入冰糖少许。

【功效】 补肾健脑, 养心安神。可防治各类老年痴呆症, 对于肝肾亏虚型老年痴呆患者尤为适宜。

【用法】 每日 1 次, 连续服用 1~3 个月。

方4 益精养神灵芝汤

【组成】 灵芝 30g, 活母鸡 1 只(约 2 000g)。

【制法】 将母鸡活杀放血, 去毛, 剖洗干净。灵芝洗净, 切成薄片, 装入鸡腹内。再将鸡放入沙锅内, 加入料酒、葱、姜、食盐、胡椒面等调料适量, 浸渍 1 小时后加水适量, 武火烧沸后改文火煨炖, 直至鸡肉酥烂。

【功效】 益精强脑, 养神益智。可防治肝肾亏虚、精髓不足型老年痴呆。

【用法】 饮汤食肉, 中、晚佐餐。

方5 补肾健脑乌龟汤

【组成】 肉苁蓉 60g, 天麻 15g, 覆盆子 30g, 熟地黄 30g, 乌龟 1 000g, 食盐、料酒少许。

【制法】 食盐半匙, 用开水泡化备用。将肉苁蓉、覆盆子、熟地黄、天麻快速洗净, 用冷却的淡盐水浸泡 1 小时。乌龟用开水烫死, 从侧面剖开, 去内脏, 洗净, 去膜, 放入沙锅内, 加入肉苁蓉、覆盆子、熟地黄、天麻及浸泡的淡盐水, 再加冷水至乌龟完全浸没; 先用旺火烧开, 加食盐半匙, 再用小火慢煨 4 小时, 至龟甲散开, 龟肉酥烂。

【功效】 补肾健脑, 壮阳益精。可防治肝肾亏损、阴阳两虚型老年痴呆。



【用法】 吃肉喝汤,午餐前及睡前空腹服食,每次1碗,1日2次,2天服完。

方6 益寿鸽蛋汤

【组成】 枸杞子、龙眼肉、制黄精各10g,鸽蛋4个,冰糖50g。

【制法】 将龙眼肉、枸杞子、制黄精洗净切碎,放入锅中煮30min;再将鸽蛋打入锅中,加入冰糖煮熟。

【功效】 补益肝肾、健脑。可防治肝肾亏虚、精血不足型老年痴呆。

【用法】 佐餐食用,每日1次,连食7日。

方7 酸枣仁粥

【组成】 酸枣仁30g,大米30g,食盐少许。

【制法】 酸枣仁30g,加水3碗煎至2碗,去渣。大米30g洗净后放入酸枣仁汤中煮粥,加食盐少许即成。

【功效】 养肝,宁心,安神,敛汗,舒筋。老年痴呆。

【用法】 空腹食之。

方8 小米龙眼粥

【组成】 龙眼肉30g,小米50~100g,红糖少许。

【制法】 将龙眼肉与小米同煮成粥。粥熟,调入红糖。

【功效】 补血养心,安神益智。用于心脾虚损,气血不足,失眠健忘,惊悸怔忡等症。

【用法】 空腹服食。

方9 洗心汤

【组成】 人参5g(另煎冲服),茯神、半夏各10g,陈皮8g,炙甘草5g,石菖蒲10g,熟附子6g,酸枣仁9g,神曲10g。

【制法】 水煎服。

【功效】 健脾益气,祛痰开窍。应用于治疗老年痴呆症



属脾虚痰阻,症见神思错乱,忽笑忽歌,寡言少语,不饮不食,气短乏力,面色㿠白。

【用法】 每日1剂,每日服2次。

方10 小麦粥

【组成】 小麦30g,大米100g,大枣5枚。

【制法】 将小麦、大米淘净,大枣去核备用。先取小麦放入锅中,加清水适量,煮至小麦熟后,去渣取汁,加大米、大枣煮粥,或将小麦捣碎后,同大米、大枣煮粥。

【功效】 养心神,健脾胃。适用于心气不足,心阴亏虚,心悸怔忡,失眠多梦,自汗,盗汗,女子脏躁(指精神恍惚,多呵欠,喜悲伤欲哭等)。

【用法】 服食,每日1剂。

方11 山茱萸生地黄春鸡汤

【组成】 光春鸡500g,山茱萸、生地黄各25g,春鸡肝(或鸡肝)3具,花雕酒、食盐各少许。

【制法】 ①将春鸡切块,放进开水锅内煮3min,用清水洗去血水,沥干待用。将鸡肝置盆内浸泡30min左右,浸出鸡肝内残留的有毒毒素血液,用清水反复洗净。②将鸡、鸡肝和生地黄、山茱萸、花雕酒一同放入沙锅内,加入适量清水,用文火煨40min,加盐调味即成。

【功效】 补肝明目,滋阴补血,美肤驻颜,增强脑力。适用于肝阴亏虚而致老年痴呆、早衰早老、动脉硬化、高血压、痛风,以及胆固醇合成调节能力差的中年人。

【用法】 空腹服食。

方12 牡丹干贝菠菜汤

【组成】 干贝50g,虾仁200g,白腩125g,鸡蛋清4个,鲜蘑菇125g,菠菜叶250g,食盐6g,味精5g,绍酒15ml,清汤



750ml,菱粉 25g,食用红色素水适量。

【制法】 ①将干贝洗净,剥去老肉,盛在碗内,加入绍酒和少许清水,上笼蒸半小时取出待用。②将蘑菇去蒂洗净,切成片泡在清水中。菠菜叶洗净,入沸水锅焯一下捞起,用清水漂冷,捣成蓉,挤出汁水待用。③将虾仁洗净,和白膘分别剁成蓉,盛在碗内,先加入绍酒、食盐、味精、蛋清拌和上劲,后加入菱粉拌匀,随后分成 2 份,取其中一份再一分为二,一半加入菠菜汁拌和,另一半加入食用红色素水拌和,然后分别放在 2 只小碗内,上笼蒸熟取出,制成花叶待用。④取 1 个圆盆,盆底先抹上猪油,将生虾胶放在盆中,堆成粉扑形,顶中央用蘑菇片摆成牡丹花蕊,外面一圈放上干贝、蘑菇片,接着安上红绿花叶,便成完整的牡丹花,上笼蒸熟。⑤将清汤倾入锅中,加入食盐、味精,待烧沸后起锅,装在汤碗内,然后将蒸熟的牡丹干贝用铲子轻轻地推入碗内,使其浮在汤上面便成。

【功效】 滋阴补肾、健脾开胃。适宜于肾阴不足、脾胃虚弱所致的口干乏津,神疲倦怠,食欲不振,老年痴呆,头空虚痛,失眠多梦,疲劳过度,心烦意乱等。

【用法】 空腹服食。

方 13 豆浆莴笋汤

【组成】 莴笋 300g,食盐 5g,味精 2g,猪油 50g,生姜、大葱各 10g,鲜豆浆 750ml。

【制法】 ①将莴笋去皮,洗净,切成长 7cm,筷子粗的条,姜切片,葱切段待用。②锅置火上,下猪油烧至六成热,下生姜、大葱稍炸出香味,下莴笋条、盐,炒至断生,拣去生姜、大葱不要,冲入豆浆,烧开后加味精即可。

【功效】 祛火除热、益脑止惊。适用于秋季癫发作者。

【用法】 随量饮之。

